

Ulkus Peptikum (Ulcus ventriculi und duodeni)

1-persönliche Daten: Anton Bäurle/Heide-Helga Schmit
Alter: 42 Jahre Gewicht: 72 kg Größe: 1,67 m

2-Allergie: Eine Allergie gegen Nüsse sei bekannt (Juckreiz).

3- Genussmittel/ Noxen:

Nikotin: Nichtraucherin/ 20 Zigaretten pro Tag seit 18 Jahren

Alkohol: gelegentlich/ 1-2 Gläser Rotwein.

Keine Drogen.

Sport: kein/Fußball ab und zu/ Laufen /gelegentlich kegeln mit ihrem Mann

4- Sozialanamnese: Familienstand: (verheiratet/ledig/geschieden/verwitwet) habe einen gesunden Sohn, lebe mit seiner Familie /Alleinerzieherin,

Arbeit: Hausfrau/ Apotheker/

Er habe viel Stress auf der Arbeit

5- Familienanamnese:

-Vater: gesund/(Schlaganfall)

-Der Bruder: Arterielle Hypertonie

-Mutter: D.M. Typ 2 (Zuckerkrankheit), Arterielle Hypertonie (Bluthochdruck), Apoplex

6.Aktuelle Beschwerden:

Herr Bäurle ist ein 39 jähriger Pt, der sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit gestern/2 W bestehender, krampfartiger, epigastrischer Schmerzen ohne Ausstrahlung vorgestellt hat.

Der Pt berichtet, dass die Schmerzen langsam aufgetreten seien und sich im Lauf der Zeit verschlechtert hätten. Zusätzlich bewertet er die Schmerzen mit 7 von 10 auf der Schmerzskala. Die Schmerzen seien nahrungsabhängig und beim Essen oder nach Alkoholtrinken schlimmer geworden. Es gebe keine Faktoren, die die Schmerzen verstärken oder vermindern würden (widerspricht dem vorherigen Satz). Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint.

Begleitsymptome: Ferner sind dem Pt folgende Begleitsymptome aufgefallen:

-Er klagt über Nausea (Übelkeit),

-Pyrosis (Sodbrennen), /Aufstoßen,

-Fieber (nicht gemessen).

-Des weiteren klagt der Pt über leichten Gewichtsverlust von ca...kg /innerhalb ...Wochen.

Die Fragen nach anderen Beschwerden wie Erbrechen (emesis), Dysphagie, Blähungen wurden von dem Patienten verneint.

Vegetative Anamnese:

-Die Vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf

-Insomnie (Durchschlafstörungen) wegen Schmerz.

-Inappetenz (Appetitlosigkeit)

-Obstipation (Verstopfung).

7.Vorerkrankungen:

-Migräne

-Commotio cerebri (Gehirnerschütterung) vor 30 Jahren

-arterielle Hypertonie (Bluthochdruck) seit 10 Jahren,

-Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion) seit 7 Jahren,

-COPD seit 17 Jahren,

-Diskushernie (Bandscheibenvorfall)

- es wurde beim/bei der Pt. eine Appendektomie/ Hysterektomie/ Cholezystektomie durchgeführt

-Salpingektomie (Eileiterentfernung), Operation einer Inguinalhernie (Leistenbruch)

8.-Medikamentenanamnese:

In Bezug auf Medikation nehme Herr .. die folgenden Medikamente ein:

-(Ramipril/ Captopril / Enalapril (1-0-1)

-Ibuprofen /ASS / Diclofenac wegen der Dorsalgie (Rückenschmerzen) bei Bedarf

- L-Thyroxin
- Pille zur Verhütung
- ein Medikament gegen Migräne, dessen Namen unbekannt sei.
- Die Grundimpfungen worden geimpft / Der Impfstatus sei unbekannt.

9. Verdachtsdiagnose:

- Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Ulcus Ventriculi hin. Als Differentialdiagnosen kommen die folgenden in Betracht:
- 1-Myokardinfarkt (Herzinfarkt).
- 2-Akute Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung).
- 3-Gastritis (Magenschleimhautentzündung).
- 4-Cholelithiasis (Gallensteine).
- 5-Cholezystitis (Gallenblasenentzündung).

10-Maßnahmen

- Als erste Maßnahme würde ich den Pt körperlich untersuchen (Messung der Vitalzeichen). Zur weiteren Abklärung sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden:
- 1-Laboruntersuchung: B.B- CRP – BSG - HB . Lipase- Amylase
- 2-Urease-Schnelltest
- 3-Röntgenaufnahme
- 4-Abdomensonografie
- 5-Endoskopie: Ösophago-Gastro-Duodenoskopie (ÖGD)
- 6-EKG:
- Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:
- 1- Stationäre Aufnahme
- 2- Nahrungskarenz
- 3- PPI-Infusionstherapie (Ompersazol 40mg).
- 4- Ggf. Triple-Therapie sollte beim Nachweis von Helicobacter pylori erfolgen: PPI 20 - Clarithromycin - Amoxicillin
- 5- Operation, wenn es Komplikationen wie Blutung oder Perforation gibt

Fragen:

- Wo und wann haben die Schmerzen begonnen?
- Sind die Schmerzen plötzlich oder eher langsam aufgetreten?
- Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
- Haben sich die Schmerzen im Laufe der Zeit verbessert oder verschlechtert?
- Wie stark sind die Schmerzen auf eine Schmerzskala von 0 bis 10, wobei 0 keine Schmerz und 10 stärkste Schmerz ist.
- Können sie die Schmerzen aushalten oder brauchen Sie sofort ein Schmerzmittel?
- Falls ja: Haben Sie eine Medikamentallergie?
- Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben? Sind sie eher dumpf, stechend, krampfartig, drückend, pochend, ziehend...
- Treten die Schmerzen ständig oder nur gelegentlich auf?
- Gibt es bestimmte Auslöser für Ihre Schmerzen/Beschwerden?
- Was haben Sie gegessen? War es etwas ungewöhnliches?
- Treten die Schmerzen auch auf, wenn Sie nüchtern sind oder nur nach dem Essen?
- Haben Sie dagegen etwas eingenommen?
- Falls ja: Was genau? Hat es Ihnen geholfen?
- Hatten Sie solche Beschwerden früher schon mal?
- Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang? Welche Farbe hat Ihr Stuhl, ist er blutig, teerschwartz, gelblich? Welche Konsistenz hat der Stuhl, weich, fest, schleimig, schaumig?
- Haben Sie Probleme mit dem Wasserlassen?
- Leiden Sie unter Übelkeit oder Erbrechen?
- Haben Sie Sodbrennen?

- Fühlen Sie sich aufgebläht?
 - Hat sich Ihr Appetit in letzter Woche/Monate geändert?
 - Haben Sie zu- oder abgenommen?
 - Haben Sie Schwierigkeiten mit ein- oder durchzuschlafen?
 - Sind Ihnen Schweißausbrüche oder Nachtschweiß aufgefallen?
 - Nehmen Sie oft Schmerzmitteln ein?
- Falls ja: Nehmen Sie zusätzlich zu den Schmerzmitteln einen Magenschutz?
- Sind bei Ihnen schon Magenerkrankungen bekannt?

Definition

Umschriebener Epitheldefekt, der die Submucosa erreicht

Ulcus ventriculi (Magengeschwür): 80% der Fälle in der kleinen Kurvatur des Magens.

Schmerzen direkt nach dem Essen.

Ulcus duodeni (Zwölffingerdarmgeschwür): meist im bulbus duodeni lokalisiert. Schmerzen treten nüchtern auf, Besserung durch Essen.

Ursachen

- ✓ Helicobacter-pylori-Infektion
- ✓ NSAR
- ✓ akuter Stress
- ✓ Rauchen
- ✓ genetische Disposition

✓ Klinik

- ✓ häufig asymptomatisch, v.a. bei Diabetikern, Alkoholikern und bei der Einnahme von NSAR
- ✓ epigastrische Schmerzen, vor allem Nüchternschmerz bei ulcus duodeni
- ✓ postprandialer Schmerz und Völlegefühl mit Übelkeit und Erbrechen: stenosierender Magenulkus
- ✓ ggf. ausstrahlende Schmerzen in den rechten Oberbauch, nach retrosternal, in den Unterbauch oder den Rücken

Diagnostik

- ✓ Endoskopie mit Biopsie: Ausschluss Malignom und Helicobacter pylori
- ✓ Labor: Serum-Ca²⁺, Parathormon
- ✓ Gastrin-Bestimmung, Sekretin-Test: Zollinger-Ellison-Syndrom

Therapeutische Maßnahmen

- ✓ allgemeine Maßnahmen: Schonung, Nikotinabstinenz, ulzerogene Medikamente vermeiden (z.B. NSAR), kleinere und häufigere Mahlzeiten
- ✓ Säurehemmer: PPI, H₂-Rezeptorantagonisten, Antazida
- ✓ Prostaglandinanaloga (Schleimhautschutz)

Differentialdiagnostik

GERD, Magenkarzinom, Magen-, Duodenal-, Pankreaskarzinom, Cholelithiasis, Erkrankungen des Kolons

Spezielle Fragen bei Verdacht auf Ulcus ventriculi und Ulcus duodeni zur Differentialdiagnostik

- Leiden Sie an Appetitlosigkeit und/oder Völlegefühlen?

- Treten die Schmerzen auch auf, wenn Sie nüchtern sind (V.a. Ulcus ventriculi) oder nur nach dem Essen (V.a. Ulcus duodeni)?

Definition

Das **Ulcus ventriculi** ist ein Geschwür (Ulkus) der Magenschleimhaut. Es handelt sich um eine Form der gastroduodenalen Ulkuskrankheit.

Ätiologie

Die Ursachen sind vielfältig. Auslösende Faktoren bzw. Erkrankungen sind u.a.:

- Helicobacter pylori (seltener als bei Ulcus duodeni)
- Gastritis vom Typ B
- NSAR, wie z.B. Acetylsalicylsäure, Indometacin oder Diclofenac
- Noxen (Nikotinabusus, Alkoholabusus)
- Zollinger-Ellison-Syndrom
- Hyperparathyreoidismus
- Psychische Faktoren (Stress)

Die familiäre Häufung der Erkrankung weist auf eine genetische Disposition hin.

Pathohistologie

Der Schleimhautdefekt eines Ulcus ventriculi überschreitet die Lamina muscularis mucosae. Dadurch heilt ein Ulcus ventriculi nicht narbenfrei ab. Es kann histopathologisch von außen nach innen in vier Zonen eingeteilt werden:

- Außenzone mit Fibrin, Granulozyten und Zelltrümmern
- Eosinophile Quellungsnekrose
- Granulationsgewebe
- Zentrale Narbenzone

Symptome

Das klinische Bild kann variieren. Im Vordergrund stehen dumpfe oder brennende Schmerzen im Epigastrium, die in der Regel im zeitlichen Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme auftreten. In manchen Fällen wird der Schmerz durch die Nahrungsaufnahme ausgelöst, in anderen wird er durch sie vermindert. Die Schmerzen können in Richtung Sternum, Unterbauch oder auch in den Rücken ausstrahlen. Weitere Symptome sind:

- Blähungen, Aufstoßen und Völlegefühl
- Übelkeit und Erbrechen
- Appetitlosigkeit
- Gewichtsverlust

Diagnose

- Anamnese
- Endoskopie: Ösophago-Gastro-Duodenoskopie (ÖGD)
- Nachweis von Helicobacter pylori

Einleitung

Basierend auf der Lokalisation des Ulkus findet gemäß der Klassifikation nach Johnson eine Einteilung in drei Typen statt:

- Typ I: Ulkus an der kleinen Magenkurvatur, subazid (ca. 60 %)

- Typ II: Kombiniertes Magen- und Duodenalulcus, normal oder hyperazid(ca. 20 %)
- Typ III: Ulcus präpylorisch, meist hyperazid

Die Lokalisation des Ulcus ventriculi entspricht weitgehend dem Befallsmuster der chronischen Gastritis.

Komplikationen

Kommt es zu einer stärkeren Blutung aus dem Ulkus, treten Kaffeesatzerbrechen (Hämatemesis) und Meläna auf. Weitere Komplikationen sind

- Anämie
- Penetration bzw. Perforation des Ulkus mit Peritonitis
- Narbenbildung (Sanduhrmagen)

Das Risiko, an Magenkrebs zu erkranken, ist bei Patienten mit Ulcus ventriculi signifikant erhöht.

Medikamentöse Therapie

Die Therapie erfolgt medikamentös durch Säurehemmung mit einem Protonenpumpenhemmer (PPI), wie z.B. Omeprazol oder Pantoprazol. Bei Nachweis von Helicobacter pylori wird eine Helicobacter-pylori-Eradikation mittels Bismut-Quadrupletherapie als Erstlinientherapie empfohlen. Sie besteht aus einem PPI plus Tetracyclin, Metronidazol und Bismut.

Aufgrund zunehmender Resistenzen gegen Clarithromycin wird die Triple-Therapie nur noch als Zweitlinientherapie verwendet. Zur Tripletherapie werden meist ein Protonenpumpenhemmer und zwei Antibiotika (v.a. Clarithromycin und Amoxicillin) eingesetzt.

Bei konsequent durchgeführter medikamentöser Therapie ist die Heilungsrate größer als 90 Prozent. Allerdings muss mit Rezidiven gerechnet werden.

Operative Therapie

Operative Interventionen sind nur bei Komplikationen (z.B. Ulkusperforation) notwendig, die mit der Ösophago-Gastro-Duodenoskopie nicht beherrscht werden können.

Gastrointestinale Blutung

1-persönliche Daten:

Name: Eicker /Schneider/Kehl /Kowalski/ Keller

Alter: 51 Jahre, Gewicht: 81 kg, Größe: 1,80 m

2- Allergie: Keine Allergien bekannt

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: 30 Zig/T seit 20 Jahren (30 P/Y)

Alkohol: Eine Flasche Bier jeden Tag / Glas Wein 4 mal pro Woche/3-4 Viertel Rotwein abends täglich

Drogen: Keine

Sport: Er treibe keinen Sport.

4- Sozialanamnese:

Familienstand: Frau Kowalski sei verheiratet und habe einen Sohn/ 2 gesunde Kinder

Arbeit: (Kraftwagenfahrer/LKW-Fahrer/ Hausfrau/habe viel Stress bei der Arbeit.

5- Familienanamnese:

- Vater: sei an einem Myokardinfarkt (Herzinfarkt) verstorben
- Mutter: gesund
- Geschwister: gesund

Patientenvorstellung

Frau Kowalski ist eine 67-jährige Patientin, die sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit 3 Tagen auftretender, zunehmender, dumpfer, epigastrischer Schmerzen (Oberbauchschmerzen) ohne Ausstrahlung vorgestellt hat

2-aktuelle Beschwerden:

- Der Pt. berichtet, dass die Schmerzen vor zwei Wochen plötzlich aufgetreten seien und sich seit 2 Tagen verschlechtert hätten.
- Zusätzlich teilt er mit, dass die Schmerzen 7 von 10 auf der Skala seien und sich nach Emesis (Erbrechen) verbessert hätten.
- Es gebe Nahrungsaufnahme als Auslöser der Schmerzen. Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint.

3-Begleitsymptome: Ferner sind dem Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen: Er klagt über

- Hämatemesis (blutiges Erbrechen, zweimal)
- Meläna (Teerstuhl) seit 2 Tagen
- Reizhusten, unproduktiver Husten,
- zunehmende Schwäche
- Nausea (Übelkeit)
- Des weiteren klagt der Pt. über Gewichtszunahme von ca...kg /innerhalb ...Wochen aufgrund von Kortison.

4-Vegetative Anamnese

Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf

- nächtliche Hyperhidrose (Nachtschweiß)
- Insomnie (Schlafstörung)
- Inappetenz (Appetitlosigkeit)
- Fiebergefühl

5-Vorerkrankungen: An Vorerkrankungen habe er

- arterielle Hypertonie (Bluthochdruck) seit 10 Jahren,
- Rheumatoide Arthritis seit 10 Jahren,
- Bronchitis
- Der Pt. sei mit 18 Jahren wegen eines Kreuzbandrisses/ Appendizitis (Blinddarmentzündung) operiert worden .
- Der Impfstatus sei unbekannt

6-Medikamentenanamnese:

Frau Kowalski nehme die folgende Medikamente regelmäßig ein:

- Kaptopril 25 mg (1-1-1)
- Prednisolon 15mg (1-0-0)
- Diclofenac 50mg (1-1-1)
- Die Frage nach Magenschutz-Tabletten wurde verneint.

7-Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf OGI (obere gastrointestinale) Blutung hin. Als Differentialdiagnosen kommen folgende im Betracht:

- 1- Ulcusblutung (Ulcus ventriculi, Ulcus Duodeni)
 - 2-blutende Ösophagusvarizen (Krampfadern in der Speiseröhre)
 - 3-Mallory-Weiss-Syndrom,
 - 4-Magen-Karzinom-Maßnahmen
- Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen (kurze Anamnese, kurze körperliche Untersuchung, Überwachung der Vitalparameter.) Zur weiteren Abklärung sollten folgende Maßnahmen durchgeführt werden:
- 1-Blutabnahme: Blutbild, Blutgruppenbestimmung, Gerinnung, Elektrolyte.

2-Ösophagogastroduodenoskopie: (ÖGD) mit Biopsien

3-Abdominalsonographie

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:

A -Sofortmaßnahmen (akute OGI-Blutung):

Falls hämodynamische Instabilität besteht, sollte möglichst schnell eine Ösophagogastroduodenoskopie durchgeführt werden.

–Endoskopische Diagnostik und Therapie (Injektion von Adrenalinlösung, Gefäßclip, Laser).

B-Bei endoskopisch nicht beherrschbarer Blutung sollte frühzeitig ein chirurgisches Konsil organisiert werden.

C- Ulcuskrankheit: HP-bedingte Ulcuskrankheit:

- Triple-Therapie über 7 bis 14 Tage, also 2 Antibiotika mit einem Protonenpumpeninhibitor. -

Die französische Triple-Therapie besteht aus: Amoxicillin, Clarithromycin und einem PPI.

Die italienische Triple-Therapie aus: Metronidazol, Clarithromycin mit einem PPI

Fragen:

- Haben Sie Übelkeit und Erbrechen?
- Haben Sie Blut im Erbrochenen bemerkt? Falls ja: War es hellrot oder kaffeesatzartig? Hat sich der Schmerz nach dem Erbrechen gebessert?
- Haben Sie Blut im Stuhl gesehen? Falls ja: War es hellrot oder schwarz (teeartig) gefärbt?
- Haben Sie Bauchschmerzen?
- Wo genau sind die Schmerzen?
- Wie lange bestehen die Beschwerden/Schmerzen?
- Haben Sie Medikamente eingenommen, um die Beschwerden zu lindern? Falls ja: Welches Medikament und Dosierung? Hat es Ihnen geholfen?
- Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten?
- Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 keine Schmerzen und 10 der stärkste Schmerz ist?
- Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben? (dumpf, stechend, brennend, krampfhaft)
- Haben sich Ihre Beschwerden seit Ihrem Auftreten verändert?
- Gibt es etwas, dass die Schmerzen lindert oder verstärkt?
- Werden Ihre Beschwerden durch bestimmte Auslöser beeinflusst? z.B. Essen, Bewegung, Stress?
- Haben Sie schon Mal solche Beschwerden gehabt?
- Hatten Sie Beschwerden wie extreme Schwäche, Atemnot oder Herzrasen?
- Hatten Sie Ohnmachtsanfälle? Ist Ihnen schwindelig geworden?
- Fühlen Sie Herzrasen oder einen unregelmäßigen Herzschlag?
- Fühlen Sie sich kraftlos, schwach oder müde?
- Sehen Sie blasser als sonst aus?
- Haben Sie Durchfall oder Verstopfung?
- Haben Sie Schlafstörungen oder Appetitlosigkeit?
- Haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab- oder zugenommen?
- Haben Sie Fieber oder Schüttelfrost?
- Schwitzen Sie nachts ungewöhnlich stark?
- Haben Sie kalten Schweiß bemerkt?

ÖGD Aufklärung: Bei der Magenspiegelung führen wir einen dünnen, flexiblen Schlauch mit einer Kamera durch den Mund in den Magen ein, um den Magen von innen anzuschauen. Falls eine Blutung vorliegt, können wir diese während der Untersuchung direkt behandeln. Wir können auch Gewebeprobe entnehmen. Auf Wunsch können Sie ein Beruhigungsmittel bekommen, damit Sie möglichst wenig davon spüren.

Warum muss man bei der Einnahme von Kortison und NSAR ein Magenschutzmittel einnehmen?

Kortison, NSAR und Aspirin können die Magenschleimhaut durch die Reduzierung der Säureproduktion reizen und das Risiko für Magenbeschwerden oder Geschwüre erhöhen. Diese Geschwüre können zu Blutungen führen.

-Manfred Kaiser-Schmitt 67jähriger Patient geboren am 13.03.1957, 1,87m 83Kg
 Wohnhaft: Stuttgart
 Hausarzt: Dr. Müller
 -Keine Allergien/Glutenunverträglichkeit
 -Medikamentenanamnese: Ibuprofen 600mg b.B.
 Beloc-Zok einmal täglich (Dosierung n.E.)
 Simvastatin 0-0-1(Dosierung n.E.)
 -Genussmittelanamnese: Nikotinabusus: 50py
 Alkoholkonsum: 1 kleine Flasche Bier/Abend seit mehreren Jahren Drogenabusus: verneint
 -Familienanamnese: Vater: gestorben (Ursache unbekannt)
 Mutter: an Hirninfarkt gestorben
 Bruder (64J): hat an ein Herzinfarkt gelitten
 -Sozialanamnese: Geschieden, wohnt allein
 Kinder: 2 Söhne, 1 Tochter
 Beruf: Bauingenieur
 Lebensstil: kein Sport, ungesunde Ernährung
 -Aktuelle Anamnese: Seit 2 Wochen bestehende, dauerhafte, epigastrische abdominelle Schmerzen.
 Dumpf, brennend. Keine Ausstrahlung. Nach Essen verschlimmern. Nichts dagegen eingenommen. Er
 war nicht zuvor bei einem anderen Arzt gewesen.
 -Begleitsymptome: Hämatemesis seit gestern
 Meläna seit gestern
 -Restliche vegetative Anamnese: Übelkeit
 Wasserlassen: keine Beschwerde
 Inappetenz
 abgenommen in der letzten Zeit
 Husten (seit mehreren Jahren wegen Rauchen)
 Schlafstörungen
 Scheißausbrüche als Begleitsymptom der Schmerzen
 Restliche vegetative Anamnese: unauffällig
 Eigenanamnese: Dorsalgie seit 15Jahren
 aHT, Hyperlipidämie
 -Voroperationen: Kreuzbandruptur im linken Knie
 -VD: obere gastrointestinale Blutung (Ulcus ventriculi)
 -DD: •andere Ursachen der OGB (Ulcus Duodeni, Ösophagusvarizen) • Cholezystitis • Pankreatitis •
 KHK

Herr Peter Kowalski , ist ein 51 jähriger Patient , der sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme
 wegen seit zwei Tagen aufgetretener, bestehender Hämatemesis (Hellrot Blut Erbrechen) vorgestellt
 hat. Außerdem klagte er über bestehende, zunehmende drückende, epigastrische
 Oberbauchschmerzen ohne
 Ausstrahlung. Die Beschwerden seien langsam aufgetreten und hätten sich im laufe der Zeit
 verschlechtert. Die schmerzen würden bei 06/10 auf der Skala liegen. Er habe dagegen Milch
 getrunken und habe es ihm geholfen. Die Frage nach ähnlichen Beschwerden wurde verneint. Die
 Beschwerden seien von den folgenden
 Symptomen begleitet : Fatigue +++, Tachycardie, Meläna, Meteorismus, Pyrosis
 Die Vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf Insomnie wegen schmerzen.
 An Vorerkrankungen leide er an Arterielle hypertonie seit 10 Jahren, Rheumatoide Arthritis seit 10
 Jahren.
 Er wurde wegen Appendektomie operiert.
 Er nehme regelmäßig Medikamente ein:
 Captopril 25 mg 1.1.1
 Diclofenac 25 mg / 50 mg bei bedarf
 Noxen : Er rauche 20 Zigaretten pro Tag mit seinem 16 Lebensjahr
 Er trinke täglich 1 Glas Wein oder 1 Flasche Bier
 Sozial Anamnese: Er sei Fernfahrer von Beruf und habe viel Stress bei der Arbeit.
 Er sei verheiratet und habe 1 gesund Sohn.

Herr Keller, Peter 50 J, 09.02.1974, 79 kg, 1,75 m

-Allergie/Unv: Glutenunverträglichkeit
 -Noxen: 20 Zigaretten täglich seit seinem 16. Lebensjahr
 2-3 Flaschen Bier täglich und gelegentlich Schnaps seit 35 Jahren
 kein Drogenkonsum
 kein Sport
 -Sozialanamnese: verheiratet, 4 gesunde Kinder, habe ein Bauunternehmen
 -Familienanamnese: Die Mutter-Apoplex
 Der Vater-gesund
 Der Bruder-MI
 -Aktuelle Anamnese: Der 50-jährige Patient, Herr Peter Keller, stellte sich aufgrund seit über 2-3 Wochen bestehender, progredienter, krampfartiger, nahrungsabhängiger Abdominalgie im Epigastrium ohne Ausstrahlung, sowie seit heute Morgen bestehender zweimaliger Hämatemesis bei uns vor. Die Schmerzen seien auf einer Skala von 0-10 bei 7 einzuordnen. Er verspüre eine Besserung nach der Einnahme von Ibuprofen 600 mg und nachdem er etwas getrunken habe. Die Reduzierung des Rauchens verschlimmere die Schmerzen. Ferner klage er über Pyrosis, Nausea und Schwindel. Bis auf Meläna seit 2 Tagen, Inappetenz, Insomnie und Stress bei der Arbeit ist. Die vegetative Anamnese ist unauffällig. Als Vorerkrankungen seien bei Herrn Keller aHT und Hyperlipidämie bekannt. Eine Kreuzband-OP sei ihm mit 18 durchgeführt worden. Die Medikamentenanamnese ergab die Einnahme von Beloc, Metoprolol und Ibuprofen bei Bedarf. Er sei standardmäßig geimpft.
 -Reaktionen: -Was habe ich? Ich habe ein Unternehmen, soll ich hier bleiben? -Ich habe zugenommen, als ich mit der glutenfreien Diät begonnen habe. Es würde nicht schaden, etwas abzunehmen. Kann ich mich wieder glutenhaltig ernähren? -Was machen Sie jetzt?
 -AA Gespräch: Patientenvorstellung, hat er eine Herzerkrankung? Warum habe ich gefragt? (ASS!) Was machen wir? (stationäre Aufnahme, Zugang legen, Blut entnehmen, körperliche Untersuchung, ÖGD...),

Mein Fall war Obere gastrointestinale Blutung, die Symptome waren genau wie in den Protokolle: Seit gestern bestehende, progredienter, nahrungsabhängige Epigastralgie/Oberbauch (NRS 8/10) mit Strahlung in den ganzen Abdomen.

-Begleitsymptome: Hämatemesis (Bluterbrechen), Meläna (Schwarzer Stuhl).

-Risikofaktoren: Einnahme von Ibuprofen, viel Kaffee, Alkohol und scharfes Essen.

So die Diagnose war ganz klar. Es ist wichtig, Fragen zu stellen, die Blutung zu finden und die Differenzialdiagnose auszuschließen. Zum Beispiel Vorgeschichte über Ulkus Peptikus oder nach Risikofaktoren fragen.

Ulcus (Estress, schlecht Diät oder lange Zeit ohne Essen, epigastralgie in der Vergangenheit, Ulcus ventriculi va duodeni, Schmerzen vor, während oder nach Ernährung Abnahme usw)

Cholecystitis (was genau haben Sie gegessen, bevor die Schmerzen auftraten, fettreich essen? Haben sie Dyslipidämie, Ictericia (gelbe Sucht)

Pankreatitis : Strahlung in den Flanken und.

-Arzt-Arzt gespräch: Ich habe den Patienten vorgestellt und dann hat der Oberarzt gefragt:

-Verdachtsdiagnose: Ober GIS Blutung

-Differentialdiagnose:

-Die wahrscheinliche Ursache der Blutung: Magengeschwür

-Untersuchungsmethode zum Ausschluss einer DD, zur Bestätigung meiner VD: Gastroduodenoskopie und zur Ermittlung der Blutungsursache.

Reaktion: Trinke ich viel Alkohol, ist es nicht normal? (1 Flasche Bier jeden Tag seit er 18 Jahre alt war) Rauche, gleiche Reaktion.

Mein Alkohol oder Tabakkonsum hat mit meinen Beschwerden etwas zu tun?

Was habe ich? etwas schlecht?

Warum stellen Sie so viele Fragen?

Definition

Unter der **oberen gastrointestinalen Blutung** versteht man eine Blutung, die vom oberen Gastrointestinaltrakt, d.h. dem Abschnitt zwischen Ösophagus und der Flexura duodenojejunalis, ausgeht. Diese Form der Blutung macht etwa 90% der gastrointestinalen Blutungen aus.

Ätiologie

Zu den häufigsten Ursachen für eine obere gastrointestinale Blutung gehören:

- Ulcus duodeni
- Ulcus ventriculi
- Ösophagusvarizen
- Erosionen
- Gastritis
- Mallory-Weiss-Syndrom

Ulkusblutungen werden oft durch Medikamente verursacht. Zu den typischen ulzerogenen Substanzen gehören u.a. ASS, Diclofenac, Ibuprofen und Glukokortikoide. Seltener sind Magenkarzinome oder Duodenalkarzinome die Blutungsquelle.

Klinik

Eine obere gastrointestinale Blutung imponiert durch das Erbrechen von hellrotem Blut (Hämatemesis) oder kaffeesatzartigem Blut. Teerstühle (Meläna) sind manchmal das einzige Symptom einer oberen gastrointestinalen Blutung und treten erst mit zeitlicher Verzögerung auf. Eine starke Blutung kann zu einem hypovolämischen Schock mit Tachykardie und Blutdruckabfall führen.

Diagnostik

Das Erbrechen von Blut weist auf eine obere gastrointestinale Blutung hin. Die Abklärung der Blutung erfolgt durch eine Ösophagogastroduodenoskopie. Zur Ursachenforschung sollten ein Blutbild, die Blutgerinnung und Leberenzyme herangezogen werden.

Klassifikation

Die obere gastrointestinale Blutung wird durch die Einteilung nach Forrest klassifiziert:

- **Typ I:** Aktive Blutung
 - Typ Ia: Arteriell spritzende Blutung
 - Typ Ib: Sickerblutung
- **Typ II:** Inaktive Blutung
 - Typ IIa: Mit sichtbarem Gefäßstumpf
 - Typ IIb: Koagelauf Lagerung auf einer Ulkusläsion
 - Typ IIc: Hämatinauf Lagerung auf einer Ulkusläsion
- **Typ III:** Eine Blutung liegt nicht vor, jedoch eine sichtbare Läsion und eine Blutungsanamnese.

Therapie

Nach der stationären Aufnahme und der Stabilisierung des Kreislaufs des Patienten durch Elektrolytlösungen, kolloidale Lösungen und Blut wird zunächst eine Endoskopie durchgeführt. Wird dabei die Ursache der Blutung entdeckt, wird zunächst versucht, die Blutung durch die Injektion von Adrenalinlösung oder Fibrinkleber zum Sistieren zu bringen. Auch Laser- bzw. Thermokoagulation sind mögliche Optionen.

Ösophagusvarizenblutungen können häufig nur durch die Einlage von Sonden, sog. Sengstaken-Blakemore-Sonden, gestillt werden, welche nur für max. 48h im Ösophagus verbleiben dürfen, da sonst die Gefahr der Entstehung von Drucknekrosen besteht. Magenfundusvarizen werden durch die Einlage von Linton-Nachlas-Sonden behandelt.

Um die Durchblutung zu senken und die Umgehungskreisläufe zu verschließen, kann Vasopressin intravenös verabreicht werden, alternativ dazu ist die Gabe von Terlipressin und weiteren Analoga indiziert.

Eine endoskopisch nicht stillbare Ulkusblutung bedarf der Exzision des Ulkus sowie der Ligatur des versorgenden Blutgefäßes. Zusätzlich sollte ein Protonenpumpeninhibitor wie z.B. Omeprazol oder Rabeprazol intravenös verabreicht werden.

Der Notfalltherapie sollte eine kausale Therapie folgen.

Prognose

Die durchschnittliche Letalität der oberen gastrointestinalen Blutung beträgt fünf bis zehn Prozent, bei einer Ösophagusvarizenblutung erhöht sie sich auf 30%. 90% der Blutungen können konservativ therapiert werden, wobei es in 70% der Fälle zu einem spontanen Sistieren der Blutung kommt.

GERD Gastroösophageale Refluxkrankheit

1- persönliche Daten:

Name: Herr Oskar Schmit/ Sebastian Schmidt/ Klaus Mühe

Alter: 50 Jahre, Größe: 1.79 m, Gewicht: 95 kg

2-Allergie: Keine Allergien bekannt

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: Nichtraucher / 10 bis 20 Zigaretten täglich

Alkohol: ein Glas Wein bzw. eine Flasche Bier / Tag

Drogen: keine – mit 20 habe er Gras geraucht.

Sport: kein / Fahrrad fahren

4- Sozialanamnese:

Familienstand: verheiratet - ein Sohn - wohne zusammen mit seiner Familie

Arbeit: Angestellter/ Schreiner /Taxifahrer / Büroangestellter/ als Hausmeister tätig

5- Familienanamnese: Unauffällig

-Vater: sei gesund/ Arterielle Hypertonie

-Mutter: sei gesund/ Apoplex (Schlaganfall)

-Der Bruder: Ösophaguskarzinom (Speiseröhrekrebs), er sei daran gestorben.

-Die Schwester: leide an MS (multipler Sklerose) seit 6 Jahren

6-aktuelle Beschwerden:

-Frau Schmidt ist eine 42-jährige Patientin, die sich heute Morgen bei uns in der Notfalleinweisung wegen seit 1 - 5 Monaten auftretender, zunehmender, brennender, retrosternaler Schmerzen ohne Ausstrahlung vorgestellt hat. Die Pt. berichtet, dass die Schmerzen langsam aufgetreten seien und sich im Verlauf verschlechtert hätten.

-Zusätzlich schätzt sie die Schmerzen auf 3-7 von 10 auf der Schmerzskala.

-Die Schmerzen seien nahrungsabhängig, lageabhängig und beim Essen (z.B. Schokolade-scharfes Essen- Kaffee oder Alkohol) und beim Liegen schlimmer geworden.

-Es gebe keine Faktoren, die die Schmerzen verstärken oder vermindern würden (widerspricht dem Satz vorher).

Sie fügte hinzu, dass sie dagegen ein Antazidum eingenommen habe/dass der Hausarzt dagegen Tabletten verschrieben habe (aber die Tabletten ihr nicht ganz geholfen hätten.) Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde (verneint/bejaht).

Begleitsymptome:

Ferner sind dem Pt folgende Begleitsymptome aufgefallen: Er klagt über

- Dysphagie (Schluckstörung)

- Pyrosis (Sodbrennen)

- Nausea (Übelkeit)

-nächtlichen trockenen Husten

- morgendliche Heiserkeit
- Die Frage nach Hämatemesis (blutiges kaffeesatzartiges Erbrechen), Meläna (Teerstuhl), Palpitation (Herzklopfen), Dyspnoe (Kurzatmigkeit), Emesis (Erbrechen) und Halitosis (Mundgeruch) wurde verneint.
- Des weiteren klagt der Pt. über (Gewichtsverlust/-zunahme) von ca...Kg /innerhalb ...Wochen.

7-Vegetative Anamnese:

- Die Vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf
- nächtliches Fieber (manchmal)
- Insomnie (Schlafstörungen).

8-Vorerkrankungen:

- Es seien keine relevanten Vorerkrankungen bekannt. /- An Vorerkrankungen leide er an
 - Es wurde beim Pt. eine Cholecystektomie durchgeführt (die Gallenblase entfernt).
- Der Impfstatus sei unbekannt/komplett.

9-Medikamentenanamnese:

- Der Pt. nehme derzeit keine Medikamente ein.
- Die Patientin nehme folgende Medikamente ein:
- ASS 100 mg zweimal täglich.
- Antazida

Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf GERD hin.

- Als Differentialdiagnosen kommen die folgenden in Betracht:
- KHK.
- Achalasie.
- Ösophagitis.
- Ösophaguskarzinom
- Barrett-Ösophagus
- Gastritis

10-Maßnahmen

- Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen.
 - Zur weiteren Abklärung sollten die folgende Maßnahmen durchgeführt werden:
 - Labordiagnostik: BB, BSG, CRP, Herzenzyme. Troponin.
 - EKG
 - Röntgen Thorax
 - PH-Metrie (24-Stunden-PH-Messung)-Ösophagogastroduodenoskopie ÖGD
- Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:
- 1 Allgemein: mehrere kleine Mahlzeiten
 - Schlafen mit erhöhtem Oberkörper.
 - Gewichtsnormalisierung.
 - Meidung von Noxen: Nikotin, Alkohol, Kaffee.
 - 2 Medikamentös: PPI, (Ranitidin), Antazida: (Natriumbicarbonat)
 - 3. ggf. chirurgische Therapie

Komplikationen: Ösophagitis, Barrett-Ösophagus, Adenokarzinom

Fragen:

- Wo genau spüren Sie das Brennen oder die Schmerzen?
- Strahlen die Beschwerden in andere Körperteile aus, wie z.B. den Hals, Rachen oder den Rücken?
- Wie würden Sie die Beschwerden beschreiben? Sind sie eher brennend, drückend, stechend...
- Hatten Sie schon Mal ähnliche Beschwerden?
- Haben Sie bereits Medikamente gegen diese Beschwerden eingenommen? Falls ja: Hat es Ihnen geholfen?
- Leiden Sie unter saurem Aufstoßen oder Rückfluss von Mageninhalt?

- Haben Sie häufig saures Aufstoßen oder einen bitteren Geschmack im Mund?
- Seit wann haben Sie diese Beschwerden?
- Sind die plötzlich oder allmählich aufgetreten?
- Haben Sie die Beschwerden anhaltend oder nur gelegentlich?
- Gibt es ein Auslöser, die die Beschwerden verschlimmert? z.B. fettiges oder scharfes Essen, Kaffee, Alkohol?
- Werden die Beschwerden stärker nach dem Essen?
- Wie stark sind die Beschwerden auf einer Skala von 0 bis 10?
- Gibt es etwas, dass die Beschwerden lindert?
- Leiden Sie unter chronischen Husten, Halsschmerzen oder Heiserkeit?
- Haben Sie Schwierigkeiten beim Schlucken (Dysphagie) oder verspüren Sie Schmerzen beim Schlucken (Odynophagie)?
- Haben Sie ein Völlegefühl? Leiden Sie an Blähungen?
- Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen? Falls ja: Wie sah das Erbrochene aus? Gab es Blut in Ihre Erbrochene?
- Leiden Sie unter Appetitlosigkeit?
- Hat sich Ihr Gewicht in der letzten Zeit ungewollt verändert?
- Verstärken sich die Beschwerden beim Hinlegen oder Schlafen?
- Wie viele Kissen brauchen Sie zum Schlafen? Können Sie mit erhöhtem Oberkörper besser Schlafen?
- Gibt es eine bestimmte Lage oder Position die Ihre Beschwerden lindert?
- Haben Sie Schwierigkeiten beim Stuhlgang oder Wasserlassen?
- Hatten Sie einen teeartigen Stuhlgang?

Der Patient XY, 95 kg, 179 cm, stellte sich aufgrund eines seit längerer Zeit bestehenden Druckgefühls hinter der Brust, Pyrosis, Heiserkeit und Husten bei uns vor. Der Patient hat darauf hingewiesen, dass Schokolade, Kaffee, Flachliegen und Rauchen die Beschwerden verschlimmern würden. Die vegetative Anamnese war unauffällig. Die Fragen nach Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten wurden verneint. Der Patient raucht seit 31 Jahren etwa 20 Zigaretten täglich und trinkt 1-2 Gläser Wein, manchmal auch Spirituosen.

In der Familienanamnese ergaben sich beim Bruder ein Ösophaguskarzinom und bei der Schwester Multiple Sklerose seit 6 Jahren. Der Patient ist verheiratet und hat einen Sohn. Er ist Angestellter beim Verkehrsdienst. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine gastroösophageale Refluxkrankheit hin.

Fragen:

1. Ist der Patient adipös? Ja BMI: 29,65
2. Risikofaktoren der Refluxkrankheit? Adipositas, Rauchen, Alkoholkonsum, fettreiche Essen, spätes Essen vor dem Schlafen, Schwangerschaft, Medikamente (NSRA, Nitrate), Hiatushernie (Zwerchfellbruch)
3. Wenn bereits ein Barrett-Ösophagus vorliegt, was machen wir? Wenn bereits ein Barrett-Ösophagus vorliegt, sollte der Patient regelmäßig endoskopisch kontrolliert werden. Zusätzlich wird in der Regel eine Therapie mit Protonenpumpenhemmern durchgeführt, um die Säureproduktion zu reduzieren. Falls Dysplasien nachgewiesen werden, sollte eine endoskopische Therapie, zum Beispiel eine Radiofrequenzablation oder eine endoskopische Resektion, erfolgen, um das Risiko für ein [Ösophaguskarzinom](#) zu senken.
4. Was ist die wichtigste Untersuchung und warum? 24-h-pH-Metrie ist Goldstandard.

Definition

GERD= gastroesophageal reflux disease Rückfluss von saurem Mageninhalt und/oder galligem Duodenalinhalt in die Speiseröhre durch Insuffizienz des unteren Ösophagussphinkters

Ursachen

- ✓ gestörte Verschlussfunktion des unteren Ösophagussphinkters
 - ✓ Cardiainsuffizienz
 - ✓ aggressives Refluat (Mageninhalt) durch Noxen: Kaffee, Nikotin, Medikamente, scharfe Gewürze
- => verursachen niedrigen pH-Wert des Mageninhaltes

Klinik

- ✓ Sodbrennen: brennende retrosternale Schmerzen, von unten aufsteigend
- ✓ epigastrische Schmerzen
- ✓ saures Aufstoßen
- ✓ Dysphagien
- ✓ Odynophagie
- ✓ ggf. Heiserkeit und Mundgeruch

Diagnostik

- ✓ probatorische Medikamentengabe: (PPI)
- ✓ 24 Stunden pH-Metrie: Messung von saurem und/oder galligem Reflux mittels Nasensonde

Therapeutische Maßnahmen

- ✓ probatorische Medikamentengabe: PPI
- ✓ Meiden von Nikotin, Alkohol, Kaffee, einschnürender Kleidung, opulente fetthaltige Mahlzeiten (v.a. abends), Anticholinergika, Kalziumantagonisten, und Nitrate soweit mögliche
- ✓ Gewichtsreduktion bei Übergewicht
- ✓ Prokinetika wie z.B. Metacloperamid oder Domperidon
- ✓ operativ: z.B. laparoskopische Fundoplicatio

Differentialdiagnostik

- ✓ Ösophagitis, KHK, Ösophagusulcera, Magenulkus, Magenkarzinom, funktionelle Ösophagusbeschwerden

Definition

Die **Refluxkrankheit** ist eine durch pathologischen Reflux von Mageninhalt ausgelöste entzündliche Erkrankung der Speiseröhre (Ösophagus). Nach der Montreal-Definition umfasst die Refluxkrankheit jede Form des Rückflusses von Mageninhalt, die zu Symptomen oder Komplikationen führt.

Pathophysiologie

Es bestehen eine Reihe von Schutzmechanismen gegen den ösophagealen Reflux:

- Zwischen Magen und Speiseröhre befindet sich der untere Ösophagussphinkter (UÖS). Es handelt sich hierbei nicht um einen ringförmigen Sphinkter, wie beispielsweise im Duodenum, sondern um spiralg angeordnete Muskelzüge am distalen Ende des Ösophagus. Der untere Ösophagussphinkter besitzt einen Ruhetonus mit einem Druck von 18 bis 24 mmHg. Das zeitgerechte Öffnen des Sphinktermechanismus ist Bestandteil des Schluckakts.
- Der distale Anteil des Ösophagus (Pars abdominalis) liegt in der Bauchhöhle. Es herrschen dort dieselben Druckverhältnisse wie in der restlichen Bauchhöhle, sodass kein Überdruck vom Magen in Richtung Ösophagus entstehen kann.

- Die Speiseröhre mündet spitzwinklig in den Magen. Dieser sogenannte His-Winkel verhindert rein mechanisch einen Reflux.

Jedoch bieten diese Schutzmechanismen keinen vollständigen Schutz. Der Ruhetonus des unteren Ösophagussphinkters kann durch Einwirkung verschiedener Substanzen und Gewohnheiten, die den Reflux fördern, gesenkt werden. Zu den refluxfördernden Faktoren gehören:

- Alkohol
- Nikotin (Rauchen)
- Essgewohnheiten ("Völlerei")
- fettreiche Mahlzeiten (Triglyzeride, Fettsäuren)
- reichliches Essen vor dem Schlafengehen
- Adipositas
- Schwangerschaft (v.a. im letzten Trimenon)
- Medikamente
 - Anticholinergika: Sie hemmen zwar die Magensäureproduktion, führen aber zu einer Erschlaffung des unteren Ösophagussphinkters.
 - Calciumantagonisten
 - Nitrate
 - Theophyllin
 - Betablocker
- Tragen von beengender Kleidung (zu fest angelegter Gürtel, Korsett)
- Darmstenose (Pylorus-, Duodenalstenose)
- Kardiomyotomie

Eine GERD liegt jedoch erst vor, wenn der Reflux zu einem Gesundheitsrisiko und/oder einer reduzierten Lebensqualität führt. Dabei tragen zwar die oben genannten Faktoren zur Pathogenese bei und verstärken die Beschwerden, am häufigsten lässt sich jedoch keine zugrundeliegende Ursache finden, welche die Insuffizienz des UÖS erklären würde. Eine axiale Hiatushernie spielt entgegen früheren Annahmen keine pathophysiologische Rolle.

Formen

Nach Montreal-Klassifikation werden folgende endoskopisch definierte Formen unterschieden:

- Nicht-erosive Refluxerkrankungen (NERD): GERD ohne ösophageale Läsionen, 60 % der Fälle
 - NERD mit erhöhtem Reflux
 - Hypersensitiver Ösophagus
- Erosive Refluxerkrankungen (ERD): GERD mit ösophagealen Läsionen, 40 % der Fälle
 - Refluxösophagitis
 - Reflux-bedingte Strikturen
 - Barrett-Ösophagus
 - Ösophageales Adenokarzinom bei GERD

Klinik

Die Refluxkrankheit äußert sich in einer Reihe von klinischen Symptomen, die anamnestisch wegweisend für weitere diagnostische Maßnahmen sein sollten:

- Sodbrennen (saures Aufstoßen, brennende retrosternale Schmerzen): 75 % d.F.
- Verstärkung der Schmerzen postprandial, bei Verbeugung kopfüber und im Liegen
- retrosternales Druckgefühl
- Luftaufstoßen (60 %)

- Meteorismus, Flatulenz
- Dysphagie (50 %)
- Regurgitation von Nahrungsresten (40 %)
- epigastrische Schmerzen und Brennen (30 %)
- Übelkeit, Erbrechen (bis hin zu Zahnschmelzdefekten)

Die Refluxkrankheit kann auch eine Reihe von extraösophagealen Symptomen verursachen:

- stenokardische Beschwerden über nervale Reflexbahnen
- chronischer Reizhusten (Refluxbronchitis), Auslösen oder Verstärken eines Asthma bronchiale bzw. einer chronischen Bronchitis durch Mikroaspirationen und/oder refluxinduzierter Vagusreizung
- Heiserkeit (posteriore Laryngitis) durch laryngo-pharyngealen Reflux(LPR)
- Globusgefühl
- Schlafstörungen

Diagnose

Bei typischer Anamnese und Klinik werden probatorisch Protonenpumpenhemmer (PPI) zur Diagnosis ex juvantibus verabreicht. Man spricht dann von einem PPI-Test.

Zwar können Ösophagitis und Barrett-Dysplasien durch eine Endoskopie diagnostiziert werden, jedoch wird diese nur durchgeführt bei:

- Vorliegen von Alarmsymptomen (Dysphagie, Odynophagie, Gewichtsverlust, Anämie bzw. gastrointestinale Blutverluste, Hinweisen auf eine Raumforderung, eine Striktur oder ein Ulkus)
- bei Risikofaktoren (positiver Familienanamnese für Malignome des oberen Gastrointestinaltraktes; langjährigen, schweren und v.a. nächtlichen Symptomen)

Bei endoskopischem Nachweis einer Refluxösophagitis ist keine weitere Diagnostik notwendig. Sind Ulzera, exophytische Läsionen oder Stenosen erkennbar, müssen Biopsien entnommen werden.

Bei therapieresistentem GERD oder unklaren Symptomen kann eine 24-Stunden-pH-Messung bzw. pH-Metrie-Impedanz-Messung im Ösophagus zur Registrierung von Refluxepisoden durchgeführt werden. Dabei müssen PPI eine Woche vorher abgesetzt werden. Bei einer GERD zeigen sich Refluxepisoden in über 3 % der nächtlichen und > 8 % der täglichen Messzeit. Anschließend können die Refluxepisoden mit den Symptomen korreliert werden (DeMeester-Score).

Weitere diagnostische Möglichkeiten sind die oropharyngeale pH-Metrie zum Nachweis eines laryngo-pharyngealen Refluxes sowie die katheterfreie (kapselbasierte) pH-Metrie. Die Ösophagusmanometrie spielt für in der Diagnostik der Refluxkrankheit keine Rolle.

Differenzialdiagnosen

- andere Ösophagserkrankungen (eosinophile Ösophagitis, Ösophaguskarzinom, Divertikel, Achalasie, Ösophagusmotilitätsstörungen)
- gastroduodenale Ulkuskrankheit
- Magenkarzinom
- koronare Herzkrankheit
- Ulzerationen des Ösophagus durch Festkleben von Tabletten (v.a. Bisphosphonate, Doxycyclin, Eisen, NSAR)
- funktionelle Dyspepsie (Ausschlussdiagnose)

Therapie

Konservative Therapie

Bei einer leichten Refluxkrankheit werden konservative Maßnahmen empfohlen. Dazu zählen:

- Gewichtsnormalisierung
- keine Mahlzeiten am späten Abend
- kein sofortiges Hinlegen nach dem Essen
- leichte Oberkörperhochlagerung während der Bettruhe
- Meiden von individuell unverträglichen Speisen und Getränken
- Nikotinkarenz
- Reduktion des Alkoholkonsums

Medikamentöse Therapie

Bei häufigen Beschwerden oder bei Refluxösophagitis sind Medikamente erforderlich. Als Mittel der Wahl gelten Protonenpumpeninhibitoren (z.B. Pantoprazol). Bei ausreichender Dosierung bewirken sie eine totale Säuresuppression und eine schnelle Heilungsrate (ca. 90 %). Dabei muss auf die Einnahme 30 Minuten vor einer größeren Mahlzeit geachtet werden.

Bei NERD bzw. in den Stadien A und B werden PPI in der Standarddosis (z.B. Omeprazol 20 mg/d, Pantoprazol 40 mg/d) für 4 Wochen, in den Stadien C und D für 8 Wochen verabreicht. Bei erfolgreicher Akuttherapie kann eine Reduktion auf die halbe Standarddosis und eine Einnahme nach Bedarf erfolgen. Bei langer Remission (z.B. nach einem Jahr) kann ein Auslassversuch erwogen werden. Dabei muss auf eine schrittweise Reduktion geachtet werden, sonst kann es zum Säure-Rebound kommen. Nach Therapiebeendigung kommt es in über 50 % d.F. zu Rezidiven. In diesem Fall kann unter Beobachtung der Nebenwirkungen (z.B. erhöhtes Risiko für Clostridioides-difficile-Infektionen oder erhöhtes Frakturrisiko) eine Langzeit-Rezidivprophylaxe erwogen werden.

Bei unzureichendem Ansprechen auf die Akuttherapie sollte die doppelte Dosis für bis zu 8 Wochen verabreicht werden. Bei Therapieversagen sind Wechselwirkungen und die Compliance zu prüfen sowie eine Endoskopie mit Biopsie und ein Impedanz-pH-Monitoring durchzuführen. Ursachen für eine Therapieresistenz können sein:

- Magenentleerungsstörungen (führen zur gastralen Inaktivierung der PPI)
- Zollinger-Ellison-Syndrom (Messung des basalen Gastrinspiegels nach Absetzen des PPIs)
- Einnahme von NSAR
- andere Krankheitsursache

Der Einsatz von anderen Medikamenten ist nicht empfohlen und sollte nur zusätzlich zu PPI oder bei leichten Refluxbeschwerden ohne Ösophagitis erwogen werden. Dazu zählen:

- H2-Rezeptor-Antagonisten (z.B. Cimetidin, Ranitidin)
- Antazida (z.B. Magnesiumhydroxid, Magnesiumtrisilikat)
- Alginat
- Sucralfat

Chirurgische Therapie

Die Indikation zur operativen Intervention ist erst bei langjährigen, therapierefraktären Beschwerden sowie beim Vorliegen spezifischer Kriterien gegeben (u. a. PPI-Resistenz, fortgeschrittenes Stadium, rezidivierende Aspirationen oder Medikamentenunverträglichkeit). Sie umfasst die offen-chirurgische oder laparoskopische Anlage einer Fundusmanschette (Fundoplicatio) um das distale Ende des Ösophagus und stellt eine mechanische Refluxbarriere her. Die Operationsletalität beträgt meist < 0,5 %.

Eine minimal-invasive Alternative ist in geeigneten Fällen die magnetische Sphinkteraugmentaion (MSA).

Bei Stenosen kann selten eine Bougierung notwendig sein. Eine Resektion des stenosierten Teilabschnittes des Ösophagus ist nur in Ausnahmefällen indiziert. Die Letalität bei der Resektion des Ösophagus ist zu hoch, um diesen Eingriff als Standard rechtfertigen zu können.

Als weitere Therapieoption kann bei ausgewählten Patienten eine elektrische Stimulation des unteren Ösophagussphinkters in Betracht gezogen werden.

Barrett-Ösophagus

Liegt nach histologischer Untersuchung der Biopsien keine IEN vor, reicht eine Kontrolluntersuchung nach einem Jahr und anschließend alle 3 bis 4 Jahre. Findet sich jedoch eine geringgradige intraepitheliale Neoplasie (LGIN), die von einem zweiten unabhängigen Pathologen bestätigt wurde, sind eine endoskopische Mukosaresektion (EMR) und eine nachfolgende Radiofrequenzablation des nicht-dysplastischen Barrett-Ösophagus indiziert. Falls die IEN endoskopisch nicht sichtbar ist, wird eine Verlaufskontrolle nach 6 Monaten und dann jährlich empfohlen.

Bei einer hochgradigen IEN (Barrett-Karzinom) ist zwingend eine endoskopische Mukosaresektion und eine nachfolgende Radiofrequenzablation notwendig. Falls die Submukosa infiltriert ist, kommt eine Ösophagusresektion mit Magenhochzug als Ösophagusersatz infrage. Fortgeschrittenere Fälle erhalten zusätzlich eine neoadjuvante Chemotherapie.

Ösophaguskarzinom

1-persönliche Daten: Name: Franz Mühe/ Müller/Schuster/Johans Alter: 53 Jahre, Größe: 178 cm, Gewicht: 49 kg

2-Allergie - Keine Allergien seien bei ihm bekannt.

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: 1.5 Schachteln pro Tag seit 30 Jahren (45 P/Y)

Alkohol: Der Patient trinke jeden Tag 4 Flaschen Bier und jeden dritten Tag Schnaps

Keine Drogen. Sport: - keiner- gelegentlich Fahrrad fahren.

4- Sozialanamnese:

Familienstand: Verheiratet/ geschieden - 2 gesunde Kinder (26,20)

-Er lebe mit seiner Frau und dem jüngeren Sohn zusammen

Arbeit : Angestellter bei der Ärztekammer / Büroangestellter/Straßenbauarbeiter

5- Familienanamnese: Unauffällig/-

-Vater: Apoplex (Schlaganfall), Herzerkrankung ihm nicht genau bekannt

-Mutter: DM, Beinvarizen (Krampfadern)

-Der Bruder sei an Pankreaskarzinom (Bauchspeicheldrüsenkrebs)/ Prostata CA gestorben

1-Patient-Vorstellung

Herr Mühe ist ein 53-jähriger Patient, der sich heute Morgen bei uns wegen seit 3-4 M/einigen Wochen aufgetretener progredienter Dysphagie (Schluckstörung) mit retrosternalen Schmerzen ohne Ausstrahlung vorgestellt hat.

2-aktuelle Beschwerden:

-Der Pt. berichtet, dass die Beschwerden langsam aufgetreten seien und sich im Verlauf verschlechtert hätten. Die Dysphagie sei nahrungsabhängig und beim Essen besonders fester Ernährung schlimmer geworden. Die Schmerzen seien 3 von 10 beim Schlucken von Flüssigkeiten und 6 beim Schlucken von fester Nahrung

3-Begleitsymptome

Ferner sind dem Pt folgende Begleitsymptome aufgefallen:

- Er klagt über ein Globusgefühl
- Pyrosis (Sodbrennen) seit längerem
- Husten mit Auswurf (nur morgens)
- Des weiteren klagt der Pt über Gewichtsverlust von ca 12 kg in den letzten 3 Monaten

4. Vegetative Anamnese: -Die Vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf eine Insomnie (Durchschlafstörung)

Inappetenz (Appetitlosigkeit)

Die Fragen nach Fieber, Schüttelfrost, Schwitzen, Übelkeit, Erbrechen, Obstipation, Diarrhö wurden von dem Patienten verneint.

5. Vorerkrankungen: An Vorerkrankungen leide er an

-Beinvarizen (Krampfadern), deswegen trage er Kompressionsstrümpfe.

-Diabetes Mellitus Typ I seit 7 Jahren

-Hypertonie seit 15 Jahren,

Herr Schuster sei zweimal stationär im Krankenhaus gewesen, einmal wegen Tremor in den Händen ohne bekannte Ursachen und das zweite Mal wegen Bronchitis/COPD.

-Vor 4 Jahren habe er TVT mit Lungenembolie gehabt und wurde im Krankenhaus stationär aufgenommen.

Er sei nicht operiert worden.

6. Medikamentenanamnese:

Frau Müller nehme die folgenden Medikamente regelmäßig ein:

-Metformin 850 mg 1-0-1

-Metoprolol 95 mg 1-0-0.

-ASS 100 mg einmal täglich.

Der Impfstatus sei komplett.

7. Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ein Ösophaguskarzinom hin. Als Differentialdiagnosen kommen die folgenden in Betracht:

-GERD

-Ösophagitis

-Ulcus ventriculi

-Achalasie

8 –Maßnahmen

- Als erste Maßnahme würde ich den Pt körperlich untersuchen.

-Zur weiteren Abklärung sollten die folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

1-Laboruntersuchung: BB –CRP- BSG-

2- Ösophagoskopie mit Biopsie

3--Endosonografie

- CT Thorax-Abdomen

-Skelettszintigraphie

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor:

1-kurativen Therapieansatz: die Ösophagusresektion mit Lymphadenektomie.

2- palliative Therapieverfahren für Patienten mit Metastasen (z. B. Chemotherapie), Implantation von Metallstents

3-Die operative Therapie bei Komplikationen....

Frageb bei Anamnese:

- Wann haben die Beschwerden begonnen?
- Sind die Beschwerden plötzlich oder eher langsam angefangen?

- Hatten Sie schon Mal unter ähnliche Beschwerden gelitten?
- Haben sich Ihre Symptome im Laufe der Zeit verschlechtert?
- Gibt es bestimmte Auslöser für die Beschwerden?
- Gibt es Situationen, in denen die Beschwerden schlimmer werden?
- Haben Sie Schwierigkeiten oder Schmerzen beim Schlucken?
- Können Sie die Schluckbeschwerden lokalisieren? Spüren Sie diese im Halsbereich oder hinter dem Brustbein?
- Treten diese Beschwerden nur bei fester oder auch bei flüssiger Nahrung auf?
- Sind die Schmerzen anhaltend oder wiederkehrend?
- Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
- Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10?
- Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben?
- Müssen Sie nach dem Essen häufig husten oder würgen?
- Leiden Sie unter Husten oder Heiserkeit?
- Ist der Husten trocken oder mit Auswurf?
- Treten Brustschmerzen auf? Wenn ja, sind sie beim Atmen oder Husten stärker?
- Haben Sie das Gefühl, nicht genug Luft zu bekommen?
- Verspüren Sie Engegefühl im Brustbereich?
- Haben Sie Medikamente gegen Ihre Beschwerden eingenommen? Wenn ja, welche und haben diese geholfen?
- Haben Sie häufiger Sodbrennen oder müssen Sie sauer aufstoßen?
- Ist Ihnen übel oder müssen Sie erbrechen?
- Haben Sie Blut erbrechen?
- Haben Sie bemerkt, dass Ihr Stuhl schwarz ist?
- Hat sich Ihr Appetit verändert?
- Haben Sie ungewollt an Gewicht verloren? Wenn ja: wie viel kg und in welchem Zeitraum?
- Wie ernähren Sie sich? Essen Sie gerne geköpelte oder verarbeitete Fleischprodukte?
- Trinken Sie gerne Heißgetränke oder essen Sie die Speisen zu heiß?
- Trinken Sie Alkohol?
- Haben Sie Fieber oder Nachtschweiß bemerkt?
- Haben Sie Schlafstörungen?

Herr otto schutser 54 ja, kommt wegen seit wochen bestehender, langsam aufgetretener, retrosternaler dysphagie mit fester Essen und mit reflux der speise während der Rückenlage, und Gewichtsverlust (er habe sich nicht gewogen) in zeitraum von 2 wochen und asthänie,
 Vegetative Anamnese: unauffällig bis auf insomnie,
 VE DM2, AH, z.n rezidivierende arthrits urica,
 medika: belockzok, janumet,
 keine allergien,
 rauchen 20zig/tag seit 30jahren,
 alkohol 10 Flaschen Bier/tag,
 familien anamnese: vater herzinsuffizienz, mutter DM1, bruder prostata ca
 sozial: geschieden, lebe allein, keine kinder, bauer von arbeit.
 AAG was sind die risikofaktoren? Was VD? DD? Was werden Sie machen? THERAPIE? Und aufklärung VD und OGD,

Herr Schuster, Otto 54J, 01.03.1970, 54kg
 keine Allergie 20Zig/Tag seit 30 Jahren, 10 Flaschen Bier täglich
 kein Drogenkonsum
 Bauarbeiter, geschieden, kein Kind, lebe allein
 Vater: eine Herzerkrankung, Mutter: DM, ein Bruder: Prostatakarzinom (wurde operiert)

Seit 3-4 Wochen bestehende, drückende, nahrungsabhängige, retrosternale Schmerzen sowie Dysphagie, keine Auslöser, Gewichtsabnahme von 2 kg innerhalb einer Woche. Nur mit flüssiger Nahrung könne er sich ernähren. Er habe früher unter Pyrosis gelitten, aber jetzt habe er keine Pyrosis. Die Fragen nach ähnlichen vorherigen Beschwerden, Fieber, Nachtschweiß, Meläna, Nausea und Emesis wurden verneint. Bis auf morgendliche Tussis ist die vegetative Anamnese unauffällig.

VE: DM, aHT, Gicht keine Op

Med: Janumet 50/850mg 1-0-1, Beloc-Zok ?mg 1-0-0

keine Reise

A-P: Was habe ich? Soll ich hier bleiben? Kann ich jetzt 2 Flaschen Bier am Kiosk holen?

A-A: VD? DD? Risikofaktoren (Zigaretten und Fleischkonsum)? Wichtigste Untersuchung(ÖGD)?

Therapie?

Chirurgische Therapie? Welches Typ von Karzinom (Plattenepithelkarzinom)? Wenn es inoperabel ist (Palliative Therapie, Chemo-Radiotherapie)? Keine Aufklärung

Herr Mühe Franz

53 Jahr alt 11.12.1971

179 cm groß 49kg schwer

Der Patient stellte sich in unsere Notaufnahme wegen seit 4 Wochen bestehender, progredienter und retrosternaler Schmerzen ohne Ausstrahlung vor. Er berichtete, dass die Beschwerde langsam aufgetreten seien und sich im Verlauf verschlechtert hätten. Zusätzlich teilte er mit, dass die Schmerzen 3-4 von 10 auf der Schmerzskala betragen würden. Die Schmerzen seien nahrungsabhängig und beim Essen, besonders beim festen Essen schlimmer geworden seien und mit Dysphagie begleitet. Des Weiteren klagte er über Gewichtsverlust von ca. 12 kg innerhalb 3 Monaten. Die Fragen nach Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß, Defekation und Miktion wurden von dem Pt verneint. Die vegetative Anamnese sei bis auf Inappetenz und morgendlicher, trockener Husten unauffällig.

Vorerkrankungen : TVT vor 10 Jahren. Er sei einmal TVT mit Lungenembolie im Krankenhaus aufgenommen und medikamentös behandelt worden. Er sei nie operiert worden.

Keine Allergien seien bei ihm bekannt.

Der Impfstatus sei komplett.

Noxen: Er rauche 30 Z/T seit 20 Jahren (30 PY) trinke 3-5 flaschen Bier und 1-2 Gläser Snaps täglich seit langem. Drogen wurden verneint.

Familienanamnese: Vater leide an aHT. Die Mutter habe an Apoplex gelitten und sei die rechten Arm ein bisschen gelehmt. Er habe einen Bruder gehabt und er sei an Pankreaskarzinom gestorben.

Fragen von Prüfern.

1. Welche Verdacht Diagnose haben Sie?
2. DD
3. Diagnostische Maßnahmen?
4. Therapeutische Maßnahmen?
5. ÖGD dem Pt aufklären und versuchen den Patienten zu beruhigen?

Definition

Bösartiger Tumor der Speiseröhre

Ursachen/Risikofaktoren

- ✓ langjähriger Genuss von hochprozentigem Alkohol in Kombination mit Rauchen
- ✓ Aflatoxine (Pilzgifte)
- ✓ Eisen- und Vitaminmangel, Plummer-Vinson-Syndrom
- ✓ Schleimhautveränderungen: Achalasie, Sklerodermie, Laugenverätzung, Barrett-Ösophagus

Klinik

- ✓ Dysphagie
- ✓ retrosternale und epigastrische Schmerzen
- ✓ Übelkeit, Appetitlosigkeit und Gewichtsabnahme

Diagnostik

- ✓ Endoskopie mit Biopsie
- ✓ Röntgen-Ösophagusbreischluck
- ✓ Endosonografie: Ausdehnung
- ✓ Bronchioskopie: Bronchialsystem betroffen?
- ✓ Thorax-CT: Metastasen, Invasion von Nachbarstrukturen?
- ✓ Röntgen Thorax, Sonografie, Skelettszintigrafie

Therapeutische Maßnahmen

- ✓ Tumorresektion
- ✓ Strahlentherapie bei inoperablen Plattenepithelkarzinomen
- ✓ Chemotherapie
- ✓ photodynamische Therapie: endoskopische Laserapplikation nach Gabe einer photosensibilisierenden Substanz

Spezielle Fragen bei Verdacht auf Ösophaguskarzinom und zur Differentialdiagnostik

- Haben Sie Schluckbeschwerden?
- Treten diese Beschwerden nur bei fester oder auch bei flüssiger Nahrung auf?
- Haben Sie häufiger Sodbrennen oder müssen Sie sauer aufstoßen?
- Können Sie die Schluckbeschwerden lokalisieren? Spüren Sie diese im Halsbereich oder hinter dem Brustbein?
- Haben Sie Husten? Tritt dieser vor allem im Liegen auf?

Definition

Beim **Ösophaguskarzinom** handelt es sich um einen bösartigen Tumor(Krebs) in der Speiseröhre (Ösophagus).

Einleitung

Man unterteilt Ösophaguskarzinome pathohistologisch in:

- Plattenepithelkarzinome (esophageal squamous-cell carcinoma, ESCC)
- Adenokarzinome (esophageal adenocarcinoma, EAC)
- undifferenzierte Karzinome (selten)

Aufgrund ihrer Lokalisation nehmen Adenokarzinome des ösophagogastralen Übergangs (AEG) dabei eine Sonderrolle ein.

Ätiologie

Was genau das Karzinom verursacht, ist nicht bekannt. Eine erhöhte Inzidenz ist bei Nikotinabusus, Alkoholabusus, sowie bei vermehrter Aufnahme von Nitrosaminen oder Aflatoxinen (Gift aus Schimmelpilzen) erwiesen.

Ein Ösophaguskarzinom entwickelt sich in der Regel aus einer Präkanzerose. Dazu gehören u.a.:

- Barrett-Ösophagus
- Achalasie
- Sklerodermie

- Verätzungen
- Plummer-Vinson-Syndrom

- **Symptomatik**

Zunächst hat der Patient unspezifische Dysphagie (Schluckbeschwerden beim Essen) und/oder Pseudohypersalivation (Probleme mit dem Schlucken von Speichel). Meist kommt es zu einem Gewichtsverlust. Mögliche weitere Symptome sind zudem retrosternale Schmerzen zervikale Lymphadenopathie, selten Nervenlähmungen (z.B. Nervus laryngeus recurrens)

Diagnostik

Zur Diagnostik des Ösophaguskarzinoms und ggf. Bestimmung des Tumorstagings gehören u. a.:

- Endoskopie (mit Biopsie des entsprechenden Gewebes)
- Röntgen-Kontrastmittel-Untersuchung (Ösophagus-Breischluck)
- Ultraschalluntersuchung
- Computertomographie ggf. MRT
- Tumormarker (SCC, CEA, CA19-9) zur Verlaufskontrolle
- Skelettszintigraphie und PET-CT zum Ausschluss von Fernmetastasen
- evtl. Bronchoskopie und Mediastinoskopie

Therapie

- Endoskopische Resektion der Mukosa bei Frühkarzinomen
- Ösophagektomie (mit Lymphadenektomie) und Magenhochzug
- neoadjuvante Radiochemotherapie (Bestrahlung und Chemotherapie z.B. nach dem FLOT-Schema)
- falls proximal lokalisiert ggf. Pharyngektomie und/oder Laryngektomie

Palliativ kommen Radiochemotherapie (Cisplatin, 5-Fluorouracil) und die Implantation eines Stents oder Tubus infrage.

Komplikationen

Mögliche Komplikationen eines Ösophaguskarzinoms sind:

- Stenosierung
- Ösophagitis
- Ösophagotracheale Fistel

Cholelithiasis/ Cholezystitis (Gallenblasenentzündung)

1-persönliche Daten: Frau Anna Müller, 41 Jahre, Größe:169 cm, Gewicht:68 kg.

2-Allergien: Keine

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: Nichtraucherin

Alkohol: ein Glas Wein gelegentlich.

Keine Drogen.

Sport: Walking 2mal / Woche - Fahrrad fahren

4- Sozialanamnese: Familienstand: verheiratet, zwei Kinder.

Arbeit: Lehrerin, Hausfrau, Maschinenschlosser, Büroangestellte

5- Familienanamnese:

-Vater: an Hepatozellulärem Karzinom (HCC, Leberkrebs) gestorben.

-Mutter: Arterielle Hypertonie (Bluthochdruck), Diabetes Mellitus DM

-Sie habe keine Geschwister.

1. Patient-Vorstellung

Frau Anna Müller ist eine 39-jährige Patientin, die sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit gestern/ drei Stunden aufgetretender, drückender, dumpfer, kolikartiger, rechtseitiger epigastrischer Schmerzen (Oberbauchschmerzen) mit Ausstrahlung in den Rücken sowie die rechte Schulter vorgestellt hat.

2-aktuelle Beschwerden:

- Die Pt berichtet, dass die Schmerzen plötzlich nach Mittagessen aufgetreten seien und sich im Verlauf der Zeit verschlechtert hätten. Zusätzlich teilt sie mit, dass die Schmerzen 7-8 von 10 auf der Skala seien und wenn sie Buscopan-Zäpfchen benutze, besser würden.
- Fettes Essen sei Auslöser der Schmerzen.
- Darüber hinaus klagt die Patienten über ähnliche Schmerzen vor (einem Monat/ 4 Tage) nach fettigem Essen, die nur teilweise verschwunden seien.

3-Begleitsymptome

Ferner sind der Pt folgende Begleitsymptome aufgefallen:

- Sie klagt über
- Nausea (Übelkeit)
- Fieber 38.5 Grad /(das nicht gemessen wurde).
- Emesis (Erbrechen) einmal

4. Vegetative Anamnese:

- Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf
 - Inappetenz (Appetitlosigkeit) wegen der Schmerzen
 - Insomnie (Schlafstörungen) wegen der Schmerzen.
 - Obstipation (Verstopfung),
- Die Fragen nach Fieber, Schüttelfrost, Diarrhö, Nachtschweiß, wurden verneint.

6- Vorerkrankungen:

1-Die Frage nach Vorerkrankungen wurde verneint.

2-An Vorerkrankungen habe sie

- Migräne
- arterielle Hypertonie (Bluthochdruck) seit 5 Jahren,
- Diskushernie (Bandscheibenvorfall)
- Hyperlipidämie (erhöhte Blutfettwerte)

Frau Müller sei niemals operiert worden/ Es wurde bei Frau Müller eine Hysterektomie (Gebärmutterentfernung) aufgrund von Blutungen vorgenommen.

7-Medikamentenanamnese:

Frau Müller nehme die folgenden Medikamente ein

- Treptane
- Ibuprofen (400-600) mg
- Enalapril 12.5/10 mg
- Captopril (1-0-0) Wasser Tabletten
- Atorvastatin /Simvastatin 20 mg (1-0-0)
- Laxativa Tropfen bei Bedarf
- Buscopan Zäpfchen

Sie fügte hinzu, dass sie aufgrund der aktuellen Beschwerden eine Tablette Ibuprofen 800 mg eingenommen habe, aber laut der Patientin habe die Tablette ihr nicht geholfen.

-Die Grundimpfungen wurden geimpft.

7. Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Cholelithiasis/ Cholezystitis hin. Als Differentialdiagnosen kommen die folgenden in Betracht:

- 1- Gallenkolik / Cholelithiasis (Stein)
- 3- Ulcus (ventriculi , duodenie)
- 4- Akute Pankreatitis
- 5- Hinterwand-Infarkt

- 6-rechte basale Pneumonie
- 7- Akute Gastritis.
- 8- Ileus
- 9- Nephrolithiasis

8 –Maßnahmen

- Als erste Maßnahme würde ich die Pt körperlich untersuchen. Murphy- Zeichen. Zur weiteren Abklärung sollten die folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

1-Laboruntersuchung (Differentialblutbild, CRP, BSG, Leberwerte: SGPT-SGOT.↑ ALP und Gamma GT-Bilirubin, Amylase und Lipase.)

Urin-Analyse

2-Röntgen-Abdomen

3-Abdominalsonographie

4-ERCP:

5-EKG

-Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:

1-Stationäre Aufnahme.

2-Nahrungskarenz.

3-Infusionstherapie.

4-Analgetikum ((bis auf Morphinum)) sowie Spasmolytikum.

5-Antibiotikum bei Entzündung (Ciprofloxacin und Metronidazol)

Konservative Therapie: ERCP -wenn ein Stein größer als 1 cm ist

-Orale Steinauflösung -wenn die Steine kleiner als 1cm sind,

Operative Therapie: (laparoskopische) Cholezystektomie, wenn es eine Cholezystitis gibt.

Mögliche Anamnesefragen:

- Wo haben die Schmerzen begonnen?
- Wo sind die Schmerzen derzeit lokalisiert?
- Seit wann haben Sie diese Schmerzen?
- Hatten Sie schon mal unter ähnliche Beschwerden gelitten?
- Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
- Haben sich die Schmerzen im Laufer der Zeit verschlechtert?
- Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10?
- Haben Sie schon etwas gegen die Schmerzen eingenommen? Falls ja: Was, wenn, in welchem Dosierung? Hat es Ihnen geholfen?
- Können Sie die Schmerzen aushalten oder brauchen Sie dringend einen Schmerzmittel?
- Ist bei Ihnen Medikamentenallergie bekannt?
- Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben?
- Treten die Schmerzen ständig oder nur gelegentlich auf?
- Sind die Schmerzen anhaltend oder wiederkehrend?
- Gibt es bestimmte Auslöser für die Beschwerden?
- Sind die Schmerzen nahrungsabhängig?
- Verspüren Sie die Schmerzen auch, wenn Sie nüchtern sind?
- Leiden Sie unter Übelkeit oder Erbrechen?
- Wie sah das Erbrochen aus?
- Leiden Sie unter Sodbrennen, Aufstoßen oder Blähungen?
- Hatten Sie Fieber, Schüttelfrost oder Nachtschweiß?
- Ist Ihnen Gelbverfärbung der Haut oder der Augen aufgefallen?/ Haben Sie Gelbsucht bemerkt?
- Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Wasserlassen oder Stuhlgang?
- Wie sah Ihr Stuhl aus? Wie ist die Konsistenz?
- Wie ist Ihr Appeti?
- Haben Sie ungewollt ab oder zugenommen?

Herr Hans Müller ist ein 41 jähriger Patient der sich heute Morgen bei uns wegen seit 6 Monaten aufgetretender, intermittierender, stechender rechtseitiger OberBauchSchmerz mit Ausstrahlung in die rechte Schultter vorgestellt hat.

- Die schmerzen sein 10/10 nach dem Essen
- Der Patient berichtete über mehrere Episoden seit 6 Monaten
- Ibuprofen nicht geholfen
- Es gebe fettes Essen als Auslöser für diese Schmerzen
- BS: Pyrosis, Übelkeit, Vomitus (1 /2 Mal) manchmal Fiber (unregelmäßig)
- Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf eine Obstipation
- Als Vorerkrankungen leide er an arteriellen Hypertonie sowie Hyperlipidämie
- In Bezug auf die Medikation nehme er Ramipril 1.0.0 und Sinnvastatin 1.0.0 ein (die Dosierung sei unbekannt)
- Er trinke Wein 1Mal pro Woche
- Er rauche nicht, keine Allergie
- Familien Anamnese ist unauffällig
- Die anamnatische Angaben deuten am ehesten auf eine Cholezystolithiasis hin.
- Reaktionen: Was habe ich, kann ich jetzt gehen?

AA Gespräch: VD?

Labor untersuchung?

Wie können wir zwischen cholezystitis und cholezystolithiasis unterscheiden? (Fiber, schüttelfrost, Labor) endzündliche parametern

-Gibt es ein Zusammenhang zwischen Pyrosis und VD? (Nein) ,und mit Vomitus (ja). Bei Cholezystitis treten häufig Übelkeit und Vomitus auf, da die Entzündung der Gallenblase zu einer Reizung des vegetativen Nervensystems und zu Verdauungsstörungen führt.

-Therapie Wenn es auch keine stein in sonographie gibt (ich habe gesagt nur eine Oralhydratation, der Arzt hat mir gesagt nein wir müssen auch eine Op machen)

Herr Klaus Müller ist ein 41 jähriger Patient der sich heute Morgen bei uns wegen seit 6 Monaten aufgetretener, intermittierender, krampfartiger Oberbauchkoliken (Schmerzen) rechts ohne Ausstrahlung vorgestellt hat. Die schmerzen würden plötzlich aufgetreten dann eine Stunde dauern. Der Patient berichtete über ungefähr 3 Episoden wöchentlich seit 6 Monaten. Es gebe fettes Essen als Auslöser für diese Schmerzen

Die Fragen nach Ikterus, Fieber oder Ausstrahlung in den Schulter wurden verneint

Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf eine Obstipation sowie eine Schmerz bedingte Insomnie

Als Vorerkrankungen leide er an arteriellen Hypertonie sowie Hyperlipidämie

In Bezug auf die Medikation nehme er Ramipril 1.0.0 und Sinnvastatin 1.0.0 ein (die Dosierung sei unbekannt)

Er trinke Wein 1Mal pro Woche, Keine Allergie, und Familien Anamnese ist unauffällig

Die anamnatische Angaben deuten am ehesten auf eine Cholezystolithiasis hin

DD: Cholezystitis, Gastritis und Kolon irritabile

Reaktionen: Was hat Drogenkonsum mit meiner Schmerzen zu tun? Was wurden Sie machen?

AA Gespräch: Was spricht gegen cholezystitis? Könnte es Ulkus sein? Warum ? Warum haben Sie Kolon irritabile erwähnt?

-Was ist Murphy Zeichen? Wegen die Schmerzen die Einatmung abbrechen beim Abtasten des rechten Oberbauchs.

Aufklärungen: Sonographie ERCP Cholezytektomie

Der Patient hat sogar gefragt: Ist ERCP gefährlich? Bei der OP, werde ich Vollnarkose bekommen?

Wurden Sie ein Schnitt in meinem Bauch machen? Wie groß? 3 ? Warum 3 ? Wie lange soll ich denn in Krankenhaus bleiben?

Herr Mühe Franz

53 Jahr alt 11.12.1971

179 cm groß 49kg schwer

Der Patient stellte sich in unsere Notaufnahme wegen seit 4 Wochen bestehender, progredienter und retrosternaler Schmerzen ohne Ausstrahlung vor. Er berichtete, dass die Beschwerden langsam

aufgetreten seien und sich im Verlauf der Zeit verschlechtert hätten. Zusätzlich teilte er mit, dass die Schmerzen 3-4 von 10 auf der Schmerzskala betragen würden. Die Schmerzen seien nahrungsabhängig und beim Essen, besonders beim festen Essen schlimmer geworden seien und mit Dysphagie begleitet. Des Weiteren klagte er über Gewichtsverlust von ca. 12 kg innerhalb 3 Monaten. Die Fragen nach Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß, Defekation und Miktionsproblemen wurden von dem Pt verneint. Die vegetative Anamnese sei bis auf Inappetenz und morgendlicher, trockener Husten unauffällig. Vorerkrankungen: TVT vor 10 Jahren. Er sei einmal TVT mit Lungenembolie im Krankenhaus aufgenommen und medikamentös behandelt worden. Er sei nie operiert worden. Keine Allergien seien bei ihm bekannt. Der Impfstatus sei komplett. Noxen: Er rauche 30 Z/T seit 20 Jahren (30 PY), trinke 3-5 Flaschen Bier und 1-2 Gläser Snaps täglich seit langem. Drogen wurden verneint. Familienanamnese: Vater leide an aHT. Die Mutter habe an Apoplex gelitten und sei die rechte Arm ein bisschen gelehmt. Er habe einen Bruder gehabt und er sei an Pankreaskarzinom gestorben. Fragen von Prüfern.

1. Welche Verdachtsdiagnose haben Sie?
2. DD
3. Diagnostische Maßnahmen?
4. Therapeutische Maßnahmen?
5. ÖGD dem Pt aufklären und versuchen den Patienten zu beruhigen? usw.

Cholezystitis

Definition

Akute Entzündung der Gallenblase

Ursachen

✓ Komplikation der Cholelithiasis mit sekundärer bakterieller Beteiligung

Klinik

✓ Schmerzen im rechten Oberbauch ✓ Fieber ✓ Schüttelfrost ✓ Übelkeit und Erbrechen ✓ Druckschmerz ggf. mit Abwehrspannung im rechten Oberbauch

Diagnostik

✓ Sonografie: Untersuchung des Abdomens zum Nachweis von Gallensteinen

✓ Labor: GOT, GPT, Bilirubin, γ -GT, CRP und Leukozyten

Therapeutische Maßnahmen

✓ Nahrungskarenz

✓ Analgesie: z.B. nicht-spasmogene Opiate, z.B. Pethidin

✓ Antibiose i.v., z.B. Ceftriaxon

✓ operativ: Cholezystektomie nach Abklingen der Entzündung

Differentialdiagnostik

Hepatitis, Cholelithiasis, kardiopulmonale Erkrankungen, akute Pankreatitis, Porphyrie

Cholelithiasis

Definition

Als Cholelithiasis bezeichnet man Konkrement (Steine) in der Gallenblase (= Cholezystolithiasis) oder im Gallengang (Choledocholithiasis)

Ursachen

✓ Cholesterinsteine: erhöhte biliäre Cholesterinkonzentration oder verminderte biliäre Gallensäurekonzentration sowie Hypomotilität der Gallenblase

- ✓ Pigmentsteine: erhöhte Bilirubinkonzentration in der Blasengalle durch eingeschränkte Leberfunktion oder bakterielle Freisetzung von Bilirubin Risikofaktoren
- ✓ Adipositas
- ✓ höheres Lebensalter
- ✓ fettreiche Kost, strenges Fasten
- ✓ Schwangerschaft
- ✓ alkoholische Leberzirrhose
- ✓ zystische Fibrose

Klinik

- ✓ meist asymptomatisch
- ✓ rechtsseitige kolikartige Oberbauchschmerzen insbesondere bei Zystikusverschluss oder Choledochussteinpassage
- ✓ ausstrahlende Schmerzen in den Rücken und in die rechte Schulter
- ✓ unspezifische dyspeptische Beschwerden durch fette Speisen, Alkohol, Kaffee, Eier,...
- ✓ postprandiales Druchgefühl im Epigastrium
- ✓ Nausea
- ✓ Völlegefühl
- ✓ Erbrechen
- ✓ Meteorismus

Diagnostik

- ✓ Abdomensonografie
- ✓ ERCP oder MRCP bei Verdacht auf Choledocholithiasis
- ✓ PTC: bei nicht durchführbarer ERCP
- ✓ CT: vor allem vor oraler Lysetherapie oder extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL)
- ✓ Labor:
 - BSG erhöht und Leukozytose bei Cholezystitis
 - Bilirubin und aP und γ GT und Amylase zusätzlich erhöht bei Cholangitis mit Obstruktion
 - Lipase und Amylase bei erhöht bei biliärer Pankreatitis

Therapeutische Maßnahmen

- ✓ Cholezystolithiasis:
 - operativ: Cholezystektomie
 - nichtchirurgisch: orale Litholyse: Ursodeoxycholsäure und Chenodeoxycholsäure 3 bis max. 18 Monate oder ESWL
- ✓ Choledocholithiasis
 - Therapie wie bei akuter Cholezystitis oder
 - ERCP mit Papillotomie und endoskopischer Steinextraktion

Differentialdiagnostik

Hepatitis, Ulcus, Cholelithiasis, Hinterwandinfarkt, Lungenembolie, chronische Pankreatitis, Nephrolithiasis

Leberzirrhose

1-persönliche Daten: Name: Schultze, Bruno / Mark Freudenberg / Maria Freudenberg 65 Jahre alt, 180 cm groß, 86 kg schwer

2-Allergie: Keine

3- Genussmittel/ Noxen

-Nikotin: Nichtraucher/ 30 Zigaretten/Tag seit 20 Jahren

-Alkohol: Bier (5-6 Flaschen) und Schnaps jeden Tag seit 20 Jahren/ seit Volljährigkeit / 7-8 Gläser Wein täglich

-Drogen: keine -Marihuana vielmals während der Ausbildung

Sport: keiner

4- Sozialanamnese: Familienstand: geschieden, 2 gesunde Kinder, alleinlebend.

Arbeit: Straßenbauer/ Verkäuferin bei OBI, Mercedesmitarbeiter /Autoschlosser. Er habe viel Stress auf der Arbeit

5- Familienanamnese: Unauffällig/

-Vater: Demenz (Gedächtnisschwund)/ sei an Leberkrankheit verstorben

-Mutter: Hypertonie Bluthochdruck/ DM

2-aktuelle Beschwerden:

Herr Schlüter ist ein 46-jähriger Patient, der sich heute Morgen bei uns in der in der Klinik wegen seit 3 Monaten bestehender, drückender, diffuser Abdominalschmerzen- mittlerer Oberbauchschmerzen ohne Ausstrahlung, mit Abgeschlagenheit und Unruhegefühl vorgestellt hat. Der Pt. berichtet, dass die Schmerzen langsam aufgetreten seien und sich stetig verschlechtert, aber im Laufe des Tages ein bisschen verbessert hätten. Zusätzlich teilt er mit, dass die Schmerzen 5 von 10 auf der Skala seien. Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint. Er war bei Hausarzt wegen dieser Beschwerden, aber ohne Erfolg.

3-Begleitsymptome

Ferner sind dem Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

-Er klagt über Dyspnö beim Treppensteigen seit 3 Monaten

-Nausea (Übelkeit)

-Flatulenz (Blähungen)

-Aszites (Wasserbauch) seit 5 Monaten

-Herzrasen- Tremor (Zittern) sowie Konzentrationsstörungen

-Emesis (Erbrechen) einmal

-Beinkribbeln

-Des weiteren klagt der Pt. über Gewichtszunahme von ca 5 kg innerhalb 3 Monaten. Die Fragen nach Ikterus, Ödemen, Nykturie, Hautveränderungen (insb.Verminderung Bauchbehaarung), Dyspnoe, Husten und vorheriger Bluttransfusion wurden verneint.

4. Vegetative Anamnese: -Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf

-unregelmässigen Stuhlgang, Stuhlveränderung/ Diarrhö seit 4-5 Monaten

-Schweißausbruch Nachtschweiß

-Inappetenz (Appetitlosigkeit), trockenen Husten

5-Vorerkrankungen:

-Es seien keine relevanten Vorerkrankungen bekannt.

-An Vorerkrankungen habe er

-erhöhte Leberwerte

-eine Lebererkrankung / unklare Pankreaserkrankung vor vielen Jahren, die stationär behandelt wurde

-akute Hepatitis mit Ikterus vor 15 Jahren.

-Der Pt sei vor 15 Jahren wegen Unterschenkelfraktur/Armfraktur operiert worden.

Der Impfstatus sei unbekannt.

6-Medikamentenanamnese:

Der Pt nehme die folgenden Medikamente ein:

-Omeprazol 30 mg regelmäßig

-Aspirin /Ibuprofen bei Bedarf

7- Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Leberzirrhose hin.
Als Differentialdiagnosen kommen in Betracht:

1. Virale Hepatitis: durch Virusnachweis im Blut.
2. Leberkarzinom (HCC): bei Verdacht ist Leberbiopsie wegweisend.
3. Hypothyreose: hier ist Messung von T3, T4, TSH durchzuführen.
4. Magenkarzinom: bei Verdacht ist ÖGD empfohlen
5. Reizdarmsyndrom: Ausschlussdiagnose

8 –Maßnahmen

- Als erste Maßnahme würde ich den Pt körperlich untersuchen. (Aszites, Spider nevi, Gynäkomastie, Schrumpfleber)
 - Zur weiteren Abklärung sollten die folgende Maßnahmen durchgeführt werden:
 - Leberblutparameter: Erhöht: AST, ALT, AP, Gamma-GT, LDH Erniedrigt: Bilirubin, Albumin, Natrium, Kalium, Vit-K abhängige Gerinnungsfaktoren, Cholinesteraz. INR: verlängert
 - Sonographie des Abdomens.
- Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor:
1. Diätmaßnahmen: Reduktion von Flüssigkeits- und Alkoholzufuhr
 2. Diuretika: Spironolactone
 3. Vermeidung von lebertoxischen Medikamenten
 4. ÖGD: um die Ösophagusvarizen zu beurteilen und ggf. zu behandeln.
 - 5-Lebertransplantation

Mögliche Fragen:

- Was führt Sie zu uns?
- Seit wann haben Sie x?
- Haben die Beschwerden plötzlich oder eher langsam angefangen?
- Gibt es einen bestimmten Auslöser für die Beschwerden?
- Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
- Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10?
- Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben?
- Sind die Schmerzen anhalten oder wiederkehrend?
- Verspüren Sie ein Druck- oder Völlegefühl im Oberbauch?
- Leiden Sie unter Blähungen, Übelkeit oder Erbrechen?
- Haben Sie Probleme mit dem Wasserlassen oder Stuhlgang?
- Hat sich Ihr Bauchumfang verändert?
- Leiden Sie unter Beinschwellungen?
- Haben Sie irgendwelche Hautveränderungen am Bauch oder Rumpf bemerkt?
- Leiden Sie unter Juckreiz?
- Sieht Ihr Haut blass oder gelblich aus?
- Bekommen Sie öfters spontan blaue Flecke oder Einblutungen?
- Leiden Sie unter Nasenbluten?
- Wie sehen Ihre Fingernägel aus?
- Ist Ihnen Haarausfall am Bauch an der Brust aufgefallen?
- Hat sich Ihre Brustgröße verändert?
- Fühlen Sie sich müde oder erschöpft?
- Haben Sie Herzrasen?
- Wie ist Ihre Appetit?
- Haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab- oder zugenommen?
- Leiden Sie unter Herzrasen, Atemnot, Husten?

Therapie:

- Alkoholkarenz
- Eiweißreich Ernährung (bis zu akuter hepatischer Enzephalopathie)
- Impfungen: gegen Hepatit A und B, Influenza, Pneumokokken

- Vermeidung hepatotoxischer Medikamente (NSRA, Paracetamol) !!! Keine NSAR bei Aszites: Gefahr akuter Nierenverschlechterung !!!
- Nicht-selektive Betablocker (NSBB): Propranolol oder Carvedilol reduzieren den portalen Druck durch Senkung des Herzzeitvolumens
- Diuretika: Spironolakton (Behandlung von Aszites)
- Cefotaxim (Behandlung von spontan bakterielle Peritonitis)
- Vazopressin-Analoga: Terlipressin (Behandlung von Varizenblutung)
- Lebertransplantation: die einzige kurative Therapie.

Komplikationen:

- Aszites mit spontan bakterieller Peritonitis (SBP): Fieber, diffuse Bauchschmerzen
- Varizenblutungen: z.B. mit Hämatemesis und hypovolämischem Schock. Eine Ösophagusvarizenblutung hat eine Letalität von bis zu 30 %.
- Hepatische Enzephalopathie: mit neuropsychiatrischen Symptome bis hin zum Coma hepaticum
- Hepatorenales Syndrom mit funktionellen Nierenversagen

MELD-Score: wird zur Einstufung der Schwere von Lebererkrankungen verwendet.

Eingehende Parameter:

- Gesamt Bilirubin (mg/dl)
- INR (international normalized ratio)
- Serumkreatinin (mg/dl)

Child-Pugh-Klassifikation: Einschätzung der Leberfunktion und Prognose bei Leberzirrhose. Bewertete Parameter:

- Bilirubin
- Albumin
- INR
- Aszites
- Enzephalopathie

Schulze Peter, 46 J, 181 cm, 86 Kg

Pt. kommt wegen diffusen Bauchschmerzen und Bauchvergrößerung seit 3 Monaten. Er klagt über Nausea und hat 5 Kilo Gewichtszunahme.

Keine Allergie/keine Unverträglichkeit

Nikotin: Nichtraucher

Alkohol: 8 Flaschen Bier täglich + 700 ml Schnaps. (Vodka Gorbatschow)

Drogen: keine.

Familie: Eltern gesund, Einzelkind.

Sozialanamnese: Straßenbauer, Geschieden, 2 Kinder (kein Kontakt) Vegetative Anamnese:

Gewichtszunahme, Insomnie

VE: unklare Lebererkrankung schon bekannt. Z.n Unterschenkelsfraktur rechts mit 15 J.

Medikamente: Paracetamol 500 mg bB

AAG: Patientenvorstellung: nur wichtige Informationen VD und DD? KU - auskultation, percussion, palpation.

Labor - BB, Leberwerte, Koagulation parameters Ultraschall- was kann man sehen? Elastographie.

Aufklärung - Magenspiegelung, Diagnose und Therapie

Therapie- Alkoholkarenz Transösophageale sclerosierung der Ösophagialen Venen und Parazentese Leber Transplantation

Schulze Peter, 46 J, 1,90m, 86Kg Hausarzt: Dr Müller

Er kommt wegen diffusen Bauchschmerzen und Bauchvergrößerung seit 3 Monaten. Er klagt über Völlegefühl, Nausea und Diarrhöe. Keine Allergie/keine Unverträglichkeit. Nikotin: hat 10 PY geraucht, Alkohol: 8 Flaschen Bier täglich seit 20 J. Und 3/4 von Schnaps. Drogen:0 Familie: Eltern gesund, Einzelkind

Sozialanamnese: Straßenbauer Geschieden seit 10 J., 2 gesunde Kinder

Vegetative Anamnese: Gewichtszunahme, Inappetenz, Insomnie

VE: unklare Lebererkrankung schon bekannt. Z.n Unterschenkelsfraktur vor 15 J. Medikament: nur Paracetamol 500 mg bB

AAG: Patientenvorstellung, welche VD und DD? Aufklärung für eine Magenspiegelung, Wie diagnostiziert man eine Aszites? Welche Laborparameter bestimmt man bei einer Leberzirrhose? Was ist eine Varize?

Anamnese: Der Patient hat seit 3 Monaten Krampfadern im Bauchbereich, die dem Nabel entspringen. Er beschreibt sie ähnlich wie die Krampfadern im Bein seiner Mutter. Er sagt, er hat in letzter Zeit 4 Kilogramm zugenommen. Er kann nicht schlafen wegen dieses Drucks im Bauch.

Begleitsymptome: Übelkeit.

Meine Fragen waren über:

Hautveränderungen: Ja, rote sowie Sonnenzeichen (Gefäßspinnen).

Juckreiz: Ja.

Herzrasen: Nein.

Raucher, Alkoholiker und die restlichen Informationen sowie das Protokoll.

AA Gespräch:

Was hat der Patient?

Was hat der Patient gesagt?

Verdachtsdiagnose?

Was sollen wir durchführen, um Aszites festzustellen?

KU (Perkussion).

Differenzialdiagnose?

Was machen wir jetzt? (KU, LU, Sono.)

Wie erklärt sich der Juckreiz?(Bilirubin bewirkt den Juckreiz)

Was ist im Labor wichtig?

Wie sind die Werte? (Hoch)

Und im fortgeschrittenen Stadium? (Normal)

Die Therapie?

Was für Diuretika?

Wie wirkt Spironolacton? (Kaliumsparendes Medikament)

akute Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsentyphus)

1- persönliche Daten: Frau Ina Franke/Kerle- Marko

Alter: 40 Jahre, Gewicht: 80 kg, Größe: 1,79 m

2-Allergie: Keine / Pollenallergie (Heuschnupfen) sei bei ihm bekannt.

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: ca. 2 Schachteln /Tag seit 20 Jahren (40 P/Y)

Alkohol: 5 Flaschen Bier täglich seit mehr als 10 Jahren.

Keine Drogen.

Sport: keiner / Fahrrad fahren

4- Sozialanamnese:

Familienstand: Verheiratet - 2 gesunde Kinder

-Er lebt mit seiner Frau und den Kindern zusammen

Arbeit: (Laborant/ Maschinenschlosser)

5- Familienanamnese:

-Vater:

-Mutter:

- Der Bruder: Leberzirrhose- mit Aszites (Bauchwassersucht)
- Die Eltern und Kinder seien gesund

aktuelle Beschwerden:

Frau Franke ist eine 40-jährige Pt., die sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit gestern Mittag /gestern Abend bestehender, drückender, dauerhafter, progredienter, gürtelförmiger epigastrischer Schmerzen (Bauchschmerzen) mit Ausstrahlung in den Rücken sowie in die Flanken vorgestellt hat. Die Pt. berichtet, dass die Schmerzen plötzlich ca. 30 Minuten nach dem Mittagessen aufgetreten seien und sich im Verlauf verschlechtert hätten. Zusätzlich teilt sie mit, dass die Schmerzen 8-10 von 10 auf der Skala seien und nach Einnahme von Ibuprofen 800mg besser geworden seien. Die Schmerzen seien nahrungsabhängig und bei fettigem Essen schlimmer geworden. Darüber hinaus klagte die Patientin über ähnliche Schmerzen vor 4 Tagen, die nur teilweise gelindert seien.

Begleitsymptome: Ferner sind der Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen: Sie klagt über

- Nausea (Übelkeit)
- Meteorismus/ Flatulenz (Blähungen)
- Emesis einmal heute Morgen (gelbes, schleimiges Erbrechen)

Vegetative Anamnese: Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf

- Inappetenz (Appetitlosigkeit),
- Insomnie (Schlafstörung) wegen der Schmerzen
- Fieber (nicht gemessen)
- Schweißausbrüche, Nachtschweiß
- Des weiteren klagt die Pt. über (Gewichtsverlust/-zunahme) von ca. 1 kg /innerhalb 4 Tagen

Vorerkrankungen: Die Vorgeschichte war unauffällig.

An Vorerkrankungen leide sie an

- Arterieller Hypertonie (Bluthochdruck)
- Migräne
- Hypercholesterinämie (erhöhten Blutfettwerten)
- Diskushernie (Bandscheibenvorfall)
- Die Patientin habe als Kind Windpocken und Mumps gehabt. Zudem sei sie gegen diese Krankheit geimpft.
- Es wurde bei der Pt. eine Hysterektomie vor 4 Jahren/ Appendektomie (mit 12 J.)/ Inguinalhernie (mit 4 J.) durchgeführt.

Medikamentenanamnese:

Die Fragen nach Vorerkrankungen, O.P sowie Medikationen wurden verneint.

Die Patientin nehme folgende Medikamente regelmäßig ein:

- 2 Medikamente gegen Hypertonie
- eines gegen Migräne, Name nicht bekannt.

Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf akute Pankreatitis hin.

Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

- 1-Magenulkus
- 2-Cholezystitis
- 3-Nephrolithiosis.
- 4-Appendizitis.
- 5-Myokardinfarkt.

Maßnahmen:

-Als erste Maßnahme würde ich die Pt. körperlich untersuchen:

Messung der Vitalzeichen, Schocksymptome, Aszites, Ikterus

-Zur weiteren Abklärung sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden:

- 1-Laboruntersuchung: Blutbild, CRP, BSG, Lipase, Amylase, Elastase, ALP (alkalische Phosphatase), Gamma GT, Bilirubin
- 2- Röntgenologie: Abdominalsonographie, Röntgen Abdomen, CT-Abdomen: "SENSITIVE UNTERSUCHUNG " Röntgen-Thorax
- 3-EKG :

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor:

- 1-Stationäre Aufnahme (Intensivstation)
- 2- Infusionstherapie
- 3- Ausreichende Flüssigkeitszufuhr.
- 4- Analgetikum (Mitamizol bis auf Morphin).
- 5- Kalzium-Substitution.
- 6-Antibiotikum wie Metronidazol + Ciprofloxacin.
- 7-Thromboseprophylaxe wie Heparin + Kompressionstrümpfe.
- 8-Wenn die Ursache ein Gallenblasenstein ist, nehmen wir am Patienten ERCP vor.

Mögliche Anamnesefragen:

- Seit wann haben Sie die Schmerzen?
- Wo genau sind die Schmerzen lokalisiert?
- Sind die Schmerzen plötzlich oder eher langsam aufgetreten?
- Haben sich die Schmerzen im Laufe der Zeit verschlechtert?
- Gibt es etwas, dass die Schmerzen lindern oder verschlimmern?
- Gibt es einen bestimmten Auslöser für die Schmerzen?
- Haben Sie diese Schmerzen nach fettreichen Mahlzeiten?
- Wie stark sind die Schmerzen auf eine Skala von 0 bis 10?
- Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben?
- Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
- Sind die Schmerzen anhaltend oder wiederkehrend?
- Hatten Sie schon einmal ähnliche Beschwerden?
- Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen?
- Verspüren Sie eine Besserung nach dem Erbrechen?
- Haben oder hatten Sie Fieber?
- Haben Sie bemerkt, dass Ihre Haut oder Ihre Augen gelblich sind?
- Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Wasserlassen oder Stuhlgang?
- Leiden Sie unter Durchfall oder Verstopfung?
- Haben Sie Veränderungen im Stuhl bemerkt?

Karl Franke, 39J , epigastrische Schmerzen mit Ausstrahlung in den Unterbauch sowie in die Flanken

BS: Diarrhoe (2Mal, flüssig)

VA: Inappetenz

Reaktionen: Was habe ich? Was werden Sie für mich machen? Sollte ich hier bleiben?

AA Gespräch: Nur aktuelle Beschwerden, dann sofort zur Fragen: Welche Verdachtsdiagnose haben Sie?

Differentialdiagnosen? Riskofaktoren? Maßnahmen und Therapie?

Was müssen wir auf Therapie des pankreatitis achten?

Klinik

Die Patienten klagen über relativ plötzlich einsetzende, starke Ober- und Mittelbauchschmerzen, begleitet von Übelkeit und Erbrechen. In 90 % der Fälle strahlen die Schmerzen gürtelförmig in den Rücken aus. Weitere Symptome sind Erbrechen (80 %), Meteorismus, Fieber (60%) und Schockzeichen.

Eine akute Pankreatitis beginnt in der Regel mit einem heftigen epigastrischen Dauerschmerz, der oft gürtelförmig in den Rücken ausstrahlt. Typisch ist ein prall-elastisches Abdomen ("Gummibauch"). Weitere Symptome sind:

- Übelkeit und Erbrechen
- Blähungen
- Darmlähmungen bis hin zum paralytischen Ileus
- Schocksymptome (Tachykardie, Hypotonie)

- Fieber
- Aszites
- Ikterus

Grünlich-braune Hautveränderungen an den Flanken (Grey-Turner-Zeichen), um den Nabel (Cullen-Zeichen) oder in der Leiste (Fox-Zeichen) sind Hinweise auf einen schweren Krankheitsverlauf.

Labordiagnostisch kommt es zu einem Anstieg der Pankreasenzyme im Blut (Lipase, Amylase, Elastase) und Urin (Amylase). In 50 bis 70% der Fälle ist die akute Pankreatitis mit einer vorübergehenden Hyperglykämie assoziiert.

Gleichzeitige Therapie:

- Zugang einlegen, Flüssigkeitszufuhr (um hypovolämie zu vermeiden)
- Vital parameter messen
- Monitisieren
- Schmerzmittel verabreichen (bis zum opioid)
- Blut abnehmen: Lipase, Amylase, CRP, BB, Elektrolyte, Leberwerte
- Abdomen Sonographie (Gallensteine?)
- Essen verboten

Appendizitis

1- persönliche Daten:

Name: Max Müller: Alter: 37 Jahre, Gewicht: 69 kg, Größe: 1,68 m

2-Allergie: keine

3- Genussmittel/ Noxen

-Nikotin: Nichtraucher

-Alkohol: gelegentlich ein Glas Wein

-Drogen: keine

-Sport: Spaziergehen, Radfahren

4- Sozialanamnese:

Familienstand: die Pt. sei verheiratet und habe 2 gesunde Kinder (Sie sei alleinerziehend)

Arbeit: Versicherungsagent/ Angestellte im Büro

5- Familienanamnese:

-Der Vater: Myokardinfarkt (Herzinfarkt)

-Die Mutter gesund /Apoplex (Schlaganfall)

-Die 3 Kinder seien gesund

-Die Schwester leide an Mamakarzinom (Brustkrebs).

2-aktuelle Beschwerden:

Frau Müller ist eine 37-jährige Patientin, die sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit gestern Abend aufgetretender, bestehender, stechender, krampfartiger, rechtsseitiger Abdominalschmerzen (Unterbauchschmerzen) ohne Ausstrahlung vorgestellt hat. Die Pt. berichtet, dass die Schmerzen plötzlich nach dem Abendessen periumbilikal (im Mittelbauch) begonnen hätten und dann an den rechtseitigen

Unterbauch gewandert seien. Zusätzlich teilt sie mit, dass die Schmerzen 6-7 von 10 auf der Skala seien und sich im Laufe der Zeit verschlechtert hätten. Die Schmerzen seien lageabhängig und beim Liegen schlimmer und beim Bücken besser geworden. Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint.

3-Begleitsymptome Ferner sind der Pt folgende Begleitsymptome aufgefallen:

-Sie klagt über Nausea (Übelkeit)

-Emesis (Erbrechen) einmal.

-Fieber seit gestern Abend (nicht gemessen)

Die Fragen nach gynäkologischen, Defäkations- oder Miktions-Problemen, Nachtschweiß, Gewichtsveränderungen sowie nach Aufnahme von ungewöhnlichen Lebensmitteln wurden von der Pt verneint.

4. Vegetative Anamnese:

-Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf

- Inappetenz (Appetitlosigkeit)

- Insomnie (Schlafstörungen) wegen der heftigen Schmerzen.

5-Vorerkrankungen:

Es seien keine relevanten Vorerkrankungen bei ihr bekannt.

An Vorerkrankungen leide sie an

-arterieller Hypertonie

-Hypothyreose

-chronischer Bronchitis

-Es wurde bei der Pt. eine Cholezystektomie (Gallenblasenentfernung) vor 5 Jahren sowie eine Tonsillektomie (Mandelentfernung) vor 10 Jahren und eine rechtsseitige Inguinalhernien (Leistenhernien) operation durchgeführt.

6-Medikamentenanamnese:

- Frau Müller nehme derzeit keine Medikamente ein.

Die Patientin nimmt Pantoprazol bei Bedarf ein.

7. Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Appendizitis hin. Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

-Gastrointestinale DD: 1)Pankreatitis 2)Cholecystitis 3)Darmperforation 4)Morbus Crohn

5)Divertikulitis 6)Kolonkarzinom 7)Gastroenteritis.

-Urologische DD: 8)Nephrolithiasis.

-Gynäkologische DD: 9)Extrauterin gravidität 10)Endometriose

8-Maßnahmen

Als erste Maßnahme würde ich die Pt körperlich untersuchen. Zur weiteren Abklärung sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden:

1-Laboruntersuchung (Differentialblutbild, CRP, BSG, Lipase, Amylase, Urinuntersuchung)

2- Abdomensonographie 3-Ggf. CT-Abdomen: bei unklaren Befunden.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:

1- Stationäre Aufnahme

2- Nahrungskarenz.

3- Infusionstherapie.

4- Darmentleerung.

5- Bei positiven Befunden (d.h. Appendizitis) Laparoskopische Operation (Appendektomie).

6-Bei Perforation des Appendix oder Peritonitis sollte eine offene Operation durchgeführt werden.

Mögliche Anamnesefragen:

- Wo genau sind Ihre Schmerzen lokalisiert?
- Wo haben die Schmerzen begonnen?
- Wann haben die Schmerzen aufgetreten?
- Gibt es einen bestimmten Auslöser für die Schmerzen?
- Sind die Schmerzen plötzlich oder eher langsam aufgetreten?

- Haben sich die Schmerzen im Laufe der Zeit verschlechtert?
- Sind die Schmerzen anhaltend oder wiederkehrend?
- Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
- Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10?
- Haben Sie schon etwas eingenommen?
- Könnte Sie die Schmerzen anhalten oder brauchen Sie dringend ein Schmerzmittel?
- Ist bei Ihnen Medikamentenallergie bekannt?
- Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt?
- Sind die Schmerzen lage- oder bewegungsabhängig?
- Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben?
- Hatten Sie früher schon einmal ähnliche Beschwerden?
- Haben Sie Probleme mit Stuhlgang?
- Könnte es sein, dass Sie schwanger sind?
- Ist Ihr Blinddarm schon entfernt worden?

Hans Müller, 41 J., 1,69 m, ca. 80 kg

verheiratet, zwei gesunde Kinder, Büroangestellter

Impfstatus: vollständig

Reise: Spanien im August

Med: Pantoprazol (Dosis unbekannt) b.B., Ibuprofen b.B. (gegen Rückenschmerzen)

Keine Allergien oder Unverträglichkeiten

Vater: a. Hypertonie, an einem MI verstorben

Rauchen: Rauchstopp vor 15 Jahren (zuvor nur gelegentlich geraucht)

Alkohol: ein Glas Wein 1-2 Mal pro Woche

Drogen: verneint

Der Pt stellte sich heute wegen seit gestern Abend plötzlich aufgetretender, stechender Schmerzen im rechten UB ohne Ausstrahlung vor. Aktuell sei die Schmerzintensität 7-8 von 10 auf der NRS. Dem Patienten zufolge seien sie bei Flexion des Oberkörpers besser und im Flachliegen schlimmer geworden. Begleitend klagte er über Schüttelfrost, erhöhte Temperatur (nicht gemessen), Nachtschweiß, Inappetenz und Nausea. Verneint wurden die Fragen nach Emesis und Diarrhoe. Im AA Gespräch: Keine vollständige Vorstellung, sondern ein Dialog, wie es bereits viele Kolleg*innen beschrieben haben.

Erzählen Sie, wen Sie gesehen haben?

Welche Beschwerden hat er?

Welche Verdachtsdiagnose haben Sie? Warum? Differenzialdiagnosen?

Wie gehen Sie vor, um Ihren Verdacht zu bestätigen?

Welche Laborwerte möchten Sie anfordern?

Welche Informationen liefert ein Blutbild? (Leukozyten-, Erythrozyten- und Thrombozytenzahl)

Würden Sie den Urin untersuchen? Warum?

Falls die Entzündungsparameter nicht erhöht sind, was könnte ein Grund sein? (lokalisierte Entzündung)

Was würden Sie noch tun? Was kann man in Sonografie sehen?

Welche Therapie schlagen Sie vor?

den Patienten über eine laparoskopische Appendektomie aufklären (Stichwort: Schlüssellochoperation)

Fragen des Patienten:

Kann es sein, dass ich eine Blinddarmentzündung habe? Was werden Sie später mit mir machen?

Was ist ein CT?

Die Patientin stellte sich heute bei uns wegen seit gestern Morgen bestehender, plötzlich aufgetretender, drückender, ziehender, postprandialer Abdominalgie in der Regio Inguinalis re. ohne Ausstrahlung vor. Sie berichtet, dass diese Schmerzen von Regio periumbilicalis in die Regio Inguinalis re. gewandert seien. Des

Weiteren, fügte die Patientin hinzu, die Schmerzintensität liege bei 5-6 von 10 einer Schmerzskala. Die Fragen nach Nausea, Vomitus, Pyrexie, Nachtschweiß und Schüttelfrost wurden verneint. Die Patientin habe 1 Tablette von Ibuprofen 400mg ohne Verbesserung eingenommen und

Wärmflasche wegen Schmerzen benutzt. Die Patientin konnte letzte Nacht nicht auf der rechten Seite schlafen.

In Bezug auf **vegetative Anamnese** leide sie an schmerzbedingter Insomnie, Inappetenz, Obstipation (1Mal/2 Tagen, Stuhl sei hart, ohne Blut) und produktiver Tussis mit schleimigem Sputum.

Bezüglich der **Vorerkrankungen** leide sie an aHT (seit 10J.) und Hypothyreose (seit 10J.). Sie wurde wegen Tonsillektomie (als Teenager), Cholezystitis (vor 10J) und Salpingektomie li. (vor 6-7J) ohne Komplikationen operiert worden. Sie sei vollständig geimpft, auch gegen Covid-19 (4-mal).

Sie nehme regelmäßig Ramipril 10 mg (1-0-0), L-Thyroxin 100 µg (1-0-0) und orales Kontrazeptivum ein.

Die **Allergien** und Unverträglichkeiten wurden verneint.

Sie rauche 40 Zig/Tag seit mehr als 20J. (ca. 40PY). Sie trinke gelegentlich 1Fl. Bier oder Wein. Der Drogenkonsum wurde verneint.

Sein Vater sei gesund. Seine Mutter habe Apoplex erlitten (leide jetzt an rechtzeitiger Parese und Dysarthrie).

Die Schwester habe an Mammakarzinom gelitten (Z.n. Operation, Chemotherapie).

Sie sei verheiratet, habe 2 gesunde Kinder. Sie sei Hausfrau.

A-A Gespräch:

Welche Diagnose, Untersuchungen, DD, Behandlung.

Könnte die Patientin schwanger sein?

Könnte es Möglichkeit von Extrauterin gravidität bestehen?

Was können wir bei Sonografie des Abdomens schauen?

Wichtig ist es bei Frauen gynäkologische Untersuchung, Schwangerschaftstest (Beta-Humanes Choriogonadotropin) und transvaginale Sonografie durchzuführen.

Definition

Entzündung des Appendix vermiformis. Volkstümlich fälschlicherweise als „Blinddarmentzündung“ bezeichnet. Häufigste Ursache des akuten Abdomens.

Ursachen

✓ nicht bekannt

Klinik

✓ periumbilikale oder epigastrische Schmerzen, die in den rechten Unterbauch ausstrahlende Schmerzen

✓ Appetitlosigkeit ✓ Übelkeit, Erbrechen ✓ leichtes Fieber

Diagnostik

✓ typische Schmerzzeichen McBurney, Lanz, Rovsing und Blumberg

✓ Labor: Leukozytose sowie CRP und BSG erhöht

✓ Differenz der Körpertemperatur zwischen axillärer und rektaler Messung $\geq 1^\circ\text{C}$

✓ Sonografie

✓ ggf. CT

Therapeutische Maßnahmen

✓ Appendektomie

Differentialdiagnostik

✓ Perforation von Magen/Duodenum, Darm oder Gallenblase,

Gallenkolik, Harnleiter-/ Nierenkolik, Ileus, eingeklemmte

Bauchwandhernie, Divertikulitis, akuter Schub eines Morbus Crohn(s), Lungenembolie, Hinterwandinfarkt

Spezielle Fragen bei V.a. Appendizitis und zur Differentialdiagnostik

- Strahlen die Schmerzen aus oder sind sie nur an dieser einen Stelle?

• Haben Sie Schmerzen beim Wasserlassen oder häufigen Harndrang? Haben Sie Blut im Urin bemerkt? => V.a.

Nephro-/Urolithiasis

• Wandern die Schmerzen auch an andere Stellen? => s.o.

• Könnte es sein, dass sie schwanger sind? => V.a.

Extrauterin gravidität

• Ist Ihr Blinddarm schon entfernt worden?

• Weitere Fragen zum Stuhlgang (Konsistenz, Frequenz, Farbe

Gastroenteritis

1-Persönliche Daten:

Name: Max Müller /Reiner Müller Alter: 55 Jahre, Gewicht: 68 kg, Größe: 1,78m

2-Allergie: gegen Penicillin

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: Nichtraucher

Alkohol: 2 Gläser Bier am Wochenende

Drogen: Keine

Sport: Keiner

4- Sozialanamnese

Familienstand: verheiratet, wohne in Karlsruhe mit seiner Familie.

2 gesunde Kinder

Arbeit: Schreiner

5- Familienanamnese: In der Familienanamnese fanden sich:

-Vater: Myokardinfarkt (Herzinfarkt), Bronchialkarzinom (Lungenkrebs)

-Die Mutter sei an Kolonkarzinom (Darmkrebs) gestorben

Die Kinder: gesund

2-aktuelle Beschwerden

Herr Reiner Müller ist ein 55-jähriger Pt., der sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit 2 Wochen bestehender, diffuser, krampfartiger, Abdominalschmerzen/ umbilikaler Schmerzen ohne Ausstrahlung vorgestellt hat. Der Pt. berichtet, dass die Schmerzen plötzlich aufgetreten seien und sich im Verlauf verschlechtert hätten. Zusätzlich teilt er mit, dass die Schmerzen 5-7 von 10 auf der Skala seien. Die Schmerzen seien nahrungsabhängig und sind beim Essen schlimmer geworden. Die Fragen nach ähnlichen vorherigen Schmerzen wurde verneint.

3-Begleitsymptome Ferner sind dem Pt folgende Begleitsymptome aufgefallen:

-Er klagt über wässrige Diarrhoe (Durchfall)

-Erhöhte Temperatur

-Nausea (Übelkeit)

-Emesis (gelbes Erbrechen)

-Des weiteren klagt der Pt. über Gewichtsverlust von ca. 2 kg innerhalb 2 Wochen.

4. Vegetative Anamnese: Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf

-Inappetenz (Appetitlosigkeit)

-Die Frage nach Fieber, Nachtschweiß wurde verneint

5-Medikamentenanamnese:

-Der Pt. nehme zurzeit keine Medikamente ein.

-Herrnehme die folgenden Medikamente regelmäßig ein:

-B-Blocker 1-0-1

-Imodium gegen Diarrhoe

Der Impfstatus ist unbekannt.

6- Vorerkrankungen:

An Vorerkrankungen leide er an:

- Prostatahyperplasie (gutartige Vergrößerung der Vorsteherdrüse)

-Arterielle Hypertonie (Bluthochdruck)

-unklare Rhythmusstörung

-Zystitis (Harnblasenentzündung) vor einem halben Jahr

- Der Pt. sei mit 13 J wegen Unterarmfraktur (Unterarmbruch) operiert worden.

7. Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Gastroenteritis hin.

Als Differentialdiagnosen kommen die folgenden in Betracht:

-Chronische Darmerkrankungen(Colitis Ulcerosa und Morbus Crohn)

- Kolonkarzinom (Darmkrebs!!!)

-Divertikulitis

-Reizdarmsyndrom

8 –Maßnahmen

Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen. Zur weiteren Abklärung sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden:

1-Laboruntersuchung:Blutbild, CRP,BSG,...Elektrolyte, Stuhlkultur, Urinstatus und Hämokult-Test

2- Abdominalsonographie

3- Kolonoskopie

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor:

1-Rehydration: Viel trinken (Tee) und Orale Rehydratationslösungen (ORL)

2- Leichtes Essen

3- Antibiotika beim Nachweis von Erregern (wie Salmonella typhi, Vibrio cholerae)

Vorbeugen: 1-Gute Hygiene halten. 2-Impfungen gegen Rotaviren und Reisekrankheit wie Cholera.

Fragen:

- Sind die Schmerzen langsam oder plötzlich angefangen?
- Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 schmerzfrei und 10 stärkste Schmerz ist?
- Können Sie die Schmerzen anhalten oder brauchen Sie sofort etwas dagegen?
- Haben Sie schon Medikamente gegen Ihre Schmerzen eingenommen? Falls ja: Hat es Ihnen geholfen?
- Sind die Schmerzen dauerhaft da oder gehen Sie auch wieder weg?
- Könnten Sie die Schmerzen beschreiben? Sind sie eher dumpf, stechend, brennend, kolikartig, krampfartig?
- Strahlen die Schmerzen in anderen Körperteilen aus?
- Haben sich die Schmerzen im Laufe der Zeit verschlechtert?
- Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen?
- Haben Sie etwas Ungewöhnliches oder Verdorbenes gegessen?
- Könnte es sein, dass Sie in der letzte Zeit rohe Lebensmittel gegessen haben?
- Sind die Symptome Nahrungabhängig?
- Hatten Sie solche Symptome schon einmal?
- Hat jemand aus Ihrem Umfeld ähnliche Symptome?
- Sind Sie in der letzten Zeit vereist?Haben Sie dort etwas Ungewöhnliches ausprobiert?
- Seit wann leiden Sie unter Durchfall?
- Haben Sie Blut oder Schleim im Stuhl bemerkt?
- Sind Ihnen übel und haben Sie erbrochen? Falls ja: Wie sah das Erbrochene aus? Haben Sie Blut bemerkt?
- Haben Sie Schluckbeschwerden?
- Haben Sie Sodbrennen?
- Hat sich Ihre Appetit verändert?
- Haben Sie ungewöhnlich Gewicht verloren?

Definition

Entzündung der Schleimhaut von Magen und Darm, die meistens infektiös bedingt ist.

Ursachen

- ✓ Viren: Rotaviren, Noroviren, Astroviren, Adenoviren u.a.
- ✓ Bakterien: Salmonellen, Campylobacter, Shigellen, Escherichia coli, Clostridium difficile
- ✓ Parasiten: Giardia, Cryptosporidium
- ✓ verdorbene Lebensmittel
- ✓ Medikamente, chemische Giftstoffe

Klinik

- ✓ Anorexie (=Inappetenz)
 - ✓ Übelkeit, Erbrechen
 - ✓ Diarrhoe, mit und ohne Blut/ Schleim
 - ✓ Bauchkrämpfe
 - ✓ evtl. Fieber und Muskelschmerzen
 - ✓ ausgeprägtes Krankheitsgefühl
 - ✓ auffällige Darmgeräusche (Borborygmen)=>
 - ✓ differentialdiagnostisches Kriterium zum paralytischen Ileus
 - ✓ Hypotonie, Tachykardie und Flüssigkeitsmangel durch dauerhaftes Erbrechen
 - ✓ Kreislaufkollaps mit Schock und oligurisches Nierenversagen in schweren Fällen
- Die Beschwerden treten meistens plötzlich auf und enden in der Regel mit einer Spontanremission innerhalb von 24 Stunden

Diagnostik

- ✓ Anamnese
- ✓ Messung der Vitalzeichen
- ✓ Abdominale Untersuchung
- ✓ Labor:
 - Blutbild
 - Elektrolyte
 - Stuhluntersuchung
- **Therapeutische Maßnahmen**

- ✓ orale oder intravenöse Rehydration
- ✓ Nahrungskarenz oder leicht verdauliche Kost
- ✓ Antidiarrhoische Medikamente z.B. Loperamid
 - nicht bei E. coli oder Clostridium difficile
 - nicht bei Kindern > 2 Jahre
- ✓ bei starkem Erbrechen z.B. Promethazin, Ondansetron, Prochlorperazin
- ✓ Antibiotika nur in Ausnahmefällen wie z.B.
 - bei Frühgeborenen

- im ersten Drittel der Schwangerschaft
- bei bekannter Immunschwäche
- bei blutigen Durchfällen
- Nachweis von *Vibrio Cholerae*: Ciprofloxacin, Doxycyclin

Differentialdiagnostik

Appendizitis, Cholezystitis, CED akuter Schub, "Reisedurchfall"

Spezielle Fragen bei V.a. Gastroenteritis und zur Differentialdiagnostik

- Haben Sie Fieber? => alle weiteren Fragen zum Fieber stellen
- Haben Sie etwas Ungewöhnliches gegessen?
- Hatten Sie diese Symptome schon einmal?
- Waren Sie in der letzten Zeit verreist? Wo waren Sie? Wie lange sind Sie schon zurück?
- Haben andere Personen aus Ihrem direkten Umfeld ähnliche Symptome?
- siehe auch Fragen zur Appendizitis, Pankreatitis, CED, Ulcus ventriculi und duodeni

Laktoseintoleranz

1-Persönliche Daten:

Name: Marina Nowak/Novalk Alter: 29 Jahre, Gewicht: 150 kg, Größe: 1,70 m.

2-Allergie: Keine Allergien bekannt/ Pollenallergie (Heuschnupfen) sei bei ihr bekannt.

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: Nichtraucherin.

Alkohol: ein Glas Wein gelegentlich / 2 Gläser Rotwein täglich.

Keine Drogen.

Sport: Marathon.

4-Sozialanamnese:

Familienstand: verheiratet, 3 gesunde Kinder. Sie lebe mit ihrem Mann und ihren Kindern.

Arbeit: Steuerberaterin - Teilzeitarbeit im Büro sowie Hausfrau (stressiger Zustand)

5-Familienanamnese: Unauffällig/

Der Vater: Bronchialkarzinom (Lungenkrebs), er sei daran mit 50 Jahren gestorben.

Die Mutter: arterielle Hypertonie (Bluthochdruck)

Kinder: gesund

Aktuelle Beschwerden:

Frau Nowak ist eine 29-jährige Patientin, die sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit 5 Jahren bestehender, diffuser, kolikartiger (krampfartiger) Abdominalschmerzen (Bauchschmerzen) mit wässriger Diarrhö (Durchfall) (5-6 Mal pro Tag) vorgestellt hat. Die Pt. berichtet, dass die Schmerzen langsam/plötzlich nach Aufnahme von Milchprodukten aufgetreten seien und sich im Verlauf der Zeit verbessert/verschlechtert hätten. Zusätzlich teilt sie mit, dass die Schmerzen 6 von 10 auf der Skala seien. Es gebe Milchkonsum als Auslöser der Schmerzen. Die Patientin habe so ähnliche Beschwerden vor drei Jahren gehabt, deswegen sei sie beim Hausarzt gewesen, aber nicht behandelt worden. Die Pt. wurde vom Hausarzt zur Abklärung der Beschwerden überwiesen.

Begleitsymptome

Ferner sind der Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

Sie klagt über -Meteorismus/ Flatulenz (Blähungen)

-Müdigkeit

-Des weiteren klagt die Pt. über Gewichtsverlust von ca...kg /innerhalb ...Wochen.
Die Frage nach Meläna (Teerstuhl), gynäkologischen oder Miktionsproblemen (Schwierigkeiten beim Wasserlassen) wurden von der Patientin verneint

Vegetative Anamnese:

-Die vegetative Anamnese sei unauffällig

Vorerkrankungen:

-Es seien keine relevanten Vorerkrankungen bekannt.

Die Pt. sei einmal aufgrund einer Dehydratation durch Diarrhö stationär behandelt worden.

-Die Pt. sei als Kind wegen Appendizitis (Blinddarmentzündung) operiert worden.

5- Medikamentenanamnese:

-Die Pt. nehme zurzeit keine Medikamente ein.

Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Laktoseintoleranz hin.

Als Differentialdiagnosen kommen die folgenden in Betracht:

CED (Morbus Crohn, CU)

Gastroenteritis, Zöliakie

Reizdarmsyndrom

Maßnahmen

- Zunächst sollte die Patientin körperlich untersucht werden:

- Inspektion - Palpation - Perkussion - Auskultation.

Zur weiteren Abklärung sollten folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

1- Laboruntersuchung: Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte

2- Sonografie des Abdomens

3- H2-Laktose-Atemtest

4- Laktose-Toleranztest

Falls die Diagnose gesichert ist, würde ich der Patientin empfehlen,

1- Milchprodukte zu vermeiden oder laktosearme Milch zu trinken.

2-Vor dem Verzehr von Milchprodukten sollte die Patientin laktasehaltige Tabletten einnehmen.

Mögliche Fragen:

- Wann tritt der Bauchschmerzen auf?
- Gibt es einen bestimmten Auslöser für die Beschwerden? Vielleicht ein Nahrungsmittel?
- Sind die Beschwerden plötzlich oder eher langsam angefangen?
- Leiden sie am ersten mal unter diese Beschwerden?
- Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10?
- Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben?
- Wie schnell nach dem Essen von Milchprodukten treten die Beschwerden auf?
- Wie lange halten die Beschwerden an?
- Hängt der Bauchschmerz von der Menge der Milchprodukte?
- Treten die Beschwerden auch bei anderen Lebensmitteln auf?
- Bekommen Sie diese Beschwerden auch beim Verzicht auf Milchprodukte?
- Haben Sie schon laktosefreie Produkte versucht zu konsumieren? Haben Sie es vertragen?
- Gab es Phasen, in denen Sie völlig beschwerdefrei waren?
- Hatten Sie ähnliche Beschwerden in der Vergangenheit?
- Wurde bei Ihnen schon eine Darmspiegelung durchgeführt?
- Leiden Sie unter Durchfall oder Verstopfung?
- Wie sieht Ihr Stuhl aus? Welche Konsistenz und Farbe hat er?
- Tritt der Durchfall nach dem Verzehr von Milchprodukten auf?
- Leiden Sie unter Blähungen?
- Wie ist Ihr Appetit?
- Haben Sie in der letzten Zeit ungewollt ab- oder zugenommen?
- Leiden Sie unter Übelkeit oder Erbrechen?
- Fühlen Sie sich müde oder erschöpft?
- Fühlen Sie sich niedergeschlagen oder traurig?
- Schlafen Sie gut?

- Beeinflussen die Beschwerden Ihren Alltag oder Ihre Lebensqualität?

H2 Atem Test Aufklärung: Durchführung: Der Atemtest wird nach einer Nahrungskarenz von 12 Stunden am nüchternen Patienten durchgeführt. Zunächst wird der Basalwert abgenommen. Der Patient trinkt anschließend Testlösungen, die 50 g Laktose oder Fruktose in 400 ml Wasser enthalten. Sollen verschiedene Intoleranzen getestet werden, wird der Test an 2 verschiedenen Tagen durchgeführt. Nach dem Trinken der Testlösung wird in Intervallen von 15 oder 30 Minuten über ca. 2-3 Stunden das expiratorische Atemgas auf Wasserstoff untersucht. Aus der Höhe des Wasserstoffgehaltes lässt sich eine evtl. Störung der Zuckerverdauung ablesen.

Name: Herr Peter Novak

Alter: 29 J. Gewicht: 66 kg Größe: 1,79 m

Noxen Nichtraucher; Trinkt gelegentlich Wein

Familienanamnese Vater: mit 50. Lebensjahr an Magenkarzinom gestorben, Mutter: gesund, Tochter: Neurodermitis

Sozialanamnese: Verheiratet; Drei Kinder

Beschwerden: Der Patient klagte über Blähungen und Durchfall (wässrig, dünn) Seit ein paar Jahren, Die mit Milchverzierung verbunden. Die Beschwerden sind mit diffusen kolikartigen Bauchschmerzen verbunden. Die Schmerzintensität gab der Patient mit 5/10 auf der Schmerzskala.

Vegetative Anamnese: unauffällig

Vorerkrankungen: keine Bekannte Erkrankungen

Medikamente: er nimmt keine Medikamente

Operationen: Appendektomie mit 12 J. + Unterschenkelfraktur (konservativ behandelt) mit 18 J.

Arzt-Arzt Gespräch

Der Arzt hat mir die folgenden Fragen gestellt:

Diagnostische Maßnahmen? Therapie? DD? Wie können Wir die DD ausschließen? Der Patient hat die Beschwerden seit Jahren, warum hat er sich jetzt gestellt? Der Patient ist untergewichtig, woran das liegen kann?

Definition

Es handelt sich um eine Unverträglichkeit gegen Milchzucker (Laktose) aufgrund eines Enzymmangels.

Ätiologie

Ursache der Laktoseintoleranz ist ein erworbener oder angeborener Mangel des Enzyms Laktase (Beta-Galactosidase), das auf dem Bürstensaum der Enterozyten des Dünndarmes exprimiert wird. Die Laktoseintoleranz ist daher eine Form der Maldigestion.

Durch den Enzymmangel kann das Disaccharid Laktose nicht in seine Bestandteile, die Monosaccharide Glukose und Galaktose, aufgespalten werden. Laktose selbst wird nicht resorbiert und gelangt dann bis in den Dickdarm, wo ortsständige Bakterien die Laktose abbauen. Als Gärungsprodukte entstehen meist kurz nach der Laktoseaufnahme Laktat sowie CO₂ (Kohlendioxid), CH₄ (Methan) und H₂ (Wasserstoff).

Primäre Laktoseintoleranz: ist genetisch bedingt und führt nach Laktasemangel durch.

Bei der **sekundären Form** der Laktoseintoleranz führen gastrointestinale Erkrankungen wie z.B.:

- Sprue
- Morbus Crohn des Dünndarms
- Rotavirus-Gastroenteritis

zu Schädigungen der Bürstensaumepithelien und damit zu einem Mangel an Laktase.

Symptome

Nach dem Verzehr von laktosehaltigen Nahrungsmitteln kann es zu folgenden Symptomen kommen:

- Bauchschmerzen (teilweise kolikartig)
- Völlegefühl
- Nausea
- Erbrechen
- Flatulenz
- Diarrhoe

Bei der adulten Laktoseintoleranz setzt diese Symptomatik erst langsam nach dem Abstillen ein.

Diagnostik

Wegweisend für die Diagnose ist die genaue Anamnese. Ein Ernährungstagebuch kann hierbei sehr hilfreich sein. Gesichert werden kann die Diagnose mittels des Laktosetoleranztests oder mit dem H₂-Atemtest.

Laktosetoleranztest Durchführung:

1. Laktosegabe: *Erwachsene* erhalten 50 g Laktose in 400 ml Wasser oder Tee per os, *Kinder* 2 g Laktose/kg KG (max. 100 g) per os.
2. Bestimmung der Nüchtern-Glucose
3. Weitere Blutentnahmen nach 30, 60, 90 und 120 Min. zur Glucose-Bestimmung

Therapie

Die Therapie ist nur durch eine entsprechende Diät (laktosearme sogar laktosefreie Diät) möglich.

Das Enzym Laktase (Beta-Galactosidase) steht z.B. als Tabletten zur Einnahme zur Verfügung. Hierbei stimmt der Patient seine individuelle Dosis an Laktaseeinheiten nach dem Laktosegehalt der Nahrungsmittel ab.

Karzinoid (neuroendokriner Tumor(NET))

1-Persönliche Daten:

Name: Müller/Katharina Huber, Alter: 45 Jahre, Gewicht: 65 kg, Größe: 169 cm

2-Allergie: Keine

3- Genussmittel/ Noxen: Nikotin: Nichtraucherin, kein Alkohol, keine Drogen.

Sport: gelegentlich

4- Sozialanamnese: Familienstand: verheiratet, ein gesundes Kind

Sie lebe mit ihrer Familie.

Arbei: Hausfrau/ Immobilienmaklerin

5- Familienanamnese:

Die Familienanamnese sei unauffällig.

Schwester: Mammakarzinom (Brustkrebs)

Die Eltern und der Sohn seien gesund

2-aktuelle Beschwerden:

Frau Katharina Huber ist eine 45-jährige Pt., die sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit 2 Wochen bestehender, anfallsartiger, dumpfer, diffuser, kolikartiger erstmaliger, Abdominalschmerzen (Unterbauchschmerzen) mit Ausstrahlung in den ganzen Bauch vorgestellt hat. Die Pt. berichtet, dass die Schmerzen langsam/plötzlich aufgetreten seien und sich im Verlauf

verbessert/verschlechtert hätten. Zusätzlich teilt sie mit, dass die Schmerzen 5-7 von 10 auf der Skala seien. Die Schmerzen seien nahrungsabhängig und beim Essen schlimmer/besser geworden. Es gebe keine Auslöser /..... als Auslöser der Schmerzen.

3-Begleitsymptome: Ferner sind der Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen: Sie klagt über

- wässrige Diarrhoe (Durchfall) 1-2mal pro Tag
- Tachykardie (Herzrasen)
- Flush (Gesichtsrötung)
- Hitzegefühl
- Während des Anfalls habe die Patientin ihren Blutdruck einmal gemessen und er war 180/110 mm Hg.
- Des weiteren klagt die Pt. über einen Gewichtsverlust von ca. 5 kg innerhalb 2 Monaten.

4- Vegetative Anamnese:

- Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf
- Insomnie (Durchschlafstörung).

Die Fragen nach Meläna, Fieber, Schüttelfrost, Schweißausbrüchen, Brustschmerzen, Luftnot wurden verneint.

5-Vorerkrankungen:

- Es seien keine relevanten Vorerkrankungen bekannt.

An Vorerkrankungen leide sie an

- arterieller Hypertonie (vom HA noch nicht medikamentös eingestellt)

Die Pt. habe als Kind an Pertussis (Keuchhusten)/ allen üblichen Kinderkrankheiten gelitten.

Der Impfstatus sei komplett

- Außerdem erwähnte der Pt einen Auslandsaufenthalt in (.....) vor Monaten.

6-Medikamentenanamnese:

- Die Pt. nehme zurzeit keine Medikamente ein.
- Die Patientin nimmt die Pille seit 25 Jahren regelmäßig ein

7- Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ein Karzinoid hin. Als Differentialdiagnosen kommen die folgenden in Betracht:

- Morbus Crohn,
- Colitis ulcerosa,
- Kolonkarzinom,
- Reizdarmsyndrom
- Hyperthyreose,
- Phäochomozytom

8-Maßnahmen

Als erste Maßnahme würde ich die Pt. körperlich untersuchen. Zur weiteren Abklärung sollten die folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- Labor: BB, Entzündungsparameter (CRP;BSG), (T3,T4,TSH), Serotonin im Serum, Elektrolyte (5-HIES) 5- Hydroxyindolessigsäure im 24-Stunden-Urin↑

Abdomen-Sonographie

Koloskopie mit Biopsien.

CT/MRT

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen schlage ich vor:

Karzinoidtumore und einzelne Metastasen werden in der Regel operativ entfernt. Bei multiplen Metastasen wird eine Chemotherapie empfohlen

- Knochenmetastasen Strahlentherapie

Pathogenese

Bei Karzinoiden handelt es sich um epitheliale, hormonaktive, neuroendokrine Neoplasien, die vasoaktive Substanzen produzieren und in den Blutkreislauf sezernieren. Zu den häufig produzierten Substanzen zählen Kallikrein, Serotonin, Histamin und Bradykinin.

Tumorklassifikation

Karzinoiden sind überwiegend im Gastrointestinaltrakt, insbesondere in der Appendix(45%), im Ileum(28%) und im Rektum(16%) lokalisiert (extraintestinal meist im Bronchialbaum). Eine Metastasierung erfolgt häufig in die Leber.

Symptomatik

Durch die schnelle Sekretion inadäquat hoher Mengen vasoaktiver Substanzen entsteht ein Symptomkomplex, bestehend aus:

- Flush durch Vasodilatation (Rötung des Gesichts, Hitzewallung, Herzjagen und Schwitzen)
- wässrige Diarrhöen mit kolikartigen Bauchschmerzen
- kardiale Symptomatik (Trikuspidalklappeninsuffizienz und/oder Pulmonalklappenstenose)
- Bronchospasmus, Asthmaanfall
- Teleangiectasien
- Pellagra-ähnliche Dermatosen durch Tryptophanverbrauch[1]

Die meisten Symptome treten in der Regel erst bei Metastasierung in die Leber auf. Solange keine Lebermetastasen vorhanden sind, wird Serotonin durch Monoaminoxidasen der Leber abgebaut.

Diagnostik

Bei Verdacht auf ein Karzinoidsyndrom sollten durch Laboruntersuchungen die erhöhten vasoaktiven Hormone nachgewiesen werden. Getestet werden unter anderem:

- 5-Hydroxyindolessigsäure(5-HIES) im Sammelurin
- Serotonin im Blut

Eine Lokalisationsdiagnostik erfolgt mit bildgebenden Verfahren (u.a. Sonographie, CT) und endoskopischen Verfahren (u.a. Koloskopie, Gastroskopie).

Therapie

Im besten Fall erfolgt die komplette chirurgische Resektion des Karzinoids mit Primärtumor und regionären Lymphknoten.

Konservativ kann bei Inoperabilität oder zur symptomatischen Linderung bis zum OP-Termin die Sekretion des Karzinoids durch das Somatostatin-Analogon (Octreotid) gesenkt werden. Die Serotonin-bedingte Diarrhö reagiert auf Telotristat. Eine Reduktion der Tumormasse kann mit Chemotherapien und antiproliferativ wirksamen Substanzen (u.a. Interferon) angestrebt werden.

Divertikulitis

1-persönliche Daten:

Name: Franz Müller / Wehmher Maria, Alter: 65 Jahre,
Gewicht: 78 kg, Größe: 175 cm

2-Allergie: Keine Allergien bekannt/ Milchprodukte/ Kupferallergie

3-Genussmittel/ Noxen

Nikotin: Nichtraucher

Alkohol: kein/ regelmäßig ein Viertel Wein jeden Abend seit 20 Jahren

Drogen: Keine

Sport: ab und zu Fahrrad Fahren

4-Sozialanamnese:

Familienstand: verheiratet, wohne mit seiner Frau - 2 gesunde Kinder
Arbeit: Autoverkäufer/ Rente seit 3 Monaten, vorher Lehrer
(er habe relativ viel Stress bei der Arbeit)

5-Familienanamnese:

- Vater: Bronchialkarzinom (Lungenkrebs) Apoplex (Schlaganfall) gestorben
- Mutter: Kolonkarzinom/ DM
- Kinder gesund
- Keine Geschwister

1- Patient-Vorstellung

Herr Franz Müller ist ein 46-jähriger Patient, der sich heute Morgen bei uns wegen seit 2 Wochen/ 3 Tagen aufgetretender/ bestehender, diffuser, linksseitiger Abdominalschmerzen (Unterbauchschmerzen) ohne Ausstrahlung vorgestellt hat.

2-Aktuelle Beschwerden:

Der Pt. berichtet, dass die Schmerzen plötzlich aufgetreten seien und sich im Verlauf verschlechtert hätten. Zusätzlich teilt er mit, dass die Schmerzen 4-7 von 10 auf der Skala seien, beim fettigen Essen schlimmer und beim Sitzen besser würden. Darüber hinaus klagt der Patient über ähnliche Beschwerden vor 4 Wochen.

3-Begleitsymptome

Ferner sind dem Pt folgende Begleitsymptome aufgefallen: Er klagt über

- Flatulenz (Blähung)
- Fieber
- abwechselnde Diarrhö (Durchfall) und Obstipation (Verstopfung) seit 2 Jahren

4. Vegetative Anamnese:

- Die Vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf
- Insomnie (Durchschlafstörungen),
- Inappetenz (Appetitlosigkeit)
- Pyrosis (Sodbrennen) nach dem Essen
- Nykturie (nächtliches Wasserlassen)

5. Vorerkrankungen:

An Vorerkrankungen leide er an

- Arterieller Hypertonie (Bluthochdruck)
- BPH benigner Prostatahyperplasie (gutartiger Vergrößerung der Vorsteherdrüse)
- Herzrhythmusstörung
- rezidivierender Zystitis (Blasenentzündung)
- Hypercholesterinämie (erhöhte Blutfettwerte)
- Coxarthrose links (Hüftgelenksarthrose)
- es wurde beim Pt. eine Cholezystektomie vor 20 Jahren durchgeführt.

Impfstatus: komplett, keine Reise.

6. Medikamentenanamnese:

-Der Pt. nehme zurzeit keine Medikamente ein.
Herr Müller nehme die folgenden Medikamente ein:
B-Blocker 1.0.1
Prostagutt 1.0.0
Antibiotikum gegen FSME
Baldrian zur Nacht.
-Atrovastatin 20mg 0-0-1
-Voltaren 100mg bei Bedarf
Er fügte hinzu, dass er aufgrund der aktuellen Beschwerden eine Tablette Paracetamol eingenommen habe, die Tablette hätte ihm nicht geholfen.

7. Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Divertikulitis. hin. Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

1-Kolonkarzinom.

2. Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (Morbus Crohn, CU)

3. Reizdarmsyndrom.

4. Appendizitis

5. Karzinoide

8. Maßnahmen

- Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen. Zur weiteren Abklärung sollten die folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

1- Laboruntersuchung (BB, CRP, BSG)

2- Abdominalsonographie: Darmwandverdickung.

3- CT-Abdominal

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:

1- Nahrungskarenz Nur parenterale Ernährung.

2- Analgetikum.

3- Antibiotikum.

4- Spasmolytikum.

5- Operation: Wir müssen operieren, wenn es Komplikationen oder ein Rezidiv gibt.

Mögliche Fragen:

- Wo sind die Schmerzen genau lokalisiert?
- Wie stark sind die Schmerzen auf eine Skala von 0 bis 10?
- Haben sie schon etwas dagegen eingenommen?
- Brauchen Sie dringend ein Schmerzmittel? Wenn ja: Den Patienten sofort behandeln: Zugang einlegen, Flüssigkeitszufuhr, Schmerzmittel verabreichen (erst nach Medikamentenallergie fragen), Vitalparameter messen, falls nötig ist Sauerstoff geben...
- Sind die Schmerzen plötzlich oder eher langsam angefangen?
- Sind die Schmerzen anhaltend oder wiederkehrend?
- Sind die Schmerzen gewandert?
- Starhlen die Schmerzen irgendwohin aus?
- Haben sich die Schmerzen im Laufe der Zeit verschlechtert?
- Sind Ihre Beschwerden zum ersten Mal aufgetreten?
- Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben? Ziehend, stechend, kolikartig, dumpf, diffus...
- Haben Sie irgendwelche Auslöser für Ihre Beschwerden bemerkt?
- Sind die Schmerzen nahrungsabhängig?
- Gibt es etwas, die die Schmerzen lindern?
- Haben Sie in der Vergangenheit oft an Darmbeschwerden gelitten?
- Haben Sie Probleme mit Wasserlassen und Stuhlgang?
- Sind Ihnen Veränderungen beim Stuhlgang aufgefallen? Haben Sie Blut beim Stuhl bemerkt? Ist Ihr Stuhl teeartig/schwarz?
- Leiden Sie unter Übelkeit oder Erbrechen?
- Haben Sie Blut erbrochen?
- Leiden Sie unter Blähungen oder saurem Aufstoßen?
- Leiden Sie unter Fieber oder Nachtschweiß?
- Hat sich Ihr Appetit verändert?
- Haben Sie ungewollt ab- oder zugenommen?
- Könnte es sein, dass sie schwanger sind? (V.a. Extrauterin-Gravidität?)
- Gibt es in Ihrer Familie Magen-Darm-Erkrankungen?

Herr Klaus Maier 57 J, seit 1 Woche bestehende linksseitige Schmerzen im Unterbauch mit Ausstrahlung in das linke Bein. Die Schmerzen seien pochend/bohend und dauerhaft im Verlauf. Hätten eine Intensität von 7/10. Keine Rötung/Ödem auf der betroffenen Stelle. Ich habe nach einer Beule gefragt ob es sich um eine Hernie handelt und er hat gesagt ja, ich glaube schon.. und wenn ich drauf drücke tut es mehr weh. Danach hab ich gefragt ob die Beule gehts nach innen und bleibt da oder kommt es raus wieder nach Ausüben des Drucks und hier hat der P gesagt okay es gibt keine Beule um mich nicht mehr zu verwirren und gelächelt.

Fieber betrug 38.5.

Abwechselnde Diarrhö und Obstipation.

Nachtschweiß mit nassem Schlafanzug und Haare.
Keine Gewichtsabnahme. Insomnie wegen Schmerzen.
Op: Appendektomie
VE: MI mit PTCA und Stenteinlage, arterielle Hypertonie
Rauchen mit 20 py
Regelmäßiger Alkoholkonsum von 1 Glas Rotwein am Wochenende
FA: Vater an Kolonkarzinom gestorben. (Wegen Nachtschweiß und Fieber war ich hier auch verwirrt)
Mutter: DM
Lehrer. Verheiratet. 2 Gesunde Kinder.
Dann bin ich alleine in ein anderes Zimmer für Dokumentation gegangen.
Habe ich nur 2-3 Sätze gemacht für Vorstellung. Sie haben nach Koloskopie gefragt. Wann empfehle ich?
Nach Abklingen der Beschwerden mit Antibiotikagabe. Welche? Für gram negative und anaerob aber die Name weiß ich nicht. Sehr gut, kein Problem. Das war es. Keine Aufklärung. Der Oberarzt hat gesagt, dass er am Anfang auch an eine Hernie gedacht habe. Ganze Sätze im Anamnesegeespäch benutzen, eine gute Dokumentation machen. (Ich konnte über Therapie Empfehlungen nicht schreiben weil ich kein mehr Zeit hatte, aber gar kein Problem)

Franz Wehner 67j dumpfer, druckender Unterbauch schmerzen, links, ohne Ausstrahlung. 4 bis 6 von 10. Langsam aufgetreten, seit 3 Tagen, im Verlauf verschlechtert. Nausea, meteorismus, ähnlichen vorherigen Beschwerden vor 4monaten. Fiber nicht gemessen, Schüttelfrost, schwitzen. Inappetenz, Schmerzbedingte insomnie, Chronische Obstipation, Wasserige diarrhoe seit 3 Tagen (ohne Blutspuren). Allergie: Nickel, Chrom. Nicht Raucher. 1bis 2 Gläser Wein Abends. Hypercholesterinämie, Coxarthrose, Chronische dorsalgie.
OP: cholezystectomie (zn: cholezystitis)
Vater: an apoplex gestorben, Mutter: DM.
Verkäufer, verheiratet, 2 gesunde Kinder. Stress bei der Arbeit.
Fragen: Patienten vorstellen. Was hat er über seine Obstipation erzählt? Ist er in Ruhe Phase? -warum? nimmt er Voltaren ein? was hat sein Vater? wie alt ist er? welche Vorerkrankungen hat er? welche op? Diagnose Differenzialdiagnose? warum Divertikulitis und nicht kolonkarzinom? was machen Sie bei körperliche Untersuchung (DRU + Abwehrspannung) Labor? was erwarten Sie? welche Apparat? warum keine Koloskopie?
Therapie? Welche antibiotika? bei rezidivierende Divertikulitis, was machen sie? (Elektive OP) welche op? (Partielle hemikolektomie).

Franz Müller, 65 JA, 1,75m ...
Allergien/Unverträglichkeiten: Laktose-intoleranz und Hausstaub Familienanamnese: Vater leide an DM. Habe an MI gelitten.
Aktuelle Beschwerden: Die Beschwerden seien langsam (subakut) aufgetreten. Intensität der Schmerzen war variable, 4/10 morgens und 8/10 abends.
Vegetative Anamnese: Keine Pyrexie, Pyrosis, Nykturie.
Vorerkrankungen und Voroperationen: • Keine Coxarthrose und Hyperchol. • Z.n Appendektomie statt Cholezystektomie.
Er sei in die Schweiz gereist.
Pat. Fragen: Was habe ich? Muss ich im Krankenhaus bleiben?
Arzt-Arzt Gespräch: Er lässt mich den Patienten vorstellen und fragt nach Diagnose und Therapie. Verwenden wir die Koloskopie sofort? Nicht bei akuten Anfällen.
Was würden wir auf dem Ultraschallbild sehen? Verdickung.
Wie können wir auf Komplikationen prüfen, wenn wir keine Koloskopie durchführen können? CT mit Kontrastmittel.
Welches Antibiotikum würden Sie verabreichen und warum? Ceftriaxon, die antibiotische Therapie sollte gram negative und anaerobe Erreger erfassen.

Herr Wehmer Ulrich 68 Jahre, 166cm, 68kg.

Kam zu uns mit Abdominalgie sinister, dumpf, ohne Ausstrahlung, dauerhaft, 7/10 auf der Schmerzskala, keine Auslöser, begleitet mit abwechselnd Diarrhö und Obstipation sowie Febris, andere Symptomen unauffällig.

Vegetativ anamnestisch ergab sich lediglich Parasomnie.

Bei den Vorerkrankungen ergab sich Hypercholesteronämie und Hüftgelenksarthrose links

Medikamente: Voltaren retard

Allergien gegen Chrome und Nickel

Noxen: Nichtraucher, 1 Glas Wein abends

Familienanamnese: Apoplex beim Vater und DM bei der Mutter

Sozialanamnese: Verkäufer von Beruf, viel Stress bei der Arbeit, verheiratet, habe 2 gesunde Kinder

Fragen:

Diagnose?

Untersuchungen?

Was finden wir in Ultraschall?

müssen wir sofort operieren?

-Warum gibt es abwechselnd Diarrhö und Obstipation beim Divertikulitis? Können Sie uns das erklären? Weil die Entzündung im Darm die normale Darmbewegung stört. Die Entzündung wird die Darmwand gereizt und führt sie zu unregelmäßiger Peristaltik.

-Medikamente und Therapie?

Könnte es Appendizitis sein?

Wirst du ein Koloskopie sofort durchführen? Warum nicht?

Definition

Entzündung eines oder mehrerer Divertikel und ihrer Umgebung

Divertikulose: Ausstülpung der Darmwand nach außen (meist des Colon sigmoideum)

Ursachen

✓ unklar. Eventuell durch Druckerhöhung aufgrund von chronischer Obstipation und/oder altersbedingte herabgesetzte Dehnbarkeit des Darms

✓ Risikofaktoren Divertikulose: ballaststoffarme Ernährung, schwaches Bindegewebe, Rauchen, Bewegungsmangel (Erkrankung der Industrienationen)

Klinik

✓ ziehende, teils kolikartige, je nach Lokalisation Bauchschmerzen (meist linksseitig im Unterbauch), evtl. mit Ausstrahlung in den Rücken

✓ subfebrile Temperaturen, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen

✓ Druckschmerz und Abwehrspannung

✓ verminderte Darmgeräusche

✓ Diarrhoe (manchmal mit Blut- oder Schleimbeimengungen) oder Obstipation

✓ Diagnostik

✓ Anamnese

✓ Labor:

- BSG und CRP erhöht
- Leukozytose und Linksverschiebung
- Blutkulturen abnehmen zur Erregerdiagnostik

✓ bildgebende Verfahren

- Abdomensonografie: verdickte Darmwand, Abszess, freie Flüssigkeit bei Perforation
- Röntgen-Abdomen: freie Luft bei Perforation
- Abdomen-CT oder MRT: bei diagnostischer Unsicherheit
- Endoskopie: nach Abklingen der akuten Entzündung

Therapeutische Maßnahmen

- ✓ eventuell Nahrungskarenz bei drohendem Ileus
- ✓ Analgesie (Metamizol, Opiodie), Spasmolytika
- ✓ operativ: Resektion des betroffenen Darmabschnitts

Differentialdiagnostik

CED, Kolonkarzinom, Adnexitis, Reizdarmsyndrom (Colon irritable)

Pathogenese

Eine Divertikulitis entsteht vermutlich dadurch, dass Stuhl bzw. schwer verdauliche Nahrungsreste Druckläsionen der verdünnten Divertikelwand erzeugen. Von dort aus können sich bakterielle Infektionen in das umgebende Bindegewebe ausbreiten und eine Peritonitis auslösen.

Symptome

Die klassische Symptom-Trias der Divertikulitis besteht aus:

- Abdominalschmerz (meist linker Unterbauch)
- Fieber
- Leukozytose

Als zusätzliche Symptome können Nausea, Diarrhoe oder auch Obstipation auftreten.

Diagnostik

- Klinische Untersuchung (Druckschmerzhafte "Walze" im linken Unterbauch)
- Sonografie (Suche nach wandverdickten Kolonabschnitten und freier Flüssigkeit)
- Computertomografie des Abdomens

Die Kontrastmitteldarstellung des Darms bietet deutlich weniger Informationsgewinn als die Computertomografie bei ähnlicher Strahlenbelastung und wird daher nicht mehr durchgeführt. In der akuten Phase besteht bei einer Koloskopie ein erhöhtes Perforationsrisiko.

Differentialdiagnosen

Neben urologischen und gynäkologischen Erkrankungen sollte an folgende Differentialdiagnosen gedacht werden:

- Kolonkarzinom
- Ischämische Kolitis
- Reizdarmsyndrom
- Appendizitis
- Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa)
- Idiopathische myointimale Hyperplasie mesenterialer Venen

Kolon irritable (Reizdarmsyndrom)

1-Persönliche Daten: Name: Zimmermann Thomas / Zimmermann Toni, Alter: 67 Jahre, Gewicht: 94 kg, Größe: 1,64 m

2-Allergie: Keine Allergien bekannt/ Pollenallergie (Heuschnupfen) sei bei ihm bekannt.

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: Nichtraucher, aber seit 3 Monaten raucht er 3 Zig/Tag

Alkohol: gelegentlich ein Glas Sekt.

Keine Drogen.

Sport: regelmäßig (Jogging und Fitnessstudio).

4- Sozialanamnese:

Familienstand: - verheiratet, lebe mit Ehefrau und seinen 3 Kindern, die alle gesund seien.

Arbeit: Angestellter bei einer Automobilfirma /Büroarbeiter Sozialarbeiter (habe viel Stress auf der Arbeit)

5- Familienanamnese:

-Vater: Bronchialkarzinom (Lungenkrebs)

-Mutter: Apoplex (Schlaganfall)

-Die Kinder und Geschwister seien gesund

6-Aktuelle Beschwerden:

Herr Toni Zimmermann ist ein 46-jähriger Patient, der sich heute Morgen bei uns wegen seit 6 Monaten / mehreren Jahren bestehender, kolikartiger, rezidivierender, diffuser Abdominalschmerzen (Unterbauchschmerzen) ohne Ausstrahlung vorgestellt hat. Der Pt. berichtet, dass die Schmerzen plötzlich ca. 2 Stunden nach dem Essen oder beim Stress aufgetreten seien und sich nach der Darmentleerung oder dem Rauchen verbessert hätten. Zusätzlich teilt er mit, dass die Schmerzen 5 von 10 auf der Skala seien. Die Schmerzen seien nahrungsabhängig, stressabhängig und bei Essen oder Stress schlimmer geworden. Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde vom Pt. bejaht. Er sei bei 15 anderen Ärzten gewesen, ohne eine Diagnose zu erhalten. Er fügte hinzu, dass er dagegen Buscopan-Tabletten (1-1-1) eingenommen habe, aber die Tabletten hätten ihm nicht ganz geholfen.

7-Begleitsymptome: Ferner sind dem Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

-Er klagt über: -abwechselnde Diarrhö (Durchfall) und Obstipation (Verstopfung)

-Flatulenz (Blähungen)

-Des weiteren klagt der Pt. über Gewichtsverlust von ca. 5 kg innerhalb 2 Monaten.

Die Fragen nach Meläna , Hämatochezie (frisches Blut im Stuhl), Gewichtsverlust, Nausea (Erbrechen) wurden vom Pt. verneint.

8- Vegetative Anamnese:

-Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf Insomnie (Schlafstörungen).

9-Vorerkrankungen: An Vorerkrankungen leide er an:

-Arterielle Hypertonie (Bluthochdruck)

-Harnwegsinfektion.

- Der Pt. sei vor 5 Jahren/ mit 10 Jahren wegen Appendizitis (Blinddarmentzündung) operiert worden.

Sein Impfstatus ist vollständig.

10-Medikamentenanamnese:

-Der Pt. nehme zurzeit keine Medikamente ein.

-Die Patientin nehme Ibuprofen gelegentlich ein und benutze Zäpfchen gegen Obstipation.

11-Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Kolon irritabile (Reizdarm) hin. Als Differentialdiagnosen kommen die folgenden in Betracht:

1. Laktoseintoleranz

2. Morbus Crohn

3. Colitis Ulcerosa

4. Kolonkarzinom,

5. Divertikulitis

12-Maßnahmen

Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen. Zur weiteren Abklärung sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden:

1-Laboruntersuchung: Differentialblutbild, (Leukozytose), CRP, BSG

2- Sonographie

3-Koloskopie

4-Endoskopie (ÖGD) und Colonoskopie

Falls die Diagnose gesichert ist, werden verordnet

- -Spasmolytika Butylscopolamin (z.B. Mebeverin, Buscopan)
- ggf. Psychotherapie (Gesprächstherapie, Hypnose)
- Ernährungstherapie: Vermeidung subjektiv unverträglicher Speisen
- bei starker Obstipation Gabe von Laxanzien

Fragen:

- Wann haben die Schmerzen zum ersten mal angefangen?
- Wie oft treten die Beschwerden auf? Täglich, wöchentlich?
- Wo genau sind die Bauchschmerzen?
- Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10?
- Wie würden Sie die Beschwerden beschreiben? Krampfartig, dumpf, stechend...
- Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
- Wann treten die Beschwerden? Gibt es einen bestimmten Auslöser für die Beschwerden?
- Wie lange dauert ein Anfall?
- Verstärken sich die Beschwerden in stressigen Situationen? Wenn ja: Gibt es in Ihrem Leben aktuell viel Stress, oder emotionale/berufliche Belastung?
- Gibt es bestimmte Lebensmittel, die Ihre Beschwerden verschlimmern? z.B. Milchprodukte, Brot...
- Leiden Sie unter Blähungen und Völlegefühl?
- Haben Sie Sodbrennen, Übelkeit oder Erbrechen?
- Verbessern sich die Schmerzen nach dem Stuhlgang?
- Wie oft haben Sie Stuhlgang?
- Wie sieht der Stuhl aus? (Weich, hart, blutig, schleimig)
- Leiden Sie unter das Gefühl von unvollständiger Darmentleerung?
- Haben Sie eher Durchfall, Verstopfung oder beides im Wechsel?
- Wurde schon eine Darmspiegelung oder andere Tests bei Ihnen gemacht? Wenn ja, wann?
- Wie ist Ihre Appetit?
- Haben sie in letzter ungewollt Zeit Gewicht verloren? Wenn ja: Wie viel kg und in welchem Zeitraum?
- Fühlen Sie sich oft müde oder erschöpft?
- Haben Sie jemals Antibiotika über längere Zeit eingenommen?
- Haben Sie bekannte Darmerkrankung?

Herr Klaus Müller, 53 Jahre alt, 179 cm, 80 kg stellte sich bei uns wegen seit 3 Monaten aufgetretender Abdominalschmerzen vor. Die Schmerzen hätten nirgendwohin ausstrahlt und seien maximal ein 7 auf einer Skala von 0 bis 10. Herr Müller berichtet weiter, dass die Schmerzen nach der Darmentleerung nachgelassen hätten. Im Verlauf des obigen Zeitraumes habe er Diarrhö oder Obstipation gehabt. Die Fragen zu Gewichtsveränderungen, Zusammenhang mit Lebensmitteln und Fieber wurden verneint.

Der Patient leide an folgenden Vorerkrankungen:

arterielle Hypertonie

Diabetes mellitus

Z.n. Appendektomie vor 50 Jahren.

Arzt-Arzt Gespräch

Verdachtsdiagnose

-Differenzialdiagnosen und Diagnostik der VD.

-Mögliche Laborbefunde: keine unauffälligen Befund

-Aufklärung einer Koloskopie und wie man sie durchführt

Beratung, Behandlung und allgemeine Maßnahmen.: Zur Darmspiegelung wird ein biegsamer Schlauch über den After durch den gesamten Dickdarm bis zur Mündung des Dünndarms vorgeschoben. Damit der Darm sich entfaltet, wird Luft eingeblasen. So können krankhafte Veränderungen besser erkannt werden. Bei dieser Untersuchung können bei Bedarf Gewebeproben entnommen werden. Die gesamte Untersuchung ist weitgehend schmerzfrei. Da es manchmal dennoch unangenehm sein kann, erhalten sie vorab ein Schmerz- oder Beruhigungsmittel oder eine Kurznarkose z.B. mit Propofol. Vor der Untersuchung müssen Sie eine Darmreinigung durchführen und 12-24 Stunden nüchter sein, sollten aber trinken. Sehr häufig kommt es nach der Untersuchung zu Blähungen, die aufgrund der eingeblasenen Luft entstehen. Diese verschwinden aber nach kurzer Zeit wieder. In Einzelfällen können Verletzungen der Darmwand auftreten, die eine Bauchfellentzündung zur Folge haben. Diese muss intensivmedizinisch versorgt werden. Aber machen Sie keine Sorgen, Sie sind in guten Händen.

Definition

Die Diagnose "Reizdarmsyndrom" ist im strengen Sinn eine Ausschlussdiagnose. Sie wird dann gestellt, wenn trotz sorgfältiger Untersuchung des Patienten keine organischen Ursachen für bestehende abdominelle Beschwerden gefunden werden können.

Symptome

Das Reizdarmsyndrom äußert sich durch schwer einzuordnende Beschwerden des Verdauungstrakts. Die Patienten klagen oft über krampfartige, als dumpf empfundene Bauchschmerzen. Gleichzeitig leiden sie unter Völlegefühl und Blähungen. Der Stuhlgang kann im Sinne einer Obstipation oder Diarrhoe verändert sein.

Nach Rom-IV-Kriterien liegt ein Reizdarmsyndrom vor, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

- wiederholte Bauchschmerzen assoziiert mit mindestens zwei der folgenden Kriterien:
 - Zusammenhang mit der Stuhlentleerung
 - Änderung der Stuhlfrequenz
 - Änderung der Stuhlkonsistenz
- Beginn der Beschwerden vor mehr als 6 Monaten
- Beschwerden an mindestens einem Tag pro Woche im letzten Monat

Diagnostik

- Anamnese
- Abdominelle Palpation
- Sonografie
- Endoskopie
- Labor
 - Blutbild: unauffällig
 - Entzündungsparameter: unauffällig
 - Test auf okkultes Blut im Stuhl (z.B. iFOBT): negativ
 - Calprotectin im Stuhl: negativ
 - Pankreaselastase im Stuhl: unauffällig

Differentialdiagnosen

Mögliche Ursachen, die es auszuschließen gilt, sind:

- Nahrungsmittelunverträglichkeiten
 - Laktoseintoleranz
 - Fructoseintoleranz
 - Histaminintoleranz
- Lebensmittelallergien

- Störungen der Gallenfunktion
- exokrine Pankreasinsuffizienz
- Mastzellaktivierungssyndrom

Therapie

Es gibt bisher (2026) keine gesicherte Kausaltherapie und keine etablierte symptomatische Standardtherapie des RDS. Die Erstlinientherapie sollte auf der Grundlage einer tragfähigen Arzt-Patient-Beziehung ("sprechende Medizin") auf nachhaltige Veränderungen des Lebensstils in den Bereichen Ernährung, Stressbewältigung und Selbsthilfe sowie Phytotherapie und Probiotika ausgerichtet sein. Zur Behandlung des Symptoms "Bauchschmerzen" sollen Spasmolytika, aber keine Analgetika (ASS, Paracetamol, NSAR, Metamizol) oder Opiode eingesetzt werden. Mit Amitriptylin kann man bei Erwachsenen Schmerzen und die globale Symptomatik (mit Ausnahme von Obstipation) behandeln. Besteht eine psychiatrische Komorbidität, können auch Antidepressiva vom SSRI-Typ erwogen werden.

Kolorektale Karzinom

1-Persönliche Daten: Franz Meister/ Herr Hans Müller
67 J., 67 kg schwer, 1.87m groß.

2-Allergie: Keine / Penizillin

3-Genussmittel/ Noxen

Nikotin: Nichtraucher/eine Schachtel/Tag seit 20 Jahren (20 PY)

Alkohol: 2 oder 3 Gläser Bier täglich. (Das Glas beträgt circa 500 ml.)

Keine Drogen.

Sport: keiner.

4- Sozialanamnese: Familienstand: verheiratet / ledig 2 gesunde Kinder/ eine gesunde Tochter, 30 Jahre alt. Er wohne allein.

Arbeit: Schreiner/Büroarbeiter in Ärztekammer/Pensionist, hat früher bei Mercedesgearbeitet

5- Familienanamnese:

-Vater: an Kolonkarzinom verstorben

-Mutter:

-Er habe keine Geschwister.

2-aktuelle Beschwerden:

Herr Meister ist ein 67-jähriger Pt., der sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit 2/ seit 3 Monaten bestehender, diffuser, krampfartiger Abdominalschmerzen (Unterbauchschmerzen) mit wässriger Diarrhoe vorgestellt hat. Der Pt. berichtet, dass die Schmerzen langsam aufgetreten seien und sich im Verlauf verschlechtert hätten. Zusätzlich teilt er mit, dass die Schmerzen 5 von 10 auf der Skala seien. Die Schmerzen seien nahrungsabhängig, nach dem Essen schlimmer und bei Stuhlgang besser geworden. Die Fragen nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint. Der Pt. wurde vom Hausarzt zu uns überwiesen.

3. Begleitsymptome

Ferner sind dem Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

-Er klagt über -wässrige Diarrhoe

-Meläna

-Miktionsprobleme -Polyurie (häufiges krankhaftes Wasserlassen)

-Des weiteren klagt der Pt. über Gewichtsverlust von ca. 3/8 kg in den letzten 2 Monaten.

4. Vegetative Anamnese:

-Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf

- eine leicht erhöhte Temperatur
- Inappetenz

5. Vorerkrankungen: An Vorerkrankungen leide er an

- COPD, die mit einem ihm unbekannten Spray behandelt werde
- Colon irritabile (Reizdarmsyndrom)
- Arterielle Hypertonie (Bluthochdruck) seit 5 Jahren
- Herzrhythmusstörungen
- Prostatahyperplasie (Vergrößerung der Vorsteherdrüse)
- sowie rezidivierende Zystitis (häufige Harnwegsinfekte) 5 mal im letzten Jahr.
- Es wurde bei dem Pt. eine Cholezystektomie vor 30 Jahren durchgeführt.
- Der Impfstatus ist komplett /unbekannt.

6. Medikamentenanamnese:

- Der Pt. nehme zurzeit keine Medikamente ein.
- Der Pt. nehme die folgenden Medikamente regelmäßig ein:
- B-Blocker - Metoprolol (1-0-0)
- ein Medikament gegen Prostatahyperplasie (Vergrößerung der Vorsteherdrüse)

7. Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ein kolorektales Karzinom hin. Als Differentialdiagnosen kommen die folgenden in Betracht:

- 1- Divertikulitis.
- 2- Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (Morbus Crohn, CU).
- 3- Reizdarmsyndrom.
- 4-Karzinome

8. Maßnahmen: Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen. (Digital-rektale Untersuchung!)

- 1-Laboruntersuchung (BB,CRP, BSG;HT:HB), Tumormarker CEA und CA 19-9
- 2-Vollständige Koloskopie mit Biopsie
- 3- Abdominal-Sonographie: Darmwandverdickung.
- 4-CT-Abdominal-Thorax

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor:

Chirurgische Therapie: Die Operation kann offen oder laparoskopisch durchgeführt werden. Lymphabflussgebiet mit Entfernung von > 12 Lymphknoten (totale mesokolische Exzision) angemessener Sicherheitsabstand zum gesunden Gewebe
Medikamentöse Therapie: Zytostatika - 5-Fluorouracil (5-FU)

Der Patient ist 60J, 179cm und 72kg. Er hat seit 3 Monaten bestehende, langsam auftretende diffuse Bauchschmerzen mit Verstopfung. Die Schmerzen treten mit der Verstopfung auf und nach dem Stuhlgang

werden die Schmerzen gelindert. Er hat das Essen geändert, aber es hat ihm nicht geholfen. Gegen Verstopfung hat er Abführmittel genommen. Sein Stuhl ist dünner als sonst.

Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz. Er hat 1kg abgenommen.

Er hat keine Allergien, keine Vorerkrankungen, keine Operationen.

Er raucht nicht, trinkt gelegentlich Alkohol und hat Drogen nicht probiert.

Er ist verheiratet und hat ein Sohn oder eine Tochter. Er ist Büroarbeiter. Sein Vater leidet an Kolonkarzinom und seine Mutter und Schwester sind gesund.

A-A Gespräch: Die goldstandard der Kolonkarzinom? Aufklärung der Koloskopie. Und Wie weit sollte die Koloskopie vorgeschoben werden?

Die Tumormarker? Und wenn Tumormarker nicht erhöht ist, kann man die Karzinom ausschließen?

Aufklärung: CT, Koloskopie und digital rektale Untersuchung

Herr Franz Meister. 63 J, Größe: 1.8 m, Gewicht: 67 kg. Der 63 jährige Patient stellte sich heute bei uns mit seit ca. 3 Monaten, plötzlich aufgetretender, bestehender, zunehmender Gewichtszunahme von 6-8 kg vor. Als Begleitesymptome nannte er Fatige seit 4 Wochen. Die vegetative Anamnese sei bis auf wässrige Diarrhö 12 Mal/T und seltene Obstipation unauffällig. (Menge von 1 Tase von 12 Unzen).

B-Symptomatik, Tachikardie, Thorax- und Abdominalschmerzen, kopschmerzen, Hämatokese, Meläna wurden verneint. Insomnie und Beschwerden bei der Miktion trotz Prostatahyperplasie wurden verneint.

VE: COPD seit 4 J, Prostatahyperplasie seit 2 J, Colon irritabile seit 10 J

MA: Prostagut 1-0-0

Keine Allergie und Unverträglichkeit

Z.n. Cholezytektomie

FA: Vatter sei vor 10J an Kolonkrebs verstorben, Mutter sei gesund

Noxen: 1 Packungzigarette/T seit 10 J, 1 Flasche Bier/T seit 5 Tagen. Drogen wurden verneint. Keine Sport

Keine Diät

Er sei verheiratet, habe 1 gesunde Tochter und wohne allein, er habe eine schlechte Beziehung mit seiner Ehefrau.

VDiagnose: Kolonkarzynom

DD: Hyperthyreose, Prostatakarzynom akuter Schub von Colon irritabile und chronisch entzündliche Darmerkrankung.

Definition

ist eine maligne Neoplasie des Dickdarms (Kolon) oder des Mastdarms (Rektum). Kolorektale Karzinome sind bösartige, das heißt lokal infiltrierende und potentiell metastasierende Neubildungen des Epithels.

Risikofaktoren

der Verlust von Tumorsuppressorgen (APC-Tumorsuppressorgen, DCC-Tumorsuppressorgen) und die Aktivierung von Onkogenen (K-Ras-Onkogen).

- Rauchen, Alkohol
- Adipositas
- ballaststoffarme, fettreiche Ernährung
- übermäßiger Fleischkonsum (v.a. rotes Fleisch)
- Alter über 40 Jahre
- assoziierte Krankheiten:
 - kolorektale Adenome
 - Colitis ulcerosa
 - Morbus Crohn
 - Diabetes mellitus Typ 2

Symptome

Das kolorektale Karzinom zeigt i.d.R. keine auffälligen Frühsymptome. Typische Beschwerden treten häufig erst in fortgeschrittenen Stadien auf. Neben B-Symptomen (Gewichtsverlust, Nachtschweiß, Fieber) und unspezifischen Allgemeinsymptomen (z.B. reduzierte Leistungsfähigkeit) sind Veränderungen des Stuhlgangs typisch. Dazu zählen:

- Obstipation
- rektaler Blutabgang (z.B. Hämatochezie, Meläna, okkultes Blut)
- paradoxe Diarrhoe
- ungewollter Stuhlabgang bei Flatus ("falscher Freund")

- Bleistiftstuhl

Bei Sitz des Tumors im Colon ascendens kann eine Obstipation fehlen, da der Stuhl hier noch nicht eingedickt ist und die Tumorengstelle passieren kann.

In gravierenden Fällen kann ein stenosierendes kolorektales Karzinom zu einem Ileus bzw. zu einem akuten Abdomen führen und damit einen Notfall darstellen.

Lokalisation

Am häufigsten treten kolorektale Karzinome im Bereich des Rektums (30 bis 50 %) und des Colon sigmoideum (18 bis 30 %) auf.

Diagnostik

Die Koloskopie mit Entnahme von Probebiopsien besitzt die höchste Sensitivität und Spezifität aller Untersuchungen und stellt somit den diagnostischen Goldstandard dar. Bei nicht durchführbarer Koloskopie (z.B. Verlegung des Darmlumens durch den Tumor) wird zunächst der zugängliche Darmabschnitt endoskopierte und eine virtuelle Koloskopie (CT-Kolonographie) durchgeführt. Innerhalb von 3 bis 6 Monaten nach der Operation sollte die Koloskopie nachgeholt werden. Insbesondere Tumore des tiefen Rektums, können bei digital-rektaler Untersuchung ertastet werden. Als Screening eignet sich der Stuhltest auf okkultes Blut (FOBT).

Pyelonephritis (Nierenbeckenentzündung)

1-Persönliche Daten: Name: Frau Anna Müller/ Natalie Krämer / Alter: 75 Jahre, Gewicht: 60kg, Größe: 1,58m

2-Allergie: Keine

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: 1 Schachtel/Tag seit 50 Jahren = 50 PY

Alkohol: ein Glas Wein (Rotwein) oder eine Flasche Bier täglich seit langem

Keine Drogen.

Sport: Sie gehe gerne zu Square Dance.

4- Sozialanamnese: Familienstand: Sie sei verwitwet seit 15 Jahren /geschieden und habe 5 Kinder, alle sind gesund.

Arbeit: Sie sei Rentnerin und davor habe sie als Kindergärtnerin- als Versicherungsberaterin- beim Finanzamt gearbeitet.

5- Familienanamnese: Unauffällig/

-Vater: DM (Zuckerkrankheit), arterielle Hypertonie (Bluthochdruck), Rheumaleiden

-Mutter: an MI gestorben

Bruder: DM

Bruder: arterielle Hypertonie

Die Eltern seien seit langem gestorben und sie weiß nicht, wann und woran!

2-aktuelle Beschwerden:

Frau Natalie Krämer ist eine 75-jährige Patientin, die sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen vor 2 Tagen auftretender, bestehender, krampfartiger, ziehender, stechender, zunehmender, linkseitiger (Flankenschmerzen/ Rückenschmerzen) mit Ausstrahlung in den Unterbauch /die linke Leiste/ linke Flanke und in den Rücken/ Innenseite des linken Oberschenkels vorgestellt hat. Die Pt. berichtet, dass die Schmerzen langsam aufgetreten seien und sich im Verlauf verbessert/verschlechtert hätten. Zusätzlich teilt sie mit, dass die Schmerzen 6-7 von 10 auf der Skala seien. Die Schmerzen seien lageabhängig, beim Bewegen schlimmer und in Ruhe besser geworden. Es gebe keine Auslöser der Schmerzen.

Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint.

3-Begleitsymptome

Ferner sind der Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

- Dysurie (schmerzhaftes Wasserlassen, brennende Schmerzen beim Wasserlassen)
- Polyurie (vermehrtes Wasserlassen)
- Nykturie (nächtliches Wasserlassen)
- Nausea (Übelkeit)
- Fieber, 39° C - nicht gemessen seit 2 Tagen
- Schüttelfrost,
- Schwächegefühl
- Der Urin sei gelblich, sehr dunkel, stinkend und trüb

4-Vegetative Anamnese:

- Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf
- Inappetenz (Appetitlosigkeit)
- Insomnie (Schlafstörungen) wegen der o.g. Beschwerden
- produktiver Husten mit gelblichem Auswurf

5-Vorerkrankungen: An Vorerkrankungen leide sie an:

- 1- DM Zuckerkrankheit seit 20 Jahren
- 2- COPD (Chronisch obstruktiver Lungenerkrankung)/ Asthma seit langem / seit 30 Jahren
- 3-arterieller Hypertonie

Sie sei nicht operiert worden /Es wurde bei der Pt. eine Tonsillektomie (Mandelentfernung) mit 11 Jahren durchgeführt.

6-Medikamentenanamnese:

- Frau Krämer nehme zurzeit keine Medikamente ein.
- Frau Krämer nehme die folgenden Medikamente ein:
- Metformin 1000 mg (1.0.1) regelmäßig
- Abführmittel gegen Obstipation (Verstopfung) bei Bedarf
- inhaliere Spiriva - Salbutamol Spray 2-3 mal
- Ramipril 5 (1-0-0)
- Diuretika 12,5 (0-0-1)

Frau Krämer wurde jährlich gegen Influenza geimpft.

Sie habe wegen der aktuellen Beschwerden Paracetamol/Ibuprofen eingenommen, aber die Tabletten hätten ihr nicht geholfen.

7-Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Pyelonephritis hin. Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht: Akute Cholezystitis, Sigmadivertikulitis, Pankreatitis, Akute Appendizitis

8 –Maßnahmen: Als erste Maßnahme würde ich die Pt. körperlich untersuchen. (Klopfschmerzhaft –Nierenlager)

-Zur weiteren Abklärung sollten die folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- 1-Blutabnahme (entzündliche Parameter wie BSG, CRP, Leukocytose, Nierenparametern)
- Urinstatus (Mittelstrahlurin) (Nitrit erhöht, Leukozyturie, ggf. Erythrozyturie, tubuläre Proteinurie)
- 2-Urinkultur mit Erreger- und Resistenztestung
- 3-Abdomensonographie
- 4-Ggf. CT-Abdomen

-Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:

- Ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mind. 1,5 l/Tag)
- o Antibiotika (z.B. Levofloxacin 500 mg/Tag für 10 Tage p.o)
- o ggf. Analgetika zur Schmerzlinderung der Dysurie
- o ggf. Spasmolytikum bei Krämpfen

Fragen:

- Seit wann bestehen diese Beschwerde?

- Haben Sie schon Mal ähnliche Beschwerden gehabt?
- Sind die Beschwerden plötzlich oder eher langsam angefangen?
- Wie stark sind die Schmerzen auf einer skala von 0 bis 10?
- Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
- Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben?
- Leiden Sie unter Fieber oder Schüttelfrost?
- Haben Sie Ihr Fieber gemessen. Falls ja: Wie hoch war es?
- Haben sich die Beschwerden im Laufe der Zeit verschlechtert?
- Haben Sie schon etwas dagegen eingenommen? Falls ja: welches Medikamente und wann? Hat es Ihnen geholfen?
- Gibt es einen bestimmten Auslöser für die Beschwerden?
- Treten die Schmerzen nach dem Essen auf?
- Sind die Schmerzen anhaltend oder wiederkehrend?
- Haben Sie Schmerzen oder ein Brennen beim Wasserlassen?
- Leiden Sie unter schwachen oder unterbrochenen Harnstrahl?
- Wie oft müssen Sie tagsüber urinieren? Müssen Sie häufiger Wasserlassen als sonst?
- Leiden Sie unter nächtliches Wasserlassen? Wie oft müssen Sie nachts auf die Toilette?
- Tropft der Urin nach dem Wasserlassen nach?
- Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Harnblase nach dem Wasserlassen nicht vollständig entleert ist?
- Müssen Sie häufiger in kleinen Mengen wasserlassen?
- Haben Sie Schwierigkeiten, den Urin zu halten?
- Wie sieht Ihr Urin aus? Hat sich die Farbe, der Geruch oder das Aussehen verändert? Haben Sie Blut im Urin bemerkt?
- Hatten Sie in letzter Zeit Harnwegsinfekte?
- Leiden Sie unter neurologischen Erkrankungen, die Ihre Blasenfunktion beeinflussen könnten? z.B. Parkinson, MS

79 Jahre alt Patient, akute, starke, linksseitige Flankenschmerzen ohne Ausstrahlung. Schmerzen seien stechend und aber auch dumpf (er hat fast alle Adjektive benutzt stechend -brennend-dumpf-heller Schmerz). Sie sind dauerhaft da und mit der Zeit schlimmer geworden. Die verstärken sich bei Bewegung. Außerdem habe er 39,3 Fieber, rektal, heute Morgen gemessen. Er habe gegen Beschwerden paracetamol und Ibuprofen eingenommen, mit geringem Ansprechen der Symptomatik. Er klagte auch über Ischurie, Dysurie, bräunlichen, schäumenden Urin mit „fischigem“ Geruch. Er habe Inappetenz und Schlafstörungen, weil er in der Nacht häufig auf die Toilette gehen muss. (5-6 mal seit zwei Tagen mit geringem Urin, normalerweise geht er 1-2 mal).

Er habe DM-Typ 2 seit 20 Jahren, der mit Metformin 1000 (1-0-1) eingestellt und COPD, die mit Spiriva behandelt (2 mal am Tag und bei Bedarf)

Er habe Kribbeln an den Beinen (er hat das ganz am Ende gesagt, wenn ich Kribbeln oder Taubheitsgefühl am Körper nachgefragt habe. diabetische Neuropathie?) Das habe ich ganz am Ende gefragt und danach war der Patient etwas unruhiger wegen Schmerzen, also Ende des Gesprächs - ich gebe gleich Analgetikum.

Raucher, seit 60 Jahren 20 Zigaretten pro Tag, Alkohol: 1 Glas Rotwein jeden Abend, kein Drogenkonsum

Seit 3 Jahren verwitwet, habe 2 gesunde Kinder Rentner, vorher Bauingenieur

Er habe dazwischen viel gesprochen. Man muss aufmerksam sein. Wenn er über Beschwerden gesprochen hat, hat er schon etwas über sein DM, Rauchen, Aufenthalt in einer Lungenklinik wegen COPD, Rauchen und Rotwein erzählt.

Verdacht auf Pyelonephritis und diabetische Nephropathie

DD: Urolithiasis, MI, Divertikulitis, Bandscheibenvorfall

Beim Arzt Gespräch hat er ohne Patientenvorstellung, direkt mit Fragen angefangen. Warum habe ich diesen Verdacht? Außer MI, wurde ich für jede Differenzialdiagnose auf dem Arztbrief gefragt, warum es in der DD List ist. Pyelonephritis Diagnose (Kultur fast vergessen) Was gebe ich als Therapie? Welche Antibiotika? Schicke ich den Patienten nach Hause mit Rezept? (Nein) Erklären Sie

bitte das zur Krankenversicherung warum. Patient hat Diabetes, Höher Risiko für Komplikationen und Untersuchungen wegen diabetischer Nephropathie.

Welche Komplikationen? Abszess, akute Nierenversagen, Sepsis.

Definition

Eine **Pyelonephritis** ist eine Entzündung des Nierenbeckens mit Beteiligung des Nierenparenchyms, die meist durch eine ascendierende bakterielle Harnwegsinfektion verursacht wird.

Ihre Abgrenzung von einem schweren Harnwegsinfekt ist schwierig. Pyelonephritiden sind die häufigsten bakteriellen Nierenerkrankungen im Erwachsenenalter. Escherichia coli kann in ca. 75 % der Fälle in Deutschland als Erreger identifiziert werden.

Entstehung

Zumeist liegt eine ascendierende Harnwegsinfektion vor. Uropathogene Bakterien (v.a. uropathogene Escherichia coli) aus Harnröhre oder Blase steigen über die Ureteren bis ins Nierenbecken auf. Neben Escherichia coli können weitere typische Erreger auftreten, darunter Kokken, Klebsiellen, Enterobacteriaceae oder Proteus.

Risikofaktoren

Wesentliche Risikofaktoren sind:

- weibliches Geschlecht (anatomisch kürzere Harnröhre)
- sexuelle Aktivität
- Schwangerschaft
- Urolithiasis
- Benigne Prostatahyperplasie
- Fehlbildungen
- Analgetikaabusus
- Morbus Crohn o.a. chronische Darmentzündung
- Vesikoureteraler Reflux (VUR, insb. bei Kindern)
- Harnabflussstörungen (Steine, Prostatahyperplasie, mechanische Obstruktion)
- neurogene Blasenentleerungsstörung
- Dauerkatheter (DK)
- Immunsuppression
- Diabetes mellitus (prädispositioniert komplexe und emphysematöse Form)
- vorangehende/rezidivierende Harnwegsinfektionen

Symptomatik

Akute Pyelonephritis

Plötzlich einsetzende Erkrankung mit schwerem Krankheitsgefühl:

- Fieber
- Schüttelfrost
- Dysurie, ggf. Pollakisurie
- Flankenschmerzen mit klopfschmerzhaftem Nierenlager
- ggf. gürtelförmige Schmerzen wie bei einer Pankreatitis
- ggf. Rückenschmerzen

Chronische Pyelonephritis

Schleichender oder schubweiser Verlauf mit uncharakteristischen Symptomen wie:

- Müdigkeit und Abgeschlagenheit
- subfebrile Temperaturen
- Übelkeit und Brechreiz
- Gewichtsabnahme
- Pollakisurie

- progrediente Niereninsuffizienz

Diagnostik

- **Klinik:** Fieber, Flankenschmerz mit klopfschmerzhaftem Nierenlager, Übelkeit/ Erbrechen, diffuse Harnwegsbeschwerden, ggf. eitrige Urinbeimengungen (trübe Diurese)
- **Labor:** Urinstatus (insb. Leukozyten, Nitrit), Urinmikroskopie, zwingend: Urinkultur mit Erreger- und Resistenztestung, Blutkulturen bei schweren Verläufen, Entzündungsparameter (CRP, Leukozyten), Nierenfunktionsparameter (Serumkreatinin, eGFR)
- **Bildgebung:** Sonographie der Nieren/des Urogenitaltraktes bei Verdacht auf Komplikationen, unklarem Verlauf oder komplizierten Fällen; CT (kontrastmittelgestützt) bei Verdacht auf Abszess, emphysematöse Pyelonephritis oder bei fehlender Besserung unter adäquater Therapie

Prostatakarzinom

1-persönliche Daten: Herr Franz Meister,
67 Jahre, 1,54 m groß, 60 kg schwer

2-Allergie: keine

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: Nichtraucher

Alkohol: keiner

Droge: Keine

Sport: keiner

4- Sozialanamnese: Familienstand: ledig

Arbeit: in Rente

5- Familienanamnese:

-Vater: sei an Kolonkarzinom vor ein paar Jahren verstorben

-Mutter: -

-Der Bruder -

----- Anamnese

1. Patient-Vorstellung

Herr Franz Meister ist ein 67-jähriger Patient, der sich heute Morgen bei uns wegen aufgetretener Gewichtsabnahme vorgestellt hat.

2-aktuelle Beschwerden:

Zusätzlich teilt der Pt. mit, dass er ca. 7-8 kg in den letzten 3 Monaten abgenommen habe.

3-Begleitsymptome

Ferner sind dem Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

-Er klagt über

- Müdigkeit

- Miktionsstörung (Polyurie, Dysurie, Nykturie bis 3 Mal in einer Nacht)

4- Vegetative Anamnese

-Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf

- Schlafstörung wegen der Nykturie.

5.Vorerkrankungen:

- An Vorerkrankungen leide er an

- Reizdarmsyndrom - COPD - Prostatahypertrophie.

6- Medikamentenanamnese:

- Der Pt. nehme zurzeit keine Medikamente ein.
- Herr Meister nehme die folgenden Medikamente ein:
 - Tabletten gegen Prostatahypertrophie
 - Behandlungs-Spray.... für COPD-Behandlung.

7-Verdachtsdiagnose:

- Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ein Prostatakarzinom hin. Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:
 - Benigne Prostatahyperplasie (BPH)
 - Urolithiasis (Harnsteine)

8-Maßnahmen

- Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen. Anamnese: Beschwerden beim Wasserlassen, LWS-Syndrom (aufgrund von Metastasen) Digital-rektale Untersuchung unregelmäßiger, fast steinharter Knoten; im Frühstadium tastbar
- Zur weiteren Abklärung sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden:
 - Labor: Blutbild, BSG ↑, CRP ↑, AP ↑, Kalzium↑, PSA↑ (Prostata-spezifisches Antigen),
 - Urin-Status
 - transrektale Sonographie
 - MRT
 - transrektale Stanzbiopsie perineale Stanzbiopsie
- Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor:
 - 6.1 Chirurgische Entfernung
 - Prostatektomie (laparoskopische Prostatektomie)
 - 6.2 Strahlentherapie
 - 6.3 Medikamentöse Therapie
 - Chemotherapie

Fragen:

- Seit wann bestehen die Beschwerden?
- Sind die Beschwerden plötzlich oder eher langsam aufgetreten?
- Hatten Sie Mal unter ähnliche Beschwerden gelitten?
- Haben Sie Schwierigkeiten beim Wasserlassen?
- Haben Sie Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen?
- Müssen Sie häufiger als sonst Wasser lassen?
- Leiden Sie unter einem schwachen oder unterbrochen Harnstrahl?
- Liegt eine Startverzögerung beim Wasserlassen?
- Müssen Sie länger als sonst urinieren?
- Leiden Sie unter nächtliches Wasserlassen?
- Haben Sie Blut im Urin bemerkt?
- Haben Sie Unvermögen, den Harn zu halten?
- Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Harnblase nach dem Wasserlassen nicht vollständig entleert ist?
- Tropft nach dem Wasserlassen noch etwas Urin nach?
- Haben Sie unfreiwilligen Harnverlust unter Harndrang?
- Können Sie beim Harndrang Ihren Urin halten?
- Leiden Sie unter Erektionsstörungen?
- Haben Sie eine verminderte sexuelle Funktion oder sexuelle Unlust?
- Haben Sie Schmerzen beim Stuhlgang oder eine Veränderung der Stuhlgewohnheiten? (Rektumtumor oder Infiltration?)
- Haben Sie Schmerzen in den Knochen. Insbesondere im Rücken, in den Hüften oder in den Rippen? (Knochenmetastase?)
- Sind Ihnen vergrößerte Lymphknoten aufgefallen?
- Besuchen Sie regelmäßig Ihren Urologen/Urologin?

Definition

Ist eine von Zellen der Vorsteherdrüse (Prostata) ausgehende maligne Neoplasie des Mannes.

Pathogenese

Das Prostatakarzinom ist in der überwiegenden Mehrzahl ein Adenokarzinom der Prostata, das aus den Drüsenepithelzellen hervorgeht.

Klinik

Im Frühstadium ist Prostatakrebs meist asymptomatisch. Im späteren Stadium können unter anderem folgende Beschwerden auftreten:

- Miktionsstörungen
 - Pollakisurie
 - Dysurie (Algurie)
 - Schwacher Harnstrahl
 - Nachtropfen
 - Unterbrechung des Harnstrahls
- Restharnbildung
- Nykturie

Bei ausgedehnten Tumoren kann es weiterhin zu Erektionsstörungen kommen. Eine Hämaturie oder Hämatospermie sind selten.

Das Prostatakarzinom kann sich durch lokale Invasion (typischerweise in die Blase und die Samenblasen, selten in Harnröhre oder Rektum), durch lymphatische Ausbreitung (zuerst pelvine, dann paraaortale und inguinale Lymphknoten) oder durch hämatogene Metastasen ausbreiten.

Häufige Lokalisationen für hämatogene Metastasen sind:

- Knochen (90 %)
- Lunge (45 %)
- Leber (25 %)
- Pleura (20 %)
- Nebennieren (15 %)

Tritt im fortgeschrittenen Stadium eine Metastasierung auf, können neben Allgemeinsymptomen wie Anämie und ungewolltem Gewichtsverlust weitere Beschwerden hinzukommen, die von der Lokalisation der Metastasen abhängig sind, z.B.

- pathologische Frakturen und neurologische Ausfälle bei Knochenmetastasen
- Lymphödem der Beine oder des Hodensacks bei Lymphknotenmetastasen

Diagnostik

Nach einem auffälligen PSA-Wert oder anderen Verdachtsmomenten wird zunächst eine klinische Untersuchung vorgenommen, bei der die digital-rektale Untersuchung (DRU) zwar weiterhin Teil der urologischen Basisdiagnostik ist, in der Früherkennung jedoch keine eigenständige Rolle mehr spielt (siehe Früherkennung).

Bildgebung

-Transrektale Sonografie

-MRT der Prostata

Biopsie: transperineal oder transrektal. Heute (2025) gilt die MRT-gesteuerte Fusionsbiopsie als diagnostischer Standard, da sie eine höhere Detektionsrate klinisch signifikanter Karzinome bei gleichzeitiger Reduktion unnötiger Biopsien erlaubt.

Bei der digitalen rektalen Untersuchung kann ein Prostatakarzinom vermutet werden, wenn die Prostata hart, unregelmäßig, knotig oder asymmetrisch tastbar ist.

Angina pectoris/ KHK (koronare Herzkrankheit)

1- persönliche Daten: Name: Josef Renner/Werner Schulze/Hans Schultze 51 Jahre alt, 87 kg schwer, 1,76 m groß

2-Allergie: Keine Allergien bekannt/ Pollenallergie (Heuschnupfen) im Frühling

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: 20 Zigaretten pro Tag seit 20 Jahren (20 P/Y). Er rauche Pfeife einmal pro Tag seit 10 Jahren

Alkohol: Nur am Wochenende ein Glas Rotwein.

Drogen: Keine / er habe Marihuana einmal probiert

Sport: keiner/ Er treibe Nordic Walking (Laufen)

4- Sozialanamnese:

Familienstand: geschieden - ein Sohn -alleinlebend.

Arbeit: Er sei Lehrer von Beruf /Sie arbeitet als Hausmeisterin und habe viel Stress bei derArbeit.

5- Familienanamnese:

-Vater: Myokardinfarkt MI (Herzinfarkt), er sei daran gestorben/habe an Kolonkarzinom (Darmkrebs) gelitten und sei daran gestorben.

-Mutter: gesund.

-Er habe keine Geschwister.

-Das Kind sei völlig gesund.

1. Patient-Vorstellung

Herr Josef Renner ist ein 51-jähriger Patient, der sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit heute Morgen - zwei Stunden aufgetretender, bestehender, progredienter, drückender, retrosternaler Schmerzen / linksseitiger Thoraxschmerzen mit Ausstrahlung in den ganzen Thorax sowie den linken Arm/die linke Schulter / den linken Unterkiefer vorgestellt hat.

2-aktuelle Beschwerden:

Der Pt. berichtet, dass die Schmerzen plötzlich nach dem Frühstück / nach einem Streit mit dem Nachbarn aufgetreten seien und sich im Verlauf verschlechtert hätten. Zusätzlich teilt er mit, dass die Schmerzen 8-10 von 10 auf der Skala seien. Die Schmerzen seien belastungsabhängig und bei körperlicher Belastung sowie bei Kälte schlimmer geworden. Es gebe Körperbelastung als Auslöser der Schmerzen. Er fügte hinzu, dass er dagegen Tabletten (Ibuprofen) eingenommen habe, aber die Tabletten hätten ihm nicht geholfen. Außerdem erwähnte der Patient, dass er ähnliche Beschwerden vor 3 Wochen beim Treppensteigen in den zweiten Stock gehabt habe, die in Ruhe besser geworden seien.

3-Begleitsymptome Ferner sind dem Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

-Dyspnoe (Atemnot)

-Nausea (Übelkeit)

-Todesangst

Die Fragen nach Palpitation, Bewusstseinsstörung, Hämatemesis, Erbrechen und Pyrosis wurden verneint.

4-Vegetative Anamnese:

-Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf

-Inappetenz (Appetitlosigkeit)

- Insomnie (Schlafstörungen)
- Nykturie (nächtliches Wasserlassen) (6 Mal pro Nacht)
- Schweißausbrüche, Nachtschweiß
- morgendlichen trockenen Husten (seit 3 Wochen).

5-Vorerkrankungen:

- An Vorerkrankungen leide er an -DM typ II (Zuckerkrankheit) seit vier Jahren
 - Arterieller Hypertonie (Bluthochdruck) seit fünf Jahren
 - Hyperlipidämie seit ein paar Monaten
 - Nacken und Rückenschmerzen seit 10 Jahren
 - Herr Renner sei nie operiert worden.
- Der Impfstatus sei komplett.

6-Medikamentenanamnese:

Herr Renner nehme die folgenden Medikamente regelmäßig ein:

- Ramipril- Lasopril 10 mg 1.0.0 .
 - HCT Hydrochlorothiazid 12.5 mg 1- 0-0.
 - Metformin 850 mg 1-0-1.
 - Simvastatin
 - Laxativum (Abführmittel)
- Ibuprofen 1 Tablette bei Bedarf

7- Verdachtsdiagnose:

-Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Angina Pectoris/KHK Koronare Herzkrankheit hin. Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

- 1-Aortendissektion,
- 2-Pneumothorax
- 3- Refluxkrankheit,
- 4-GERD

8-Maßnahmen

-Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen. Zur weiteren Abklärung sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden:

- 1-Laboruntersuchung (BB, CRP, BSG, Herzenzyme (Troponin-CK-MB LDH,) BGA (Blutgasanalyse)
 - 2-Apparative Untersuchung (Elektrokardiographie EKG, Röntgenthorax, Koronerangiografie
- Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:
- A.Änderung des Lebensstils:- Kochsalzarme Kost
- Ein gesundes Gewicht halten.
 - Körperlich aktiv sein.
 - Normalen Blutdruck halten.
 - Gesunden Cholesterinspiegel halten.
 - Rauchen aufhören.
 - Normalen Blutzucker halten.
- B.Therapeutische Maßnahmen: 1.ACE- Hemmer (Ramipril). 2. β -Blocker (Metoprolol). 3. Antianginöse Medikamente wie Glyceroltrinitrat
- Lipidsenker: Simvastatin. Herzkatheter, ggf. Bypassoperation.

Fragen:

- Haben Sie Brustschmerzen oder eine Engegefühl in der Brust?
- Haben Sie jetzt auch diese Schmerzen?
- Seit wann haben Sie diese Schmerzen?
- Wie stark sind die Schmerzen auf eine Skala von 0 bis 10?
- Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
- Haben Sie schon etwas dagegen eingenommen? Wenn ja: Welches Medikament haben Sie eingenommen und hat es Ihnen geholfen?
- !!!Handeln!!! Vital parameter messen, Nitrat geben, Sauerstoff messen und ggf. O2 geben, Zugang einlegen, monitorisieren... wenn es nicht besser geht: morphin

- Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam begonnen?
- Gibt es einen bestimmten Auslöser für die Schmerzen?
- Sind die Schmerzen anhaltend oder wiederkehrend?
- Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben? Stechend, dumpf, krampfartig, brennend
- ...
- Wie haben sich die Beschwerden im Laufe der Zeit verändert?
- Ist das zum ersten Mal passiert? Wenn nein: Wie oft haben Sie so etwas erlebt?
- Treten die Schmerzen nur bei Belastung auf oder auch in Ruhe?
- Wie viele Stockwerke können Sie beschwerdefrei steigen?
- Wann treten die Schmerzen auf, tagsüber oder in der Nacht?
- Wie lange dauert ein Anfall?
- Wie verhalten sich die Schmerzen bei Belastung oder beim Atmen?
- 'Verstärken sich die Schmerzen beim Liegen, Sitzen oder Stehen?' Oder 'Sind die Schmerzen lageabhängig?'
- Haben Sie schon Medikamente dagegen eingenommen? Hat es Ihnen geholfen?
- Haben Sie es mit einem Nitrospray versucht?
- Haben Sie wie Luftnot, Schweißausbrüche, Blässe oder Herzrasen ander Beschwerde?
- Haben Sie Herzrasen oder Herzstolpern?
- Haben Sie kalten Schweiß bemerkt?
- War Ihnen ohnmächtig?

Herr Josef Renner 55 Jahre Alt.

Er stellte sich bei uns wegen seit 3 Wochen bestehender Thoraxschmerzen vor. Die Schmerzen seien drückend, intermittierend und belastungsabhängig. Die Intensität liege bei 0 auf der Schmerzskala bei Ruhezustand und 6 bei Belastung, mit Ausstrahlung in den linken Arm. Er habe keine Medikamente dagegen eingenommen. Als Begleitsymptome nannte er Parästhesie an den linken Arm. In der vegetativen Anamnese erwähnte er Einschlafstörungen. An Vorerkrankungen seien arterielle Hypertonie seit 10 Jahren, Diabetes mellitus Typ 2 seit 10 Jahren und TVT vor 4 Jahren bekannt. An Voroperationen sei eine Appendektomie vor 30 Jahren bekannt. Diese sei komplikationslos verlaufen. An Medikamenten nehme er Metformin 1000mg und Lisinoprol. Er sei vollständig geimpft und sei in letzter Zeit nicht im Ausland gewesen. Es seien keine Allergien bekannt.

Er rauche Pfeifen x mal am Tag. Er trinke 2 Flaschen Bier am Tag. Er nehme keine Drogen. Er treibe keinen Sport.

Er sei verheiratet und habe 3 gesunde Kinder. Er arbeite als Hausmeister.

Der Vater leide an arterieller Hypertonie.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf stabile Angina.

Als Differenzialdiagnose kommen die folgenden in Betracht: Gastritis, Zervikaler Diskusprolaps..

Diagnose und Therapie wie im Protokoll.

Aufklärung PTA (Perkutane transluminale Angioplastie): Bei Ihnen ist ein Blutgefäß verengt. Bei der perkutanen transluminalen Angioplastie führen wir über ein dünnes Röhrchen einen kleinen Ballon in das Gefäß ein. Der Ballon wird an der engen Stelle aufgeblasen, damit das Gefäß wieder weiter wird und das Blut besser fließen kann.

Herr Schlanitz ist ein 51-jähriger Patient, der sich heute morgen bei uns wegen seit 2 Tagen aufgetretener, bestehender Thoraxschmerzen mit Ausstrahlung in den linken Armen vorstellte. Die Schmerzintensität wurde mit 6/10 auf der Schmerzskala bewertet. Der Patient berichtete, dass die Schmerzen plötzlich nach Streit mit Nachbarn und sich im Laufe der Zeit verschlimmert hätten. Zusätzlich teilte er mit, dass die Schmerzen belastungsabhängig sind und im Ruhe besser geworden seien. Die Frage nach Atemnot, Herzrasen, Herzklopfen wurden verneint. Ferner sind dem Patienten folgende Begleitsymptome aufgefallen: Meteorismus, Verstopfung. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Schwitzen, Insomnie.

Arzt Arzt Gespräch: Diagnose Mehr als 20 Minuten, warum nicht MI Warum nicht koronaro direkt
Unterschied zwischen stabil und instabil Angina Patient hat Nackensteifigkeit, hat das etwas zu tun mit
angina Maßnahmen
Warum troponine und nicht dd Und Therapie

Herr Johans Schulze ist ein 51 jähriger Patient der sich heute bei uns wegen seit heute morgen bestehender, druckender, starker Thorakalgie mit Ausstrahlung in den Unterkiefer sowie in den linken Arm vorgestellt hat. Der Patient berichtet, dass die Schmerzen plötzlich nach der Streit mit dem Nachbarn aufgetreten und im Lauf der Zeit schlimmer geworden seien. Die Schmerzen liegen bei 7 von 10 auf der Skala. Er fügte hinzu dass er die ähnlichen Beschwerden vor 4 Wochen nach einer stressige Situation gehabt hatte. Als Begleitsymptom klagt er über Tachykardie, Nausea, Angst, Pyrosis und Gastralgie seit 5 Jahren. Die Fragen nach Dyspnoe, Husten, Regurgitation, Vomitur wurden verneint. An Vorerkrankungen fanden sich: aHT und DM Typ 2 seit 10J.
Keine relevante Operation sei bei ihm bekannt.
AA Gespräch: DD. Erwartung bei Labor und EKG. Was sind herzenzymen. Therapie. PTCA aufklärung sowie die Krankheit.

PTCA: Bei Ihnen ist ein Herzkranzgefäß verengt. Wir möchten das Gefäß mit einem Katheter erweitern. Dafür führen wir einen dünnen Schlauch über die Leiste oder den Arm bis zum Herzen ein. An der verengten Stelle wird ein kleiner Ballon aufgeblasen, damit das Gefäß wieder weiter wird. Oft setzen wir zusätzlich eine kleine Gefäßstütze ein, einen sogenannten Stent, damit das Gefäß offen bleibt. Der Eingriff erfolgt unter örtlicher Betäubung. Wie bei jedem Eingriff gibt es Risiken, zum Beispiel Blutung, Gefäßverletzung, Herzrhythmusstörungen oder selten ein Herzinfarkt. In den meisten Fällen verläuft der Eingriff jedoch ohne Komplikationen.

Definition

Bei der KHK handelt es sich um eine arteriosklerotisch bedingte Erkrankungen der Herzkranzgefäße. Es kommt zu einem Missverhältnis von Sauerstoffangebot und -bedarf im Herzmuskel.

Die KHK manifestiert sich auf 2 Arten:

Latente KHK: asymptomatische KHK=> stumme Ischämie ohne Angina-pectoris-Beschwerden.

Manifeste KHK: symptomatische KHK=> von der stabilen Angina pectoris bis zum akuten Koronarsyndrom

✓ asymptomatische KHK (stumme Ischämie)

✓ symptomatische KHK:

1. stabile Angina pectoris (reversible Myokardischämie)
2. Akutes Koronarsyndrom (ACS): instabile Angina pectoris, NSTEMI, STEMI
3. Myokardinfarkt
4. Herzrhythmusstörungen
5. Plötzlicher Herztod

Ursachen/ Risikofaktoren

✓ s. Herzinfarkt

✓ bekannte KHK

✓ genetische Disposition

✓ obstruktive Schlafapnoe

- ✓ erhöhte Entzündungsparameter

Klinik

Das Leitsymptom einer KHK ist die Angina Pectoris

Stabile AP

- ✓ retrosternale Schmerzen, ausgelöst durch körperliche oder psychische Belastung
- ✓ Schmerzen können zum Hals, Unterkiefer/Zähne, in die Schultergegend, in den linken oder rechten Arm bis in die ulnaren Fingerspitzen ausstrahlen
- ✓ retrosternales Druck- oder Engegefühl
- ✓ Brennen im Brustkorb
- ✓ Auslösen der Schmerzen durch Kälte und Nahrungsaufnahme
- ✓ Beschwerden klingen in der Regel durch Ruhe nach 5-15 min Ruhe ab
- ✓ gutes Ansprechen auf Nitrate (nach 1-2 Min)

Instabile AP

- ✓ erstmaliges Auftreten gilt als primär instabil
- ✓ Beschwerden treten in Ruhe auf
- ✓ Häufigkeit der Schmerzanfälle nimmt zu
- ✓ spricht schlecht auf Nitrate an
- ✓ zunehmender Bedarf an antianginösen Medikamenten

Merke:

- ✓ Das Leitsymptom Brustschmerz kann bei Patienten mit Diabetes mellitus, Niereninsuffizienz, bei Frauen, bei Patienten über 75 Jahren und bei Herzoperierten fehlen.
- ✓ Die Patienten klagen möglicherweise über Übelkeit, Schwindel, Atemnot oder Ausstrahlung ins Epigastrium

Diagnostik

- ✓ Anamnese
 - => Vorhandensein von AP-Anfällen macht KHK wahrscheinlich
 - => NYHA-Klassifikation abfragen
- ✓ Labor
 - => Herzenzyme zum Ausschluss eines Herzinfarktes: CK, CK-MB, Troponin T und I
- ✓ EKG
 - => Grundrhythmus, Reizleitungsstörungen, Ischämie- oder Hypertrophiezeichen • ggf. Belastungs-EKG zur Ischämie-Diagnostik
- ✓ Bildgebende Verfahren
 - Echokardiografie (Ejektionsfraktion, Vitien, Kinetikstörungen, Aortenwurzelbeurteilung), Stressechokardiografie
 - => Ausschluss von z.B. Aortenstenose
 - Stress-MRT
 - => Nachweis von Perfusionsstörungen und Wandbewegungsstörungen des Myokards in Ruhe und unter Stress (Adenosin, Dobutamin)
 - Koronarangiografie (Goldstandard)

Selten:

✗ Positronen-Emissionstomografie (PET)

=> Beurteilung myokardialer Perfusion und Vitalität

✗ SPECT

✗ Mehrschicht-Spiral-CT (sehr gute Sensitivität)

=> für Patienten mit niedriger bis mittlerer Vortestwahrscheinlichkeit

Therapeutische Maßnahmen

✓ Akuttherapie

- schnellwirksame Nitrate als Spray oder Kapsel
- Reperfusion: systemische Lyse oder Katheterintervention (PTCA)

✓ Kausaltherapie: Minimierung der Risikofaktoren

✓ stabile Angina pectoris

- Reduktion der Risikofaktoren
- Thrombozytenaggregationshemmer: Clopidogrel (z.B. Plavix), ASS, Betablocker, Statine, ACE-Hemmer

✓ Betablocker

✓ Langwirksame Nitropräparate z.B. ISDN (Isosorbiddinitrat) zur Anginaphylaxe

✓ Kalziumantagonisten

- wenn kontraindiziert sind, nicht wirken oder nicht vertragen werden!

✓ PTCA=> Stent Implantation

Differentialdiagnostik

✓ kardiale Ursachen: Herzinfarkt, Schwere Tachykardien, Aortenvitien, Mitralklappenprolaps, Kardiomyopathie

✓ nichtkardiale Ursachen: Lungenembolie, Pleuritis, Bronchialkarzinom, Aortendissektion, Ösophagusreflux, vertebrale Thoraxschmerzen, Tietze-Syndrom, akute Pankreatitis, Gallenkolik

Myokardinfarkt

Definition

Syn. Herzinfarkt

Untergang von Myokardgewebe aufgrund einer Durchblutungsstörung durch teilweisen oder vollständigen Verschluss einer Koronararterie.

Ursachen

✓ plötzlicher Verschluss einer Koronararterie durch einen Thrombus

✓ instabile Angina Pectoris

Auslösende Faktoren

✓ Blutdruckschwankungen bei Stress und körperlicher Anstrengung

✓ zirkadiane Zunahme der Aktivität von Gerinnungsfaktoren und Katecholaminen (40% der Infarkte ereignen sich in den Morgenstunden)

Risikofaktoren

✓ Hypercholesterinämie

✓ art. Hypertonie

- ✓ Diabetes mellitus
- ✓ Nikotinabusus
- ✓ KHK oder Herzinfarkte bei Familienangehörigen ersten Grades
- ✓ Adipositas
- ✓ körperliche Inaktivität
- ✓ männliches Geschlecht und Lebensalter (m $\geq$ 45 Jahre; w $\geq$ 50 Jahre)

Klinik

- ✓ plötzlich starke, überwiegend retrosternale Angina-pectoris-Schmerzen, die zum Hals, Unterkiefer, in den linken (auch rechten) Arm und die Schulter ausstrahlen können (Vernichtungsschmerz!)
- ✓ körperliche Ruhe und Nitroglyzerin lindern Beschwerden nicht oder kaum
- ✓ 20% der Herzinfarkte verlaufen als „stumme“ Infarkte ohne Schmerzsymptomatik oder mit einem leichten retrosternalen Druckgefühl (vor allem bei Diabetikern)
- ✓ Schwächegefühle
- ✓ (Todes-) Angst
- ✓ vegetative Symptomatik: Schwitzen, Übelkeit, Erbrechen, u.a.
- ✓ Dyspnoe
- ✓ evtl. Blutdruckabfall

Diagnostik

- ✓ Anamnese
 - Vorbestehen einer KHK oder AP
 - Grunderkrankung, Risikofaktoren
 - ✓ körperliche Untersuchung
 - Auskultation: Arrhythmien, Perikardreiben, feuchte Rasselgeräusche (bei Lungenödem)
 - Ödeme, Halsvenenstauung
 - ✓ Labor: Leukozyten, BZ, CRP $\uparrow$, Troponin I und hsTn (hochsensitives Troponin), (CK-MB), LDHA (Laktatdehydrogenase)
 - ✓ EKG: STEMI /NSTEMI
 - ✓ bildgebende Verfahren
 - (Farbdoppler-) Echokardiografie
 - Linksherzkatheteruntersuchung (Goldstandard)
 - ggf. Kardio-MRT
- => funktionelle Beurteilung von Herzkammern und Herzklappen

Therapeutische Maßnahmen

- ✓ Notarzt rufen. In Deutschland Tel. 112
- ✓ Oberkörper hochlagern (30°)
- ✓ O2- Zufuhr per Nasensonde (4-8l O2// Min)
- ✓ Nitrate
- ✓ Sedierung und Analgesie bei Bedarf (Morphin=> senkt O2-Verbrauch)
- ✓ duale Plättchenhemmung
- ✓ Betablocker

✓ ACE-Hemmer (nicht in der Akutbehandlung)

Differentialdiagnostik

Instabile Angina Pectoris ohne Troponinanstieg, Lungenembolie, Aortendissektion, Stresskardiomyopathie, siehe KHK

TVT

1. persönliche Daten: Name: Reiner Kovermann, Hans Kovermann / Alter: 52 Jahre, Gewicht: 61 kg, Größe: 161cm

2-Allergie: Keine Allergien

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: 30 Zigaretten/Tag seit 30 Jahren (45 P/Y)

Alkohol: ein Glas Rotwein täglich / nur am Wochenende

Keine Drogen. Kein Sport.

4- Sozialanamnese: Familienstand: verheiratet, er habe 3 Kinder und lebe mit seiner Frau zusammen.

Arbeit: Der Pt. sei Manager/Geschäftsführer von Beruf, fliege viel mit dem Flugzeug und habe viel Stress auf der Arbeit.

5- Familienanamnese: Unauffällig/

-Vater: Blutgerinnungsstörung,

-Mutter: DM Typ2 Zuckerkrankheit / Mammakarzinom (Brustkrebs), sie sei daran gestorben.

-Er habe keine Geschwister.

2-aktuelle Beschwerden:

Herr Reiner Kovermann ist ein 52-jähriger Pt., der sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit drei Tagen bestehender, dauerhafter, drückender, zunehmender Schmerzen in der rechten Wade/Unterschenkel mit Ausstrahlung in den ganzen Unterschenkel/ Kniegelenk vorgestellt hat. Der Pt. berichtet, dass die Schmerzen plötzlich nach einer lange Reise (Indien/Brasilien) vor 4 Tagen aufgetreten seien und sich heute morgen verstärkt hätten.

Zusätzlich teilt er mit, dass die Schmerzen 6 von 10 auf der Skala seien. Die Schmerzen seien lageabhängig, bei Hochlagerung des Beins besser und beim Gehen schlimmer geworden. Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde (verneint/bejaht).

3-Begleitsymptome

Ferner sind dem Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

-Rötung, Überwärmung, Schwellung an der betroffenen Stelle

-Spannungsgefühl

-Dyspnoe (Atemnot), aber seit langem und bei Belastung

-Trockener Husten

4-Vegetative Anamnese:

-Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf

-eine Obstipation (Verstopfung)

-stressbedingte Insomnie (Schlafstörungen)

-selten Vertigo (Schwindel)

5-Vorerkrankungen: An Vorerkrankungen leide er an:

-Arterielle Hypertonie (Bluthochdruck) seit 15 Jahren

-Diabetes Mellitus Typ1 (Zuckerkrankheit) seit dem 14. Lebensjahr

-Herzinsuffizienz (Herzschwäche)

-Der Pt. sei vor ... wegen Varikose (Krampfadern) im selben Bein/ im linken Bein / in beiden Beinen/ operiert worden

Der Impfstatus sei komplett.

6-Medikamentenanamnese:

Der Patient nimmt folgende Medikamente regelmäßig ein :

- Metoprolol 25 mg, (1-0-1)
- Lortab 50 mg (1 x 2) (Antitussivum)
- Tudie ((??)) 2.5 mg (1 x 1)
- Diuretika (Wasser-Tabletten) (1-0-1)
- Insulin-Pumpen
- Tropfen gegen Obstipation (Verstopfung)

6-Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf TVT (Tiefe Beinvenenthrombose) hin. Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

- Erysipel CRP.
- Varikose. (D-Dimer und Duplexsonographie)
- PaVK (kalte Haut, keine Schwellung, belastungsabhängig, Puls nicht tastbar)
- Bakerzyste.
- Trauma.

7-Maßnahmen:

- Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen.

1. Tastbarer peripherer Puls.
2. Payr-Zeichen: (Payr's sign) Schmerz bei Drücken der Fußsohle.

3. Meyer-Zeichen: Schmerz bei Waden-Kompression.

4. Homann-Zeichen: Schmerz bei Dorsiflexion des Fußes.

-Zur weiteren Abklärung sollten die folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

1-Laboruntersuchung (Blutbild, CRP-BSG, D- dimere, INR)

2-Duplex-Sonografie

3-Phlebographie

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:

1-Stationäre Aufnahme.

2-Antikoagulation: Heparin 5000 I.E IV überlappend Marcumar für 6 Monate.

3. Mobilisierung + Kompressionsstrümpfe.

4. Operative Behandlung mittels Fogarty-Katheter wenn es

a)keine Besserung bei konservativer Therapie gibt oder

b) die Thrombose in Oberschenkel oder Pelvis (Becken) besteht.

5. Schmerzmittel bei Bedarf.

Fragen:

-Was führt Sie zu uns?

-Haben die Schmerzen plötzlich begonnen oder eher langsam?

-Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 keinen Schmerz und 10 sehr starke Schmerzen bedeutet?

-Haben Sie schon etwas dagegen eingenommen? Hat es geholfen?

-Können Sie die Schmerzen anhalten oder brauchen Sie Schmerzmittel? Sind bei Ihnen Medikamenten allergie bekannt?

-Wie würden Sie Ihre Schmerzen beschreiben? Brennend, ziehend, dumpf, krampfartig?

-Hatten Sie solche Beschwerden schon einmal?

-Haben Sie sichtbare Hautveränderungen bemerkt?

-Ist Ihr Bein überwärmt oder geschwollen?

-Könnte es sein, dass Sie von einem Insekt gestochen wurden?

-Hatten Sie einen Unfall?

-Leiden Sie unter Husten, Luftnot oder Brustschmerzen?

-Strahlen Ihre Schmerzen irgendwohin aus?

-Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen?

-Sind Ihre Schmerzen bewegungsabhängig oder lageabhängig?/Wann treten die Schmerzen auf, bei Belastung oder in der Ruhe?

-Gibt es etwas, dass die Schmerzen lindert oder verstärkt?

-Haben Sie schon eine Venenerkrankung (blutader) erlebt?

- Leiden Sie oder jemand in Ihrer Familie an eine Blutgerinnungsstörung?
- Fühlen Sie an der betroffenen Bein Taubheitsgefühl, Kribbeln, oder Muskelschwäche?
- Haben Sie weitere Beschwerden?
- Haben Sie in der letzten Zeit einen Langstreckenflug gemacht?
- Bewegen Sie sich täglich?
- Haben Sie weitere Beschwerden?

Dokumentation Name: Frau Anna Müller, Alter: 52 Jahre Alt, Geburtsdatum: 04.04.1971, Größe:168 cm, Gewicht 61 kg, Hausärztin: Frau Dr. Müller

Allergien und Unverträglichkeiten keine

Noxen Rauchen: 30 Zigaretten am Tag für 30 Jahren (~45 Packungsjahr)

Alkohol: 1 Glas Rotwein fast jeden Abend

Drogen: mit 20 hat sie Joint geraucht. Schon längst aufgehört.

Sozialanamnese Beruf: Geschäftsführerin in einem internationalen Konzern

Familienstand: verheiratet, lebe mit ihrem Ehemann zusammen

Kinder: 2 gesunde Töchter

Familienanamnese Vater: Koagulopathie (Blutgerinnungsstörung) bzw. Thrombose

Mutter: Diabetes Mellitus (vermutlich Typ 1 seitdem die Patientin geboren ist)

keine Geschwister

Aktuelle Beschwerden Frau Müller ist eine 52-jährige Patientin, die sich heute bei uns in der Notaufnahme wegen einer seit 3 Tagen bestehenden, rechtsseitigen, Unterschenkelanschwellung (Beinödem) vorgestellt. Sie berichtete, dass ihr rechtes Bein röter, wärmer geworden ist. Zudem klagte sie ebenfalls über Spannungsgefühl sowie progrediente, beim Gehen verschlimmerte Schmerzen am betroffenen Bein. Die Schmerzintensität sei 5 von 10 auf einer Schmerzskala. Begleitend habe sie schmerzbedingte Durchschlafstörungen (Insomnie). Außer Obergenannten ist die vegetative Anamnese unauffällig. Darüber hinaus gab sie an, dass die Beschwerden 2 Tagen nach einem 12-stündigen Flug von Bangkok nach Frankfurt auftraten.

Vorerkrankungen und Medikation Unter Vorerkrankungen sind weitere bekannt:

arterielle Hypertonie seit 10 Jahren

Diabetes Mellitus typ 1 seit ihrem 14. Lebensjahr

Vor 10 Jahren wurde eine Phlebektomie bei ihr durchgeführt.

In Bezug auf Medikation nehme sie die folgenden Medikamente ein;

Östrogen-pille 1-0-0

ACE-Hemmer 1-0-1 (An den Namen und die Dosis kann sie sich nicht erinnern)

Insulin 20 Einheit s.c.

Der Patient sei vollständig geimpft.

Verdachtsdiagnose Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf tiefe Venenthrombose hin.

Differenzialdiagnose Differenzialdiagnostisch kommen 1) PAVK 2) Cellulitis in Betracht.

Diagnostische Maßnahmen Zur weiteren Abklärung würde ich gerne folgende körperliche labortechnische Untersuchungen durchführen:

1. Die körperliche Untersuchung: 1. Der betroffene Unterschenkel: Homan-Zeichen, Meyer-Zeichen 2. Vitalparameter

2. Labor: BB, Nierenparameter, Entzündungsparameter, CRP, BSG, D-Dimer, APTT, PT, INR

3. Bildgebende Untersuchung * Farbduplex-Sonographie ggf. CT-Angiografie/Venografie *

Komprimierbarkeit bei der Sonografie

Therapie: Sollte sich der Verdacht auf TVT bestätigen, würde ich die folgenden therapeutischen Maßnahmen empfehlen:

1. stationäre Aufnahme

2. Analgetika

3. Vollheparinisierung mit APTT Kontrolle ggf. LMWH 1 mg/kg s.c. q 12 hr

wenn Kreatinin-Clearance <30 ml/min LMWH 1 mg/kg s.c. q 1 Tag 4. Fibrinolyse oder Thrombektomie je nach Schweregrad

5. Lokale Kompression

Arzt-Arzt-Gespräch

1. Was spricht für TVT?

Alle Beschwerden

2. Welche Risikofaktoren hat die Patientin?

Immobilisierung (langer Flug)
Östrogen-pille, orale Kontrazeptiva
Tabakkonsum
aHT

3. Welche therapeutischen Maßnahmen würden sie anordnen?

siehe Oben

4. Welche Komplikationen können auftreten?

Lungenembolie

Schlaganfall in welchem Sonderfall? >> bei Patienten mit dem persistierenden Foramen ovale, der Embolus kann durch das Loch zu dem Hirngefäß wandern.

5. Um TVT und pAVK zu unterscheiden, wie kann man einfach bei der körperlichen Untersuchung machen?

Puls fühlen (am Leistenbereich und unter)

6. Was können wir machen, um die Patientin auf die Entlassung vorzubereiten?

Bridging zum Macumar (zeitweise Überbrückung einer langzeit-Antikoagulation durch ein anderes)

7. Wie lange sollte die Patientin Macumar einnehmen?

Ich habe gesagt mindestens 3 Monate bis 6 Monate, aber falls die Patientin zufälligerweise Malignom hat, sollte die Patientin Macumar langfristig bis zur Heilung des Malignoms einnehmen.

Der Oberarzt hat mir gesagt, 1 Jahr wäre besser.

Ich muss noch recherchieren.

Definition

Syn. Phlebothrombose. Akutes Gerinnsel in einer tiefliegenden Vene im Becken-/ Beinbereich (90%) oder im Armbereich, der zum vollständigen oder unvollständigen Verschluss des Gefäßes führt.

Ursachen

✓ Virchow-Trias:

- Veränderung/Verlangsamung des Blutstroms (Varizen, Herzinsuffizienz, Exsikkose)
- Veränderung der Blutzusammensetzung
- Veränderung der Gefäßinnenwand (Entzündungen, Traumen)

Risikofaktoren

- ✓ chronisch venöse Insuffizienz/ vorherige Thrombose
- ✓ höheres Lebensalter
- ✓ Adipositas (BMI ≥ 30)
- ✓ Immobilisation (Bettlägerigkeit, Lähmung)
- ✓ Herzinsuffizienz ab NYHA III, Herzinfarkt
- ✓ respiratorische Insuffizienz und COPD
- ✓ Hyperviskosität durch Exsikkose
- ✓ essentielle Thrombozythämie
- ✓ erworbener Protein C-Mangel (Leberzirrhose, Cumarintherapie, Vitamin K-Mangel)
- ✓ langandauernde chirurgische Eingriffe;
besonders im Becken-Bereich und bei Polytrauma
- ✓ paraneoplastische Genese

Klinik

- ✓ Schwere- und Spannungsgefühl, ziehende Schmerzen, Gefühl von „Muskelkater“, die sich bei Hochlagerung bessern
- ✓ Schwellung mit ggf. zyanotischer Glanzhaut
- ✓ Überwärmung

✓ Druckdolenz im Verlauf der Venenentzündung:
Meyer-Zeichen, Payr-Zeichen, Homan-Zeichen

Diagnostik

✓ Anamnese: siehe Risikofaktoren
✓ Wells-Score: Bestimmung der Thrombose-Wahrscheinlichkeit
Labor: D-Dimer-Test (TVT unwahrscheinlich, wenn <500ng/ml)

✓ bildgebende Verfahren

- (Farbduplex-) Kompressionssonografie=> fehlende oder eingeschränkte Komprimierbarkeit des im Querschnitt dargestellten Venenlumens
- Phlebografie: wenn Duplexsonografie nicht aussagekräftig ist
- Ursachenklärung (Thrombophilie, Malignom...)

Therapeutische Maßnahmen

✓ allgemein: Kompressionstherapie, Mobilisation
✓ medikamentös: Antikoagulation (Marcumar, Heparin)
✓ Lysetherapie
✓ operativ: Thrombektomie

Differentialdiagnostik

Postthrombotisches Syndrom, Lymphödem, Muskelfaserriss, akuter arterieller Verschluss, pAVK, Ischiassyndrom, rupturierte Baker-Zyste

Spezielle Fragen bei V.a. TVT und zur Differentialdiagnostik

Hatten Sie einen Unfall? => Ausschluss einer Fraktur, Kontusion,...

- Nehmen Sie Hormone? Z.B. Verhütungsmittel oder Medikamente gegen Wechseljahresbeschwerden? => Risikofaktor
- Haben Sie Schmerzen im unteren Rücken oder ein Taubheitsgefühl/ Missempfindungen (Kribbeln,...) im Bein wahrgenommen? => Ischialgie, Bandscheibenvorfall?
- Treten die Schmerzen erst nach einer bestimmten Gehstrecke auf? => PAVK?
- Leiden Sie an einer Blutgerinnungsstörung? Oder jemand in Ihrer Familie?
- Sind Sie in letzter Zeit operiert worden? Um was für eine OP handelte es sich?
- Haben Sie Luftnot? => V.a. Lungenembolie

pAVK (periphere arterielle Verschlusskrankheit)

1-persönliche Daten: Name: Hans Weber/Walter Vogel
Alter: 52 Jahre, Gewicht: 61 kg, Größe: 163cm

2-Allergie: Laktoseintoleranz - Allergie gegen Penicillin

3- Genussmittel/ Noxen
Nikotin: 20 Zig/Tag seit 40 Jahren (40py)
Alkohol: keiner
Keine Drogen.
Sport: keiner

4- Sozialanamnese:

Familienstand: verheiratet, er habe 4 Kinder und lebe mit seiner Ehefrau. Arbeit: Kraftfahrer / Busfahrer von Beruf

5- Familienanamnese:

- Vater: Myokardinfarkt (Herzinfarkt); er sei daran gestorben.
 - Mutter: leide an DM Typ 2 (Zuckerkrankheit)
-

2-aktuelle Beschwerden:

Herr Hans Weber ist ein 52-jähriger Pt., der sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit drei /ein paar Monaten bestehender, starker, zunehmender, Schmerzen in der rechten Wade/im rechten Unterschenkel ohne Ausstrahlung vorgestellt hat. Der Pt. berichtet, dass die Schmerzen beim Laufen aufgetreten seien, sich nach einer Pause verbessert hätten. Deshalb müsse er nach 200-300 m Laufstrecke eine Pause machen. Zusätzlich teilt er mit, dass die Schmerzen 6-8 von 10 auf der Skala seien. Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint.

3-Begleitsymptome

Ferner sind dem Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

- Er klagt über kalte Haut und blasse Farbe an der rechten Wade/Unterschenkel
- Die Fragen nach Fieber, Hautausschlag, Schwellung, Rötung, Motorik- und Sensibilitätsstörung wurden vom Pt. verneint.

4. Vegetative Anamnese:

- unauffällig
- Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf Obstipation.

Vorerkrankungen:

- An Vorerkrankungen leide er an -Arterieller Hypertonie (Bluthochdruck) seit 10 Jahren,
 - Diabetes Mellitus (Zuckerkrankheit) seit 25 Jahren
 - Hyperlipidämie (erhöhten Blutfettwerten), Hypercholesterinämie.
 - Myokardinfarkt (Herzinfarkt) von 6 Jahren.
 - Der Pt. sei wegen einer Diskushernie (Bandscheibenvorfall) operiert worden.
- Der Impfstatus sei unbekannt.

5. Medikamentenanamnese:

Der Patient nehme folgende Medikamente regelmäßig ein:

- Ramipril 100 mg Å~2
- Metformin 500 mg x1
- ASS (1-0-0)

6. Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf pAVK hin. Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

- TVT -Diskushernie -Conarthrose

7. Maßnahmen

- Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen.
(Puls tasten –Schwellung –Rötung –Überwärmung -)
- Zur weiteren Abklärung sollten die folgende Maßnahmen durchgeführt werden:
 - 1 -Laboruntersuchung (Blutbild, CRP-BSG, D-Dimere, INR,
 - Bestimmung von Cholesterin, HDL, LDL und Triglyzeriden und HbA 1c
 - 2-Laufbandtest
 - 3-Messung der Doppler-Verschlussdrücke an beiden Füßen und Armen in Ruhe und bei Belastung
 - 4- Doppler-Sonografie- Farbduplexsonografie mit Bestimmung der Flussgeschwindigkeit zur Erfassung der Lokalisation und des Schweregrades einer Gefäßstenose
 - 5- Farbduplexsonografie
 - 6-Ct Angiographie
- Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor (nach Fontaine und Ratschow):
 - 1-Beschwerdefreiheit (Stadium I): Prophylaxe mit 100 mg ASS vermindern Risikofaktoren.
 - 2-Claudicatio-intermittens (Stadium II): Statine.

3-Ruheschmerzen im Liegen (Stadium III): Revaskularisation durch PTA (Perkutane transluminale Angioplastie).

4-Nekrotische Veränderung (Stadium IV): Revaskularisation. Antibiose bei Infektion. Gangrän--Amputation. Wundversorgung.

Mögliche Fragen in der Anamnese:

- Seit wann haben Sie die Schmerzen?
- Sind die Schmerzen plötzlich oder eher langsam aufgetreten?
- Sind die Schmerzen anhaltend oder wiederkehrend?
- Haben sich die Schmerzen im Laufe der Zeit verschlechtert?
- Gibt es einen bestimmten Auslöser für die Schmerzen?
- Wann treten Ihre Schmerzen genau auf?
- Haben Sie Schmerzen in den Beinen beim Gehen oder auch im Ruhe?
- Wie weit können Sie ungefähr schmerzfrei gehen?
- Lindert sich die Schmerzen in Ruhe?
- Haben Sie auch in der Nacht Schmerzen?
- Hatten Sie schon mal unter ähnlichen Beschwerden gelitten?
- Wo sind die Schmerzen genau lokalisiert?
- Strahlen die Schmerzen irgendwohinaus?
- Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10?
- Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben?
- Leiden Sie unter Schwächegefühl oder Muskelschmerzen?
- Können Sie Ihre Beine und Zehen bewegen?
- Haben Sie Kribbeln oder Taubheitsgefühl an der betroffenen Seite?
- Verspüren Sie eine Besserung beim Hochlagern oder Herunterhängen des Beines?
- Haben Sie Schwellungen in den Beinen bemerkt?
- Sind Ihnen Hautveränderungen wie Haarausfall, Blässe, Rötung aufgefallen?
- Fühlen sich Ihre Beine kalt oder warm an?
- Haben Sie Wunden oder Geschwüre an den Beinen oder Füßen bemerkt?
- Kann es sein, dass Sie von einem Insekt gestochen worden sind?
- Leiden Sie schon an einer Herz- oder Gefäßkrankheit?

Der Patient war der Walter Vögel, 74 Jahre alt, bringt 87 Kilo auf die Waage. Der kam zu mir, weil er seit 6-8 Monaten Schmerzen im rechten Unterschenkel hat. Die Schmerzen kamen und gingen und sind mit der Zeit schlimmer geworden. Wenn er saß, ging's ihm besser, aber beim Laufen wurde es echt mies. Beim Chillen

waren die Schmerzen bei der Null von 10 und beim Laufen ne satte 7. Hab ihn gefragt, ob er Kribbeln, Taubheitsgefühle, Lähmungen, Hautveränderungen, ob er sich verletzt hat, lange unterwegs war, ob's geschwollen, rot oder warm war – aber nix davon. Der Mann hat seit 12 Jahren Bluthochdruck, seit 7 Jahren Probleme mit dem Cholesterin, hatte vor 8 Jahren einen Herzinfarkt und vor 15 Jahren eine OP wegen dem Bandscheibenvorfall. Auf Penicillin reagiert er mit Ausschlag, also Finger weg davon. Er raucht 30 Kippen am Tag, schon seit 15 Jahren, und kippt täglich sein Feierabendbierchen, schon ewig lang. Drogen? Hab ich vergessen zu fragen.

Beruflich war er Busfahrer, ist verheiratet und hat zwei fitte Kids. Sein Vater ist an einem Herzinfarkt gestorben und seine Mutter leidet an Lungenkrebs.

Beim Arztgespräch ging's dann rund:

-Was ich als Diagnose auf dem Schirm habe: pAVK

-Was sonst noch infrage kommt: TVT, Erysipel, Spinalkanalstenose

-Was der Unterschied zwischen PAVK und TVT ist

-Dem Walter erklären, was er hat, wie's weitergeht und was für Behandlungen es gibt: Es handelt sich um eine Gefäßkrankheit, die mit Durchblutstörungen einhergeht. Wegen der Durchblutstörung leiden die Muskeln unter Sauerstoff- und Glukosemangel. Dieser Mangel führt zu Schmerzen und sichtbaren Hautveränderungen. Wir werden jetzt eine farbkodierte Sonografie durchführen, um die Beinschlagadern zu untersuchen und mögliche Verengungen festzustellen. Nach dem Nachweis der Verengung können wir mit einer Angiographie die betroffene Schlagader darstellen und sie mit Hilfe eines Ballons erweitern.

-Dann noch einen Schnack über die Duplex-Sonographie und die PTA halten.

Duplex-Sonographie: Es handelt sich um eine Ultraschalluntersuchung zur Beurteilung der Gefäße. Bei der Untersuchung wird ein Gel auf die Haut aufgetragen, damit der Schallkopf die Ultraschallwellen besser senden kann. Anschließend empfängt der Schallkopf die reflektierten Wellen und stellt daraus Bilder auf dem Bildschirm dar. Es ist eine schmerzfreie Untersuchung und es keine spezielle Vorbereitung erforderlich.

PTA:

Der Patient stellt sich heute bei uns in der Notaufnahme wegen seit 4 Monaten bestehender, zunehmender, krampfartiger, linksseitiger Wadenschmerzen vor. Er berichtet, die Schmerzen seien nach Gehstrecke von 100 m aufgetreten, und er brauche eine 5 Minuten

Pause um weiterzugehen.

Die Fragen nach Schwellung, Rötung, blasse Haut, Kühlung an der Betroffenen Stelle, Fieber, offene Wunde wurden verneint

VE: Diabetes Type 2 Arterielle Hypertonie.

Arzt-Arzt Gespräch:

-Diagnose? pAVK

-Körperliche Untersuchung und wo genau tasten sie den Puls? A.dorsalis pedis, A.tibialis lateralis

-Weiteren Untersuchung um Klassifikation zu bestätigen (Laufband)

-Duplexsonografie

-Therapie für 4 Stadien:

-Risikofaktoren: Rauchen, Diabetes mellitus, Hyperlipoproteinämie, Hypertonie,

Adipositas, Bewegungsmangel, Stress

-Was empfehlen Sie den Patienten:

-Ist die arterielle Hypertonie Stabil jetzt (ich habe den Patienten in die Anamnese nicht gefragt)

-Wie ist ihr Diabetes (auch in die Anamnese habe danach nicht gefragt)

-Wie heißt Pavk (Schaufenster Krankheit) warum heißt so? Nach außen sieht es oft so aus, als würden die Patienten vor einem Schaufenster stehen bleiben und etwas betrachten – daher der Name

„Schaufensterkrankheit“.

Patientenname: Warter Vogel

Alter: 67 Jahre alt, Größe: 167 cm, Gewicht: 76 kg

Allergien/ Unverträglichkeiten: Penicillin,

Die allergische Reaktionen: Exanthem, Pruritus.

Genussmittel/ Noxen:

Er sei Raucher seit 40 Jahren, 25 - 30 Zigaretten täglich.

Er trinke gelegentlich Alkohol (Bier)

Drogen wurden verneint.

Sport Anamnese: Er treibe keinen Sport.

Impfstatus: Sei vollständig.

Sozialanamnese:

Er sei Rentner, früher sei Busfahrer.

Er sei verheiratet und habe 2 erwachsenen Kindern.

Er wohne mit seiner Frau in einer Wohnung zusammen.

Familienanamnese:

Der Vater des Patienten sei an aHT verstorben.

Die Mutter des Patienten sei an DM Typ 2 verstorben.

Aktuelle Beschwerden: Herr Vogel ist ein 67 jähriger Patient, der sich heute bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit paar Tagen bestehender, stechender, krampfartiger, rechtsseitiger belastungsabhängiger Unterschenkel Schmerzen vorgestellt hat.

Er berichtete, dass er beim Gehen nach einer Strecke von 50-75 Meter diese Schmerzen verspüre, dann müsse er stehen bleiben und eine Pause machen. Er fügte hinzu, dass die Schmerzen im Laufe der Zeit schlimmer geworden und in Ruhe besser geworden.

B. Symptome: Er klagte über:

1. Kälte Haut des rechten Beins.

2. Beinödem

3. Rubor.

Vegetative Anamnese: Unauffällig bis auf:

Obstipation seit langem.
morgendlicher Reizhusten

Vorerkrankungen/Voroperationen: Er leide an die folgenden Erkrankungen:

1. Er habe einmal vor 8 Jahren Herzinfarkt gehabt, dagegen er Koronarangiografie mit Stent durchgeführt habe.
2. arterielle Hypertonie seit 6 Jahren.
3. Hypercholesterinämie
4. lumbal Diskusprolaps seit 15 Jahren.

Voroperationen: Er habe keine Operation gehabt.

Medikamentenanamnese:

1. Atorvastatin ... mg, 1.0.0
2. Bisoprolol ... mg, 1.0.0
3. Ibuprofen b.B.

Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf pAVK hin.

Differenzialdiagnosen:

tiefen Venenthrombose (TVT)
Spinalkanalstenose
Erysipel
Trauma (Unterschenkel Fraktur)

Maßnahmen:

Als erste Maßnahme würde ich den Patienten körperlich untersuchen: Vitalzeichen messen, Puls prüfen (A. dorsalis pedis, A. posterior tibialis um pAVK zu bestätigen. Mayer Zeichen, Player Zeichen, Homans-Zeichen um TvT auszuschließen.

Laboruntersuchung: BB, CRP, BSG, Entzündungsparameter, D.Dimer, INR, Gerinnungswerte, Lipidspiegel, HbA1C

Röntgen des rechten Beines um Fraktur auszuschließen.

EKG

Farbkodierte Duplexsonografie

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende **Therapie** vor,

1. Stationäre Aufnahme.
2. Analgetikum
3. Statin
4. Antikoagulation Therapie.
5. Kardiologisches Konzil veranlassen.
6. Lebensstilveränderung:
7. Tabakabstinenz
8. Alkoholabstinenz
9. Bewegungsaktivitäten
10. Nahrungsumstellung

Fragen:

1. Patienten Vorstellung
2. Duplexsonografie aufklären.
3. Gründen von Verdachtsdiagnose, Risikofaktoren.
4. DD warum TVT, warum Spinalkanalstenose, ...
5. Maßnahmen Schritt bei Schritt
6. Ob der Patient eine OP braucht oder nicht.
7. Was ist pAVK, Umgangssprache (Schaufensterkrankheit, warum wird Schaufensterkrankheit genannt).
8. Therapie
9. pAVK aufklären für den Patienten

Definition

Syn. Schaufensterkrankheit

Stenosierende und okkludierende Veränderungen der Aorta und Extremitätenarterien. In 90% der Fälle sind die Arterien der unteren Extremitäten betroffen.

Ursachen

✓ Arteriosklerose

✓ Risikofaktoren sind:

- Nikotinabusus
- arterielle Hypertonie
- Diabetes mellitus

✓ Thrombangitis obliterans (M. Winiwarter Buerger), sehr selten

Klinik

✓ belastungsabhängiger ischämischer Schmerz, distal der Stenose, der in Ruhe verschwindet (= claudicatio intermittens)

✓ Beschwerdefreiheit möglich bei ausreichender Ausbildung von Kollateralkreisläufen

✓ ischämischer Ruheschmerz

✓ Puls nicht mehr tastbar, bei Stenosen zu 90% des Lumens

✓ Blässe und Kälte der Extremität (bei akutem Verschluss)

Diagnostik

✓ Anamnese

✓ Labor: Blutbild, ggf. auch zum Ausschluss einer KHK oder AVK der Hirnnerven

✓ Inspektion: Hautfarbe und -temperatur, Nekrosen, Gangrän

✓ Pulsstatus und Auskultation

✓ bildgebende Verfahren

• Dopplerdruckmessung CW-Doppler, systolisch in Ruhe

• Sonografie

→ Doppler-Sonografie (direktional)

→ Farbduplexsonografie

• Angiografie

✓ 6-Minuten-Gehtest (standardisiert)

✓ pO₂, transkutan

✓ O₂ -Sättigung mit Pulsoximeter an der Großzehe

Therapeutische Maßnahmen

✓ Kausaltherapie, s. Risikofaktoren

✓ Physiotherapie: Förderung der Kollateralbildung

✓ Therapie der Grunderkrankung (ggf. Herzinsuffizienz)

✓ Durchblutungshemmende Medikamente (Betablocker) weglassen

✓ keine Kompressionsstrümpfe tragen

✓ Behandlung von Ulcera, Nekrosen und Gangrän

✓ medikamentöse Therapie:

• Thrombozytenaggregationshemmer (Stadium II)

• Antikoagulantien

✓ Revaskularisation: PTA und Stent perkutane transluminale Angioplastie

✓ Thrombendarteriektomie (selten)

✓ Bypass

✓ Amputation (Ultima Ratio)

Differentialdiagnostik

- ✓ orthopädische und neurologische Erkrankungen
 - Arthrosen, Wurzelreizsyndrome, Spinalkanalstenose, periphere Nervenläsionen
- ✓ venöse Abflussstörungen
- ✓ diabetische Neuropathie
- ✓ äthyltoxische Neuropathie (durch Alkoholabusus)

Spezielle Fragen bei V.a. pAVK und zur Differentialdiagnostik

- Haben Sie Schmerzen nach längeren Gehstrecken in den Beinen?
- Ja? Nach welcher Strecke oder Dauer ungefähr?
- Müssen Sie deswegen anhalten?
- Ja? Werden die Schmerzen danach weniger

Stadieneinleitung pAVK nach Fontaine

Stadium I: keine Beschwerden

Stadium II (Claudicatio intermittens): Belastungsschmerz

IIa) Gehstrecke > 200m

IIb) Gehstrecke <200m

Stadium III: ischämischer Ruheschmerz

Stadium IV: Schmerz und Nekrose/Ulkus/Gangrän

Pneumonie

1-persönliche Daten: Name: Herr Thomas Meis /Herr Jakup Mais / Herr Max Mais, Alter: 56 Jahre, Gewicht: 70 kg Größe: 167 cm

2- Allergie:Keine Allergien bekannt/ Allergie gegen Penicillin sei bei ihm bekannt, Er reagiere mit dickem Hals und Verschlucken

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: Nichtraucher/ 10 Zigaretten pro Tag seit 10 Jahren

Alkohol: Keiner / trinke selten Alkohol

Drogen: Keine/ Cocain, Marihuana.

Sport: keiner/ Schwimmen, Fahrradfahren

4- Sozialanamnese:

Familienstand: Herr Meis sei verheiratet, habe 2 gesunde Kinder/ keine Kinder), wohne mit seiner Frau zusammen.

Arbeit: Büroarbeiter, Angestellter im Finanzamt

5- Familienanamnese: Unauffällig

-Vater: gesund/ arterielle Hypertonie (Bluthochdruck)

-Mutter: an Brustkrebs /Pankreaskarzinom (Bauchspeicheldrüsenkrebs) gestorben

-Kinder: gesund. - Keine Geschwister.

2-aktuelle Beschwerden:

Herr Mais ist ein 56 -jähriger Pt., der sich heute Morgen bei uns wegen seit 7 Tagen aufgetretener, bestehender, Thoraxschmerzen (Brustschmerzen) mit bestehendem Husten vorgestellt hat. Der Pt. berichtet, dass die Schmerzen/ Husten vor einer Woche plötzlich aufgetreten seien und sich seit gestern verschlechtert hätten. Der Husten verstärkte sich besonders nachts und nach dem Essen. Zusätzlich teilt er mit, dass die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10 bei 6 liegen. Die Schmerzen seien atemabhängig und würden sich beim tiefen Einatmen verstärken. Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint. Einige seiner Mitarbeiter seien derzeit mit ähnlichen Symptomen krank. Er fügte hinzu, dass er dagegen ein Antitussivum (Codein) und ein Mukolytikum eingenommen habe, aber die Medikamente hätten ihm nicht geholfen.

3-Begleitsymptome

Ferner sind dem Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen: Er klagt über

- produktiven Husten mit gelbem Auswurf (seit 3 Tagen stärker geworden)
- Fieber über 40 Grad Celsius
- Schüttelfrost
- Dyspnoe (Atemnot)
- Schweißausbruch Nachtschweiß
- Engegefühl in der Brust
- Tachykardie (Herzrasen)

4. Vegetative Anamnese:

- Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf
- Insomnie (Durchschlafstörung) in den letzten Nächten wegen des Hustens
- Inappetenz (Appetitlosigkeit)
- Des weiteren klagt der Pt. über Gewichtsverlust von ca. 2 kg innerhalb einer Woche.
- der Impfstatus sei unbekannt
- die Reiseanamnese sei unauffällig.

Die Frage nach Hämoptyse (Bluthusten) wurde vom Patienten verneint.

Vorerkrankungen: An Vorerkrankungen leide er an

- DM (Zuckerkrankheit) seit 10 Jahren
- arterieller Hypertonie (Bluthochdruck) seit 4 Jahren / langer Zeit,
- Prostatakarzinom seit 3 Jahren.

Er wurde mit hormonaler Chemotherapie sowie chirurgisch behandelt.

Er besuche das Krankenhaus zweimal pro Monat wegen der Bestrahlungstherapie.

In der letzten Zeit sei er zweimal wegen Hyperglykämie (erhöhter Blutzuckerwerte) stationär aufgenommen worden.

5. Medikamentenanamnese:

- Der Pt. nehme zurzeit folgende Medikamente ein:
- Metformin 1000 mg 1.0.0 /Dosis sei nicht bekannt
- Diuretika 1.0.0 Ass -HTC 12.5mg
- Ramipril 10 mg 1-0-1-0
- Zytostatika (Chemotherapie) gegen Prostatakarzinom
- ASS

6. Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Pneumonie hin. Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

- 1- Akute Bronchitis.
- 3- Lungenembolie.
- 4- Bronchialkarzinom.
- 5- Spontan-Pneumothorax.
- 6- Myokardinfarkt.
- 7- Pleuraerguss.
- 8-Metastasen.
- 9-Lungentuberkulose

7. Maßnahmen: Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen.

Inspektion: Tachypnoe, Lippenzyanose, Nasenflügelatmung. Palpation: Stimmfrimitus ist verstärkt.

Perkussion: Klopfschalldämpfung

Auskultation: feinblasige Rasselgeräusche, abgeschwächtes Atemgeräusch.

-Zur weiteren Abklärung sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden:

- 1- Laboruntersuchung: BB - CRP- BSG (Blutsenkungsgeschwindigkeit), BGA, Blutkultur, Sputumkultur, Rachen-Nasen-Abstrich.
- 2- Bronchoskopie
- 3- EKG.
- 4- Röntgen-Thorax:
- 5- Lungenfunktionsprüfung.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor:

- 1- Stationäre Aufnahme.
- 2- Infusionstherapie + ausreichende Flüssigkeitsgabe.
- 3- Antibiotikum: sofort beginnen mit Penicillin oder Makroliden wie Clarithromycin, wenn Allergie gegen Penicillin beim Patienten bekannt ist.
- 4- Antitussivum (Codein-Tropfen), Mukolytikum.
- 5-Antipyretikum
- 6- Ggf. Sauerstoffgabe

Komplikationen:

- Pleuraerguss
- Empyem
- Sepsis

CURB-65 Score bei Pneumonie



Entscheidung über stationäre Aufnahme

Parameter Punkte

Confusion (Verwirrtheit): 1

Urea > 7 mmol/Lm 1

Respiratory Rate ≥ 30 : 1

Blood pressure <90/60: 1

Alter ≥ 65 Jahre: 1

≥ 2 Punkte $\rightarrow$ stationäre Aufnahme

≥ 3 Punkte $\rightarrow$ Intensivmedizin erwägen

Fragen:

- Ist der Husten trocken oder mit Auswurf?
 - Welche Farbe hat der Auswurf? Ist er gelblich, grünlich oder blutig?
 - Ist Ihr Husten anfallsartig oder wiederkehrend?
 - Hat der Husten plötzlich oder langsam begonnen?
 - Wird Ihr Husten nachts oder morgens stärker?
 - Gibt es Ihrer Beschwerden bestimmte Auslöser?
 - Seit wann haben Sie diese Beschwerden?
 - Ist das zum ersten Mal passiert?
 - Haben Sie Schmerzen in der Brust beim Atmen oder Husten?
 - Werden die Schmerzen beim Husten oder tiefem Einatmen schlimmer?
 - Strahlen die Schmerzen in den Rücken oder in die Schulter aus?
 - Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 schmerzfrei und 10 unerträgliche Schmerzen beschreiben?
 - Haben Sie ein Engegefühl in der Brust?
 - Haben Sie Atemnot?
- Falls ja: Wird Ihre Atemnot schlimmer bei Bewegung oder im Liegen?

Ulrich Mais, 59 Jahre

Hauptbeschwerde: Fieber, Schüttelfrost seit 3 Tagen und quälender Husten seit 1 Woche („Ich huste immer“) mit gelbem Auswurf. Keine Auslöser, Verstärkungs- oder Linderungsfaktoren sowie Abhängigkeit. Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde bejaht (Patient: „Ja, habe so mehrmals gehabt aber nicht so stark“). Damals wurde er mit „dicker Erkältung“ diagnostiziert. Die Einnahme von ACC und Paracodein-Tropfen hat eine kleine Verbesserung gebracht, besonders beim Schlafen („Ich schlafe besser mit diesen Tropfen“).

Begleitsymptome: Antriebslosigkeit, Fatigue.

Die Fragen nach Thoraxschmerzen, Dyspnoe, Anosmie, Ageusie, Tachykardie, Palpitationen, Hämoptoe und ähnliche Beschwerden in der Umgebung wurden verneint.

Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf Inappetenz und Insomnie, die sich mit der Einnahme von Paracodein-Tropfen verbessert hätte. Vorerkrankungen: aH,DM. Der Patient leide zurzeit an einem Prostatakarzinom, das mit Strahlentherapie behandelt sei wurde(Empathie zeigen).

Medikamente: Ramipril, Metformin, HCT.

Allergie: Penicillin (Exanthem).

Rauchen/Alkohol/Drogen:Verneint.

Reaktionen: Patient: „Was habe ich? Wie könnten Sie eine Lungenentzündung bestätigen?“ (Labor und Röntgen). „Ich rauche nicht und trinke nicht, und Sie fragen nach Drogen? Natürlich nein.“ Antwort: „Ja, Herr Mais, das habe ich mir schon gedacht, aber ich muss Sie fragen, um sicherzugehen.“ muss ich hier bleiben?

AA: Ich habe den Patienten präsentiert bis zu den Medikamenten. Danach wurde ich direkt nach der Diagnose gefragt:

- „Was ist besonders bei diesem Patienten?“ (Antwort: Strahlentherapie und DM=Immunsuppression).
- „Wie können wir die Sauerstoffsättigung messen?“ (Antwort: Fingerpulsoxymeter und BGA).
- „Werden Sie den Patienten stationär aufnehmen?“ (Antwort: „Ja, natürlich, wegen der Immunsuppression.“). Der Chefarzt hat mir gesagt, dass dieser Patient intensiv aufgenommen werden sollte.
- Was finden Sie Im Röntgen ?(Infiltration /bronchiektasie)
- Was erwarten Sie vom Labor ?(leukozytose/Crp erhöht)
- Sputum kultur ist auch sehr wichtig mich Antibiotogramm.

Herr Mais, 56 Jahre. 1,70 m 70 kg

Allergien: Penicillin (Exanthem)

Verheiratet / zwei gesunde Kinder.

Arbeit: Angestellter.

Vater: gesund, Mutter: Pankreaskarzinom (gestorben)

Rauchen: unauffällig. Alkohol: 1 Glas Wein am Wochenende.

Er kam heute zu uns mit seit 3 Tagen bestehendem, plötzlich aufgetretenem progredientem Fieber 40°.

Begleitend habe er Schüttelfrost, Husten mit gelbem schleimigem Sputum, Schweißausbruch, Dyspnoe, Insomnie und Thorakalgie ohne Ausstrahlung. Dagegen habe er Paracetamol 500mg, Aspirin und Codein eingenommen und das habe ihm nicht geholfen.

Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf Inappetenz.

Die Sexualanamnese ergab Impotenz.

Die Vorerkrankung-Anamnese ergab Diabetes mellitus seit 12 Jahren, mit Metformin 850mg behandelt, arterielle Hypertonie seit 5 Jahren, wogegen er Linopril 5mg (1.0. .5) und HCT 12,5mg (1.0.0) nehme.

Z.n. Prostatakarzinom vor 2 Jahren, das mit Prosastektomie und Zytostatika behandelt wurde.

Es besteht der Verdacht auf Pneumonie.

Als **Differenzialdiagnosen** kommen Influenza und Covid-19 in Betracht.

Weitere Maßnahmen sind: -Körperliche Untersuchung. -Laboruntersuchung: BB, CRP, BSG, BGA, Sputum und Blutkultur.

-Als bildgebende Untersuchungen (Röntgen und C. T des Thorax. -Nasen-Rachen Abstrich.

Arzt-Arzt Gespräch:

Ich habe nur die aktuelle Anamnese präsentiert, und dann fing er an zu fragen. Das Gespräch hat ungefähr 15 Minuten gedauert. (Jede Antwort muss ein vollständiger Satz sein, aber ich werde mich kurz äußern)

- Welche Verdachtsdiagnose haben Sie? *Pneumonie*
- Welche Risikofaktoren für Pneumonie hat der Patient? *er klagt an D.M und arterielle Hypertonie, und Z.n Zytostatika und alle diese Risikofaktoren neigen zu Pneumonie.*
- Gibt's eine Verbindung zwischen HCT und Pneumonie?
- Was ist HCT? Es ist eine Abkürzung für Hydrochlorothiazide und wirkt auf die distalen gewundenen Tubuli.
- Was sollen Sie machen? Körperliche Untersuchung als erste Maßnahme.
- Was erwarten Sie bei? *Inspektion: Zyanose, Tachypnoe, Palpation: Stimmfrimetus ist verstärkt.*
- Auskultation: Rasselgeräusche, Perkussion: Klopfeschalldämpfung.*
- Oberarzt: Bezüglich der Laboruntersuchungen, was erwarten Sie?
- BB Leukozytose (neutrophile) CRP und BSG erhöht.*
- Ist HbA1c wichtig? *ja, es ist sehr wichtig.*
- Warum? wenn HbA1c erhöht, ich denke an die Komplikationen, und Pneumonie gilt als Komplikation des D.M und auch Immunsystem.

- Was erwarten Sie bei Röntgen: Infiltrat
- In welche Lappen? ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
- Oberarzt: welche Therapie? *Allgemeine Maßnahmen..... der Patient hat Penicillin Allergie, deshalb werde ich Penicillin vermeiden, und danach werde ich empirische Antibiotika geben.*
- Welche Antibiotika? *Makrolid z.B Clarithromycin*
- Gibt's andere Antibiotika? *Ceftriaxon*
- Welcher Typ von Pneumonie hat der Patient? *ambulant erworbene Pneumonie*
- Warum? *Während dieser letzten Tage gibt es keine Hospitalisierung*

Definition

Entzündung des Alveolarraumes und/oder des Interstitiums, die chronisch oder akut verlaufen kann.

Ursachen

- ✓ Infektion durch:
 - Pneumokokken, Staphylokokkus aureus, Haemophilus influenzae, Mykoplasmen, Chlamydien, Legionellen
 - Parasiten, Pilze, Viren (v.a. bei immungeschwächten Patienten)
 - nosokomial: MRSA
- ✓ Noxen (Gifte)
- ✓ Aspiration von Fremdkörpern

Klinik

- ✓ plötzlicher Beginn
- ✓ grippeähnliche Symptome: (hohes) Fieber, Schüttelfrost, Husten
- ✓ ggf. Atemnot
- ✓ rotbraunes Sputum oder trockener Reizhusten mit spärlichem Auswurf, produktiver Husten
- ✓ Dyspnoe, Thoraxschmerzen

Diagnostik

- ✓ Anamnese: Fieber, Husten, Auswurf
- ✓ Auskultation: Stimmfremitus, Rasselgeräusche
- ✓ Blutbild: BSG, CRP, Leukozytose,...
- ✓ BGA, Pulsoximetrie, Sputumanalyse, Erregernachweis
- ✓ Röntgen Thorax in 2 Ebenen
- ✓ ggf. Urintest (bei V.a. Legionellenpneumonie)
- ✓ Bronchoskopie (selten)

Therapeutische Maßnahmen

- ✓ allgemeine Maßnahmen
 - körperliche Schonung
 - ausreichend Flüssigkeitszufuhr
 - Sauerstoff per Nasensonde bei Hypoxie
 - Atemtherapie und Inhalation
- ✓ medikamentöse Therapie: Antibiotika

Differentialdiagnostik

Lungentuberkulose, Bronchialkarzinom, Sarkoidose, Bronchitis, allergische bronchopulmonale Aspergillose; Lungenmykose, Lungenembolie, Lungenödem

Influenza (Grippe)

1-Persönliche Daten: Name: Frau Ina Wieland/Doro Wieland, Alter: 46 Jahre, Gewicht: 76 kg, Größe: 1.75 m

2-Allergie: Keine Allergien bekannt/ Allergie gegen Jod sei bei ihr bekannt.

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: Nichtraucherin,

Alkohol: trinke sehr selten Alkohol,

Keine Drogen.

Sport: sie treibe oft Sport (Nordic Walking und Gymnastik)

4- Sozialanamnese: Familienstand: Die Pt. sei verheiratet und habe 3 Kinder. Sie wohne zusammen mit ihrem Ehemann und ihren Kindern.

Arbeit: Sie sei Hausfrau/Angestellte in einer Uhrenfabrik von Beruf

5- Familienanamnese: -Unauffällig/

-Der Vater: Apoplex (Schlaganfall); er habe jetzt eine leichte Behinderung

-Die Mutter: gesund

-Keine Geschwister

-Die Kinder seien gesund

2-aktuelle Beschwerden:

Frau Doro Wieland ist eine 46-jährige Pt., die sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit gestern bestehendem trockenem Husten, begleitet von Thoraxschmerzen ohne Ausstrahlung, vorgestellt hat. Die Pt. berichtet, dass die Schmerzen langsam/plötzlich aufgetreten seien und sich im

Verlauf verschlechtert hätten. Zusätzlich teilt sie mit, dass die Schmerzenvon 10 auf der Skala seien und vom an

gewandert seien. Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint/bejaht.

3-Begleitsymptome

Ferner sind der Patientin folgende Begleitsymptome aufgefallen:

-Cephalgie (Kopfschmerzen)

-Fieber (39 C°).

-Schnupfen,

-Gliederschmerzen (Ostealgie)

-Halsschmerzen beim Husten

-Dysphagie (Schluckstörung)

-Abgeschlagenheit

Darüber hinaus klagt die Pt. über einen zunehmenden verschlechterten AZ.

4. Vegetative Anamnese:

-Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf

-Inappetenz, Durst

-Schüttelfrost

-Schweißausbrüche

-Insomnie (Schlafstörungen) wegen Hustens in der Nacht und ihres zweijährigen Sohnes

Vorerkrankungen:

- Es seien keine relevanten Vorerkrankungen bekannt.

- An Vorerkrankungen leide sie an -DM Typ 1 (Zuckerkrankheit) seit 25 Jahren

Sie sei zweimal aufgrund eines hyperglykämischen Schocks ins Krankenhaus aufgenommen worden.

Die Patientin sei nicht operiert worden.

-Sie sei gegen alle Kinderkrankheiten und jährlich gegen Grippe geimpft.

Die Reiseanamnese sei unauffällig.

5. Medikamentenanamnese:

-Die Pt. nehme zurzeit keine Medikamente ein/

1. Insulin (Bolus) Spritzen (4mal/d)
2. ASS 100 mg (1-0-0)

Sie habe wegen des Fiebers Paracetamol 500 mg eingenommen.

6. Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Influenza hin. Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

- 1-Pneumonie,
- 2- Pneumothorax
- 3- Bronchitis
- 4-Laryngitis

7. Maßnahmen: Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen. Zur weiteren Abklärung sollten die folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- Labordiagnostik (BB,BSG ;CRP, Nasen- und Rachenabstriche
- Influenza-Virus-RT-PCR (diagnostischer Goldstandard) Nachweis von Virus-RNA aus Nasen- und Rachenabstrichen)
- Influenza-Schnelltest innerhalb von 24–48 Stunden
- Röntgen-Thorax
- EKG

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:

Ausreichende Flüssigkeitszufuhr

Fiebersenkende Maßnahmen

Medikamente, Analgetika (z.B. Ibuprofen und Paracetamol)

Bei trockenem, unproduktivem Husten ggf. Antitussiva (z.B. Dihydrocodein)

Bei schweren Verläufen: Stationäre Aufnahme und Isolierung über mind. 7 Tage

Fragen:

- Wann haben Sie zum ersten mal Beschwerden bemerkt?
- Sind die Beschwerden plötzlich oder eher langsam angefangen?
- Gibt es einen bestimmten Auslöser für die Schmerzen?
- Hatten Sie Fieber? Haben Sie es gemessen? Wie hoch war es?
- Seit wann haben Sie Fieber?
- Schwitzen oder frieren Sie?
- Hat jemand in Ihrem Umfeld ähnliche Beschwerden?
- Haben Sie Glieder-, Gelenk- oder Kopfschmerzen?
- Haben Sie Heiserkeit oder Schluckbeschwerden?
- Haben Sie Atemnot oder ein Engegefühl in der Brust?
- Haben Sie Husten? Wenn ja: Ist er trocken oder mit Auswurf?
- Seit wann haben Sie Husten?
- Sind Ihnen vergrößerte Halsknöpfe aufgefallen?
- Ist Ihr Nase verstopft?
- Leiden Sie unter Appetitlosigkeit?
- Besteht Ihnen Geschmacks- oder Geruchsverlust?

Herr Mais Klaus, ein 58 Jahre Patient stellte sich mit seit 3 Tagen plötzlich mit Fieber 40 grad, seit 5 Tagen Husten mit Auswurf als gelblich und grünlich beschrieben und mit Schüttelfrost begleitend und Belastungsabhängige Dyspnoe vor.

Gegen Fieber Ibuprofen 600mg bei Bedarf eingenommen und ACC 600 um Husten zu lindern und Codein tropfen, weil er unter Schlafstörung aufgrund Husten klagte. Appetitverminderung seit beginn der Beschwerden.

Z.n Prostata Karzinom seit 1 Jahr, mit Strahlentherapie, z.n Diabetes typ2 mit Metformin 1-0-0 dosis unbekannt, z.n arterielle Hypertonie mit Ramipril 5mg 1-0-1/2 und HCT 1-0-0.

Penizillin allergie seit 5 Jahre bekannt äußert sich durch Hautausschlag DD Pneumonie, Bronchitis, Covid 19

Diagnostische Maßnahmen KU, BB, CRP, BSG, Auswurf für Erregernachweis und Resistenztests zu bestimmen. Röntgenaufnahme

Therapie: Stationäraufnahmen, Antibiotikum (Azithromizin, Clarithromicin aufgrund Penizillinallergie), Sauerstoff bei Bedarf, Symptomatische Behandlung.

Definition

Influenza (Einzelstrang-RNA-Viren) ist eine durch das Influenzavirus verursachte Erkrankung der Atemwege. Hierdurch wird die Schleimhaut (Mucosa) der Atemwege angegriffen und das Eindringen anderer pathogener/toxischer Erreger erleichtert. Das Influenzavirus ist sehr ansteckend.

Übertragung

Die Übertragung von Influenzaviren erfolgt meist durch das Einatmen (Inhalation) von infizierten Partikeln (Tröpfcheninfektion bei Husten und Niesen). Es sind aber auch Schmier- und Kontaktinfektionen möglich. Niedrige Luftfeuchtigkeit und Kälte begünstigen die Übertragung der Viren. Deshalb kommt es zu einer Häufung von Infektionen während der Herbst- und Wintermonate.

Symptome

Typisch ist ein plötzlicher und heftiger Ausbruch der Krankheit. Die Symptome gleichen zum Teil denen einer starken Erkältung, meist sind sie jedoch stärker ausgeprägt:

- Husten
- Fieber
- Halsschmerzen
- Kopfschmerzen
- Gliederschmerzen
- Schüttelfrost

Mehrtägiges Fieber von 39 bis 40 Grad ist möglich. Komplikationen können Kreislaufschwäche, Entzündung des Nervensystems und der Lunge sein.

Diagnostik

Eine endgültige und sichere Diagnostik der Influenza nur durch labormedizinische Untersuchungen erfolgen. Bei Influenzapneumonie finden sich im Röntgen-Thorax i.d.R. eine segmentale alveoläre Verschattung oder mehrere 1-2 cm große Herde, die zur Konfluenz neigen. Die Befunde können ein- oder beidseitig vorliegen.

Es gibt Influenza-Schnelltests zum raschen Nachweis von Influenza-Antigenen (Typ A und Typ B). Sie finden beispielsweise in Arztpraxen oder Notaufnahmen Anwendung. Ein positives Ergebnis im Schnelltest sollte im Zweifelsfall durch eine PCR bestätigt werden. Die PCR ist heutzutage als Goldstandard der Influenza-Diagnostik anzusehen. Sie dient dem sicheren Nachweis viraler RNA.

Der indirekte Nachweis einer Infektion umfasst die Bestimmung der Influenza-Antikörper (insbesondere IgA und IgG) im Serum.

IgA- und IgG-Antikörper sind etwa 5 bis 10 Tage nach Infektionsbeginn im Serum nachweisbar. Während IgA-Titer nach etwas einem Monat wieder in ihrer Serumkonzentration abfallen, sind IgG-Titer teilweise länger als ein Jahr im Serum nachweisbar. IgA-Antikörper sind nicht bei jedem frischen Infekt und nicht bei jedem Patienten nachweisbar.

Therapie

- Bettruhe
- Körperliche Schonung
- Ausreichende Flüssigkeitszufuhr

-Zur Verhinderung oder Therapie von Sekundärinfektionen kann der Einsatz von Antibiotika sinnvoll sein. Bei sehr hohem Fieber ist zudem die Gabe von Antipyretika (z.B. Paracetamol) zu erwägen.

Verlauf

Die akute Erkrankung klingt in der Regel etwa nach 5 bis 7 Tagen ab. Einzelne Symptome (z.B. Husten, Abgeschlagenheit) können jedoch noch über einen längeren Zeitraum weiter bestehen. Je nach Schwere der durchgemachten Erkrankung ist eine Rekonvaleszenz über Tage, aber auch über Wochen möglich.

Pertussis (Keuchhusten)

1- persönliche Daten: Herr Peter Kaiser, 72 Jahre alt, 1.78 m groß, 78 kg schwer

2-Allergie: Der Patient habe eine Allergie gegen Hausstaub.

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: 1 Packung täglich seit 50 Jahren (50 Py).

Alkohol: 1-2 Flaschen Bier täglich.

Keine Drogen.

Sport: Zu seinen sportlichen Aktivitäten gehört Fahrradfahren (E-Bike).

4- Sozialanamnese:

Familienstand:verheiratet - 2 gesunde Kinder. Er lebe zusammen mit seiner Familie.

Arbeit: Herr Kaiser sei Rentner und er habe als Erzieher gearbeitet.

5- Familienanamnese:

-Vater: Myokardinfarkt (Herzinfarkt)

-Mutter: verstorben.

-Der Bruder: Bronchialkarzinom, er sei daran gestorben.

Schwester: Diabetes mellitus Typ 1

2-aktuelle Beschwerden:

Herr Kaiser ist ein 72-jähriger Pt., der sich heute Morgen bei uns wegen eines seit 3 Wochen bestehenden, trockenen Hustens vorgestellt hat. Der Pt. sei wegen dieser Beschwerden bei Hausarzt, dieser habe ihm ACC gegen Husten verschrieben, aber die Tabletten hätten ihm nicht geholfen. Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint.

3-Begleitsymptome

Ferner sind dem Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

-Fieber bis 39,7 C

-Nausea (Übelkeit)

4. Vegetative Anamnese: Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf

-Appetitlosigkeit

-Insomnie

Vorerkrankungen:

-Arterielle Hypertonie seit 25 Jahren, die mit behandelt werde.

-Diabetes mellitus Typ 2 seit 15 Jahren,

Benigne Prostatahyperplasie seit 5 Jahren, mit Inkontinenz.

Es wurde bei dem Pt. eine Cholezystektomie vor 25 Jahren durchgeführt.

Die Reiseanamnese sei unauffällig.

Sein Impfstatus sei vollständig.

5. Medikamentenanamnese:

-Der Pt nehme zurzeit keine Medikamente ein.

Herr Kaiser nehme die folgenden Medikamente ein:

- B-Blocker 1-0-0 und Diuretika 1-0-0
- Metformin 1-0-0 (die Dosierung sei ihm nicht rememberlich)
- Prostagutt

6. Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Pertussis hin. Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

- Pneumonie
- Bronchitis
- COPD
- Asthma
- Fremdkörperaspiration

7. Maßnahmen

-Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen. Zur weiteren Abklärung sollten folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- 1- Laboruntersuchung: BB - CRP- BSG -BGA, Sputumkultur, Rachen-Nasen Abstrich.
- Pertussis-PCR
- ELISA zum Nachweis von AgG Antikörpern
- 2- Bronchoskopie:
- 3- EKG:
- 4- Röntgen-Thorax:
- 5- Lungenfunktionsprüfung.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:

- 1- Stationäre Aufnahme.
- 2- Ausreichende Flüssigkeitszufuhr
- 3- O2-Gaben
- 4- Die Therapie der Wahl ist die Gabe von Makrolid antibiotika
 - Erythromycin (40-50 mg/kg KG über 14 Tage).
 - Azithromycin (10-12mg/kg KG)
 - oder Clarithromycin (15-20 mg/kg KG)
- Salbutamol

Fragen:

- Seit wann besteht der Husten?
- Ist ihr Husten langsam oder plötzlich aufgetreten?
- Ist Ihr Husten anhalten oder anfallsartig?
- Ist der Husten trocken oder mit Auswurf?
- Falls mit Auswurf ist: welche Farbe und Konsistenz ist die Auswurf?
- Hat sich der Husten verstärkt oder verändert?
- Gibt es Personen in Ihrem Umfeld mit ähnlichen Beschwerden?
- Haben Sie Atemnot beim Husten?
- Müssen Sie nach dem Husten würgen oder erbrechen?/Kommt es nach dem Husten zum Würgen oder Erbrechen?
- Haben Sie bereits Medikamente gegen Husten eingenommen?
- Haben oder hatten Sie Fieber?
- Verspüren Sie beim Husten Schmerzen in der Brust oder im Bauch?
- Sind Sie gegen Keuchhusten geimpft?
- Waren Sie bereits beim Arzt wegen dieser Beschwerden?/Waren Sie deswegen schon beim Arzt?

Wie nachweisen wir eine Pertussis hin? Rachen Abstrich

Wie gehen wir weiter nach Abstrich? Molekulare PCR

Wie ist die Therapie? wie Protokoll

Wie gehen wir in schwer verlauf vor? Stationiert + isoliert —> bis Künstlich Beatmung

Nennen Sie die verschiedene Krankheit Stadium (ich habe vergessen.

Stadium catarrhal (kataral dönem)

Stadium convulsivum (konvulsif dönem)

Stadium decrementi (iyileşme dönemi)

Definition

Pertussis ist eine hoch ansteckende Infektionskrankheit, die meist durch das Bakterium Bordetella pertussis ausgelöst wird.

Symptome

Nach einer Inkubationszeit von 7 bis 20 Tagen beginnt die Erkrankung in der Regel mit typischen Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen und leichtem Fieber. Diese Symptome können bis zu 2 Wochen andauern (Stadium catarrhale).

Es kommt zu heftigen stakkatoartigen (art arda gelen, kısa, kuru ve kesik kesik öksürük) Hustenstößen mit herausgestreckter Zunge in Salven (atak) von 15-20. Dabei wird ein zäher, glasiger Schleim herausgewürgt. Diagnostisch wichtig sind auch die inspiratorisch hörbaren keuchenden Geräusche. Eine Zyanose ist oft sichtbar, die durch die anhaltende Luftnot entsteht. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Stimm lippenkrampf (Laryngospasmus (ses tellerinin ani kasilması)) kommen, was zur Apnoe führt. Die Hustenattacken können bis zum Erbrechen führen und - vor allem bei Erwachsenen - auch nach Abklingen der Infektion noch mehrere Wochen anhalten (Stadium decrementi).

Diagnostik

-Blutbild: Lymphozytose (>20.000)

-Erregernachweis: Der direkte Erregernachweis (Kultur, PCR) gelingt insbesondere in den ersten 2 Wochen nach Krankheitsbeginn (Stadium catarrhale) und kurz danach. Erst im anschließenden Stadium convulsivum lassen sich als indirekter Erregernachweis spezifische Antikörper gegen Bordetella pertussis serologisch nachweisen.

Beweisend ist die Anzüchtung von Bordetella pertussis aus dem Rachenabstrich in der Kultur.

Therapie

Die Behandlung erfordert - vor allem bei Kindern und Patienten mit schwerer Symptomatik - häufig einen stationären Aufenthalt. Die Therapie der Wahl ist die Antibiotikagabe, in der Regel Erythromycin (40-50 mg/kg KG über 14 Tage). Als Alternative kommt die Therapie mit neueren Makrolidantibiotika wie Azithromycin (10-12mg/kg KG) oder Clarithromycin (15-20 mg/kg KG) in Frage.

COPD (Chronic obstructive pulmonary disease) (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung)

1- Persönliche Daten: Herr Anton Schulz/Kaiser, 74 Jahre, 197cm groß, 120 kg schwer

2-Allergie: Hausstaub. Er reagiere auf Hausstaub mit Rhinitis (Schnupfen) und Husten

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: 25 Zig./Tag seit 20 Jahren (P/Y 25)

Alkohol: er trinke keinen Alkohol.

Keine Drogen.

Sport: Fahrradfahren.

4- Sozialanamnese:

Familienstand: Er sei verheiratet und habe 2 gesunde Kinder.

Arbeit: Herr Schulz sei Rentner.

5- Familienanamnese:

-Vater: an Myokardinfarkt gestorben.

-Mutter: gesund

-Der Bruder leide an Bronchialkarzinom.

2-aktuelle Beschwerden:

Herr Schulz ist ein 74-jähriger Pt., der sich heute Morgen bei uns wegen seit 3 Monaten aufgetretenem, bestehendem Husten mit weißem schleimigem Auswurf vorgestellt hat. Der Pt. berichtet, dass die Beschwerden seit langsam/plötzlich aufgetreten seien und sich seit gestern verschlechtert hätten. Es gebe keine Faktoren, die den Husten verstärken oder lindern. Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint/bejaht.

3-Begleitsymptome

Ferner sind dem Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

- Brustschmerzen
- Atemnot

4. Vegetative Anamnese:

- Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf
- Inappetenz (Appetitlosigkeit) seit gestern.
- Insomnie (Schlafstörungen)

Die Frage nach Gewichtsveränderung, Fieber, Schüttelfrost und Problemen beim Stuhlgang, Wasserlassen wurden verneint.

Vorerkrankungen:

- Arterielle Hypertonie seit 10 Jahren
- Diabetes Mellitus seit 15 Jahren bekannt.
- Benigne Prostatahyperplasie (seit 2 Jahren)

Es wurde bei dem Patienten mit 30 Jahren eine Cholezystektomie (Gallenblasenentfernung) durchgeführt.

Der Impfstatus sei komplett.

Die Reiseanamnese sei unauffällig.

5-Medikamentenanamnese:

- Der Pt. nehme zurzeit keine Medikamente ein/
- Die Patientin nehme
- Metformin 500mg 1-0-1
- B-Blocker – Metoprolol 25mg
- Hustenmittel
- Diuretikum. Die Dosis sei unbekannt.

6. Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf COPD hin. Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

- Pertussis.
- Pneumonie.
- Sarkoidose.
- Bronchialkarzinom. -TB.

7. Maßnahmen

- Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen.

-Zur weiteren Abklärung sollten folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

1-Labor: BB-CRP-BSG-2-Lufu (Lungenfunktionsprüfung), verminderte FEV1; die Einsekundenkapazität weniger als 70 % des Normalwerts.

3-BGA

4-EKG und Echo: Auskunft über die Herzfunktion. Es kann Hinweise auf einen erhöhten Lungendruck (pulmonale Hypertonie) und damit eine Rechtsherzbelastung geben.

5-Röntgen-Thorax und CT: Es lassen sich etwa Lungenentzündung, Lungenstauung (pulmonary vascular congestion), Pneumothorax und Tumoren erkennen.

6-Bronchoskopie

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:

- 1- Aufhören zu rauchen
- 2-Impfungen: Grippeimpfung (Influenza). Pneumokokkenschutzimpfung.

3-Medikamentöse Therapie: Inhalative Glukokortikoide. Beta-2-Sympathomimetika: Salbutamol, Theophyllin. Es sollte nur als dritte Wahl bei der COPD-Therapie eingesetzt werden.
Schleimlösende Medikamente (Expektorantien/Mukolytika).
4-Operative Therapie: Bullektomie. Lungentransplantation.
5-Behandlung akuter Exazerbationen (deutlicher Verschlechterungen): Antibiotika.
Sauerstoffgabe oder Beatmung.

Mögliche Fragen:

- Seit wann bestehen die Beschwerden?
- Sind die Beschwerden plötzlich oder eher langsam angefangen?
- Hatten Sie schon mal ähnliche Beschwerden?
- Seit wann haben Sie Atemnot?
- Ist das zum ersten Mal passiert?
- Wann sind die Beschwerden zum ersten Mal aufgetreten?
- Wie oft haben Sie Atemnotfall?
- Haben sich die Beschwerden im Laufe der Zeit verschlechtert?
- Gibt es bestimmte Auslöser für Ihre Atemnot?
- Haben Sie Atemnot nur bei Belastung oder auch in Ruhe?
- Bei welchen körperlichen Aktivitäten bekommen Sie Atemnot?
- Ist die Atemnot lageabhängig? Bekommen Sie auch Atemnot im Liegen?
- Wie viele Kissen brauchen Sie beim Schlafen?/Brauchen Sie beim Schlafen Ihren Oberkörper erhöhen, um besser Luft zu bekommen?
- Seit wann haben Husten?
- Hat sich der Husten in Intensität verändert?
- Ist Ihr Husten trocken oder mit Auswurf?
- Wie ist die Farbe und Konsistenz des Auswurfs?
- Ist der Auswurf gelb, grün, klar oder blutig?
- Ist der Auswurf eher dünnflüssig oder zäh?
- Tritt der Husten eher morgens, tagsüber oder nachts auf?
- Könnten Sie bitte die Auswurfmenge einschätzen?
- Haben Sie Blut im Auswurf bemerkt?
- Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Lunge pfeift oder rasselt?
- Ist Ihr Husten anhalten oder wiederkehrend?
- Leiden Sie unter Hustenattacken?
- Haben Sie etwas gegen Husten eingenommen? Hat es Ihnen geholfen?
- Fühlen Sie sich oft müde oder schwach?
- Haben Sie kalte und bläulich verfärbte Lippen und Finger bemerkt?
- Wie sehen Ihre Nägel aus? (Trommelschlägelfinger?)
- Haben Sie Schwellungen an den Beinen bemerkt? (Rechte herzinsuffizienz?)
- Haben Sie Fieber oder Schüttelfrost?
- Haben Sie Brustschmerzen oder Kopfschmerzen?
- Haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab- oder zugenommen?
- Sind Ihnen Gewichtsveränderungen aufgefallen?
- Leiden Sie unter Schlafstörungen?
- Haben Sie gleiche Beschwerden früher gehabt?
- Haben Sie allergien oder Asthma?

Definition

Ihr liegt eine chronische Bronchitis zugrunde, die mit einem Lungenemphysem einhergeht. Eingeatmete Partikel des Zigarettenrauchs löst eine Entzündungsreaktion in den Atemwegen aus.

Chronische Bronchitis: Husten und Auswurf bestehen bei einem Patienten in 2 aufeinanderfolgenden Jahren während mindestens 3 aufeinanderfolgenden Monaten (laut WHO)

Lungenemphysem: Irreversible Erweiterung und Zerstörung der Alveolen

Ursachen

- ✓ inhalative Noxen: Tabakrauch, Stäube, Schwefeldioxid, Stickoxide, saure Aerosole, Feinstaub
- ✓ Beruf ist wichtig: Personen, die im Rahmen ihrer Beschäftigung organischen oder anorganischen Stäuben, toxischen Gasen oder Lösungsmitteldämpfen ausgesetzt sind, haben ein erhöhtes COPD-Risiko

Klinik

- ✓ AHA: Atemnot, Husten, Auswurf=> vor allem morgens
- ✓ Exazerbation:
 - Dyspnoe bei Belastung oder in Ruhe
 - vermehrter Husten
 - Sputumzunahme und erhöhte -viskosität, in gelbgrüner Färbung
- ✓ Zyanose
- ✓ Engegefühl in der Brust
- ✓ Einsatz der Atemhilfsmuskulatur, Fassthorax
- ✓ Trommelschlägelfinger

Diagnostik

- ✓ Anamnese: 90 % der COPD-Patienten sind (Ex-) Raucher
- ✓ körperliche Untersuchung (Fass-Thorax): Häufig zeigt sich ein Einsatz der Atemhilfsmuskulatur. Befunde in der Auskultation der Lunge sind eine verlängerte Expiration, Pfeifen, Giemen, Brummen sowie ein abgeschwächtes Atemgeräusch. Bei der Perkussion kann ein hypersonorer Klopfeschall detektiert werden. Die Lungengrenzen sind typischerweise kaum verschieblich.
- ✓ Röntgen Thorax: in 2 Ebenen.
- ✓ Lungenfunktionsdiagnostik: Spirometrie
- ✓ BGA
- ✓ EKG und Echokardiografie: zeigen die Rechtsherzbelastung
- ✓ CT: zur Beurteilung des Lungenemphysems

Therapeutische Maßnahmen

- ✓ Meiden von Noxen
- ✓ medikamentöse Therapie: inhalative Glukokortikoide, Anticholinergika, β 2-Sympathikomimetika
- ✓ Sauerstofftherapie bei schwerer COPD
- ✓ Mukopharma (z.B. Acetylcystein)
- ✓ Impfung: Influenza, Streptococcus pneumoniae
- ✓ Physiotherapie: Atemtherapie
- ✓ Antibiotika: bei akuter und häufiger Exazerbation, bei beatmeten Patienten und kardialer Komorbidität (Erkrankungen des Herzens)

Differentialdiagnostik

Linksherzinsuffizienz, Bronchialkarzinom, akute Bronchitis, Bronchiektasie, Asthma bronchiale, Sarkoidose

Schlafapnoe

1-Persönliche Daten: Herr Max Müller, 61Jahre alt, 181cm groß, 91 kg schwer

2-Allergien: Er reagiere allergisch auf Aspirin mit Quaddeln (Urtikaria)-Pencillinallergie

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: 20 Zigarillos (kleine Zigarren) täglich seit 20 Jahren

Alkohol: zwei Flaschen Bier täglich und am Wochenende mehr

Keine Drogen.

Sport: Er treibe keinen Sport.

4- Sozialanamnese:

Familienstand: Der Patient sei verheiratet und lebe mit seiner Frau zusammen.

Arbeit: Er sei LKW-Fahrer/Kraftfahrer von Beruf, aber jetzt könne er wegen seiner Müdigkeit nicht mehr arbeiten.

5- Familienanamnese:

-Vater: DM Diabetes mellitus seit Jahren

-Mutter: an Bronchialkarzinom (Lungenkrebs) gestorben

-2 Söhne: gesund.

2-aktuelle Beschwerden:

Herr Müller ist ein 61-jähriger Pt., der sich heute Morgen bei uns wegen erstmaliger Müdigkeit seit drei Monaten vorgestellt hat. Zusätzlich teilt er mit, dass er eine Einweisung von seinem Hausarzt dabei habe mit den folgenden Ergebnissen:

1)Körperliche Untersuchung unauffällig

2)Laboruntersuchung unauffällig

3)Röntgen des Thorax unauffällig, er leide an COPD

4)CT des Thorax keine Befunde.

3-Begleitsymptome

Ferner sind dem Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

-Durchschlafstörung

4. Vegetative Anamnese:

-Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf

-Insomnie (Durchschlafstörung)

-Des weiteren klagt der Pt. über Gewichtsabnahme von ca. 2 kg innerhalb einer Woche.

5. Vorerkrankungen:

- Arterielle Hypertonie,

- Prostatahyperplasie,

- COPD / Asthma bronchiale.

- Er wurde nie operiert/ OP wegen Unterarmfraktur in der Kindheit.

Der Impfstatus sei komplett.

Die Reiseanamnese sei unauffällig.

6. Medikamentenanamnese:

-Der Pt. nehme zurzeit keine Medikamente ein/

-Insulin regelmäßig

-Aspirin bei Bedarf

-Amlodipin (10mg,(1-0-0))

-unbekannte Tabletten gegen Prostatahyperplasie (1-0-0)

-habe ein Sauerstoffgerät zu Hause

-unbekanntes Spray gegen Asthma-COPD bei Bedarf

7. Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ein obstruktives Schlafapnoesyndrom hin. Als Differentialdiagnosen kommen in Betracht:

-Lungenkarzinom

-Hypothyreose

-Anämie

8. Maßnahmen: Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen.

-HNO-ärztliche Untersuchung

-Zur weiteren Abklärung sollten die folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

-TSH, T3, T4 –HG- bestimmen. Kardiorespiratorische Polygraphie. Polysomnographie.

3-Schilddrüsenultraschall

4- ggf Schilddrüsenzintigrafie.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor:

1- Stationäre Aufnahme.

A. Beatmungstherapie: "Beatmungsmaske") CPAP-Therapie (nasal Continuous Positive Airway Pressure).

B. Lebensstil

1. Änderung der Schlafposition: Schlafen in Seitenlage (erschwert das Schnarchen);

2. Gewichtsreduktion;

3. Verzicht auf Alkohol, Rauchen, schwere Mahlzeiten am Abend und auf Sedativa;

C. Mechanische Maßnahmen: Unterkieferprotrusionsgeräte; vergrößern den Rachenraum.

D. Chirurgische Eingriffe: Uvulopalatopharyngoplastik (Laser-UPPP).

Mögliche Anamnesefragen:

- In welcher Position schlafen Sie? Schlafen Sie in Rücken-, Seiten- oder Bauchlage?
- Haben Sie einen Zusammenhang in einer bestimmten Schlafposition beobachtet?
- Schnarchen Sie?
- Ist Ihrem Partner/Ihrer Partnerin lautes und unregelmäßiges Schnarchen aufgefallen?
- Lindert eine Seiten- oder Bauchlage das Schnarchen?
- Ist Ihrem Partner/Ihrer Partnerin Atempausen oder Atemaussetzer aufgefallen?
- Schlafen Sie mit offenem Mund?
- Haben Sie Mundtrockenheit oder Halsschmerzen nach dem Aufwachen?
- Husten Sie?
- Ist Ihr Husten trocken oder mit Auswurf?
- Leiden Sie unter Nasenverstopfung?
- Leiden Sie unter Erstickengefühl beim Schlaf?
- Schrecken Sie nachts aus dem Schlaf auf?
- Leiden Sie unter Herzrasen oder Luftnot in der Nacht?
- Leiden Sie unter Atemnot? Kommt es bei Ihnen bei körperlicher Belastung oder auch in Ruhe?
- Atmen Sie schnell und flach? Fühlen Sie, dass Sie nicht genug Luft bekommen?
- Fühlen Sie sich morgens unausgeschlafen? Fühlen Sie sich morgens als ob sie sich nicht erholt haben?
- Fühlen Sie sich tagsüber sehr müde?
- Fühlen Sie sich nicht voll leistungsfähig?
- Leiden Sie unter ausgeprägter Tagesschläfrigkeit?
- Kommt es bei Ihnen zu Sekundenschlaf?
- Müssen Sie häufig tagsüber schlafen?
- Haben Sie morgendliche Kopfschmerzen?
- Leiden Sie unter Konzentrationsstörungen?
- Sind Ihnen Gedächtnisstörungen aufgefallen?
- Fühlen Sie sich niedergeschlagen oder traurig?

Schlafbezogene Atmungsstörung

Definition

Nächtliche Atmungsstörung mit klinischer Beschwerdesymptomatik und/oder gesundheitlichen Risiken. Die Atempausen betragen mindestens 10 sec.

Ätiologie: Vermehrtes Auftreten nach dem 40. Lebensjahr. Männer sind doppelt so häufig betroffen wie Frauen.

Risikofaktoren

-Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom (>90%)

✓ Tonsillenhyperplasie

✓ Nasenseptumdeviation

=> Obstruktion der oberen Atemwege; der primäre Atemantrieb bleibt erhalten

-Zentrales Schlafapnoe-Syndrom (< 10%)

✓ Herzinsuffizienz

=> keine Obstruktion, aber zeitweise fehlende Innervation der Atemmuskulatur

-Pickwick-Syndrom

✓ Adipositas, BMI ≥ 30

-Allgemeine begünstigende Faktoren:

✓ abendliche Einnahme von Alkohol, Betablockern und Sedativa

Klinik

✓ Fremdanamnese: lautes und unregelmäßiges Schnarchen mit Atemaussetzern

✓ Tagesmüdigkeit, Sekundenschlaf

✓ morgendliche Kopfschmerzen

✓ Durchschlafstörungen

✓ Depressionen

✓ Potenz- und Libidostörung

Diagnostik

✓ Fremd- und Eigenanamnese

✓ 24-Stunden-Blutdruckmessung

✓ Polygraphie= Messung von:

- Atemfluss
- Atempausen,
- Sauerstoffsättigung im Blut
- Herzfrequenz
- Schnarchgeräusche
- Atembewegungen von Brustkorb und Bauch

✓ Elektroenzephalografie (EEG)

✓ Elektrookulografie (EOG) zur Messung der Augenbewegungen

✓ Elektromyografie (EMG)

✓ ggf. EKG

Therapeutische Maßnahmen

✓ Behandlung der Grunderkrankung

✓ Gewichtsreduktion bei Übergewicht

✓ Vermeidung von Alkohol, Nikotin und Sedativa

✓ regelmäßige Schlafgewohnheiten

✓ Einstellung des Blutdrucks

Differentialdiagnostik

Differentialdiagnostisch finden sich kaum Möglichkeiten. Es könnte sich noch um Narkolepsie oder Depressionen handeln sowie verschiedene Formen der Schlafstörungen.

Definition

Das **obstruktive Schlafapnoesyndrom** ist eine durch partielle Verlegung der oberen Atemwege entstehende Einschränkung der Atmung.

Ätiologie

Das adulte OSAS entsteht durch Einengungen im Bereich der oberen Atemwege, z.B. durch:

- Übergewicht (80 % der Betroffenen, *siehe auch*: Pickwick-Syndrom)
- vergrößerte Tonsillen (Tonsillenhypertrophie)
- verbogene Nasenscheidewand (Septumdeviation)
- vergrößerte Nasenmuscheln
- vergrößertes Zäpfchen (Uvula)
- Kieferfehlstellungen (Retrognathie)

Symptome

Häufige Symptome des OSAS sind:

- Schnarchen
- Mundatmung
- Husten (durch ausgetrocknete Schleimhaut)
- eingeschränkte Hörfähigkeit (meist: Schallleitungsschwerhörigkeit)

Diagnostik

- kardiorespiratorische Polygraphie
- Polysomnographie

Therapie

-Die CPAP-Therapie über Nasenmaske ist die Standardtherapie. Sie stellt im Grunde eine "Schienung" der oberen Atemwege dar.

-Verhinderung der Rückenlage durch eine Spezialweste oder ein Kissen im Rücken.

-Unterkieferprotrusionsgeräte (z.B. Esmarch-Schiene) vergrößern den Rachenraum.

-Uvulopalatopharyngoplastik (UPPP) mittels Laser oder konventionell hilft nur in einzelnen Fällen bei obstruktivem Schlafapnoesyndrom.

-Verbesserung der Nasenatmung durch Septumplastik oder Conchotomie

Als begleitende Maßnahmen kommen in Betracht:

- Gewichtsreduktion (BMI), am besten durch Ernährungsumstellung
- Schlafhygiene
- Sport und Bewegung
- Zungenmuskel-Training
- keinen Alkohol unmittelbar vor der Bettruhe
- keine schweren Mahlzeiten vor der Bettruhe
- Umstellung insbesondere von Schlafmitteln (Hypnotika) unter ärztlicher Aufsicht

Schlafmitteln: Barbiturate, Benzodiazepine, Chloralhydrat, Baldrian (pflanzliche Hypnotika) (keine OTC)

Migräne

1-Persönliche Daten: Name: Frau Nadine Kovermann,
Alter: 39 Jahre, Gewicht: 76 kg, Größe: 1,77m

2-Allergie: Keine Allergien bekannt

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: Nichtraucherin

Alkohol: 1 Glas Wein gelegentlich

Keine Drogen.

Sport: Radfahren

4- Sozialanamnese:

Familienstand: Sie sei geschieden und habe 4 gesunde Kinder.

Sie lebe alleine/zusammen mit ihrem Freund / ihrer Familie

Arbeit: Maklerin

5- Familienanamnese: Unauffällig/

-Vater: Demenz (Gedächtnisschwund), er sei daran gestorben.

-Mutter: Hirntumor, sie sei daran gestorben.

2-aktuelle Beschwerden:

Frau Kovermann ist eine 39-jährige Pt., die sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit 2 Tagen bestehender, anfallsartiger, pulsierender, linkseitiger Cephalgie (Kopfschmerzen) mit Ausstrahlung in den Hinterkopf/ins linke Auge vorgestellt hat. Die Pt. berichtet, dass die Schmerzen langsam/plötzlich aufgetreten seien und sich im Verlauf verbessert/verschlechtert hätten. Zusätzlich teilt sie mit, dass die Schmerzenvon 10 auf der Skala seien und in Ruhe und bei Dunkelheit besser geworden seien. Es gebe Stress als Auslöser der Schmerzen. Sie fügte hinzu, dass sie vorher schon dreimal ähnliche Symptome gehabt habe. Die Patientin war beim Arzt und habe die Diagnose Migräne erhalten.

3-Begleitsymptome

Ferner sind der Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen: Sie klagt über

- Emesis (Erbrechen) 3mal

- Übelkeit

- sowie Tränen während des Anfalls.

- eine Photophobie (Lichtblitz)

- eine Phonophobie

Die Frage nach Fieber und Bewusstlosigkeit wurden von der Patientin verneint.

4. Vegetative Anamnese:

Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf

- Inappetenz (Appetitlosigkeit)

- schmerzbedingte Insomnie (Schlafstörung)

- Außerdem erwähnte die Pt. einen Auslandsaufenthalt auf Mallorca vor 6 Wochen.

5.Vorerkrankungen:

Sie hatte keine Vorerkrankungen/ An Vorerkrankungen leide sie an

-eine TVT/ (tiefe Venenthrombose) vor 2 Jahren, die mit niedermolekularem Heparin behandelt worden sei

-Es wurde bei der Pt. vor 5 Jahren eine Hysterektomie (Gebärmutterentfernung) durchgeführt.

6. Medikamentenanamnese:

-Die Pt. nehme zurzeit keine Medikamente ein.

-Aufgrund der aktuellen Symptome habe sie Ibuprofen, Aspirin und Triptane eingenommen, aber die Tabletten hätten ihr nur ein bisschen geholfen/ nicht geholfen.

7. Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Migräne hin. Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

1. Sinusitis (Nasennebenhöhlenentzündung)

2. Meningitis (Hirnhautentzündung)

3. Subarachnoidalblutung.

4. Gehirntumor.

5. Glaukom.-Cluster-Kopfschmerzen.- Spannungskopfschmerzen.- Apoplex (Schlaganfall)

8. Maßnahmen: Als erste Maßnahme würde ich die Pt. körperlich untersuchen, um Meningitis auszuschließen.

a) Brudzinski-Zeichen: Der Patient wird flach auf dem Rücken gelagert. Der Untersucher beugt den Kopf kräftig im Nacken (Ventralflexion). Das Brudzinski-Zeichen ist positiv, wenn der Patient die Knie anzieht. Beweist Meningitis oder Subarachnoidalblutung.

b) Kernig-Zeichen: Der Patient wird flach auf dem Rücken gelagert. Die Beine werden bei gestrecktem Knie im Hüftgelenk gebeugt. Beugt der Patient dabei aufgrund von Schmerzen die Knie, ist das Kernig-Zeichen positiv. Beweist eines Nervendehnungsschmerz.

c) Lasègue-Zeichen:

-Zur weiteren Abklärung sollten die folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

1- Laboruntersuchung: Blutbild: CRP-BSG-Anzahl der Leukozyten -unauffällig.

2- Lumbalpunktion: Wenn die Ergebnisse der Brudzinski- oder Kernig-Zeichen positiv sind.

3-MRT und CT des Schädels: Um Gehirntumor und Schlaganfall auszuschließen.

4-EEG: Um die elektrischen Gehirnaktionen beurteilen zu können.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:

1-Allgemein: Bettruhe- Patientin von äußeren Reizen (Licht, lauten Geräuschen) abschirmen.

2- Medikamentös:

A-Akut: -Gegen Übelkeit und Erbrechen ein Antiemetikum wie Metoclopramid.

-Kopfschmerzen: 1- Leichte bis mittelstarke Migräneattacke: Mittel der ersten Wahl sind NSAR oder ASS.

B-Prophylaxe: Treten die Attacken mehr als 3-mal im Monat auf oder halten länger als 72 Stunden an, ist prophylaktisch die Einnahme von ... zu empfehlen.

Mögliche Fragen:

- Seit wann haben Sie Kopfschmerzen?
- Hatten Sie schon mal ähnliche Beschwerden gehabt?
- Sind die Schmerzen plötzlich oder eher langsam angefangen?
- Sind die Schmerzen anhaltend oder wiederkehrend?
- Wie häufig treten die Anfälle auf?
- Wie lange dauert ein Anfall insgesamt?
- Wie lange dauert eine typische Schmerzattacke?
- Wo genau spüren Sie die Schmerzen? Am Hinterkopf, Stirn, hinter den Augen...?
- Sind die Schmerzen ein- oder beidseitig?
- Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
- Leiden Sie unter Nackensteifigkeit?
- Wie stark sind die Schmerzen auf eine Skala von 0 bis 10?
- Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben? Stechend, ziehend, dumpf, bohrend, hämmernd, pochend, pulsierend?
- Gibt es einen bestimmten Auslöser für die Schmerzen? Stress, Schlafmangel, bestimmte Nahrungsmittel, Alkohol, Menstruation?
- Haben Sie sich am Kopf verletzt?
- Verstärkt Licht oder Lärm Ihr Kopfschmerz?
- Wie lange sitzen Sie vor dem Bildschirm?
- Leiden Sie unter Sehstörungen? z.B. sehen Sie Blitze oder Flimmern wenn die Anfälle auftreten?
- Schlafen Sie gut? Wie lange schlafen Sie insgesamt?
- Wird Ihr Kopfschmerz von Übelkeit und Erbrechen begleitet?
- Bekommen Sie vor einem Anfall bestimmte Wahrzeichen?
- Was hilft gegen die Schmerzen?
- Haben Sie Schmerzmittel eingenommen? Welche und in welche Dosis? Hat es Ihnen geholfen?
- Ist oder war Ihnen schwindelig?
- Leiden Sie häufig an einer Nasennebenhöhlenentzündung?

Herr Paul Kovermann 39 Jahre, seit 2 Tagen, bestehender, plötzlich aufgetretender, pulsierender, rechtsseitiger Cephalgie.

Begleitende Symptome: Nausea, Emesis (2-Mal), Phonophobie und Lichtblitzen

VE: Venenthrombose im linken Bein vor 10J, behandelt mit Heparin.

Allergie/Unverträglichkeiten: Laktoseintoleranz

Noxen: Raucher 10Z pro Tag seit 20 Jahren. Alkohol 1 Flasche Bier oder 1 Glass Wein jeden Abend, Drogenkonsum wurde verneint.

FA: Mutter: an Hirntumor mit 60 Jahren gestorben.

Vater: leiden an Demenz und lebt im Heim.

DD: Spannungskopfschmerzen, Cluster-Cephalgie, Hirntumor, Meningitis

Diagnostik: 1. KU: Neurologische Untersuchung, Nackensteifigkeit

2. Labor: unauffällig (BB, Elektrolyten, Entzündungsparameter),

Bildgebung: CT/MRT des Schädels

3. Der Prüfer sagte, wir könnten ein EEG machen, und ich frage mich, was wir bei einer Migräne finden können. Ich wusste nicht, wie ich antworten sollte, und sagte nur, dass wir Befunde sehen könnten, die mit einem Anfall vereinbar sind.

Therapie: 1. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr 2. Analgetika (NSAR + ASS/Sumatriptan) 3. Antiemetika (Metoclopramid) 4. Körperschonung 5. Prophylaxe vorschlagen (propanolol, amitriptilin) 6.

Nikotinverzicht

Schwierigen Situationen: Habe ich Krebs? Muss ich hierbleiben?

A-A Gespräch: Ich durfte den beschwerden Teil praktisch ohne Unterbrechung vortragen, ich wurde direkt nach Diagnose und Therapie gefragt.

- Was sind die klassischen Symptome einer Migräne und wie unterscheiden sie sich von anderen Kopfschmerzen? Die Migräne ist durch einseitige, pulsierende Kopfschmerzen mit Übelkeit, Photophobie und Phonophobie gekennzeichnet und unterscheidet sich vom Spannungskopfschmerz durch stärkere Intensität und vom Clusterkopfschmerz durch längere Dauer und fehlende autonome Symptome.
- Was kann ich in Labor finden? Nichts, es ist unauffällig, weil Migräne eine funktionale neurologische Erkrankung ist.
- Welche Therapie wäre das Beste? Schmerzmittel verabreichung (falls nötig ist, bis zu Triptane), antiemetika, ruhe, dunkler raum, wenig lärm.
- Welche Emetika wäre das Beste? Metoclopramid

Frau Elke Kovermann ist eine 39-jährige Patientin, die sich heute Morgen bei uns wegen seit 2 Tagen bestehender, plötzlich aufgetretender, pulsierender, linksseitiger Cephalgie vorstellte. Die Patientin berichtete, dass bereits ähnliche vorherigen Beschwerden aufgetreten seien, aber jetzt seien sie schlimmer geworden. Die Einnahme von Paracetamol und Ibuprofen habe keine Verbesserung gebracht. Die Beschwerde seien von Nausea, Emesis (2-Mal), Phonophobie und Lichtblitzen begleitet. Die Vegetative Anamnese ist bis auf Inappetenz, schmerzbedingte Insomnie und Diarrhö (seit langer Zeit) unauffällig.

VE: Venenthrombose im linken Bein vor 8 J, behandelt mit Heparin und langfristige Therapie mit Antikoagulantien *Migräne ist schon bei der Patientin bekannt.

VO: Histerektomie vor 3 J

Die Patientin nehme keine Medikamente ein.

Allergie/Unverträglichkeiten: Laktoseintoleranz seit 5 Jahren

Noxen: Nicht Raucherin, trinke 1 Glass Wein jeden Abend, Drogenkonsum wurde verneint.

FA: Vater: an Hirntumor mit 60 Jahren gestorben

Mutter: leide an Demenz und lebt im Heim

SA: Geschieden, 4 Kinder (alles Gesund), lebe mit ihrer Familie zusammen. Sie sei Maklerin bei einer Immobiliere Firma. Habe viel Stress bei der Arbeit.

Die anamnetische Angaben deuten am ehesten auf Migräne hin.

Als Differenzialdiagnosen kommen folgenden im Betracht: Hirntumor Meningitis, Apoplex.

Zur Weiteren Abklärung, werde ich die folgenden Maßnahmen durchführen: Körperliche Untersuchung (Neurologische US)

Labordiagnostik: KBB, Entzündungsparameter, Retentionsparameter Bildgebende Verfahren: CT Schädels, MRT, Lumbalpunktion

Sollte die Diagnose Bestätigen, werde ich die folgenden Therapie empfehlen: Körperliche Schonung (abschirmen von Licht und Geräusche), Analgetika (Triptane), Antiemetikum

A-P: Könnte es Krebs sein?

A-A Gespräch: Ich habe Nur die erste Linie der Vorstellung gesagt, danach kommen die Fragen:

Verdachtsdiagnose? Seit wann treten die Schmerzen auf? Differenzialdiagnosen und wie können wir sie ausschließen.

Was machen wir bei Neurologische US? Wie können wir eine Meningitis ausschließen? (Fieber, Lumbalpunktion), Borreliose (Serologie, Zecken Gebiss) FSME. Wie ist die Familie Zustand der Patientin? Warum hatte sie ein Hysterektomie?

Ich werde bei der körperliche US nachfragen, Was könnte die Auslöser für ihre Migräne sein? Was machen die Patientin beruflich? Stress bei der Arbeit und Familie? Welche Therapie? Am Ende Abklärung der Diagnose und Therapie zur der Patientin. Kann ich nach Hause? Nein. Sie müssen ein paar Stunden bei uns bleiben, damit können wir eine Blutabnahme zur Labordiagnostik und einige Untersuchungen durchführen.

Definition

Rezidivierend auftretender, einseitig lokalisierter Kopfschmerz, der oftmals mit Übelkeit, Erbrechen, Phono- und Photophobie einhergeht. In etwa 10-30% der Fälle kommt es dabei zu Aura-Phänomenen. Dabei handelt es sich um reversible fokale neurologische Ausfälle wie z.B. Gesichtsfeldausfälle

(z.B. Flimmerskotome) oder Paresen, die nicht länger als eine Stunde anhalten.

Auslöser/ Risikofaktoren

Es gibt verschiedene Theorien zu den Ursachen, aber keine gesicherten Erkenntnisse. Zu den Risikofaktoren zählen:

✓ weibliches Geschlecht

✓ Familiäre Disposition

Mögliche Auslöser sind:

✓ Klimaeinflüsse: Wetterwechsel, Kälte

✓ Genussmittel: Alkohol, Nikotin, Zitrusfrüchte, Milchprodukte, tyraminhaltige Lebensmittel (Schokolade, Rotwein)

✓ Veränderungen des Schlaf-Wach-Rhythmus, Zeitverschiebungen

✓ Nach einer anstrengenden, stressigen Zeit (sogenannte "Feiertagsmigräne")

✓ Bei Frauen zusätzlich • Menstruation • Hormoneinnahme: Kontrazeptiva

Klinik

✓ Prodromi (fakultativ) = Vorbotensymptome Stunden bis 2 Tage vor jeder Migräneattacke

- Stimmungsveränderung
- Heißhunger oder Appetitlosigkeit
- Schwierigkeiten beim Schreiben und Lesen
- Vermehrtes Gähnen

✓ Kopfschmerzen

- Lokalisation: Ca. 60% einseitig, insbesondere frontal, frontotemporal, retroorbital
- Dauer: 4-72 Stunden
- Verlauf: Langsam zunehmender Schmerz
- Charakter: Pulsierend, bohrend, hämmernd

✓ Begleitphänomene

- Phonophobie
- Photophobie
- Übelkeit/ Erbrechen
- Verstärkung durch körperliche Tätigkeiten

✓ Migräne mit Aura (früher Migraine accompagnée)

- anfallsweise auftretende, reversible fokale neurologische Symptome, migränetypische **Kopfschmerzen** sind dabei nicht immer vorhanden (Migraine sans migraine)
- Beteiligung des Sehnervs
- **Flimmerskotom** von parazentral nach peripher wandernd
- Gezackte Grenzlinien bzw. Fortifikationsspektren, die das Flimmerskotom umgeben oder ausfüllen

- Photopsien (Lichtblitze)
- grelle Farbwahrnehmungen
- Paresen
- Sensibilitätsstörungen, Parästhesien
- Schwindel
- Aphasie

Diagnostik

- ✓ Anamnese und neurologischer Status, siehe klinische Beschwerden
- ✓ Entscheidend sind Angaben wie
 - Lokalisation (meistens einseitig)
 - Charakter (z.B. pulsierend)
 - Dauer (ca. 4-72 Stunden)
 - Eventuelle Begleitsymptome (z.B. Aura oder **Photopsien**)
- ✓ Allgemeine Untersuchung beim Leitsymptom **Kopfschmerz** zum Ausschluss anderer Ursachen
- ✓ Neurologischer Status und detaillierter Hirnnervenstatus
- ✓ Körperliche Untersuchung
 - trigeminale Nervenaustrittspunkte
 - Bulbusdruck- und Bewegungsschmerz
 - Beweglichkeit der **HWS**, Druckschmerzhaftigkeit der perikraniellen Muskulatur
 - Klop- und Druckschmerz der Kalotte
 - **Schmerzen** bei Kieferöffnung
 - Beurteilung der Schleimhäute, Zahnstatus
 - **Erasten der A. temporalis superficialis**
 - Messung des Blutdrucks

Therapeutische Maßnahmen

Allgemein:

- ✓ Patienten von äußeren Reizen (Licht, lauten Geräuschen usw.) abschirmen
- ✓ Bettruhe

Medikamentös:

- ✓ Eine möglichst frühe und hochdosierte Medikamenteneinnahme ist häufig entscheidend für den Therapieerfolg
- ✓ Leichte bis mittelstarke Migräneattacke: Mittel der 1. Wahl sind **NSAR** (ASS oder **Ibuprofen**)
 - Bei Kindern unter 14 Jahren: **Ibuprofen** oder **Paracetamol**
- ✓ Mittelschwere bis schwere Migräneattacke bei Erwachsenen: **Triptane**
 - Nebenwirkungen: Passagerer Blutdruckanstieg (häufig), koronare Ischämien (selten) Parästhesien und Kältegefühl der Extremitäten, **Schwindel**, Müdigkeit, Flush
 - Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe, Koronare Herzkrankheit, Myokardinfarkt in der Anamnese, Prinzmetal-Angina, pAVK, ischämische Insulte, TIA in der Anamnese, arterielle Hypertonie, Schwangerschaft und Stillzeit u.a
- ✓ Ergotamintartrat: Nur bei sehr langen Anfällen oder mehrfachen Rezidiven
- ✓ Nichtopioidanalgetika und **NSAR**
- ✓ bei allen Attacken zusätzlich ein **Antiemetikum**: **Metoclopramid** 20mg, p.o. (bei Kindern wegen Dyskinesie als Nebenwirkung bevorzugt Gabe von Domperidon)

Prophylaxe:

- ✓ Lebensstiländerung (Vermeidung von Stress)
- ✓ Ausdauersport (3x/ Woche Schwimmen, Fahrradfahren, Joggen)
- ✓ Entspannungsverfahren
- ✓ Medikamentös

- Indikationen: > 3 Attacken/ Monat, Migräneattacke > 72 h oder lang anhaltende Aura-Phänomene: Betablocker (z.B. Metoprolol, Propranolol, Bisoprolol, Valproat, Topiramat, Flunarizin

Differentialdiagnostik

- **Spannungskopfschmerz**: Nur in seltenen Fällen mit Phono-/Photophobie und Übelkeit einhergehend. Verstärkt sich nicht bei körperlicher Aktivität.
- **Cluster-Kopfschmerz**
- **Paroxysmale Hemikranie**

Merkmal	Migräne	Spannungskopfschmerz	Clusterkopfschmerz
Schmerz	pulsierend	drückend	sehr stark, stechend
Seite	meist einseitig	meist beidseitig	streng einseitig
Stärke	mittel-stark	leicht-mittel	sehr stark
Übelkeit	häufig	selten	selten
Lichtempfindlichkeit	häufig	selten	möglich
Dauer	Stunden-Tage	Stunden	150-180 min
Besonderheit	Aura möglich	Druckgefühl	Auge tränt, Nase läuft

Depression

Name: Herr Gotthilf Weindele -Frau Teresa Heidenreich

Alter: 32-54 Jahre, Gewicht: 80 kg Größe: 1,70 m

2- Allergie – Pollenallergie (Heuschnupfen)- Tomatenunverträglichkeit sei bei ihm/ihr bekannt (tränennde Augen)(epiphora)

3- Genussmittel/ Noxen:

Nikotin: Nichtraucher/eine Schachtel /Tag seit 20 Jahren (20 P/Y)

Alkohol: 2 Flaschen Wein abends -8 Pils täglich seit 2 Jahren.

Keine Drogen. Sport: kein

4- Sozialanamnese:

Familienstand: Verheiratet, habe 2 Kinder und wohne mit seiner Familie/ledig/Er ist geschieden und hat zwei erwachsene Töchter

Arbeit: Verkäufer/arbeitslos

-Er habe Maschinenbau studiert -aber wegen der Beschwerden habe er sein Studium abgebrochen

5- Familienanamnese: Unauffällig/

-Vater: Selbstmord mit 58 Jahren

-Mutter: Depression, Arterielle Hypertonie, eine Herzkrankheit.

Die Schwester sei an Leukämie (Blutkrebs) vor ein paar Monaten verstorben.

Die Kinder: gesund

2-aktuelle Beschwerden:

Herr Weindele ist ein 32-jähriger Pt., der sich heute Morgen bei uns wegen seit 4-5 Jahren/2 Monaten aufgetretender, bestehender, beidseitiger, zunehmender Cephalgie (Kopfschmerzen) ohne Ausstrahlung vorgestellt hat. Der Pt. berichtet, dass die Schmerzen langsam nach Tod seiner Tochter vor 2 Monaten aufgetreten seien und sich im Verlauf der Zeit besonders seit 6 Wochen verschlechtert hätten. Zusätzlich teilte er mit, dass die Schmerzen 4 von 10 am Morgen und 5 von 10 am Abend auf der Skala seien. Es gebe keine Auslöser der Schmerzen. Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint. Der Patient sei alle 2 Wochen beim Hausarzt/

mehrmals bei verschiedenen Fachärzten, aber ohne Befund. Fast alle Labortests waren bei ihm normal. Seine letzte MRT sei vor 2 Monaten gewesen wegen Verdacht auf MS, ohne pathologischen Befund. Der Hausarzt habe ihm gesagt, dass die Beschwerden mit dem Tod der Tochter zu tun hätten.

3-Begleitsymptome

Ferner sind dem Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

- Er klagt über Schmerzen in den Muskeln, in den Knochen, im Kopf, in den Gelenken, besonders in den Knien
- schlechte Laune, er sei nervös und niedergeschlagen nach seiner Arbeitslosigkeit
- Müdigkeit - Sehstörungen - Erschöpfung- Tinnitus (Ohrgeräusche)
- Des weiteren klagt der Pt. über Gewichtszunahme von mehr als 10 kg in den letzten 2 Monaten.
- Der Patient messe den Blutdruck und Körpertemperatur 2-3 mal pro Tag.
- Die Fragen nach Traumata, Fieber, Sensibilitätsstörungen, Lähmungen, Augen- oder Ohren-Beschwerden wurden verneint.

4. Vegetative Anamnese:

- Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf
- Inappetenz (Appetitlosigkeit)
- Insomnie (Schlafstörung)
- die Reiseanamnese sei unauffällig in den letzten 6 Monaten.

5. Vorerkrankungen:

- Es seien keine relevanten Vorerkrankungen bekannt.
 - Arterielle Hypertonie (Bluthochdruck) seit 5 J.
 - Arthrose
 - Er sei nie operiert worden.
- Es wurde beim Pt. als Kind eine Appendektomie (Blinddarmentfernung) und vor 2 Jahren eine Prostatektomie durchgeführt.
- Der Impfstatus sei vollständig.

6. Medikamentenanamnese:

- Der Pt. nehme zurzeit keine Medikamente ein/die folgenden Medikamente regelmäßig ein:
- Paracetamol, Ibuprofen, Tramadol, Morphin-Voltaren 100 mg einmal am Tag
- Ramipril 10 mg (1_0_0)
- HCT Hydrochlorothiazid 12.5 mg (1_0_0)
- Diazepam (0_0_1)
- Benzodiazepin einmal täglich wegen der Schlafstörung.

7. Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Depression hin.

Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

- Migräne-Hypothyreose-Hirntumor-Hirnblutung-Demenz

8- Maßnahmen

- Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen.
- Zur weiteren Abklärung sollten die folgende Maßnahmen durchgeführt werden:
- Blutabnahme (Tsh -ft3-ft4-

...

- CT-MRT des Schädels -EEG - Polysomnographie

- Psychiatrisches Konsil veranlassen.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:

- Med: Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (z.B. Citalopram, Sertralin, Fluoxetin, Escitalopram)
- trizyklische Antidepressiva (z.B. Amitriptylin, Doxepin, Imipramin, Clomipramin) Dopamin-Lithium
- Melatonin-
- Lichttherapie
- Sonnenlicht
- Schlafentzug
- Andere Hilfsmittel: körperliche Bewegung an der frischen Luft (zum Beispiel Walken, Joggen)

Mörliche Anamnese Fragen:

- Sind die Beschwerden plötzlich oder eher langsam aufgetreten?
- Haben sich die Beschwerden im Laufe der Zeit verschlechtert?
- Gibt es einen bestimmten Auslöser für die Beschwerden?
- Haben Sie schon früher unter ähnliche Beschwerden gelitten?
- Wie würden Sie Ihre derzeitige Stimmung beschreiben?
- Fühlten Sie sich in der letzten Zeit häufig niedergeschlagen, traurig oder hoffnungslos?
- Hatten Sie in der letzten Zeit deutlich weniger Lust und Freude an Dingen, die Sie sonst gerne tun?
- Seit wann fühlen Sie sich ... und was ist passiert?
- Hatten Sie in den letzten Zeiten Freude an verschiedenen Aktivitäten und Hobbys verloren?
- Hatten Sie in den letzten Zeiten ständig das Gefühl, nicht Lust zu haben?
- Verbringen Sie mehr Zeit allein, als Sie es früher getan haben?
- Was macht Ihnen aktuell Spaß?
- Fühlen Sie sich antriebslos oder erschöpft?
- Haben Sie das Gefühl weniger Energie als sonst zu haben?
- Haben Sie Schwierigkeiten alltägliche Aufgaben zu erledigen? z.B. duschen, Haushalt, kochen, Einkauf...
- Fällt es Ihnen schwer morgens aufzustehen und den Tag zu beginnen?
- Können Sie gut ein- und durchschlafen?
- Wie stark sind die Kopfschmerzen? Können Sie die Schmerzen beschreiben? Wo sind sie genau lokalisiert? Sind die Schmerzen anhaltend oder wiederkehrend? Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
- Leiden Sie unter Konzentrationsstörungen?
- Fällt es Ihnen schwer Fernsehen zu schauen oder Gespräche zu folgen?
- Wie schlafen Sie in der letzten Zeit?
- Schlafen Sie wenig oder viel als sonst?
- Fühlen Sie sich erholt nach dem Schlaf?
- Ist Ihr Appetit in letzter Zeit verändert?
- Haben Sie ungewollt ab- oder zugenommen?
- Haben Sie einen Selbstmordgedanke?
- Haben Sie schon mal versucht sich selbst umzubringen oder zu verletzen?
- Hatten Sie schon mal konkrete Pläne oder Versuche sich selbst umzubringen?
- Haben Sie sich schon mal selbst verletzt?
- Gibt es etwas, das Sie am Leben hält?
- Haben Sie Zukunftspläne?
- Haben Sie Hoffnung, dass alles besser wird?
- Haben Sie in der letzten Zeit schwierige Lebensereignisse erlebt? Tod, Trennung, Arbeitslosigkeit, Umzug...
- Leidet in Ihrer Familie jemand unter Depression?
- Hat sich jemand in Ihrer Familie selbst umgebracht?
- Haben Sie schon in der Vergangenheit schon Mal an Depression gelitten?
- DD Fragen:
- Sind Ihnen Hautveränderungen oder Haarausfall aufgefallen?
- Haben Sie Schluckbeschwerden?
- Hören Sie Stimmen, die andere nicht hören?
- Haben Sie sich schon mal am Kopf verletzt?
- Haben Sie häufiges Zittern oder Muskelverspannungen bemerkt?
- Ist Ihnen unkordinierte Bewegung aufgefallen?
- Ist Ihnen Seh- oder Hörstörungen aufgefallen?
- erspüren Sie Kribbeln oder Taubheitsgefühle in den Armen oder Beinen?

Herr Thomas Heidenreich, 55J, 163cm, 66 kg
stellte sich heute wegen seit 10 Wochen bestehender, drückender Cephalgie ohne Ausstrahlung
begleitend mit Antriebslosigkeit, Anhedonie sowie Gedankenkreisen bei uns auf der Station vor.
Schmerzintensität 6. Ibu nicht geholfen. Schmerzen morgen stark abend besser.
Auslöser: seine Schwester an Leukämie gestorben.
Keine kontakt mit Freunde. Keine Sport. Keine Lust.
Der Pat gibt an, Suizidgedanken zu haben. (mir ist egal, ob ich lebe oder nicht).
VA: Insomnie, Inappetenz, Verstopfung (keine Gewichtsveränderung)
VE: aHT seit 7 Jahren. Ramipril 10, HCT 12,5, Adumbran.
FA: Vater hatte Depression, hat sich selbst umgebracht.

Herr Anton Kaiser 53 Jahre alt, 170 cm, 115 kg kam zu uns mit Lustlosigkeit, Müdigkeit, Erschöpfung,
habe keinen Kontakt zu Freunde und Familie und Gewichtszunahme von 10kg in 2 Jahren, begleitet mit
Belastungsdyspnoe. Die Fragen zu Cephalgie, Haarausfall, Halluzination und Fieber wurden verneint.
Die vegetative Anamnese war unauffällig. Bei den Vorerkrankungen erwähnte er aHT seit 15 Jahren,
Gonarthrose und Z.n. Appendektomie.

Arzt-Arzt Gespräch

Was habe der Patient?

Was sind Risikofaktoren?

Wie gehen sie vor?

Welche Blutwerte sind wichtig?

Arztbrief: Herr Karl Heidenreich, 55 Jahre alt, 66 kg schwer, 166 cm groß. Der Patient kam heute zu
uns mit seit 2 Monaten bestehenden, drückenden, starken Schmerzen im ganzen Kopf ohne
Ausstrahlung. Der Patient berichtet, dass die Schmerzen am Morgen sehr stark und am Abend besser
geworden seien. Darüber hinaus gab er an, dass seine Schwester vor 2 Monaten an Leukämie
gestorben sei. Außerdem erwähnte er, dass er eine schlechte Stimmung und keine Lust mehr habe
etwas zu tun. Des Weiteren fügte er hinzu, dass er Durch- und Einschlafstörungen habe. Zudem teilte
er mit, dass er bei seinem Hausarzt gewesen sei. Der Hausarzt habe ihm Adumbran 10mg
(Benzodiazepin) geschrieben, aber das Medikament habe ihm nicht geholfen. Die vegetative
Anamnese ergab Fatigue.

Als Vorerkrankung hat der Patient seit 20 Jahren arterielle Hypertonie, die mit Ramipril 10mg und HCT
12,5mg einmal morgens behandelt ist.

Der Patient trinkt 2-3 Gläser Wein abends.

Er treibt keinen Sport.

Die Fragen nach Nikotin- und Drogenkonsum wurden verneint.

Der Patient war nicht in letzter Zeit im Ausland.

Er ist durch geimpft. (viermal gegen Covid-19)

Er hat keine Allergien und keine Unverträglichkeiten.

Der Vater hat sich selbst umgebracht und war gesund. Die Mutter hat arterielle Hypertonie und
Herzinsuffizienz.

Der Patient ist Bankkaufmann, verheiratet, lebt mit seiner Frau zusammen und hat 2 gesunde Kinder.

Als Verdachtsdiagnose stelle ich Depression.

Als Differentialdiagnosen kommen die folgenden in

Betracht: Hypothyreose, Anämie, Gehirntumor.

Als erste Maßnahme untersuche ich den Patienten körperlich.

Zur weiteren Abklärung sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden: Blutabnahme und
Bestimmung von Hb, TSH, T4 und T3. Ein CT des Schädels muss durchgeführt werden.

Falls die Verdachtsdiagnose Depression bestätigt ist, schlag ich die folgende Therapie vor:

Trizyklische Antidepressiva

Psychotherapie

Patientenvorstellung:

-Was hat der Patient? *Depression*

-Der Oberarzt hat mir gesagt: Der Patient hat gesagt, dass die -Schmerzen am Morgen stark und am
Abend besser geworden sind

Adumbran, Ramipril und HCT verursachen morgendliche Kopfschmerzen, deshalb müssen wir die Medikamente umstellen.

-Wie groß sind die Gläser Wein? Als Standardglas rechnet man meist mit 0,1-0,2 Liter Wein. Ein Glas Wein enthält ungefähr 20 gr reinen Alkohol.

-Erklären Sie jetzt dem Patienten die Therapie: Wir haben den Verdacht auf eine Depression. Diese Erkrankung kann man gut behandeln. Wir empfehlen eine Psychotherapie. Dabei sprechen Sie regelmäßig mit einem Therapeuten über Ihre Gedanken, Gefühle und Probleme. Zusätzlich können Antidepressiva helfen, die Stimmung zu stabilisieren. Diese Medikamente machen nicht abhängig. Depression ist eine häufige Erkrankung und wie ich schon gesagt habe ist gut behandelbar. Wir werden Sie Schritt für Schritt begleiten.

Herr Theo Heidenreich, 55 Jahre alt, 76 kg schwer, 167 cm groß kam heute zu uns wegen seit 10 Wochen aufgetretender, drückender, beidseitiger Cephalgie ohne Ausstrahlung. Der Patient berichtete, dass die Schmerzen dauerhaft seien und Morgens immer schlimmer seien. Die Stärke der Schmerzen bewertete der Patient 7-8 von 10 auf der Skala. Darüber hinaus gab er an, dass der Tod der Schwester als die Auslöser der Beschwerden seien. Die Beschwerden seien von Nausea, Müdigkeit, Abgeschlagenheit und depressive Stimmung begleitet.

Die **vegetative Anamnese** sei unauffällig bis auf Insomnie (Durchschlafstörung) und 2 kg Gewichtsabnahme innerhalb 3 Monaten. Die Fragen nach Parästhesien, Paralyse, Hypästhesie, Sehstörungen, Schmerzen an anderer Körperregion, Husten, Tachykardie wurden verneint.

In der Anamnese der Vorerkrankungen fanden sich eine arterielle Hypertonie (behandelt mit Ramipril 20mg 1-0-0 und HCT 12.5mg 1-0-0). Außerdem nehme er ein Benzodiazepinesderivat einmal täglich wegen der Schlafstörung ein (Ich erinnere mich nicht an den Namen).

Bei ihm sei vor 5 Jahren eine Appendektomie durchgeführt worden.

Herr Heidenreich rauche nicht, trinke 2 Gläser Wein pro Woche und treibe keinen Sport.

Darüber hinaus berichtete die Patientin, dass sie keine Allergien oder Unverträglichkeiten habe und ihr Impfausweis aktuell sei.

Bei der **Familienanamnese** sagte die Patientin, ihr Vater habe sich selbst umgebracht, die Mutter leide an einer Hypertonie und einer Herzinsuffizienz und die Schwester sei an Leukämie gestorben.

Die Patientin habe 2 gesunde Kinder.

Herr Heidenreich habe als Verkäuferin gearbeitet, aber sie ist jetzt arbeitslos, sei verheiratet und lebe mit ihrer Frau zusammen.

Als **Verdachtsdiagnose** stelle ich Depression.

Als **Differentialdiagnosen** kommen Multiple Sklerose, Migräne, Hypothyreose, VitB12 Mangel in Betracht.

Als weitere Prozedere empfehle ich folgende Untersuchungen:

körperliche Untersuchung

Blutabnahme (BB,CRP,BSG,fT3, fT4,TSH, VitB12)

MRT des Schädels

Psychiatrische Konsil veranlassen!

Patient-Arzt Gespräch

Was habe ich?

Was werden Sie machen?

Arzt-Arzt Gespräch

Ich habe die Patientin fast vollständig vorgestellt. Die Fragen waren die folgenden:

Können wir den Patienten entlassen?

Was sollen wir tun, falls der Patient von 20 m Sprung möchte?

Was bedeutet Abusus, falls der Patient täglich Schlafmittel einnimmt? Ich habe gesagt, ich glaube, wir müssen ihm eine psychische Beratung empfehlen.

Er hat mir gesagt, dass das richtig ist, aber wir können sie nicht entlassen, weil Depression Patienten Suizidale Tendenzen haben können.

Herr... ist ein 65-Jähriger Patient, der sich wegen seit 4 Wochen bestehender Schmerzen im Skapula und Nacken mit Ausstrahlung in Schläfe (ich wusste dieses Wort nicht) bei uns im Krankenhaus vorstellte. Die Schmerzen seien dauerhaft da und hätten eine Intensität von 6 bis 7 von 10 auf der Schmerzskala.

Er habe dagegen Ibuprofen und Parasetamol eingenommen aber das habe keine Verbesserung gemacht. Er klagte über Müdigkeit seit der Scheidung mit der Ehefrau. Er sei wegen dieser Beschwerden bei Orthopäde gewesen aber die Untersuchungen waren unauffällig. Die Fragen nach Sensibilitätsstörung, Sehstörung, Lärmscheu, Lichtscheu, Übelkeit und Erbrechen wurden verneint. Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf Durchschlafstörung wegen Schmerzen und Einschlafstörung wegen bestender Gedanken.

An **Vorerkrankungen** leide er an:

1. Arterielle Hypertonie, der seit 20 Jahren bei ihm bekannt aber nicht medikamentös eingestellt sei.
2. Benigne Prostatahypertrophie, der mit Prostatagut eingestellt sei.
3. Hypercholesterinämie, der mit Sartan eingestellt sei.

In Bezug auf Medikation nehme er die folgende Medikamente ein:

1. Sartan (1 Tablette)
2. Prostagut 3).. 4).. (Ich habe die Dosis gefragt. Aber ob er Morgen/Mittags/Abends einnimmt habe ich vergessen zu fragen.)

Er sei Nichtraucher, trinke ab und zu Alkohol. Drogenkonsum wurde verneint. Die anamnestische Angaben deuten am Ehesten auf Depression hin.

Als **Differenzialdiagnose** können die folgende in Betracht.

1. Diskus Prolapsus
2. Migräne
3. Hypothyreose

Zur weiteren Abklärung sollte die folgende Massnahmen durchgeführt werden.

1. KU
2. Labor
3. Polysomnographie

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlagen wir die folgende Therapie vor.

1. Antidepressivum
2. Psychotherapie
3. Lichttherapie

Der Patient hat gefragt:

1. Was habe ich?
2. Was werden Sie machen?

Der Chef hat gefragt

1. Was ist ihr Verdachtsdiagnose?
2. Was sind die Differenzialdiagnose?
3. Wie könnten Sie Discus Prolapsus ausschließen?
4. Könnte es nicht Rheumatische Erkrankung sein? (Hier hat er gesagt. Das die Schmerzen ganz lokalisiert sind. Wenn die Entzündungsparameter hoch sind, könnte es auch Polymyelitis Rheumatika sein.)
5. Können Sie dem Patient Mrt aufklären? ist eine spezielle Querschnittsaufnahme. MRT erzeugt (generates) ein starkes Magnetfeld auf dem Körper. Sie legen sich auf dem Liege, die Sie in diese Maschine fährt dann bildet es schicht von schicht auf Ihrem Körper dann können wir die Befunde auf dem Bildschirm ansehen.

Es ist schmerzfrei und Strahlenfreie Untersuchung. Sie dürfen kein Eisen Oder Schmuck haben damit sie nicht in Funktion Von

MRT stören.

Herr X ist ein 32-jähriger Patient, der sich bei uns aufgrund seit 4-5 Jahren bestehender anhaltender Gliederschmerzen vorgestellt hat. Der Patient berichtete, dass die Schmerzen im ganzen Körper befindlich seien und am frühen Morgen am schlimmsten seien. Diese würden sich im Verlauf des Tages erleichtern. Weiterhin klagte der Patient, an Antriebslosigkeit und Interessensverlust zu leiden. Der Patient gab an, er habe darüber hinaus Beeinträchtigung der Sehkraft und Schwerhörigkeiten seit einigen Monaten bemerkt, welche schwankend auftreten würden. Als begleitende Symptome berichtete er über Störungen sowohl bei Ein- sowie bei Durchschlafen und Appetitlosigkeit. Es bestehe zudem eine Abgeschlagenheit.

Gewichtsveränderungen, Suizidgedanken sowie Suizidhandlungen, Missempfindungen und Kraftverlust wurden verneint. Der Patient sei aufgrund der o.g. Symptome mehrmals bei dem Hausarzt vorstellig gewesen. Die verschriebene Medikamente hätten aber zu keiner Besserung der Beschwerden geführt. Außerdem sei er vor einigen Jahren ein bildgebendes Verfahren zum Ausschluss von MS durchgeführt

worden (MRT ?), deren Befunde unauffällig gewesen seien. Keine Vorerkrankungen seien bei dem Patienten bekannt.

Keine Voroperationen. Medikamente nehme er aktuell keine. Bei dem Patienten sei eine Pollenallergie bekannt. Es bestehe kein Konsum von weder Alkohol noch Nikotin. Familienanamnestisch ergab sich Depression mütterlicherseits. Sein Vater sei gesund sowie auch zwei Geschwister. Der Patient habe das Studium vor einigen Jahren abgebrochen. Er ist ledig und hat keine Kinder.

Die anamnestischen Angaben deuten a.e. auf Depression hin.

Differentialdiagnostisch kommen die folgenden Krankheiten in Betracht:

Dystimie

Psychoaffektive Störung

Anämie

Hypothyreose

MS ?

Zur weiteren Abklärung führe ich die folgenden **Maßnahmen** durch:

körperliche Untersuchung, Blutbild, TSH, T3, T4, Ferritin, B12, Entzündungsparameter ggf. MRT

ARZT-ARZT

1) Welche Symptome sind typisch für eine Depression?

„Typische Symptome einer Depression sind eine gedrückte Stimmung, Interessenverlust (Anhedonie) und Antriebsminderung. Zusätzlich können Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Appetitveränderungen, Müdigkeit, Schuldgefühle sowie Suizidgedanken auftreten.“

2 Wie lange müssen die Symptome bestehen, damit man von einer Depression sprechen kann?

„Die Symptome müssen mindestens zwei Wochen bestehen und zu einer deutlichen Beeinträchtigung im Alltag führen.“

3 Wie würden Sie nach Suizidgedanken fragen?

„Ich würde den Patienten direkt und einfühlsam fragen:

‘Haben Sie in letzter Zeit daran gedacht, sich etwas anzutun oder nicht mehr leben zu wollen?’“

4 Welche Risikofaktoren gibt es für eine Depression?

„Zu den Risikofaktoren gehören belastende Lebensereignisse, chronischer Stress, familiäre Belastung, soziale Isolation, chronische Erkrankungen sowie Substanzmissbrauch, insbesondere Alkohol.“

5 Welche Differenzialdiagnosen müssen Sie berücksichtigen?

„Differenzialdiagnostisch müssen unter anderem Angststörungen, bipolare Störung, Anpassungsstörung, Burnout, Schilddrüsenerkrankungen, Anämie sowie Substanzmissbrauch ausgeschlossen werden.“

6 Wie wird eine Depression diagnostiziert?

„Die Diagnose wird in erster Linie klinisch gestellt, basierend auf Anamnese, psychischer Exploration und diagnostischen Kriterien (ICD-10/ICD-11). Zusätzlich können standardisierte Fragebögen eingesetzt werden.“

7 Wie wird eine Depression behandelt?

„Die Therapie besteht aus Psychotherapie, medikamentöser Behandlung mit Antidepressiva sowie psychosozialer Unterstützung. Bei schweren Verläufen kann auch eine stationäre Behandlung erforderlich sein.“

8 Welche Antidepressiva kennen Sie?

„Zu den häufig eingesetzten Antidepressiva gehören:

- SSRI (z. B. Sertralin, Citalopram)
- SNRI (z. B. Venlafaxin, Duloxetin)
- Trizyklische Antidepressiva
- Mirtazapin“

9 Wann ist eine stationäre Behandlung notwendig?

„Eine stationäre Behandlung ist indiziert bei:

- akuter Suizidalität
- schwerer depressiver Episode
- fehlender ambulanter Versorgung
- schwerer Selbstvernachlässigung“

10 Welche Komplikationen können bei Depression auftreten?

„Die schwerste Komplikation ist Suizid. Außerdem können soziale Isolation, Arbeitsunfähigkeit sowie Substanzmissbrauch auftreten.“

 Sehr wichtiger Satz für die FSP:

„Bei jedem Patienten mit Depression sollte aktiv nach Suizidgedanken gefragt werden.“

Definition

Eine **Depression** ist eine psychische Störung, die unter anderem durch eine gedrückte Stimmung, Interessenverlust, Freudlosigkeit (Anhedonie), fehlenden Willensantrieb (Abulie) und Hoffnungslosigkeit gekennzeichnet ist. Die Erkrankung wird den Affektstörungen zugeordnet und ist durch einen episodischen Krankheitsverlauf charakterisiert. Depression ist keine Traurigkeit, sondern ein Zustand, in dem die Empfindung aller Gefühle reduziert ist.

Symptome

Hauptsymptome einer depressiven Episode sind:[3]

- depressive, gedrückte Stimmung
- Interessenverlust
- Affektverarmung, insbesondere Freudlosigkeit
- Antriebsminderung
- Einschränkung der Aktivität
- Unmotiviertheit. Die Betroffenen werden passiv und sind nicht in der Lage, einfachste Alltagstätigkeiten wie Einkaufen und Abwaschen zu verrichten.

Zusatzsymptome

- Verminderter Appetit
- Negative Zukunftsperspektiven
- Schuldgefühle
- Minderwertigkeit
- Verringerte Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit
- Vermindertes Selbstvertrauen
- Durchschlaf oder Einschlafstörungen
- eine Depression kann mit suizidgedanken verbunden sein.

Therapie

- Psychotherapie
 - Pharmakotherapie: Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, Trizyklische Antidepressiva, Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, Lithium
 - Gesundes Ernährung: Das für die Ernährung notwendige Protein sollte weitgehend aus Fisch stammen. Die kohlenhydratreiche Ernährung führt im Körper zu einer vermehrten Herstellung von Tryptophan, aus welchem im Gehirn der Botenstoff Serotonin aufgebaut wird. Serotonin wiederum spielt eine wichtige Rolle bei der Stressbewältigung und vermittelt Glücksgefühle. Depressionen stehen häufig in Zusammenhang mit einem Serotoninmangel im Gehirn.
 - Sport bzw. körperliche Bewegung an der frischen Luft
 - Sonnenlicht
 - Kaffee, Schokolade
 - Opiate
- # Nach Beginn der medikamentösen Behandlung können Patienten aufgrund der Stimmungsaufhellung und der gesteigerten Energie die Kraft finden, Suizid zu begehen. Daher sollten Patienten in der Zeit nach dem Therapiebeginn engmaschig überwacht werden.

Alzheimer

1-Persönliche Daten: Name: Hans Brenzler

Alter: 82 Jahre Größe: 1,65 m Gewicht: 70-75 kg

2- Allergie: Katzenhaare und Hausstaub, die allergische Reaktion äußert sich als Nasenverstopfung, Hautausschlag, Augenentzündung

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: Nichtraucher

Alkohol: 1 Glas Wein alle 2-3 Wochen

Keine Drogen.

Sport: einstündiges tägliches Spaziergehen.

4- Sozialanamnese: Familienstand: Verwitwet, er habe 3 gesunde Töchter und lebe alleine

Arbeit: Der Patient sei pensioniert, habe früher in der Autoindustrie bei Mercedes gearbeitet

5- Familienanamnese: unauffällig

- (schlechte Beziehung zu den verstorbenen Eltern).

2-aktuelle Beschwerden

Herr Hans Brenzler ist ein 82-jähriger Patient, der sich bei uns wegen seit 4 bis 8 Wochen bestehender, erstmaliger und schleichend eingesetzter Kurzzeitgedächtnisstörung/

Gedächtnisstörung vorstellte. Der Pt. berichtete, dass die Beschwerden seit langer Zeit aufgetreten sind, sich aber seit

einigen Wochen verschlechtert hätten. Zusätzlich teilte er mit, dass er sich nur an früher erinnern könne. Es gebe keine Auslöser. Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint.

3-Begleitsymptome

Ferner sind dem Patienten folgende Begleitsymptome aufgefallen:

-Konzentrationsstörung

-Sprachstörung

-depressive Stimmungen

-Müdigkeit

-Des weiteren klagte der Pt. über Gewichtsverlust von ca. 3 kg in den letzten Monaten.

Die Fragen nach Kopfschmerzen oder Schwindel, Fieber, Schädelverletzung wurden verneint.

4. Vegetative Anamnese:

Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf

Inappetenz (Appetitlosigkeit), reduzierten Durst (Trinkmenge beträgt 1 Liter/Tag)

-Insomnie (Durchschlafstörungen) seit dem Tod seiner Ehefrau

-Obstipation (Verstopfung)-Nykturie

5.Vorerkrankungen:

-Es seien keine relevanten Vorerkrankungen bekannt/- An Vorerkrankungen leide er an

-Herzinsuffizienz (Herzschwäche)

-arterielle Hypertonie (Bluthochdruck) seit 20 Jahren

-Niereninsuffizienz/ Nierenerkrankungen

-Prostatahyperplasie -einen abgeschwächten Urinstrahl.

-Hörschwäche seit mehreren Jahren.

Es wurde bei dem Patienten eine Cholezystektomie vor 40 Jahren durchgeführt.

Der Impfstatus sei komplett; vor kurzem wurde er gegen Pertussis (Keuchhusten) geimpft.

-Die Reiseanamnese sei negativ.

Medikamentenanamnese:

-Der Pt. nehme zurzeit keine Medikamente ein/

Herr Brenzler nehme die folgenden Medikamente regelmäßig ein:

Spironolactone

Furosemid

Kandesartan

-ein Schlafmittel (dessen Name und Dosis ihm nicht Erinnerung sein)

6-Verdachtsdiagnose:

-Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Alzheimer-Demenz hin. Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

- Hypothyreose,
- Depression,
- Vit-B12-Mangel sowie
- TIA (Transitorische Ischämische Attacken)
- leichter Schlaganfall
- Hirntumor

8-Maßnahmen

- Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen (neurologische Untersuchung).

-Zur weiteren Abklärung sollten die folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

-Labordiagnostik: BB, Elektrolyten, CRP, BSG, TSH, fT3, fT4, Vit .B12.

-Lumbalpunktion: erhöhtes Tau-Protein, erniedrigtes β -Amyloidprotein.

-CT-MRT des Schädels.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Medikamente vor:

-Tacrin - Donepezil - Memantin - Galantamin – Rivastigmin.

Mögliche Fragen:

- Wie heißen Sie? Wie alt sind Sie? Wie ist Ihre Geburtsdatum?
- Was führt Sie zu uns?
- Wissen Sie heutiges Datum? In welchem Jahr sind wir?
- Welche Wochentag ist heute?
- Wissen Sie, wo Sie wohnen? Können Sie mir Ihre Wohnadresse nennen?
- Wissen Sie, wo Sie sind?
- Wie sind Sie zu uns gekommen?
- Sind Sie alleine oder haben Sie einer Begleitperson?
- Seit wann leiden Sie unter Gedächtnisverlust?
- Gibt es einen bestimmten Auslöser für die Beschwerden?
- Haben Sie zum ersten Mal solche Beschwerden?
- Hatten Sie in der letzten Zeit eine Kopfverletzung?
- Leiden Sie unter Lähmungen oder Missempfindungen wie Kribbeln?
- Können Sie sich gut konzentrieren?
- Können Sie Gespräche gut folgen und alles verstehen?
- Fällt es Ihnen schwer Fernsehen zu schauen?
- Haben Sie, Ihre Angehörige, Freunde oder Nachbarn Gedächtnisstörungen bemerkt?
z.B. vergissens Sie die Namen, Termine, Wegen...
- Fällt es Ihnen schwer, sich an den Namen zu erinnern?
- Haben Sie Schwierigkeiten, Orte oder Personen zu erkennen?
- Suchen Sie häufig im Gespräch nach dem richtigen Wort?
- Verwechseln Sie oft Wörter beim Sprechen?
- Leiden Sie unter einer Wortfindungsstörung in der letzten Zeit?
- Vergessen Sie manchmal, warum Sie in einen Raum gegangen sind?
- Haben Sie sich schon mal verlaufen?
- Haben Sie Schwierigkeiten Aufgaben im Alltag zu erledigen? z.B. Einkaufen, Kochen, Ankleidung...
- Fühlen Sie sich anhaltend traurig, niedergeschlagen? (Dysphorie?)
- Fühlen Sie als ob Sie nicht mehr Lust haben etwas zu tun? z.B. Menschen zu treffen, tägliche Aufgaben zu erledigen...
- Fühlen Sie sich erschöpft oder kraftlos? (Fatigue?)
- Leiden Sie unter Muskelschwäche?
- Haben Sie Schwierigkeiten Gegenstände zu erkennen?
- Wie ist Ihre Appetit?

- Haben Sie in letzter Zeit ungewollt angenommen?
- Haben Sie Problem beim Wasserlassen und beim Stuhlgang?
- Schlafen Sie gut? Oder Leiden Sie unter ein- oder durchschlafstörungen?
- Leben Sie allein?
- Fühlen Sie sich verlassen?
- Denken Sie an Selbstmord?

Definition

Die **Alzheimer-Krankheit** ist eine häufige neurodegenerative Erkrankung, die durch eine progrediente Atrophie der Großhirnrinde (Cortex cerebri) mit charakteristischen neuropathologischen und neurochemischen Veränderungen gekennzeichnet ist. Die Betroffenen entwickeln eine über Jahre zunehmende Demenz, die in späteren Krankheitsstadien zu einem Verlust der Alltagskompetenz und zu einem Persönlichkeitszerfall führt. Histopathologische Untersuchungen zeigen, dass Ablagerungen des Proteins Beta-Amyloid (Aβ) im Hirnparenchym und in den Hirngefäßen ein wesentlicher Treiber der Erkrankung sind.

Symptome

Die Alzheimer-Krankheit geht mit einem Abbau des Gedächtnisses sowie kognitiver, emotionaler und sozialer Fähigkeiten einher. Das erste Symptom der Alzheimer-Krankheit ist eine zunehmende Störung der Merkfähigkeit und der Orientierung. Weitere Symptome:

Amnesie	Gedächtnisverlust, Vergesslichkeit
Apraxie	Verlust praktischer Fähigkeiten, z.B. Ankleiden, Schuhe binden, Kaffee kochen
Sensorische Aphasie	Fehlendes Sprachverständnis
Agnosie	Mangelnde Interpretationsfähigkeit wahrgenommener Informationen, Überforderung beim Treffen von Entscheidungen
Motorische Aphasie	<u>Sprechstörung</u> , unverständliche Sprache
Apathie	Mangelnde Anteilnahme

Verlauf

Der Verlauf der Alzheimer-Krankheit ist chronisch progredient und lässt sich grob in drei Stadien einteilen:

- Stadium 1: Amnesie
- Stadium 2: Apraxie, sensorische Aphasie, Agnosie
- Stadium 3: Bettlägerigkeit, Apathie, Inappetenz, Inkontinenz, motorische Aphasie

Jedes Stadium dauert ca. drei Jahre lang an.

Diagnostik

- Eigenanamnese, Fremdanamnese (Befragung der Angehörigen)

- Neuropsychologische Testverfahren (z.B. DemTect, Mini-Mental-Status-Test (MMST), Uhrentest)
- Liquordiagnostik: erhöhtes Tau-Protein und phosphoryliertes Tau-Protein, erniedrigtes β -Amyloidprotein A β (1-42) und erniedrigter Quotient A β (1-42)/A β (1-40)
- Molekularbiologisch (ApoE4-Genotyp)
- Radiologie: Hirnatrophie (betont temporal und hippocampal), dient dem Ausschluss von Differenzialdiagnosen
 - Computertomografie (CT)
 - Magnetresonanztomographie (MRT)
- Nuklearmedizin: Ein Diagnoseverfahren zur Früherkennung des Morbus Alzheimer ist die Software-gestützte Messung der Stoffwechselaktivität im Hippocampus mittels Positronenemissionstomographie (PET).

Therapie

Bis heute (2026) ist die Alzheimer-Krankheit unheilbar. Daher bezieht sich die gängige Therapie auf die Linderung der Symptome. Einige Medikamente konnten in klinischen Studien eine Verbesserung der Symptomatik (besonders der Merkfähigkeit) zeigen, unter anderem: Tacrin, Donepezil, Memantin, Galantamin, Rivastigmin

Mini-mental-status-test: ist ein kurzes, ca. 10-15 minutiges Verfahren zur Beurteilung kognitiver Funktionen. Er umfasst 30 Fragen und Aufgaben zu Orientierung, Merkfähigkeit, Aufmerksamkeit, Erinnerung und Sprache. Dabei werden folgende Schwerpunkte getestet:

- Orientierung
- Merkfähigkeit
- Frischgedächtnis
- Rechnen und Buchstabieren
- Handlungsteil
- visuell-konstruktorischer Teil

Den Patient und den Angehörigen die Krankheit erklären: Die Alzheimer-Krankheit ist eine Erkrankung des Gehirns, die zu den Demenzerkrankungen gehört. Dabei lassen mit der Zeit das Gedächtnis und die Konzentration nach. Betroffene Menschen werden vergesslicher und haben Schwierigkeiten, sich Dinge zu merken oder sich zu orientieren. Die Krankheit entwickelt sich langsam über mehrere Jahre. Bedauerlicherweise ist es nicht heilbar, aber es gibt medikamenten, die den Prozess verlangsamen.

Panikattacke

1-persönliche Daten: Herr Horst Hartmann/Maria Hartmann 38-jährig, 85 kg schwer, 1,87 m groß

2-Allergie: Er reagiere allergisch auf Cotrim./Antibiotika (mit Quaddeln(deri şişmesi) und Juckreiz)

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: Er sei Nichtraucher.

Alkohol: Er trinke ein Glas Wein abends.

Keine Drogen.

Sport: Zur Sportaktivität gehört Fahrradfahren.

4- Sozialanamnese: Familienstand: Er sei verheiratet, habe 2 Kinder und lebe mit seiner Familie zusammen.

Arbeit: Ingenieur

5- Familienanamnese: Familienanamnese sei unauffällig.

2-aktuelle Beschwerden:

Herr Hartmann ist ein 38-jähriger Patient, der sich heute Morgen bei uns wegen seit 2 Wochen bestehenden Herzrasens, Herzklopfens mit Angstgefühl vorgestellt hat. (Seit einem Jahr intermittierendes, manchmal wöchentlich oder monatlich plötzlich auftretendes Herzrasen)

-Der Pt. berichtet, dass diese Beschwerden drei Mal innerhalb dieser 2 Wochen aufgetreten seien und er wegen dieser Beschwerden in der Nacht mehrmals aufgewacht sei.

-Zusätzlich teilt er mit, dass das Herzrasen ca. 30 Minuten und manchmal noch länger gedauert habe.

-Der Patient berichtet, dass er sich immer Sorgen um seine Frau mache und Herzrasen habe, wenn sie außerhalb der Wohnung unterwegs sei. Wenn seine Frau zuhause sei, würden sich seine Beschwerden lindern.

Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint.

3-Begleitsymptome

Ferner sind dem Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

- Atemnot
- Schwindel
- Schweißausbrüche
- Unruhe

Die Frage nach Brustschmerzen, Bauchschmerzen sowie Kopfschmerzen und Fieber wurden vom Pt. verneint.

4. Vegetative Anamnese:

-Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf Schlafstörung

Die Reise-Anamnese und die Sexualanamnese seien unauffällig.

5. Vorerkrankungen:

-An Vorerkrankungen leide er an Hypothyreose seit 10 Jahren.

Es wurde beim Pt. als Kind eine Appendektomie durchgeführt.

6. Medikamentenanamnese:

-Der Pt. nehme zurzeit keine Medikamente ein/

-Der Pt. nehme Insulin regelmäßig und Aspirin bei Bedarf sowie Thyroxin 150mg einmal täglich.

7. Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Panikattacken hin.

-Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

KHK,

Hyperthyreose

Depression

Herzrhythmusstörung

8. Maßnahmen

- Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen.

-Zur weiteren Abklärung sollten folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

-Labor: TSH, freie T4, T3)

-EKG, 24 hr EKG

Psychiatrie-Konsil

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:

Patientenaufklärung und Beruhigung, Betablocker, Psychotherapie, Antidepressiva oder den kurzzeitigen Einsatz von Benzodiazepinen (Diazepam) zur Unterstützung

Mögliche Anamnesefragen

- Was führt Sie zu uns?
- Leiden Sie unter Herzrasen oder -klopfen?
- Verspüren Sie Brustschmerzen? Falls ja: Sind die Brustschmerzen belastungsabhängig? Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Sind die Schmerzen anhaltend oder wiederkehrend? Intensität, Charakter fragen.
- Seit wann haben Sie diese Beschwerden?

- Haben Sie Atemnot? Sind die Atemnot belastungsabhängig?
- Ist der Atemnot mit Brustschmerz oder Brustenge verbunden?
- Schwitzen Sie mehr als sonst?
- Leiden Sie unter Schweißausbrüche?
- Leiden Sie unter Hitzewallungen oder Kältegefühl?
- Haben Sie Zittern?
- Ist oder war Ihnen schwindelig oder ohnmächtig?
- Hatten Sie solche Beschwerden früher schon einmal?
- Wie haben die Beschwerden angefangen?
- Gibt es einen bestimmten Auslöser?
- Wann ist Ihre Angst erstmals aufgetaucht?
- In welchen Situation tritt die Angst auf? Gibt es Gründe dafür?
- Wie oft leiden Sie unter diese Attacken?
- Treten die Beschwerden regelmäßig auf?
- Treten die Beschwerden plötzlich oder langsam auf?
- Wie lange hält das Angstgefühl? Dauert es Minuten oder länger?
- Wie und wann klingt die Beschwerden ab? Geht es von alleine wieder weg?
- Gibt es angstfreie Zeiten?
- Wodurch nimmt die Angst ab oder zu?
- Leiden Sie unter erhöhte Schreckhaftigkeit?
- Wie lange dauert es bis die Beschwerden Ihren Höhepunkt erreichen?
- Was spüren Sie, wenn die Angst am Höhepunkt erreicht?
- Passiert noch etwas, wenn Sie eine Attacke bekommen?
- Wie macht sich die Angst bemerkbar?
- Welche körperlichen Beschwerden bekommen Sie?
- Verspüren Sie ständige Sorge, eine weitere Panikattacke zu erleben?
- Fällt es Ihnen schwer, während einer Panikattacke sich zu kontrollieren?
- Haben Sie während der Attacke das Gefühl, dass Sie sterben könnten oder etwas Schlimmes passiert?
- Haben Sie Schlafstörungen wegen der Beschwerden?
- Werden die Beschwerden besser, wenn Sie sich sicher fühlen?

Definition

Die **Panikattacke** ist eine plötzlich und zeitlich begrenzt auftretende Alarmreaktion des Körpers mit Angst und vegetativer Symptomatik, die jedoch ohne objektiv fassbaren Anlass auftritt.

Symptome

Die Symptomatik einer Panikattacke kann folgend ausgeprägt sein:

- Dyspnoe, Engegefühl der Brust
- Gefühl einer drohenden Ohnmacht
- Angst, zu sterben
- Tachykardie und Palpitationen (meist ohne maßgebliche Erhöhung der Herzfrequenz)
- Tremor (Zittern, Beben)
- Schwitzen ("feuchte Hände")
- Übelkeit
- Hyperventilation
- Hitzewallungen ("Mir wird ganz heiß")
- Kälteschauer ("Mir läuft ein kalter Schauer über den Rücken")
- Gefühl eines Kontrollverlusts

- Entfremdungserlebnisse, Derealisationsphänomene ("Die Welt war nicht mehr wirklich"). Die Patienten geben an, während einer Panikattacke ihre Umwelt "wie durch Milchglas" wahrzunehmen.
- Depersonalisationserlebnisse

Therapie

Wichtig ist zunächst eine umfassende Information, damit der Betroffene die Symptomatik als Ausdruck der Angst begreifen kann. Mittel der Wahl sind dabei Gespräche und edukative Verfahren. Daneben haben sich verhaltenstherapeutische Verfahren als sinnvoll erwiesen. Dieser Prozess kann durch Antidepressiva oder den kurzzeitigen Einsatz von Benzodiazepinen unterstützt werden.

zervikaler Diskusprolaps (Bandscheibvorfall)

1- persönliche Daten: Herr Klaus Fischer, 67 Jahre, 83 kg, 1,67m

2-Allergie: Allergie gegen Hausstaub / Pollenallergie (Heuschnupfen(allergische Rhinitis)) sei bei ihm bekannt.

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: 30 Zigaretten am Tag seit 20 Jahren (30 P/Y)

Alkohol: Er trinke keinen Alkohol.

Keine Drogen.

Sport: spiele Kegeln.

4- Sozialanamnese: Familienstand: Er sei getrennt/verheiratet und habe 2 gesunde Kinder.

-lebe (alleine/zusammen mit seiner Frau /Familie).

Arbeit: arbeite im Büro/ Versicherungsfachmann

5- Familienanamnese: Unauffällig/

-Vater: an Myokardinfarkt gestorben

-Mutter: habe an / Pankreaskarzinom / altersbedingten Komplikationen gelitten und sie sei daran gestorben

Er habe keine Geschwister.

2-aktuelle Beschwerden:

-Herr Fischer ist ein 67-jähriger Pt., der sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit 4 Wochen aufgetretender bestehender, stechender, rechtseitiger Nackenschmerzen mit Ausstrahlung in die Schultern/den rechten Arm sowie zwischen die Schultern vorgestellt hat.

-Der Pt berichtet, dass die Schmerzen plötzlich nach dem Heben eines schweren Gegenstandes aufgetreten seien und sich seit einer Woche/im Verlauf verschlechtert und sich im Laufe des Tages verbessert hätten.

-Zusätzlich teilt er mit, dass die Schmerzen 7 von 10 auf der Skala seien.

-Die Schmerzen seien lageabhängig, atemabhängig und bei Belastung sowie beim Einatmen schlimmer geworden.

-Er fügte hinzu, dass er dagegen ein paar Tabletten Ibuprofen eingenommen habe, aber die Tabletten hätten ihm nur ein bisschen geholfen.

Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint/bejaht.

-Der Pt. wurde vom Hausarzt zur Abklärung der Beschwerden überwiesen.

3-Begleitsymptome

Ferner sind dem Pt folgende Begleitsymptome aufgefallen:

-eingeschränkte Bewegung, Parästhesien(kribbeln) und Hypästhesie(leichte taub) des rechten Arms und der

Finger I–III

-Brachialgie und Cephalgie

Die Frage nach Sensibilitätsstörung, Kraftverlust, Fieber, Nackensteifigkeit wurden verneint.

4-Vegetative Anamnese:

- Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf
- Insomnie (Schlafstörung) wegen der Schmerzen
- und gelegentlich Obstipation.
- Des weiteren klagt der Pt. über Gewichtsverlust/-zunahme von ca...kg /innerhalb ...Wochen.
- Der Impfstatus sei vollständig.

5-Vorerkrankungen:

- Benigne Prostatahyperplasie (Vorsteherdrüsenvergrößerung)
- Arterielle Hypertonie
- Hypercholesterinämie (erhöhte Blutfettwerte) seit 10 Jahren
- chronische Bronchitis (Entzündung der Bronchien) seit 15 Jahren
- Es wurde beim Pt. eine Appendektomie vor 30 Jahren, eine Cholezystektomie vor 5 Jahren und eine Tonsillektomie mit 15 Jahren durchgeführt.
- Der Impfstatus sei vollständig.

6-Medikamentenanamnese:

Der Pt. nimmt folgende Medikamente regelmäßig ein:

- Statin -Sortis 20 mg einmal täglich
- Sartan-
- Prostacur 15 Tropfen 1-0-0
- Schlafmittel bei Bedarf
- Spiriva einen Hub täglich

6-Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf einen zervikalen Diskusprolaps hin.

-Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

- 1- Muskelverspannung
- 2- Osteoporose
- 3- Wirbelfraktur
- 4- Tumor oder Metastasen
- 5-Spinalkanalstenose

7-Maßnahmen

- Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen.
- Zur weiteren Abklärung sollten folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- 1-Laboruntersuchung: Differentialblutbild, (Leukozytose), CRP, BSG,
- 2-Röntgen oder CT
- 3-MRT

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:

konservativ behandelt: -medikamentöse Schmerztherapie,

-Bewegungstherapie

-Halskrawatte: Behandlung mit einer Halskrause zur Entlastung der Halswirbelsäule bei Bandscheibenvorfall.

-Physiotherapie

Operationsindikation: a. Wenn es keine Besserung bei der konservativen Therapie gibt oder b. bei deutlicher Behinderung (Parese)

Schultergelenksluxation-Er sagte, dass er Holz im Garten gesägt habe, dann traten die Schmerzen langsam auf.

DD Sehnenverletzung; Schultergelenk -Verschiebung; Muskelverspannung (MRT; EMG; EKG)

Fragen:

- Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0-10, wobei 0 leichte Schmerzen und 10 sehr starke Schmerzen beschreiben?
- Haben schon etwas dagegen eingenommen?
- Halten Sie die Schmerzen an oder brauchen Sie dringend ein Schmerzmittel?
- Sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten oder eher langsam?
- Gibt es einen bestimmten Auslöser für die Schmerzen?

- Haben Sie eine falsche Bewegung gemacht oder etwas falsch getragen?
- Sind sie gestürzt?
- Haben Sie eine bekannte Vorgeschichte?/ Treten diese Schmerzen bei Ihnen zum ersten Mal auf?
- Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
- Wie würden Sie den Schmerz beschreiben? Ist er stechend, brennend, dumpf, ziehend?
- Fühlen Sie ein Kribbeln oder Taubheitsgefühle im/in Ihrem betroffenen Arm?
- Haben Sie Kraftverlust oder Lähmungserscheinungen bemerkt?
- Ist bei Ihnen schon ein Bandscheibenvorfall bekannt?

Arzt-Arzt-Gespräch:

- Warum handelt es sich um einen zervikalen Bandscheibenvorfall und wo befindet sich der zervikale Bandscheibenvorfall? Taubheitsgefühl bei 1.-3. Finger Zwischen C5-C6 (N. musculocutaneus), bei 3. Finger C6-C7 (N. Radius), bei 4.- 5. Finger C7-T1(N. Ulnaris).
- Welche Erkrankung hat den Lendenbandscheibenvorfall verursacht und wo ist er lokalisiert? Falsche/ belastbare Bewegung???
- Welche Untersuchungen werden durchgeführt und warum ist MRT besser als CT? Weil es die Weichteile wie Bandscheiben, Nervenwurzeln, Rückenmark und Bänder besser zeigt.
- Was sind die Differentialdiagnosen?
- Was sind die Symptome einer Schulterluxation?
 - Schulter sieht abgeflacht oder herausgesprungen.
 - Betroffene Arm kann nicht aktiv bewegt werden.
 - Es wurde Schwellung oder Hämatom sichtbar.
 - Kribbeln oder Taubheitsgefühl im Arm oder in den Fingern.
- Wie wird die Operation durchgeführt? „Bei der Operation am Hals wegen eines Bandscheibenvorfalls wird der betroffene Teil der Bandscheibe entfernt, damit die Nerven wieder frei sind. Der Chirurg macht einen kleinen Schnitt vorne am Hals und sorgt dafür, dass die Wirbel stabil bleiben. Nach der Operation kann es sein, dass Sie kurz einen Halskragen tragen und einige Tage im Krankenhaus bleiben. Danach helfen gezielte Übungen und Physiotherapie, dass Sie wieder normal bewegen können.“
- Wie wird sie konservativ behandelt? Schmerztherapie, Halskrawatte, Physiotherapie.

Der 51-jährige Patient, Herr Josef Stelzer, stellte sich heute bei uns wegen seit 4 Wochen bestehender, ziehender, zervikaler Dorsalgie vor. Die Schmerzen würden in den Schulterbereich beiderseits und in den linken Arm ausstrahlen. Auf einer Schmerzskala seien sie bei 7-8/10. Sie seien entstanden, als der Patient vor 4 Wochen schwere Gegenstände gehoben habe. Dagegen habe er Tabletten von Ibu 400mg eingenommen. Letztes Mal war vor 2 Stunden. Die vegetative Anamnese ist unauffällig. Parästhesie, Hypästhesie und Parese wurden verneint. Er rauche seit 35 Jahren ca. 20 Zigaretten/Tag. Er trinke eine Flasche Bier abends. Der Drogenkonsum wurde verneint. Er treibe keinen Sport regelmäßig. Als Vorerkrankungen gab er COPD und Cholezystitis an. Er verwende täglich morgens ein Spray Spiriva (1 Hub). Er nehme regelmäßig Lorano wegen der Hausstauballergie ein (an die Dosierung erinnere er sich nicht, die Medikamentenliste soll mit seinem Hausarzt besprochen werden). Vor 4 Jahren sei bei ihm Cholezystektomie durchgeführt worden. Mit 14 Jahren sei er wegen Appendizitis operiert worden. Die Bluttransfusion wurde verneint. Er reagiere allergisch auf dem Hausstaub. Die Allergie äußere sich mit allergischer Rhinitis und allergischer Konjunktivitis. Er sei vollständig geimpft bis auf den letzten Impfstoff gegen FSME. Er sei in letzter Zeit nicht gereist. Bezüglich der Familienanamnese sei seine Mutter an einem Pankreaskarzinom gestorben. Sein Vater lebe noch und sei über 90 Jahren alt. Keine chronischen Erkrankungen seien bei unserem Patienten bekannt(vermutlich Demenz?) Er sei ein Einzelkind. Er habe zwei gesunde Kinder. Er lebe in einem Haus mit seiner Ehefrau zusammen.

Der 51-jährige Herr Kleist stellte sich in unserer Notaufnahme wegen seit 4 Wochen bestehender, progredienter Zervikalgie mit Ausstrahlung in den rechten Oberarm vor. Als Auslöser nannte der Patient einen Versuch vor 4 Wochen, eine schwere Kiste aufzuheben, als er seinem Schwiegersohn bei dem Umzug geholfen habe. Bei diesem Ereignis fühlte der Patient plötzlich einen Knixen (oder so etwas) und dann hätten die Schmerzen begonnen. Die Fragen nach Kopfverletzungen, Synkope, Nausea, Vomit, ...

Amnesie bei diesem Ereignis wurden verneint. Im Laufe der Zeit seien die Schmerzen stärker geworden und sie verstärken sich bei den Bewegungen des Kopfes und Anheben des rechten Armes. Der Patient habe Ibuprofen mit einer vorübergehenden Schmerzlinderung eingenommen, die letzten 10 Tagen 800 mg 3-mal pro Tag. Die Fragen nach Parästhesien und Myasthenie im rechten Arm wurden verneint. Die vegetative Anamnese ergab Obstipationen seit langem. Die Fragen nach Gewichtsverlust, Fieber und Nachtschweiß wurden verneint. Der Patient leide an COPD. Er habe eine Appendektomie in Kindheit und eine Cholezystektomie vor 10-15 Jahren ohne Komplikationen gehabt. Er nehme regelmäßig

Statine 0-0-1 und bei Bedarf Antihistaminika (ich habe die Namen schon vergessen). Bei Bedarf nutze er auch Spray.

Allergie: Hausstaub (Nießen).

Noxen: Er rauche seit 30 Jahren 1,5 Packungen pro Tag (45 py) und trinke 1-2 Flaschen Bier pro Woche.

Soziale A.: Er sei verheiratet und habe 2 Kinder, arbeite als Büroangestellter.

Familienanamnese: Mutter sei im Alter von 45 Jahren an den Folgen des Pankreaskarzinoms gestorben. Der Vater sei gesund.

Verdachtsdiagnose: Diskusprolaps hin.

Differenzialdiagnosen: Wirbelfraktur, Knochenmetastasen

Diagnostik: körperliche Untersuchung, Blut, Rg-Thorax und MRT der Wirbelsäule.

Bei Bestätigung der Diagnose: Analgetika NSAID (+PPI); ggf Opioide;

CT-gesteuerte Injektion von Lokalanästhetikum an die Nervenwurzel; Bewegungstherapie;

Physiotherapie, Orthesen.

Bei Indikation operative Therapie.

Definition

Ein **HWS-Bandscheibenvorfall** ist ein Bandscheibenvorfall, der die Halswirbelsäule betrifft. Er führt zu einer Einengung der abgehenden Nerven aus dem zervikalen Rückenmark, ggf. auch zu einer Kompression des Rückenmarks selbst (Myelopathie).

Klinik

Leitsymptom des HWS-Bandscheibenvorfalls ist die Schmerzausstrahlung in den Arm. Seltener ziehen die Schmerzen auch zwischen die Schulterblätter und bis zur Hinterhauptsregion. Unter Umständen sind sie begleitet von Sensibilitätsstörungen und Lähmungen der Arm- bzw. Handmuskulatur.

Therapie

Die Differenzierung des Behandlungsbedarfs ist sehr wichtig. Es wird zwischen selbstlimitierenden und fortschreitenden Veränderungen mit neurologischen Defiziten unterschieden. Häufig klingen die Symptome von alleine innerhalb von 3 Monaten ab. Ein operatives Vorgehen wird an entsprechende Veränderungen im Röntgenbild respektive in der Magnetresonanztomographie (MRT) gekoppelt.

Ein HWS-Bandscheibenvorfall mit Myelopathie und Querschnittssymptomatik stellt in der Regel eine absolute Indikation für eine Operation dar, sofern keine schwerwiegenden anderen Einschränkungen beim Patienten bestehen, die eine OP verhindern. Wenn lediglich eine Radikulopathie vorliegt, können zuerst konservative Ansätze versucht werden.

In der Regel wird das Segment der Halswirbelsäule durch einen frontalen Zugang freigelegt und die entsprechende Bandscheibe unter mikroskopischer Sicht entfernt. Falls die degenerativen Veränderungen noch nicht zu sehr fortgeschritten sind, kann das Segment durch eine Bandscheibenprothese aufgerichtet werden. Bei fortgeschrittenen degenerativen Veränderungen wird ein Platzhalter bzw. Cage in das Bandscheibenfach eingebracht, so dass anliegende Wirbelkörper miteinander verwachsen.

Multiple Sklerose

1-persönliche Daten:

Name: Herr Klaus Huber, Alter: 33 Jahre Gewicht: kg Größe: m

2-Allergie: Der Patient reagiere allergisch gegen Fisch und alle Meeresfrüchte (geschwollene Lippen, manchmal sei sein gesamtes Gesicht geschwollen).

3- Genussmittel/ Noxen

-Nikotin: Nichtraucher,

Alkohol: gelegentlich, 1/2 l Bier pro Woche

-nehme keine Drogen

Sport: kein/ gelegentlich (jetzt nicht mehr wegen der Beschwerden)

4- Sozialanamnese:

Familienstand: ledig - keine Kinder

(Herr Huber fühlt sich einsam und isoliert in der letzten Zeit seit der Trennung seiner Eltern vor 6 Monaten)

Arbeit: Informatiker

5- Familienanamnese:

-Vater: sei gesund

-Mutter und Großmutter leiden an Mammakarzinom (Brustkrebs).

Keine Geschwister.

2-aktuelle Beschwerden:

-Herr Huber ist ein 33-jähriger Pt., der sich heute Morgen bei uns wegen seit 3 Monaten aufgetretender, bestehender Schwächen im linken Bein mit Paralyse (Lähmung) und Parästhesie (Kribbeln) vorgestellt hat.

-Der Pt. berichtet, dass die Beschwerden langsam aufgetreten und im Verlauf der Zeit schlimmer geworden seien.

-Die Beschwerden seien belastungsabhängig und lageabhängig und bei der Belastung (Treppe steigen) oder Hochlagerung des Beines schlimmer geworden.

- Treppensteigen sei Auslöser der Schmerzen.

- Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint.

3-Begleitsymptome

Ferner sind dem Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

- Depressive Stimmungen.

- Parästhesie (kribbeln/ameisenlaufen)

- Paralyse

Die Frage nach anderen Beschwerden, Schmerzen wurde verneint.

4-Vegetative Anamnese:

-Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf

-Insomnie (Schlafstörung)

5-Vorerkrankungen:

- Es seien keine relevanten Vorerkrankungen bekannt.

-Es wurde beim Pt. als Kind eine Appendektomie (Blinddarmentfernung) durchgeführt.

-vor 12 Jahren wurde Psychotherapie empfohlen und der Patient habe das gut angenommen.

6-Medikamentenanamnese:

-Der Pt. nehme zurzeit keine Medikamente ein außer ein Corticosteroid-Spray wegen seiner Allergie.

7-Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf multiple Sklerose hin.

-Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

- Diskushernie
- Osteoporose
- PAVK
- Vit-b12 mangel
- Vaskuläre erkrankungen
- rheumatische Erkrankungen: SLE, M. Sjögren, M. Behçet
- infektiöse Krankheiten mit möglicher neurologischer Beteiligung: HIV, Borreliose, Syphilis

8-Maßnahmen: Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen. (werden zusätzliche neurologische und radiologische Untersuchungen durchgeführt.)

Charcot-Trias-I: Nystagmus, skandierende Sprache und Intentionstremor

Sensibilität, Konzentration, Koordination, Muskelkraft, Muskeleigenreflexe sind erhöht, Babinski-Zeichen,

-Zur weiteren Abklärung sollten die folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

1- Laboruntersuchung (BB- ↑ Leukozyten, anti- MOG - anti-MBP-Antikörper im Serum)

Lumbalpunktion - Untersuchung des Liquors IgG-Synthese (oloklonale banden)

2- MRT zur Diagnostik und besonders zur Verlaufsbeobachtung bei Multipler Sklerose. Man sieht hyperintense Läsionen (weiß)

3-EEG

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:

1-Schub – Glucocorticoid

2-Verlauftherapie Immunsuppressivum: Azathioprin, Methotrexat

3- Psychologische Unterstützung

Fragen:

- Haben Sie Schwierigkeiten beim Sehen?
- Sehen Sie Doppelbilder?
- Ist Ihnen Unterschied in Ihrem Gesicht aufgefallen?
- Verspüren Sie häufig Kopfschmerzen? Wo sind sie ganz genau?
- Wie stark sind Ihr Kopfschmerzen auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 schmerzfrei und 10 stärkste Schmerzen beschreiben?
- Verspüren Sie ein Kribbeln oder Brennen in den Armen oder Beinen?
- Leiden Sie unter Lähmungen?
- Haben Sie Schwierigkeiten beim Gehen?
- Leiden Sie unter Zittern?
- Hat sich Ihre Stimme verändert?
- Haben Sie Schwierigkeiten beim Sprechen oder Schlucken?
- Haben Sie Schwierigkeiten beim Wasserlassen?
- Leiden Sie unter Harndrang (Pollakisurie) (sık ve ani idrar yapma isteği) oder Harnverhalt (Ischurie) (idrar yapamama)?
- Ist bei Ihnen Erektionsstörungen bekannt?
- Fühlen Sie sich aussergewöhnlich müde und kraftlos?
- Tritt die Müdigkeit auch ohne körperliche Anstrengung auf?
- Verstärkt sich Ihre Müdigkeit und Kraftlosigkeit durch körperliche Anstrengung?
- Verspüren Sie Muskel- oder Gelenkschmerzen?
- Leiden Sie unter Antriebslosigkeit?
- Haben Sie Konzentrations- und Gedächtnisstörungen?
- Ist bei Ihnen oder in der Familie Immunschwäche Erkrankungen bekannt?
- Haben Sie Gleichgewichtsstörungen? Ist Ihnen oft schwindelig?

Herr **Klaus Huber**, 33 Jahre alt.

Der Patient klagte über Hypästhesie, Parästhesie und Sehstörungen, verneinte jedoch depressive Stimmung und Paralyse.

Der Patient erzählte anfangs sehr viel und nannte fast die gesamte aktuelle Anamnese, währenddessen habe ich die wichtigen Informationen notiert und nicht wiederholt/nachgefragt.

Vorherige Erkrankungen (VA): Unauffällig bis auf Insomnie.

Vergangene Erkrankungen (VE): Zustand nach Appendektomie im Alter von 12 Jahren.

Medikamente: Keine.

Allergien: Fisch (äußert sich in geschwollenen Lippen und Zunge).

Noxen: Cannabis.

Alkohol: Kein Konsum.

Familienanamnese: Vater gesund. Mutter hatte Mammakarzinom, behandelt mit Chemotherapie, Radiotherapie und Mastektomie. Keine Geschwister.

Reaktionen: Der Patient fragte nach den möglichen Ursachen seiner Symptome und wie weiter verfahren werden soll.

Es wurde ein Arzt-Arzt-Gespräch geführt, bei dem die Verdachtsdiagnose (VD) und Differentialdiagnosen

(DD) besprochen wurden. Die körperliche Untersuchung (KU), Laboruntersuchungen und apparative Diagnostik wurden ebenfalls diskutiert. Der Oberarzt empfiehlt eine MRT-Untersuchung des Schädels und eine Therapie zu Hause, darunter Physiotherapie. Der Patient hatte im Internet recherchiert und wünschte sich eine vollständige Heilung seiner Erkrankung.

(**Aufklärung**) Es wurde ihm erklärt, dass seine Erkrankung, Multiple Sklerose, chronisch und unheilbar ist. Da der Patient im zweiten Stock wohnt, riet der Oberarzt, ihm zu empfehlen, in ein Erdgeschoss zu ziehen.

Definition

Die **Multiple Sklerose**, kurz **MS**, ist eine chronische, entzündlich-demyelinisierende Erkrankung des zentralen Nervensystems (ZNS). Die Ursache ist noch nicht vollständig geklärt.

Symptomatik

Die Symptomatik manifestiert sich zumeist zwischen dem 15. und 45. Lebensjahr in Form von Frühsymptomen wie:

- Sensibilitätsstörungen (30–40 %)
- Retrobulbärneuritis (20–30 %)
- Chronisches Erschöpfungssyndrom, Fatigue (> 50 %)

Im weiteren Verlauf sind u.a. folgende Symptome anzutreffen:

- Motorische Störungen: spastische Mono-, Hemi- oder Paraparese
- Sensibilitätsstörungen: Parästhesien, Dysästhesien
- Zerebelläre Störung: Standataxie, Gangataxie, Zeigeataxie, Nystagmus, Intentionstremor, Dysarthrie
 - Charcot-Trias: Nystagmus, skandierende Sprache und Intentionstremor
- Augensymptome: Augenmuskelparese, internukleäre Ophthalmoplegie (INO)
- Blasenstörung: Imperativer Harndrang, Inkontinenz, erektile Dysfunktion, Harnretention
- Schnelle Ermüdbarkeit und chronisches Erschöpfungssyndrom (Fatigue)
- Kognitive Störungen: verminderte Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit
- Pseudoneuritis vestibularis
- Begleitend können psychische Symptome wie Depressionen und emotionale Labilität auftreten.

Therapie

-Glukokortikoid (mit ppi zusammen)

-Immunsupresiva

-Symptomatische Therapie

Physiotherapie

Medikamentöse symptomatische Therapie

- Antispastische Therapie: Baclofen, Tizanidin, Cannabinoide, Botulinumtoxin A
- Verbesserung der Gehfähigkeit: Fampridin/4-Aminopyridin
- Schmerzen: Gabapentin/Pregabalin, TCA, Antikonvulsiva, Opioide
- Psychische Symptome: Antidepressiva
- Müdigkeit: Amantadin, Modafinil, Armodafinil, Amphetamine
- Vitamin D (vermindert die Krankheitsprogression und das Osteoporoserisiko)

Ergotherapie

Logopädie

Ausdauer-/Bewegungstraining

Psychotherapie

Hilfsmittelversorgung

Osteoporose (Konochenschwund)

1-persönliche Daten: Martin Schmidt ist ein 55-jähriger Patient, 70 kg schwer, 1,80 groß.

2-Allergie: Allergie gegen Nüsse sei ihm bekannt. Er reagiere darauf mit Schwellungen der Zunge.

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: 20 Zigaretten am Tag seit 20 Jahren 20P/Y

Alkohol: 2 bis 3 Gläser Rotwein täglich.

Keine Drogen.

Sport: Tanzen

4- Sozialanamnese:

Familienstand: Er sei verheiratet, habe 3 gesunde Kinder und wohne zusammen mit seiner Familie

Arbeit: Verwaltungsangestellter bei der Gemeinde

5- Familienanamnese: Unauffällig

Vater: Apoplex vor 4 Jahren

Mutter: Osteoporose

Er habe keine Geschwister.

2- Aktuelle Beschwerden

-Herr Schmidt ist ein 55-jähriger Pt., der sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit gestern auftretender, stechender Lumbalgie (Rückenschmerzen/ Schmerzen in thorakaler Wirbelsäule) ohne Ausstrahlung vorgestellt hat.

-Der Pt. berichtet, dass die Schmerzen plötzlich aufgetreten seien und sich im Verlauf der Zeit verschlechtert hätten.

-Zusätzlich teilt er mit, dass die Schmerzen 8-9 von 10 auf der Skala seien und sich bei Bewegung verschlechtert hätten.

Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint/bejaht.

3-Begleitsymptome

Ferner sind dem Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

-eingeschränkte Bewegung

-Kraftverlust

Die Frage nach Sturz, Hypästhesie (Taubheitsgefühl), Parästhesie (Kribbeln-Missempfindung) und Paralyse (Lähmung) wurde von ihm verneint.

4-Vegetative Anamnese: Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf

-Insomnie (Schlafstörung) wegen der Schmerzen.

Der Impfstatus sei vollständig.

5-Vorerkrankungen:

- Diabetes Mellitus seit 20 Jahren

- Osteoporose seit 2-3 Jahren
-Es wurde beim Pt. eine Appendizitis als Kind sowie eine Hüftgelenk-TEP-Femurhalsfraktur vor 3 Jahren behandelt.
Der Impfstatus sei vollständig.

Medikamentenanamnese:

Der Patient nimmt folgende Medikamente regelmäßig ein :

Metformin 1000 mg 1-0-1

6-Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Osteoporose hin.

-Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

1- Bandscheibenprotrusion.

2- Wirbelfraktur.

3-Tumor oder Metastasen.

7-Maßnahmen

- Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen.

-Zur weiteren Abklärung sollten folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

1-Laboruntersuchung (BB, Entzündungsparameter, Kalzium, Phosphor, BZ, HbA1c; PTH und TSH).

2- LWS-Röntgen mit Knochendichtemessung

(Aufhellung der Knochenstruktur durch vermehrte Strahlentransparenz- Knochendichte.)

3-LWS-MRT

4-Osteodensitometrie.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:

konservativ behandelt:

-medikamentöse Schmerztherapie, Calcium-Vitamin D-Bisphosphonate - Östrogene und Gestagene

-Bewegungstherapie

-Physiotherapie

Operationsindikation:

Stabilisierung des Skelettsystems

Fragen:

- Haben Sie letzte Zeit an Körpergröße verloren?
- Wo genau sind die Schmerzen am Rücken?
- Seit wann haben Sie die Schmerzen?
- Hatten Sie einen Unfall oder Verletzung?
- Haben Sie einen Rückenbuckel(Kyphose) (sirt kamburluğu) oder ein Hohlkreuz(Lordose) (bel çukurunun artması) festgestellt?
- Haben Sie eine Veränderung Ihrer Körperhaltung festgestellt?
- Hinken Sie?
- Haben Sie ungewollt an Gewicht verloren?
- Wurde bei Ihnen schon einmal eine Knochendichtemessung (DXA) durchgeführt?
- Haben Sie in der Vergangenheit Knochenbrüche ohne schweres Trauma erlitten?
- Haben Sie chronische Erkrankungen wie Rheuma, Diabetes oder Schilddrüsenüberfunktion?
- Nehmen Sie langfristig Kortison ein?
- Nehmen Sie regelmäßig Vit-D ein?
- Bewegen Sie sich täglich ausreichend?

Herrn Rainer Hober, 55 Jahre alt, 1,83 m groß und 83 kg schwer. Seit gestern leidet er unter plötzlich auftretenden, ziehenden und stechenden Brust-Wirbelsäulenschmerzen ohne Ausstrahlung, die sich im Verlauf verschlechtern haben. Die Schmerzen sind beim Bewegen 7 von 10 und in Ruhe 4 von 10. Es gab keine erkennbaren Auslöser, Trauma oder Verletzungen. Vor einigen Jahren wurde bei ihm Osteoporose diagnostiziert, jedoch wurde keine Behandlung durchgeführt. Zusätzlich leidet er unter morgendlichem Husten und Müdigkeit. Seine Vorerkrankungen umfassen Typ-2-Diabetes, der mit Metformin 1000 mg (1-0-1) behandelt wird, sowie eine frühere Oberschenkelfraktur, die mit Nagelosteosynthese behandelt wurde. Er hat eine Nussallergie, die zu Schluckbeschwerden führt, und

raucht seit 20 Jahren 20 Zigaretten pro Tag. Sein Alkoholkonsum beträgt 1-2 Gläser pro Abend. Der Vater hatte einen Schlaganfall und die Mutter leidet im Alter von 80 Jahren ebenfalls an Osteoporose.

Reaktion: Was werden Sie für mich tun?

AA: Nur persönlichen Daten erfassen und dann gezielte Fragen

stellen: Was hat der Patient? Seit wann? Gibt es einen Auslöser? Welche Verdachtsdiagnose haben Sie?

Welche Differentialdiagnosen erwägen Sie? KHK+++

Welche Risikofaktoren liegen vor?

Handelt es sich um primäre oder sekundäre Osteoporose?

Welche Maßnahmen und Therapien werden empfohlen?

Ätiologie

LittleDoc meint

- primäre Osteoporose – meist bei Älteren
 - postmenopausale Osteoporose (↓ Östrogen)
 - senile Osteoporose
 - idiopathische juvenile Osteoporose
- sekundäre Osteoporose
 - endokrinbedingt: Hyperkortisolismus, Hyperthyreose, Hyperparathyreoidismus, Akromegalie, Hypogonadismus
 - Stoffwechselstörungen: DM, Malabsorption (oder Diarrhö-Krankheiten), Vitamin-D-Mangel
 - medikamentös bedingt: GKK, Schilddrüsenhormone, Heparin
 - autoimmun
 - Malignome
 - mechanisch bedingt: lange Immobilisation
 - chronische Niereninsuffizienz (renale Osteopathie)
 - Osteoporosis circumscripta cranii

Risikofaktoren

- ♀: Menopause + Knochenmasse < ♂
- familiäre Belastung
- hohes Alter

15.3.3. Klinik

- Rückenschmerzen
- Körpergröße ↓
- thorakale Hyperkyphose
- Spontanfrakturen

15.3.4. Diagnostik • Labor

- Differenzialblutbild
 - BSG
 - Kalzium (Hyperparathyreoidismus?)
 - Vitamin D
 - PA (↑ ? Morbus Paget)
 - Phosphat (chronische Niereninsuffizienz?)
 - Blut und Urin: Bence-Jones-Ketten (multiples Myelom?)
 - Osteodensitometrie: Dual X-Ray Absorptiometry (DEXA) – Knochendichtemessung:
 - normal ≥ -1
 - Osteopenie -1 bis $-2,5$
 - Osteoporose $\leq -2,5$; manifeste Osteoporose $+1$ – 3
- Wirbelbrüche

- Röntgenaufnahmen der Wirbelsäule
 - Keil-, Fisch- oder Plattwirbel
 - Deckplatteneinbrüche bis Plattwirbel
 - vermehrte Strahlentransparenz
 - Trabekel wird rarefiziert
 - spongiosa Vertikalbetonung (strähniges Aussehen)
 - leere Diaphysen der langen Röhrenknochen
- Sonografie und CT-Knochendichtemessungen
- ggf. Knochenbiopsie

15.3.5. Therapie

- Kalzium 1 g / d
- Vitamin D 1000 IE / d
- Bisphosphonate: hemmen die Osteoklasten
- Denosumab: hemmt die Osteoklasten
- rekombinantes PTH
- Kalzitinin: aktiviert Osteoblasten + wirkt zentral analgetisch
- Strontiumranelat: osteoanabol
- Raloxifen: selektiver Östrogenrezeptor-Modulator (SERM), nur bei Postmenopause; antiresorptiv
- Fluoride

15.3.6. Prophylaxe

- Vitamin D3, Calcium
- Östrogene oder Raloxifen (postmenopausal)
- Sport

Gichtanfall

Gichtanfall

1-persönliche Daten: Name: Herr Ralf Bethge Alter: 45 Jahre Gewicht: 114 kg Größe: 178 cm

2-Allergie: Keine Allergien bekannt

3-Genussmittel/Noxen

Nikotin: Nichtraucher

Alkohol: Er trinke regelmäßig Alkohol (2-3 Bier täglich seit vielen Jahren)

Keine Drogen.

Sport: Er treibe keinen Sport und sei übergewichtig.

4-Sozialanamnese:

Familienstand: verheiratet - 3 Kinder

Er lebe zusammen mit seiner Familie.

Arbeit: Der Pt. sei Maschinenarbeiter/Lehrer/Laborant/Schlosser Mechaniker von Beruf.

5- Familienanamnese: Unauffällig/

-Vater: Kolonkarzinom (Darmkrebs)/ Magenkrebs, er sei daran gestorben.

-Mutter: gesund

Kinder: zwei seien völlig gesund und eine Tochter leide am Down-Syndrom.

2-aktuelle Beschwerden:

-Herr Bethge ist ein 45 -jähriger Pt., der sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit heute Nacht /2 Tagen klopfender, starker, stechender Schmerzen am linken Fuß, besonders im Hallux (der großen Zehe / Großzehengrundgelenk) ohne Ausstrahlung vorgestellt hat.

-Der Pt. berichtet, dass die Schmerzen gestern Nacht plötzlich aufgetreten seien und sich im Laufe der Zeit verschlimmert hätten.

- Heute Nacht sei er wegen der Schmerzen aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen.
- Zusätzlich teilt er mit, dass die Schmerzen 7- 8 von 10 auf der Skala seien.
- Die Schmerzen seien lageabhängig und beim Stehen/bei Bewegung schlimmer und in Ruhe besser geworden.
- Er berichtet, dass er wegen dieser Schmerzen besonders am Abend auf dem Fuß nicht auftreten kann.

3-Begleitsymptome

Ferner sind dem Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

- Schwellung
- Rötung
- sowie Überwärmung der betroffenen Stelle.
- Die Fragen nach Fieber, Verletzungen sowie vorherigen ähnlichen Beschwerden wurden verneint.

4-Vegetative Anamnese:

- Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf
- Insomnie (Durchschlafstörung) wegen der Schmerzen und Schnarchen beim Schlafen.
- Er habe guten Appetit (besonders auf Fleisch und fettiges Essen)

5-Vorerkrankungen:

- Es seien keine relevanten Vorerkrankungen bekannt/
- An Vorerkrankungen leide er an
- Migräne
- Der Hausarzt habe bei ihm erhöhte Blutfettwerte festgestellt, trotzdem nehme er keine Medikamente ein und halte keine bestimmte Diät.
- Der Pt. habe vor 25 Jahren einen Motorradunfall gehabt (Gehirnerschütterung)
- Er sei wegen einer Appendizitis/Oberschenkelfraktur vor 20 Jahren operiert worden.

Medikamentenanamnese:

- Der Patient nehme: Ibuprofen 600mg- ASS (1-0-1), Omeprazol 40 mg 1-0-1
- Er nehme Tab. gegen Bluthochdruck

6-Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Podagra (einen Gichtanfall) hin.

- Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:
- PAVK.
- TVT .
- Septische Arthritis.
- Trauma.
- Rheumatische Arthritis.

7- Maßnahmen

- Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen.
- Zur weiteren Abklärung sollten folgende Maßnahmen durchgeführt werden:
- Laboruntersuchung: B.B , Entzündliche Parameter (CRP,BSG,): erhöhte Hyperurikämie.
- Serumharnsäure (meist mehr als 6,4 mg/dl)
- Röntgen: Röntgen des Fußes, des Kniegelenks.
- Gelenkpunktion bei starkem Erguss.
- Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor: -Während eines Gichtanfalls: NSAR-ASS, Colchicin, Kortikosteroide
- Langfristige Senkung der Harnsäurekonzentration im Serum durch:
- 1. Einhaltung einer purinarmen Diät.
- 2. Alkoholabstinenz.
- 3. Medikamentöse Senkung des Harnsäurespiegels: Urikostatika (Allopurinol), Urikosurika (Probenecid).

Fragen:

- Welche Gelenke sind betroffen?

- Sind die Schmerzen plötzlich oder eher langsam aufgetreten?
- Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 schmerzfrei und 10 stärkste Schmerzen beschreibt?
- Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben?
- Sind die Schmerzen beidseitig oder einseitig aufgetreten?
- Ist das zum ersten Mal passiert?
- Gibt es bestimmte Auslöser, die die Schmerzen vermindern oder verschlimmern?
- Sind die Schmerzen anfallsartig oder bestehen sie kontinuierlich?
- Hatten Sie kürzlich eine Verletzung oder einen Unfall?
- Ist das betroffene Gelenk geschwollen, gerötet oder überwärmt?
- Können Sie das betroffene Gelenk bewegen?
- Leiden Sie unter Fieber oder Schüttelfrost?
- Haben Sie Muskel- oder Sehnen Schmerzen?
- Essen Sie häufig Fleisch, Innereien, Meeresfrüchte? (Purinreich)
- Trinken Sie Alkohol?
- Treiben Sie Sport? Bewegen Sie sich ausreichend?

45 Jahre alt. Männlich. Symptome: Stechender Schmerz im linken Großzehengelenk, 8/10, ohne Ausstrahlung, mit Rötung und Schwellung. Die Schmerzen traten plötzlich nachts auf. Der Patient kann nicht mehr laufen. Fieber wird verneint.

Der Patient wiegt 115 kg, trinkt 2 Flaschen Bier pro Tag und isst viel Fleisch.

VE: Hypertonie. Migräne. Nichtraucher. Keine Drogen.

Arzt-Arzt-Gespräch:

- Was spricht für Gicht? Alle anamnестischen Angaben.
 - DD? Septik artrit, rheumatoide Artrit, unfall
 - Welche Untersuchungen?
 - Wie hoch ist der Harnsäurespiegel bei Gicht? Über 6,5 mm/dl
 - Kann der Harnsäurespiegel bei akuter Gicht normal sein? Ja, Harnsäure wird verstärkt in den Gelenken abgelagert. Dadurch kann der Harnsäurespiegel im Blut vorübergehend sinken.
 - Akute Therapie? NSAR, Colchicine.
 - Dauertherapie? Diät, Abnehmen, Allopurinol
 - Welche Komplikationen kann eine Hyperurikämie haben außer Gicht? Gelenkzerstörung, Nierensteine,
 - Was findet man in der Pathologie bei Gicht? Uratkristalle.
 - Der Patient ist übergewichtig. Sollte er abnehmen? Ja.
 - Was kann eine Gewichtsabnahme bei diesem Patienten bewirken? Verschlechterung der Symptome.
- Keine Aufklärung. Der Patient wollte nur wissen, was er hat. Und welche Untersuchungen. Und ob er im Krankenhaus bleiben muss.

Name: Nobert Bethge, Alter: 45 Jahre, Gewicht 114 kg, Größe: 1.78m

Allergie-Noxen: Nichtraucher, 2-3 Bier täglich seit vielen Jahren. Keine Drogen. Er treibt keinen Sport.

Sozialanamnese: Familienstand: verheiratet, 3 Kinder- 2 Söhne (1 Sohn hat Down-Syndrom), 1 Tochter. Er lebt zusammen mit seiner Familie. Arbeit: Schlösser von Beruf

Familienanamnese: Vater an Kolonkarzinom verstorben. Mutter hatte viele chronische Krankheiten, sie verstarb 'beim Schlafen'.

Aktuelle Beschwerden: Herr Bethge ist ein 45-jähriger Pt, der sich heute Morgen bei uns wegen seit 2 Tagen klopfender, stechender, starker Schmerzen am linken Fuß besonders in der Hallux ohne Ausstrahlung vorgestellt hat. Der Pt berichtete, dass die Schmerzen seit 2 Tagen plötzlich aufgetreten seien und sich im Laufe der Zeit

verschlimmert hätten. Heute Nacht habe er wegen der Schmerzen aufgewacht. Er ordnete die Schmerzen auf einer Schmerzskala bei 8 ein. Die Schmerzen seien lageabhängig und beim Stehen/bei der Bewegung schlimmer und in Ruhe besser geworden. Er habe eine Tablette Ibuprofen gegen die Schmerzen genommen, was ihm eine leichte Besserung gab. Als Begleitsymptome nannte er Ödem, Erythem und Überwärmung der betroffenen Stelle. Die Fragen nach Fieber, Verletzung sowie vorherigen ähnlichen Beschwerden wurde verneint. Als Vorerkrankung leidet er an arterieller Hypertonie und Migräne. Er erlitt eine Gehirnerschütterung (Commotio cerebri) wegen eines Motorradunfalls vor 25 Jahren. Die vegetative Anamnese ist bis auf Insomnie wegen der Schmerzen

unauffällig. Er hat einen guten Appetit (besonders für Fleisch und fettiges Essen). Der Patient nimmt regelmäßig Bisoprolol 1-0-0 ein.

Die **Verdachtsdiagnose** lautet Gichtanfall (Podagra).

Als **Differentialdiagnosen** kommen Trauma, rheumatische Arthritis, septische Arthritis, pAVK, TVT.

Die weitere **Untersuchungen**:

Vitalparameter messen

Körperliche Untersuchung

Labor- Blutbild, CRP, BSG, Harnsäure, Nierenwerte

Röntgen des Fußes

Arzt- Arzt-Gespräch:

Was hat Sie zur Diagnose von Gicht geführt?

Welcher Laborparameter ist in Gicht wichtig?

Was sind einige purinreiche Lebensmittel?

Welche Änderungen des Lebensstils würden Sie empfehlen?

Welche Behandlung würden Sie empfehlen?

Ein 45 jähriger Patient, Gewicht:114 kg, Größe:170.

Beruf: Mechatroniker.

Aktuelle Beschwerde: Der Patient kam zu Notaufnahme wegen vor 2 Tagen bestehender, brennender, dauerhafter Schmerzen am Großzehengrundgelenk auf der linken Seite. Die Schmerzen sind 7 von 10 auf der Schmerzskala. Es gibt weder eine Ausstellung noch begleiteten Symptome. Der Patient ist Nichtraucher und trinkt 2 Flaschen Bier am Abend. Er hat keine Medikamente gegen diese Beschwerde eingenommen

Vorerkrankungen und OPs:

Arterielle Hypertonie.

Migräne (seit 20 Jahren).

Motorradunfall (vor 25 Jahren, nur konservative Behandlung, keine Frakturen, keine Schädigungen)

Medikamentöse:

Beta Blocker Bisoprolol 5 mg 1 - 0 - 0

Keine Allergien, kein Fieber.

Die Vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf : er isst viel Fleisch.

Familienanamnese:

Seine Mutter starb an Myokardinfarkt mit 75 Jahren.

Sein Vater lebt noch.

Er hat an Prostatakrebs gelitten und er ist mit Radiotherapie behandelt worden.

Sozialanamnese:

Er ist verheiratet und hat 3 Kinder

Ein Kind leidet an Trisomie 21 (Down Syndrom)

Verdachtsdiagnose:

Podagra (Gichtanfall)

D.D:

Pseudogicht

rheumatoide Arthritis

reaktive Arthritis

septische Arthritis

Diagnostik:

Körperliche Untersuchung

Blutbild (Hyperurikämie)

Gelenkpunktion

Röntgen, MRT

Therapie:

Urikostatika: Allopurinol

Normalisierung des Körpergewichts

Colchicin

Gonarthrose

1-Persönliche Daten: Name: Herr Müller/ Christina Nowalseki/ Christina Schmolinski Alter: 69
Jahre Gewicht: 72kg
Größe: 1,65 m

2-Allergie: Keine Allergien seien bei der Pt. bekannt.

3-Genussmittel/ Noxen

Nikotin: Frau Schmolinski rauche nicht mehr, aber vor 30 Jahren habe sie 20 Zigaretten pro Tag geraucht

Alkohol: eine Flasche Bier abends

Keine Drogen.

Sport: Die Patientin sei sportlich und sei viel gewandert, aber jetzt sei sie wegen der Schmerzen eingeschränkt.

4-Sozialanamnese: Familienstand: verheiratet, 2 gesunde Kinder. Sie lebe alleine/zusammen mit ihrem Mann /Familie.

Arbeit: Rentnerin/ pensioniert (vorher Lehrerin)

5- Familienanamnese:

Vater: sei an Myokardinfarkt (Herzinfarkt) gestorben.

Mutter: sei an Bronchialkarziom (Lungenkrebs) gestorben.

Eine Schwester: sei an Zystenkarzinom (Blasenkrebs) gestorben.

Zwei Söhne: seien gesund

2-aktuelle Beschwerden:

-Frau Schmolinski ist eine 69-jährige Pt., die sich heute Morgen bei uns wegen seit 5-6 Monaten bestehender, stechender, beidseitiger Kniegelenkschmerzen ohne Ausstrahlung vorgestellt hat.

-Die Pt. berichtet, dass die Schmerzen langsam aufgetreten seien und sich im Verlauf der Zeit verschlechtert hätten.

-Zusätzlich teilt sie mit, dass die Schmerzen 5-6 von 10 auf der Skala seien.

-Die Schmerzen seien bewegungsabhängig und beim Laufen, besonders abwärts schlimmer, aber in Ruhe oder unter Medikamentengabe (Ibuprofen) besser geworden.

-Es gebe keine Auslöser der Schmerzen.

3-Begleitsymptome

Ferner sind der Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

-eingeschränkte Beweglichkeit

-Knieschwellung

-Hinken(aksama, topallama)(fachbegriff), Humpeln(aksamak, topallamak)

-Die Frage nach Rötung oder Überwärmung, Beschwerden in anderen Gelenken wurde verneint.

4-Vegetative Anamnese:

-Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf

- Obstipation.

-Insomnie (Schlafstörung) wegen der Schmerzen, besonders wenn sie sich im Bett bewege

-Pyrosis (Sodbrennen)

Die Reiseanamnese sei unauffällig.

5-Vorerkrankungen:

-Hypercholesterinämie

-Es wurde bei der Pt. die folgende OP durchgeführt:

-eine Tonsillektomie (Mandelentfernung) mit 17 Jahren

-eine partielle Kolektomie vor 8 Jahren wegen einer Divertikulitis

Der Impfstatus sei komplett.

6-Medikamentenanamnese:

Die Patientin nimmt folgende Medikamente ein:

-Pantoprazol 40 m.g/ PPI 20mg (1-o-o) bei Bedarf !!!!!

-Ibuprofen 600 m.g (1-1-1) wegen Schmerzen

Simvastatin 20 mg (0-0-1)

7-Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Gonarthrose hin.

-Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

- 1-Septische Arthritis
- 2-Lumbale Diskushernie
- 3-Rheumatoide Arthritis
- 4-Kreuzbandruptur / Meniskusschaden
- 5-Gicht
- 6-Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK)
- 7-Bursitis

8-Maßnahmen

- Als erste Maßnahme würde ich die Pt. körperlich untersuchen.

-Zur weiteren Abklärung sollten folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- 1-Laboruntersuchung: Differentialblutbild, (Leukozytose), CRP, BSG, Harnstoff
- 2-Röntgen des Kniegelenks bds. in 2 Ebenen
- 3-Sonographie (um einen Kniegelenkserguss auszuschließen)
- 4- ggf. MRT, CT, Skelettszintigrafie

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:

- 1- Allgemeinmaßnahmen: Reduktion des Körpergewichts, Bewegung, Physiotherapie
- 2- Konservative Therapie
 - Medikamente (NSAR), intraartikuläre Kortison
 - Physikalische Therapie
 - Thermotherapie (Wärmebehandlung, Kältebehandlung)
 - Elektrotherapie
- 3 -Operative Therapie
 - Korrektur von Fehlstellungen
 - Knorpeltransplantation
 - Abrasionsarthroplastik mit Mikrofrakturierung
 - Gelenkersatz (Knie-TEP)

Komplikationen: Bewegungseinschränkung, Muskelatrophie, Invalidität (sakatlık, özürlülük)

Fragen:

- Wo genau treten die Schmerzen im Knie auf? Innen, außen der Kniescheibe oder Kniekehle?
- Sind die Schmerzen ein- oder beidseitig?
- Seit wann bestehen die Schmerzen?
- Haben die Schmerzen plötzlich oder allmählich begonnen?
- Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben? Sind sie drückend, stechend, ziehend oder dumpf?
- Wie stark sind die Schmerzen auf eine Skala von 0 bis 10, wobei 0 schmerzfrei und 10 unerträgliche Schmerzen sind.
- Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
- Sind die Schmerzen anhaltend oder schubweise?
- Wann treten die Schmerzen typischerweise auf? Morgens, abends oder die ganze Tag?
- Sind die Schmerzen belastungsabhängig?
- Gibt es einen bestimmten Auslöser für die Schmerzen?
- Sind die Knien morgens steif? Wenn ja, wie lange dauert die Morgensteifigkeit?
- Haben Sie Schwellungen, Rötungen, Überwärmung am Knie bemerkt?
- Kancken oder knirschen die Knien beim Bewegen? (Krepitation)
- Gab es frühere Verletzungen oder Operationen am Knie?

69 J Mann 176 cm 68kg

Seit 6 Monaten Bestehender persistierender(devamlı, sürekli) (auch in der Nacht, ständig), progredienter, beidseitiger Knieschmerzen. Ohne Ausstrahlung. Begleitet von Ödem & Erythem (manchmal) und eingeschränkte Beweglichkeit. Keinen Auslöser.

Gibt es etwas, dass die Schmerzen lindert oder verstärkt? Nein.

Sie sind immer stark. Wird es schlimmer mit körperlichen Aktivitäten, beispielsweise beim Gehen?
Nein. Es ist immer stark.
Ibuprofen nicht geholfen. Frage nach Trauma, Parästhesie, Hypästhesie, Parese wurde verneint .
3-8 Schmerzskala
Bohrend & brennender
Ohne Steifigkeit
Zeckenstich verneint
Veg: Schmerzbedingte Schlafstörung, Trockener morgendlicher Husten, Niedergeschlagenheit.
Mit dem Rauchen aufgehört. Früher 20PY
Alkohol: eine Flasche Bier täglich.
Keine Drogen (Reaktion: Frau Dr. haben Sie selbst Drogen ausprobiert?)
Vorerkrankungen: •Hyperlipidämie •Z.n. Diskusprolaps konservativ behandelt vor 1 Jahr •Z.n.
Hemikolektomie vor 10 J (ein Teil von Dickdarm entfernt wurde) •Tonsillektomie & Appendektomie im
Kindesalter
Medikamente: •Pantoprazole, Atorvastatin & Ibuprofen
Mutter: Bronchialkarzinom. Vater: MI. Schwester: Blasenkarzinom
Rentner, früher Lehrer in der Fahrschule. Verheiratet, 2 Kinder gesund (Reaktion: Frau Dr Sie haben
viele Fragen gestellt. Ich habe Schmerzen)
Allergien habe ich vergessen zu Fragen.
AAG: Meine VD war rheumatoide Arthritis Als DD habe ich Gonarthrose & PMR erwähnt.
Diagnostische und Therapeutische Maßnahmen für RF, Arthrose und PMR.

Coxarthrose

Herr Johannes King, 58 Jahre, 1,80m, 110kg
Genussmittel: Alkohol eine Flasche Bier täglich
FA: Vater gestorben / Mutter gestorben, Herzinsuffizienz und DM
SA: Baggerfahrer, verheiratet, eine gesunde Tochter
Anamnese: Seit 5 Monaten stechende, dumpfe Schmerzen in der Linken Hüfte mit Ausstrahlung in den
Oberschenkel bis
zum Knie. Die Schmerzen treten bei Belastung auf, bei jede 500m bekommt er Schmerzen, seit einer
Woche sind die Schmerzen progredient, 7/10 deswegen hat er Voltaren ohne Besserung benutzt.
Müdigkeit und Insomnie. Alle weiteren Fragen wurden verneint.
VE: Dm Typ II, arterielle Hypertonie, Gicht
VO: op wegen einer Meniskusriss
Medikamente: metformin, Voltaren, Ramipril
Arzt-Arzt Gespräch: Ich habe nur die persönlichen Daten gesagt und dann: So er ist Übergewicht,
strahlen die Schmerzen aus? Er hat keinen Unfall keine Parese.. was ist er von Beruf? Also das
Gespräch war wie eine Wiederholung der Anamnese. VD und was machen Sie bei der Untersuchung.
Dann teilte ich dem Patienten die Diagnose mit und sagte, dass wir eine Röntgenaufnahme machen
müssten.

Schenkelhalsfraktur

1-persönliche Daten: Herr Artur Müller, 90 Jahre, 50 kg schwer, 1,55 m groß
2-Allergie – keine/ Pencillin und ein anderes Medikament.

3-Genussmittel/ Noxen

Nikotin: Nichtraucher

Alkohol: trinke gelegentlich ein Glas Sekt. trinke einen Pikkolo
täglich seit 15 Jahren.

Keine Drogen.

Sport: keiner

4- Sozialanamnese: Familienstand: verwitwet, er lebe allein und habe 3 Töchter.

Arbeit: Rentner / pensioniert

5- Familienanamnese: unauffällig.

2-aktuelle Beschwerden:

- Herr Artur Müller ist ein 90-jähriger Pt., der sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit gestern bestehender, stechender, zunehmender Coxalgie dexter (rechtsseitiger Hüftschmerzen) mit Ausstrahlung in den... vorgestellt hat.
- Der Pt. berichtet, dass die Schmerzen plötzlich nach einem Sturz auf den Boden aufgetreten seien und sich im Verlauf der Zeit verschlechtert hätten.
- Der Pt. leide unter Schwindel (Vertigo)
- Zusätzlich teilt er mit, dass die Schmerzen 7 von 10 bei Bewegungen und 3 von 10 in Ruhe auf der Skala seien.
- Er fügt hinzu, dass er dagegen 4 Tabletten ASS eingenommen habe, aber laut Patient hätten die Tabletten ihm nur ein bisschen geholfen.

3-Begleitsymptome

- Hypästhesie (Taubheitsgefühl)
- Parese, Paralyse (er könne sein Bein nicht bewegen)

4-Vegetative Anamnese:

- Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf
- Dyspnoe bei Belastung
 - trockenen Husten und Beinödeme.

5-Vorerkrankungen:

- Myokardiopathie in 1964 und 2004, die beide stationär behandelt wurden.
- Arterielle Hypertonie seit 30 Jahren
- Osteoporose seit 15 Jahren
- TVT vor 4 Jahren
- Hypothyreose seit 5 Jahren
- chronische Bronchitis seit 3 Jahren
- vor 2 Jahren stationär behandelt wegen Kompressionsfraktur in der Wirbelsäule
- Es wurden beim Pt. folgende Operationen durchgeführt:
- Inguinalhernie-OP _Varikose-OP_ Basaliomsexzision in der rechten Backe vor 15 Jahren

6-Medikamentenanamnese:

- Der Pt nehme folgende Medikamente regelmäßig ein :
 - Ass 100mg 1.0.0
 - Omeprazol 40 mg. 1.0.0
 - Metoprolol. 1.0.1
 - Thyroxin. 1.0 0 / Schilddrüsentabletten, deren Namen ihm nicht Erinnerung sein.

7-Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Schenkelhalsfraktur hin.

- Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:
- Prellung
- Beckenfraktur (vorderer Beckenring)
- Hüftkopffraktur

8-Maßnahmen

- Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen.
- Eine Verkürzung des Beins, Fehlstellung, Rötung Druck- und Bewegungsschmerz über der Hüfte
- Sensibilität und Motorik von Bein und Fuß
- Zur weiteren Abklärung sollten die folgende Maßnahmen durchgeführt werden:
- Röntgen des Becken-Hüftgelenks
- Eine Computertomographie, wenn wir beim Röntgen nicht sicher sind. Sonographie, wenn es eine Einblutung in die Gelenkkapsel gibt.
- Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:
- Konservative Behandlung
- Eine konservative Behandlung ist prinzipiell bei stabilen und eingekeilten Frakturen vorteilhaft.
- Bein-Extension
- Operative Behandlung:

Instabile Frakturen

Eine Hüftgelenktotalendoprothese (Hüft-TEP)

Fragen:

- Wann ist der Unfall passiert?
- Wie genau ist es passiert?
- Ist Ihnen schwindelig geworden?
- Können Sie den Schmerz beschreiben?
- Wie stark ist der Schmerz auf einer Skala von 0 bis 10?
- Strahlt der Schmerz in andere Körperregionen aus?
- Können Sie das Bein noch bewegen?
- Können Sie auf das Bein auftreten?
- Spüren Sie alle Zehen? Können Sie sie bewegen?
- Konnten Sie sich vor dem Unfall uneingeschränkt bewegen?
- Haben Sie Taubheitsgefühl oder Kribbeln im Bein oder Fuß?
- Haben Sie im Hüftbereich einen Bluterguss bemerkt?
- Ist Ihr Hüftbereich angeschwollen?
- Verspüren Sie Brustschmerzen? Haben Sie Luftnot?
- Haben Sie schon früher Knochenbrüche gehabt?

Lisele Müller, 90 Jahre, 50kg, 155cm

Sie sei allergisch gegen Penicillin und Dipidolol

Sie sei Ex-Raucherin seit 20 Jahren und früher habe sie 10 bis 20 Zigaretten pro Tag seit geraucht 40 Jahre lang.

Sie trinke ein Glas Sekt jeden Tag seit 10 Jahren und früher ein Glas Wein.

Der Drogenkonsum wurde verneint.

Sie sei verheiratet und habe 3 Töchter.

Die älteste habe Mama-Ca gehabt aber nach der Behandlung mit Therapie sei sie gesund.

Sie sei Rentnerin.

(Frage nach Eltern habe ich nicht gestellt und am Ende hat der Oberarzt gesagt, dass ich sehr gut gemacht

habe. Sie ist selbst 90 Jahre alt hat er gesagt und machte keinen Sinn die Frage über Ihre Eltern stellen).

Sie habe eine Schwester aber sie wusste nicht wie ihr geht und lange Zeit nicht mehr mit ihr gesprochen.

Frau Müller ist 90 Jahre alt und stellt sich bei uns wegen seit Heute gestürzt vor. Sie berichtete, dass sie Heute Abend in der re Seite gestürzt sei und nachdem habe sie gleich Ihre Tochter angerufen. Die Tochter habe RTW angerufen und sie haben ins Krankenhaus gebracht. Zeitlich, örtlich, persönlich und situativ war sie orientiert. Sie habe keine Hämatome in der re Seite bemerkt. Auf Nachfrage wegen blutspuren auf dem Boden habe sie nicht bemerkt.

Frau Müller erwähnt, dass sie starken Schmerzen am den re Hüfte habe und kann nicht der Bein bewegen.

Auf Nachfrage werde die Beschwerden auf der Schmerzskala bei 8 in Belastung und 0 in Ruhe eingestuft.

Darüber hinaus seien der Patientin folgende Begleitsymptome aufgefallen: Appetitlosigkeit und Müdigkeit.

Die **vegetative Anamnese** sei unauffällig.

An **Vorerkrankungen** leide sie an

aHT seit 20 Jahren

pAVK

Hyperthyreose

Chronische Bronchitis seit 40 Jahren Z.n IAM vor 15 Jahren Z.n Hernia Inguinalis vor 30 Jahren Z.n

Unterschenkel Thrombose vor 15 Jahren Z.n Myokarditis vor 25 Jahren Z.n Glaukoma seit mehrere Jahren Z.n Handgelenk Fraktur li vor 15 Jahren

In Bezug auf **Medikation** nehme sie Ramipril 2.5 mg 1-0-1, Esomeprasol 20 mg 1-0-0, ASS 100 mg 1-0-0, L-Thyroxin 75 µg 1-0-0

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine symptomatische Oberschenkelhalsfraktur hin.

Differezialdiagnostisch kommen TIA, Beckenfraktur in Betracht.

Zur weiteren Abklärung empfehle ich die folgenden **Maßnahmen**:

Körperliche Untersuchung

Labordiagnostik

CT- Cranium

EKG

Rö- Oberschenkel

Rö- Becken

Der Prüfer haben mir am Ende gesagt, dass bei mir Mündlich teil besser als schriftliche Teil ist.

Sprungelenkfraktur

1-persönliche Daten: Martina Schröder /Hans Mayer, Alter: 40 Jahre Gewicht: kg Größe: m

2-Pollenallergie (Heuschnupfen)(Husten und Hautausschlag.)

3-Genussmittel/ Noxen

Nikotin: 20 Zigaretten pro Tag, seit 20 Jahren 20 PY,

Alkohol: gelegentlich

Drogen: keine

Sport: regelmäßig wie Tennisspielen und Laufen, Fußball.

4- Sozialanamnese:

Familienstand: Frau Schröder sei ledig und wohne alleine/

Verheirate, lebe mit Ehemann und 3 Kindern

Arbeit: Bankkauffrau ,Sportlehrerin; Lehrerin von Beruf.

5- Familienanamnese: Unauffällig/

-Vater: MI,

-Mutter: gesund/ DM, sei wegen Autounfall gestorben, als sie ein Kind war.

-Der Bruder leide an Hypertonie,

2-aktuelle Beschwerden:

Frau Martina Schröder ist eine 40- jährige Pt., die sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit gestern bestehender, stechender, zunehmender, rechtsseitiger Sprunggelenkschmerzen/Schmerzen in der rechten Wade mit Ausstrahlung in den Unterschenkel vorgestellt hat.

-Die Pt. berichtet, dass die Schmerzen plötzlich beim Fußballspielen/ Tennisspielen/ nach Sturzereignis mit dem rechten Fuß umgeknickt/ während des Laufens im Wald aufgetreten seien und sich im Verlauf der Zeit verschlechtert hätten. Der Pt. sei schwindelig (Vertigo).

Zusätzlich teilt sie mit, dass die Schmerzen 7-8 von 10 auf der Skala seien und bei Bewegung schlimmer würden.Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden, Kopf- und anderen Verletzungen, Erbrechen und Bewusstseinsstörungen wurde verneint.

3-Begleitssymptome

Ferner sind der Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

-Ödeme (Schwellungen)

-Hämatome (Blutergüsse),

-Rötung,

-sowie eine eingeschränkte Bewegung

Die Frage nach Parästhesie (Missempfindungen),Hypostase, Kopf- und anderen Verletzungen, Erbrechen und Bewusstseinsstörungen wurde verneint.

4-Vegetative Anamnese:

-Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf

-schmerzbedingte Insomnie (Schlafstörung),

-gelegentlich Diarrhö (Durchfall) 3-mal im Monat

5-Vorerkrankungen:

- Es seien keine relevanten Vorerkrankungen bekannt/
 - Asthma Bronchiale
 - Faktor-V-Leiden
 - Arterielle Hypertonie (Bluthochdruck)
 - Reizdarmsyndrom seit 3 Jahren
 - Es wurde bei der Pt. eine Meniskus-OP vor 3 Jahren durchgeführt.
- Sie sei gegen die Kinderkrankheiten geimpft.

6-Medikamentenanamnese:

- Die Pt. nehme zurzeit folgende Medikamente regelmäßig ein :
- Loratadin während der Saison
- Aspirin bei Bedarf
- inhaliere Berodual-Spray 3x1 gegen Asthma

7-Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Sprunggelenksfraktur/ Achillessehnenruptur hin.

-Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

- 1-TVT (tiefe Venenthrombose)
- 2-Unterschenkelfraktur
- 3-Achillessehnenruptur
- 5-Bandrupturen,
- 7-pAVK

8-Maßnahmen

-Als erste Maßnahme würde ich die Pt. körperlich untersuchen. Lokalisation des Bruchs

Prüfen der Bandstabilitäten

Prüfen von Gefäß- und Nervenverletzungen

-Zur weiteren Abklärung sollten folgende Maßnahmen durchgeführt werden: -Röntgen: Sprunggelenk und gesamter Unterschenkel -Computertomographie (= CT): bei fraglichen Röntgenbefunden und zur OP-Planung -Kernspintomographie (= MRT): Abklärung von Bandverletzungen; Weichteil- und Knorpelbeurteilung.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:

-Analgetika

Je nach Frakturtyp würde ich entweder eine konservative oder eine operative Therapie empfehlen.

Konservativ:

Geh-Gipsverband für 6 Wochen

Operativ: (mittlere Verweildauer im Krankenhaus: 6,2 Tage)

Schrauben und Metaplaten Gehstützen benutzen (Krücken)

Achillessehnenriss?

- Wenige Zentimeter oberhalb des Fersenbeinansatzes lässt sich eine Lücke in der Sehne tasten.

Hinken –eine stärkere Dorsalflexion ...

Sonografie der Achillessehne -MRT-Röntgenaufnahme: OSG mit Rückfu. in 2 Ebenen

Bettruhe, Analgetika, Gipsverband

- Dabei wird der Fuß über 4-6 Wochen mit einem Gipsverband, einer Schiene oder einem Spezialschuh (Unterschenkel-Fuß-Orthese) in leichter Spitzfußstellung fixiert

Chirurgische Therapie: Bei einer frischen Achillessehnenruptur ist die direkte End-zu-End-Sehnennaht empfehlenswert.

Fragen:

- Wie haben Sie sich verletzt?
- Was ist genau passiert?
- Haben Sie sich den Kopf verletzt? Ist Ihnen eine Rötung, Schwellung oder Schmerz am Kopf aufgefallen?
- Sind Sie gestolpert oder gestürzt? Sind Sie aus großer Höhe gestürzt?
- Ist Ihnen schwindelig oder schwarz vor den Augen geworden?
- Haben Sie den Fuß umgeknickt? Falls ja: Ist der Fuß nach innen oder außen umgeknickt?
- Haben Sie ein Knacken oder Reißen gespürt oder gehört?
- Wo genau verspüren Sie den Schmerz?

- Wie würden Sie den Schmerz beschreiben? Ist er dumpf, ziehend, druckend...
- Stahlt der Schmerzen irgendwohin aus?
- Wie stark ist der Schmerz auf einer Skala von 0 bis 10?
- Ist der Schmerz seit dem Unfall schlimmer geworden?
- Können Sie der Fuß und das Bein noch bewegen?
- Können Sie auf das Bein auftreten?
- Haben Sie an der betroffenen Seite Schwellung, Bluterguss oder Überwärmung bemerkt?
- Haben Sie eine offene Wunde am Sprunggelenk?
- Haben Sie ein Taubheitsgefühl oder Kribbeln im Fuß?
- Spüren Sie alle Zehen? Können Sie alle bewegen?
- Hatten Sie schon früher Knochenerbrüche?

Klaus Schröder, 38J. 1.80 m, 74 Kg

Anamnese: Herr Gerard Schröder ist ein 38-jähriger Patient, der sich heute Morgen bei uns wegen seit gestern bestehender, stechender, zunehmender, rechtsseitiger Sprunggelenkschmerzen vorgestellt hat. Der Patient berichtet, dass er beim Fußballspielen seinen rechten Fuß umgeknickt habe. Die Schmerzen strahlen in die Wade aus und die Intensität liege bei 8/10 auf der Schmerzskala.

Als Begleitsymptome nannte der Patient Ödeme, Hämatome, Erythem sowie eine eingeschränkte Bewegung des Sprunggelenks. Die Fragen nach Parästhesie, Hypästhesie und anderen Verletzungen wurden verneint. Die Vegetative Anamnese ist unauffällig, bis auf schmerzbedingte Insomnie.

Der Rest war genauso wie im Protokoll.

Der Patient war unruhig wegen der Schmerzen und am Ende hat gefragt, welche Maßnahmen ich veranlassen würde.

Also die AA-Gespräch war sehr oberflächlich. Ich wollte die Weber Klassifikation erklären und die haben mir gesagt, dass es nicht nötig war, dass es nur um die Sprache geht. Bei der Therapie muss man achten, dass der Patient an einer Gerinnungsstörung leide und heparinisiert werden soll.

Handgelenksfraktur

1-persönliche Daten: Herr Bender/Walter 37-jährig, 75kg schwer, 1,70 m groß

2-Allergie: keine Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt

3-Genussmittel/ Noxen

Nikotin: Er rauche 30 Zigaretten pro Tag seit 20 Jahren.

Alkohol: Er trinke eine Flasche /einen Liter Bier pro Tag.

Keine Drogen.

Sport: Keiner

4-Sozialanamnese: Familienstand: verheiratet. Er habe keine Kinder, lebe mit Ehefrau zusammen.

Arbeit: Heizungsbauer

5- Familienanamnese:

-Vater: arterielle Hypertonie

-Mutter: Diabetes Mellitus

2-aktuelle Beschwerden:

-Herr Bender ist ein 37-jähriger Pt., der sich heute bei uns in der Notfallaufnahme wegen bestehender, stechender, zunehmender, linksseitiger Handgelenksschmerzen mit Ausstrahlung in den..... vorgestellt hat.

-Der Pt. sei heute Morgen in der Badewanne auf die linke Hand ausgerutscht, danach habe er diese Schmerzen gehabt.

-Der Pt. berichtet, dass die Schmerzen plötzlich aufgetreten seien und sich im Verlauf der Zeit verschlechtert hätten.

-Zusätzlich teilt er mit, dass die Schmerzen 7-8 von 10 auf der Skala seien.

3-Begleitsymptome

Ferner sind dem Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

- Ödeme (Schwellung)
 - Verfärbung (Rötung),
 - sowie eine eingeschränkte Beweglichkeit wegen sehr starker Schmerzen.
- Die Fragen nach Parästhesien (Missempfindungen), Hypästhesie wurden verneint.

4-Vegetative Anamnese:

- Die vegetative Anamnese sei unauffällig.

5-Vorerkrankungen:

Es seien keine relevanten Vorerkrankungen bekannt/ Er wurde niemals operiert/Es wurde beim Pt. mit 17 Jahren eine Appendektomie und im Alter von 23 eine Leistenhernien- Op durchgeführt.

6-Medikamentenanamnese:

- Der Pt. nehme zurzeit keine Medikamente ein.

7-Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Handgelenksfraktur/ Distale Radiusfraktur hin.

-Als Differentialdiagnosen kommen folgende im Betracht:

- Prellung
- Bandruptur

8-Maßnahmen

-Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen.

Druckschmerz - Durchblutung, Motorik und Sensibilität

-Zur weiteren Abklärung sollten folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

-Röntgenaufnahmen des Handgelenks in zwei Ebenen.

-CT

-MRT

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:

-Konservative Behandlung

-Stabile extraartikuläre Frakturen sowie gering dislozierte intraartikuläre Frakturen

-Nach Reposition der Fraktur erfolgt eine Ruhigstellung in einer Gipsschiene über vier bis sechs Wochen.

-Operative Behandlung bei Flexionsfrakturen, offenen Frakturen, bei instabilen Frakturen, irreponiblen Frakturen, Trümmerfrakturen, dislozierten intraartikulären Frakturen und bei sekundär dislozierten Frakturen.

-Schraubenosteosynthese, Plattenosteosynthese, oder ggf. primär auch durch einen Fixateur externe versorgt.

Sturz auf die dorsalflektierte Hand (typische Abstützbewegung) →

Extensionsfraktur („Colles-Fraktur“) Sturz auf die palmarflektierte Hand → Flexionsfraktur („Smith-Fraktur“)

Fragen:

- Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10?
- Können Sie die Schmerzen aushalten oder brauchen Sie Schmerzmittel?
- Hatten Sie schon etwas dagegen eingenommen? Wenn ja: Wann, welches Medikament, welche Dosierung und wie viel mal haben Sie eingenommen?
- Ist bei Ihnen Medikamentenallergie bekannt?
- Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen?
- Können Sie den Sturz beschreiben?
- Ist Ihnen schwindelig oder schwarz vor den Augen geworden?
- Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben?
- Haben Sie Schwellung oder Bluterguss an der betroffenen Region bemerkt?
- Können Sie Ihre Hand oder Fingern bewegen?
- Verspüren Sie Taubheitsgefühl oder Kribbeln an der betroffenen Seite?
- Haben Sie schon Kälteanwendung gemacht?

Abszess am Gesäß

1-persönliche Daten: Corinna Bernhard, 31 Jahre alt, 1,72 groß, 67kg schwer

2-Allergie: Sie reagiere allergisch auf Penicillin (Hautausschlag)

3-Genussmittel/ Noxen

Nikotin: Nichtraucherin

Alkohol: ein Glas Wein/eine Flasche (0.5 l) Bier abends.

Keine Drogen.

Sport: Spazierengehen, Fitnessstudio täglich

4- Sozialanamnese: Familienstand: verheiratet. Sie wohne mit ihre Mann und Sohn zusammen.

Arbeit: Elektrikerin bei einer großen Firma/selbständige Elektrikerin

5- Familienanamnese:

-Vater: gesund/ DM seit 10 Jahren (Insulin-Pflicht),

-Mutter: Niereninsuffizienz, die mit Dialyse behandelt werde.

-Der Bruder sei gesund.

-Der Sohn sei gesund.

-----2-aktuelle Beschwerden

Frau Bernhard ist eine 31-jährige Pt., die sich heute Morgen bei uns wegen seit 3 Tagen bestehender, zunehmender, drückender, stechender Schmerzen an der rechten Hüfte/ am rechten Gesäß ohne Ausstrahlung vorgestellt hat.

-Die Pt. berichtet, dass die Schmerzen langsam nach einer Spritze beim Hausarzt (Mischung von Voltaren und Kortison) vor 8 Tagen wegen Rückenschmerzen aufgetreten seien und sich im Verlauf der Zeit verschlechtert hätten.

-Zusätzlich teilt sie mit, dass die Schmerzen 5-6 von 10 auf der Skala seien und beim Sitzen schlimmer würden, deshalb könne sie nicht sitzen. Sie habe gegen die Schmerzen Paracetamol 500 mg eingenommen. Das Fieber sei gesunken, aber die Schmerzen seien immer noch da. Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint.

3-Begleitsymptome

Ferner sind der Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

- Rötung (rubor)

- Schwellung (tumor)

- Schwitzen

- Fieber 39 Grad gestern Abend nur einmal

- Schüttelfrost

4-Vegetative Anamnese:

-Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf Schlafstörungen wegen der Schmerzen

5-Vorerkrankungen:

-Kurzzeitgedächtnisstörung seit 2 Jahren (Die Diagnose wurde noch nicht gestellt)

-Arterielle Hypertonie seit 8 Monaten

-D.M Typ 1 seit 10 Jahren,

-chronische Rückenschmerzen

-Bronchitis als Kind - es wurde bei der Patientin eine Tonsillektomie vor 15 Jahren, eine Sprunggelenksfraktur-OP vor 10 Jahren (nach einem Jahr wurden die Schrauben entfernt), eine Cholezystektomie vor 20 Jahren, eine Appendektomie mit 10 Jahren durchgeführt.

Impfstatus: vollständig, Reise: keine

6-Medikamentenanamnese:

-Die Pt. nehme die folgenden Medikamente regelmäßig ein:

-Candesartan/ sartan 8 mg 1-0-0

-Medikament gegen Hypertonie, dessen Name die Pt. nicht weiß

-Metformin 850 mg 1-0-0 /Insulin

- Divon 100 mg bei Bedarf.
- Voltaren B.b

7-Verdachtsdiagnose:

- Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf einen Abszess am Gesäß hin.
- Als Differentialdiagnosen kommen folgende im Betracht:
- Hämatom
- Trauma -eine Prellung
- Dekubitalgeschwür
- Diskusprolaps

8-Maßnahmen

- Als erste Maßnahme würde ich die Pt. körperlich untersuchen.
- Fuß (mit Inspektion, Auskultation, Perkussion und Palpation)
- Zur weiteren Abklärung sollten folgende Maßnahmen durchgeführt werden:Labor:
- Entzündungsparameter BSG, CRP und Leukozytose
- Sonografie: um Flüssigkeitsansammlung in Abszesshöhle zu sehen
- Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:
- Abszess-Inzision und Drainage
- Cephalosporin

Fragen:

- Sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten oder haben sie sich langsam entwickelt?
- Seit wann haben Sie die Beschwerden?
- Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, wobei 0 kein Schmerz und 10 der stärkste vorstellbare Schmerz ist?
- Können Sie die Schmerzen anhalten oder brauchen Sie dringend einen Schmerzmittel?
- Ist bei Ihnen Medikamentenallergie bekannt?
- Haben Sie sich an der Stelle verletzt?
- Haben Sie in letzter Zeit eine Spritze/Injektion am Gesäß bekommen? Welches Medikament wurde Ihnen gespritzt?
- Wie würden Sie Ihre Schmerzen beschreiben? Drückend, stechend, ziehend, dumpf, pulsierend ...
- Strahlen die Schmerzen in anderen Körperteilen aus?
- Ist Ihnen Hautveränderungen am Gesäß/am betroffenen Region aufgefallen? z.B. sieht die Stelle gerötet oder eitrig aus?
- Ist die betroffenen Stelle überwärmt und geschwollen?
- Haben sie Fieber oder Schüttelfrost?

AAG: Kurz Patientenvorstellung.

Was ist Verdachtsdiagnose? Welche DD gibt es hier?

Weiteres Vorgehen bezüglich Diagnostik und Therapie?

-Muss der Patient im Krankenhaus bleiben? Ja

-Der patient fragt, so das ist der Schuld des Arztes? Reaktion?

Wir können das nicht genau sagen, aber ihre Beschwerde konnte viele Ursachen haben, er ist Diabetiker.

-Der Facharzt, wenn du diesen Patienten behandeln würdest, würdest du ihm Spritze geben? Wir geben ihm keine Spritze, aber wir können anderes Schmerzmittel verschreiben z.B. Ibuprofen 3 mal täglich, denn er nimmt schon Paracetamol ein, aber keine Besserung damit.

-Bei Diagnostik hier ist Sonar wichtig, sie wollen das hören.

Er hat allergie gegen Penicillin, deswegen bei Antibiotika (cetrixone)

Herr Bernhard Lauber, 31 J, Gewicht 89kg, Größe 182cm

Allergie: Penicillin Allergie (Hautausschlag)

Nichtraucher, ein Glass Bier abends, Drogenkonsum wurde verneint.

Elektor von Beruf, verheiratet und habe eine Tochter.

Vater und Bruder sind gesund, Mutter leide an DM seit über 30 J.

Herr Lauber ist 31 Jahre alt. Er kam zu uns wegen seit zwei Tagen bestehenden, drückenden Schmerzen am rechten Gesäß ohne Ausstrahlung. Der Patient berichtete, dass die Schmerzen allmählich nach einer Injektion (Voltaren) aufgetreten seien und sich im weiteren Verlauf verschlimmert hätten. Die Schmerzintensität bewertete der Pt. mit zwischen 4 und 5 von 10 nach der Schmerzskala. Zusätzlich teilt er mit, dass er Erythem, Ödeme, Schüttelfrost, Nachtschweiß und Körpertemperatur 39 °C habe.

Die Vegetative Anamnese ist unauffällig.

Das Vorliegen von Insomnie, Inappetenz und Gewichtsverlust wurde verneint.

Vorerkrankungen: Arterielle Hypertonie und Diabetes Mellitus seit 2 J

Medikamente: Candesartan 8mg 1-0-0, Metformin 500 mg 1-0-1

Voroperationen: Z.n Sprunggelenkfraktur vor 7 J

Verdachtsdiagnose: Auf der Basis meiner erhobenen Befunde gehe ich von einem Verdacht auf Abszess am Gesäß aus.

Aber als Differenzialdiagnose denke ich auch an einen Diskusprolaps und eine Diskushernie.

Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich den Patienten körperlich untersuchen. Das umfasst Inspektion, Palpation, Perkussion und Auskultation. Ich konzentriere mich auf das rechte Gesäß.

Danach werde ich Laboruntersuchungen durchführen: BB, CRP, BSG, sowie eine Sonographie als bildgebende Untersuchung.

Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, plane ich, den Patienten zunächst konservativ zu behandeln, und bei Bedarf eine Inzision und Drainage durchzuführen.

Zudem werde ich eine Antibiotikatherapie (Cephalosporine) und eine Analgesie zur Schmerzlinderung einleiten.

Patient: was habe ich Herr Dr? Soll ich hier bleiben?

Arzt-Arzt: Warum ist der Patient hier? Welche Beschwerden hat er?

Verdachtsdiagnose? Welche Untersuchungen braucht der Patient?

Und Therapie?

Bernhard Lauber, 31 JA

Beschwerde: Roter, schmerzhafter Fleck seit 2 Tagen. Fieber bis 39 Grad. Er leidet schon längst an Rückenschmerzen und er nimmt normalerweise orale Analgetika ein, aber vor 3-4 Tagen hat er ein Voltaren Analgetikumspritz am rechten Gesäß bekommen. Bis auf Fieber war vegetative Anamnese unauffällig.

VE: A. Hypertonie und DM typ 2

Medikamente: Metformin und Candesartan

Allergie gegen Penicillin.

Noxen: Trinkt ein Flasche Bier täglich.

Familie: Mutter Typ 1 DM.

Sozial: Elektriker, verheiratet, habe eine Tochter.

AA Gespräch: Diagnose? DD? Welche Untersuchung würden Sie durchführen? Therapie? Was kann am schlimmsten Fall vorkommen? Was für eine Rolle spielt die Diabetes in diesem Fall? Was würden Sie ihm empfehlen?

Lippenkarzinom

1-persönliche Daten:

Name: Marien Leber

Alter: 62 J

Gewicht: 98 kg

Große: 1,77 m

2- Allergie - Keine

3- Genussmittel/ Noxen

Nikotin: 1 Packung/Tag seit 10 Jahren (10 PY)

Alkohol: einen kleinen Glas Schnaps täglich

-Drogen: keine

- Sport: regelmäßig Spazierengehen.

4- Sozialanamnese:

Familienstand: ledig/ keine Kinder/ wohne alleine

Arbeit: Frührentner / früher Büroarbeiter

5- Familienanamnese:

-Vater: Myokardinfarkt (er sei daran vor 2 Jahren gestorben)

-Mutter: gesund

-Der Bruder: sei an Bronchialkarzinom vor 2 Jahren gestorben.

1-aktuelle Beschwerden:

Herr Leber ist ein 62-jähriger Patient, der sich heute Morgen bei uns wegen eines seit zwei Monaten aufgetreten, bestehenden, zunehmenden Mundgeschwürs in der unteren Lippe mit Jucken und Blutung vorgestellt hat. Der Patient berichtete, dass die Beschwerde schmerzlos sei, aber er habe unangenehmes Gefühl nach dem Zitronen Verzehr. Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde vom Patienten verneint.

2-Begleitssymptomen

Ferner seien dem Patienten die folgende Begleitssymptome aufgefallen:

-Fieber und Schweißausbrüche

-Des weiteren klagt der Pt über Gewichtsverlust ca 12 kg innerhalb von 10 Monaten trotz der guten Appetit.

Die Frage nach Defäkation oder Miktionsstörung wurden verneint.

3- Vegetative Anamnese:

-Die Vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf :

-Insomnie

-Husten mit gelblichem schleimigem Sputum seit zwei Jahren

4- Vorerkrankungen:

- An Vorerkrankungen leide er an

- DM Type 2 seit 20 Jahren

- Arterielle Hypertonie seit 10 Jahren

- Myokardinfarkt zweimal (im 2004 und 2015), die mit Stentseinsetzen behandelt wurden.

Der pt habe einmal im 2001 an TVT und Lungenembolie als Komplikation gelitten.

Der Impfstatus sei unbekannt .

Die Reiseanamnese sei unauffällig

5-Medikamente Anamnese:

Im Bezug auf Medikamente nehme Herr Leber die folgende Medikamente ein :

1-Metformin 1000 mg (1-0-0).

2- Ramipril (1-0-1).

3-Insulin spritzen 6 EI (1-0-0).

4-Pflanzliche Medikament wegen der Schlafstörungen

- Er habe wegen der aktuellen Beschwerde eine Cortison Creme benutzt aber sie habe ihm nicht geholfen.

6-Verdachtsdiagnose:

- Die anamnestische Angaben deuten am ehesten auf **Lippenkarzinom** hin. Als Differentialdiagnosen kommen die folgende im Betracht:

-Herpes

-Pilze infektion

-Hautmetastasen

-Verletzungen

7-Maßnahmen

- Als erste Maßnahme würde ich den Pt körperliche untersuchen.

-Zur weiteren Abklärung sollten die folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

1-Laboruntersuchung (BB-RCP-PSG-HbA1C)

2-Biopsie entnehmen

3-CT (Abdomen –Thorax) zum Ausschluss einer Metastasen.

4- Skelettszintigraphie

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor:

Die Therapie richtet sich nach Größe und Ausdehnung der Tumoren und ggf. Bereits vorhandenen **Metastasen**.

1- Bei kleineren Tumoren kann die vollständige **Exzision** mit ausreichendem **Sicherheitsabstand** zur Heilung führen.

2-In fortgeschrittenen Stadien werden zusätzlich zur Exzision Chemotherapie und Bestrahlung eingesetzt.

Non-Hodgkin Lymphom

1-persönliche Daten: Name: Herr Fred Lange- Alter: 56 Jahre Gewicht: 67 kg Größe: 1,70m

2-Allergie: keine.

3-Genussmittel/ Noxen

Nikotin: Der Patient raucht eine Packung pro Tag seit 30 Jahren.

Alkohol: Täglich trinke er 2 Gläser Wein.

-Drogen. keine/Er hat einmal Alhachesh probiert.

-Sport: keiner

4- Sozialanamnese:

Familienstand: geschieden, er lebe allein.

Arbeit: Lehrer

5- Familienanamnese:

-Vater: pAVK

-Mutter: DM Typ1

2-aktuelle Beschwerden:

Herr Lange ist ein 56-jähriger Patient, der sich heute Morgen bei uns wegen einer seit 2 Wochen bestehenden, linksseitigen, Leistenschwellung (3 – 4 cm) vorgestellt hat.

-Der Pt. berichtet, dass er die Schwellung zufällig beim Duschen bemerkt habe. Zudem habe er darauf gedrückt, aber sie bleibe da .Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint/bejaht.

3-Begleitsymptomen

Ferner sind dem Pt. folgende Begleitsymptome aufgefallen:

-leichte Schmerzen ohne Ausstrahlung

-Fieber (39 Grad Celsius),

-Nachtschweiß,

-Des weiteren klagt der Pt. über Gewichtsverlust von ca. 4 kg innerhalb 2-3 Wochen/ in den letzten 3 Wochen.

Die Fragen nach Erbrechen, Übelkeit, Überwärmung und Rötung wurden verneint.

4-Vegetative Anamnese:

-Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf

Appetitlosigkeit,

Schlafstörungen,

Husten seit 5 Jahren mit Auswurf (normale Farbe).

5-Vorerkrankungen:

-Es seien keine relevanten Vorerkrankungen bekannt.

Es wurde beim Patienten eine Magenentfernung vor 2 Jahren wegen einer Perforation (Ulcus ventriculi) durchgeführt.

Der Impfstatus sei unbekannt.

6-Medikamentenanamnese:

-Er nehme ASS/ Ibuprofen 600 mg bei Bedarf ein.

7-Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ein Non-Hodgkin-Lymphom hin.

-Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

-Abszess

-Linguale Hernie (Leistenhernie)

8-Maßnahmen

-Als erste Maßnahme würde ich den Pt. körperlich untersuchen.

-Zur weiteren Abklärung sollten folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

1- K.U 2- Labor - BB

-Entzündungszeichen

-HB Anämie (Serumeisen erniedrigt, Ferritin erhöht)

-Thrombopenie

3- Sonographie

4- Röntgen-Thorax

5- CT (Hals, Thorax, Abdomen)

6-Lymphknotenbiopsie

7-Knochenmarksbiopsie

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:

-Polychemotherapie,

-Radiotherapie,

-Stammzelltransplantation

Fragen:

- Ist die Schwellung schmerzhaft?
- Haben Sie nur eine Schwellung bemerkt oder mehrere?
- Haben Sie in andere Körperteile auch ähnliche Schwellungen/Knoten bemerkt? Am Hals, Achselhöhle, Leiste...?
- Hatten Sie schon mal ähnliche Beschwerden?
- Leiden Sie unter Fieber?
- Wie hoch war Ihr Fieber? Wie haben sie es gemessen?
- Leiden Sie unter Nachtschweiße?
- Haben Sie in der letzter Zeit ungewollt Gewicht verloren? Falls ja: Wie viele Kilos und in welchem Zeitraum haben Sie abgenommen?
- Fühlen Sie sich häufig schwach oder kraftlos?
- Haben Sie blasse oder bräunliche Hautfarbe bemerkt?
- Haben Sie das Gefühl, nicht genug Luft zu bekommen?
- Verspüren Sie Herzrasen? In Ruhe oder bei Belastung?
- Ist oder war Ihnen schwindelig?
- Bekommen Sie öfters spontan blaue Flecken oder Einblutungen?
- Blutet Ihr Nasen öfters?
- Blutet Ihr Zahnfleisch öfter als sonst?
- Verspüren Sie Oberbauchschmerzen?
- Fühlen Sie Völlegefühl? Also denken Sie, dass Sie schneller satt werden als sonst?
- Haben Sie bei der Arbeit Kontakt zu toxischen Substanzen, wie z.B. Benzol?

Definition

Bei den Non-Hodgkin-Lymphomen handelt es sich um eine sehr heterogene Gruppe maligner Erkrankungen, die von den Zellen des lymphatischen Systems (B- und T-Zellen) ausgeht.

Ursachen

✓ Infektionen

- EBV → HIV-assoziiertes und endemisches Burkitt-Lymphom
- *Helicobacter pylori* → MALT-Lymphom
- HTL-Viren → Endemisches (Japan, Karibik) adultes T-Zell

Lymphom (=ATLL)

✓ Zellschädigung

- Toxische Substanzen: Aromatische Kohlenwasserstoffe (z.B. Benzol) Immunsuppressive und zytostatische Therapie in der Anamnese
- Radiatio (Strahlentherapie)

Klinik

✓ B-Symptomatik (Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsabnahme)

✓ Lymphknoten: persistierende oder in der Größe zunehmende, schmerzlose

Lymphknoten

✓ Splenomegalie mit linksseitigen Oberbauchschmerzen

✓ Verdrängung des Knochenmarks: Anämie (Blässe, Müdigkeit, Schwäche), Blutungen, Infekte

✓ Thrombozytopenie mit petechialer Blutungsneigung

✓ Leukopenie mit Infektneigung

Diagnostik

✓ Anamnese und körperliche Untersuchung: B-Symptomatik?

Vergrößerte Lymphknoten?

✓ Histologie

- Lymphknotenexstirpation
- Biopsien aus anderen verdächtigen Geweben, z.B. Magen, Haut, etc.
- Knochenmarkbiopsie (Beckenkamm): Histologie und Zytologie

✓ Blutuntersuchung

- Blutbild
- Entzündungszeichen
- Immunhistochemie

✓ Bildgebung

- Röntgen-Thorax, CT
- Abdomensonographie
- Ggf. PET-CT

Therapeutische Maßnahmen

Die Auswahl der Chemotherapeutika hängt unter anderem vom Lymphom-Typ ab und kann deswegen sehr unterschiedlich sein. Allgemein gilt, dass der Malignitätsgrad entscheidend ist.

✓ Radiation (Strahlentherapie)

✓ Polychemotherapie

✓ Palliativ

Differentialdiagnostik

Lymphadenopathien anderer Genese, andere maligne Lymphome, Sarkoidose, Bindegewebserkrankungen

Lyme-Borreliose

1-Persönliche Daten: Herr Maier Georg, 34 Jahre, 78 kg, 1,99m

2-Allergie: keine

3- Genussmittel/ Noxen

-Nikotin: Raucher 10py

-Alkohol: trinke gelegentlich Alkohol (ein Glas Wein).

-Keine Drogen.-Sport: keiner.

4-Sozialanamnese: Familienstand: ledig, Arbeit: Paketbote

5- Familienanamnese:

-Die Eltern seien gesund.

-Er habe eine Schwester, und sie leide am Down-Syndrom.

2-Aktuelle Beschwerden:

Herr Maier ist ein 34-jähriger Pt, der sich heute Morgen bei uns wegen eines seit 4 Tagen bestehenden, zunehmenden, einzelnen, flachen Flecks am linken Unterschenkel vorgestellt

hat. Der Pt. berichtete, dass er diesen Fleck nach einer Wanderung in den Bergen vor 2 Wochen bemerkt habe, der Fleck sei dunkelrot am Rand und hell in der Mitte wie ein heller roter Ring mit einem Durchmesser von ca. 4-5 cm.

Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint/bejaht.

Die Fragen nach Jucken, Schmerzen, Schwellung, Blutung oder Schuppen einem Zeckenbiss oder einem Mückenstich an der krankhaften Hautstelle wurden von ihm verneint.

3-Begleitsymptome

- Fieber

- Kopfschmerzen

- Muskel-, Gelenkschmerzen.

4-Vegetative Anamnese:

-Die vegetative Anamnese sei unauffällig.

5-Vorerkrankungen:

- Diabetes Mellitus Typ 1

- Migräne

6-Medikamentenanamnese:

-Der Pt. nehme zurzeit

-Insulin regelmäßig und Aspirin bei Bedarf ein.

7-Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Lyme-Borreliose (Erreger: *Borrelia burgdorferi*->wird durch den Stich von *Ixodes*-Zecken übertragen) hin.

-Als Differentialdiagnosen kommen folgende in Betracht:

1_Erysipel 2_Urtikaria

-virale Infektion,

-Basalzellkarzinom

Zur Bestätigung der Verdachtsdiagnose werde ich die folgenden Maßnahmen ergreifen:

1_körperliche Untersuchung

2_Blutabnahme (BSG – CRP Antikörper gegen Borreliose)

3_ein dermatologisches Konsil veranlassen.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie vor:

-Die frühzeitige Entfernung (innerhalb von 24 Stunden) der Zecken schützt in der Regel vor einer Infektion

-Bei Verdacht auf eine Borrelieninfektion ist die Gabe von Antibiotika notwendig, um die Erreger rechtzeitig zu eliminieren.

Doxycyclin (z.B. Vibramycin® 2 x 100 mg) über 14 Tage.

oder Amoxicillin (3 x 1000 mg) über 14 Tage.

oder hochdosiert Penicillin G (3 x 5 Mega/d) 14 Tage.

oder Ceftriaxon (z.B. Rocephin® 1 x 2g/d) über 14 Tag

Fragen:

- Haben Sie einen Zeckenbiss bemerkt? Wenn ja: Wann und wo? Haben Sie die Zecke selbst entfernt?
- Strahlen die Beschwerden in anderen körperliche Region aus?
- Wann ist die Rötung erstmals aufgetreten? Wann haben Sie das zum ersten Mal bemerkt?
- Wie sieht die Fleck aus? Welche Farbe hat der Fleck? Ist der Kreis scharf begrenzt?
- Haben Sie an der betroffenen Stelle Juckreiz, Brennung, Überwärmung, Schwellung oder Schmerzen empfunden?
- Verspüren Sie Beschwerden wie Taubheitsgefühl und Kribbeln?
- Haben Sie Schwierigkeiten beim Gehen?
- Hat sich Ihr Gang verändert? Hinken Sie?
- Haben Sie an andere Körperregionen andere Flecken bemerkt?
- Hat sich die Rötung ausgebreitet?
- Leiden Sie unter Fieber oder Schüttelfrost?
- Verspüren Sie Muskel- oder Gelenkschmerzen?
- Sind Ihre Gelenke geschwollen? Wenn ja: Welche Gelenke sind betroffen?
- Haben Sie Veränderungen in Ihrem allgemeinen Gesundheitszustand bemerkt? Wie z.B. anhaltende Müdigkeit, Schwäche oder Appetitlosigkeit?
- Sind Ihnen vergrößerte Lymphknoten aufgefallen?
- Leiden Sie unter Herzrasen oder -klopfen?
- Haben Sie bei Bekannten oder Arbeitskollegen ähnliche Symptome beobachtet?

Otitis Media

1-persönliche Daten: Lukas Maier.

2- Allergie – keine

2-Familienanamnese:

-Vater:

-Mutter: DM

2-aktuelle Beschwerden:

Lukas ist ein ... jähriger patient, der sich heute morgen bei uns in der Notfallaufnahme von seiner Mutter/seinem Vater wegen seit zwei tagen aufgetretenden bestehenden Fieber (40 c) mit zittern vorgestellt hat.

-Die Mutter des Kindes berichtete, dass ihr Sohn zu viel weint und seine Ohr vielmals gezogen habe. Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde von der Mutter (verneint/bejaht).

3-Begleitssymptomen

Ferner sind der Mutter die folgende Begleitssymptome aufgefallen.

- Inappetenz/Appetitlosigkeit
- Somnolenz/schläfrig und benommen
- Trocken husten

Die Frage nach Unfall, Hautausschlag, Hautfarbveränderung, Krampfanfall, Ikterus wurden von der Mutter verneint.

4. Vegetative Anamnese:

-Die Vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf Insomnie, Durchschlafstörungen in den letzten zwei Tagen wegen des Fiebers.

Medikamente und Allergien Anamnese:

-Der Pt nehme zurzeit keine Medikamente ein.

Die Mutter berichtete, dass sie ihr kind Zäpfchen gegen Fieber gegeben habe aber die Zäpfchen hätten ihm nur ein bischen geholfen.

Vorerkrankungen:

Der pt habe einen physiologischen ikterus nach geburt gehabt deshalb sei er eine woche im Kh gewesen.

Die Gründimfungen seien komplett.

7. Verdachtsdiagnose:

- Die anamnestische Angaben deuten am Ehesten auf Otitis Media hin. Als Differentialdiagnosen kommen die folgende im Betracht:

- Pneumonie
- Meningitis
- Harnwegsinfektion

11 –Maßnahmen

- Als erste Maßnahme würde ich den Pt körperlich Untersuchen.

LK vergrosung –exiskose –otoskopie

-Zur weiteren Abklärung sollten die folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

Blutabnahme von femoralis vene

(BB-CRP-BSG-BLUTZUCKER-ELEKETROLYTEN

Urin untersung, Lumbualpunktion oder Fontanelle

Sollte sich die Verdachtdiagnose bestätigen , schlage ich die folgende Therapie vor:

1- Stationäre Aufnahme.

-Zur Fiebersenkung kann ein Antipyretikum (z.B. Paracetamol), analgetika z.B. Diclofenac, Ibuprofen

Antibiotische Therapie

Beta-Laktam-Antibiotikum

- o Penicillin V - Amoxicillin (evtl. in Kombination mit Clavulansäure)
- o Cefuroxim
- o Makrolid Erythromycin- Clarithromycin- Azithromycin

Diabetes Mellitus Typ 1

Name: Josef Meyer / Franz Meyer / Marie Braun

Alter: 24 Jahre **Gewicht:** 75 kg **Größe:** 1,67 m groß

Allergien/Unverträglichkeiten:

Er habe eine Allergie gegen Haselnüsse und Pollen und reagiere mit Rhinokonjunktivitis = verstopfte Nase und tränenden Augen

Genussmittel:

Nikotinkonsum, er rauche 2 Zig./Woche seit – Jahren.

Alkoholkonsum, er trinke 1 Glas Weißwein pro Woche.

Drogenkonsum wurden verneint.

Sozialanamnese: Er sei Student

Familienanamnese:

- Der Vater sei an einem Herzinfarkt gestorben.

- Die Mutter leide an diabetes Mellitus Typ 2.

- Die Schwester leide an Hyperthyreose.

Aktuelle Beschwerden, vegetative Anamnese. Vorerkrankungen und Voroperation

Franz Mezer ist ein 24-jähriger Patient. Er stellte sich bei uns wegen seit 4 Wochen / 3 Monaten bestehender Müdigkeit und Konzentrationsstörung vor. Als Begleitsymptome nannte er, Polyurie, Polydipsie, trockene Haut und generalisierter Pruritus. In der vegetativen Anamnese erwähnte er Polyphagie, Gewichtsverlust von ca. 7 Kg in den letzten 3/ Monaten. Außerdem habe er Insomnie wegen Nykturie.

An Vorerkrankungen sei eine Ellenbogenfraktur vor 3 Jahren **bekannt**, mit conservative Behandlung oder

An Voroperationen sei eine Ellenbogenfraktur OP vor 3 Jahren **bekannt**, diese sei komplikationlos verlaufen.

Der Patient nehme keine Medikamente ein

Impfung und Reise Er sei geimpft. Er sei in letzter Zeit nicht im Ausland gewesen.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf Diabetes mellitus Typ 1

Als Differentialdiagnosen kommen die folgenden in Betracht:

- Anämie
- Hyperthyreose
- Depression

Um die Diagnose zu bestätigen, würde ich den Patienten körperlich untersuchen.

- Messung der Vitalzeichen: Atemfrequenz, Blutdruck, Puls, Körpertemperatur.

Zur weiteren Abklärung sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden:

1.- Laboruntersuchung:

- Hämoglobin-Wert, Thrombozyten, Hämatokrit, Erythrozyten, Leukozyten, CRP, BSG
- Elektrolyte Natrium und Kalium
- gelegentlicher bluckzucker > 200 mg/dl (ocasional)**

- **Nüchternblutzucker** (Nacht 8 h Nahrungskarenz) > 126mg/dl (normal <100 mg/dl)
- **HbA1c (Glykiertes Hämoglobin)** > 6,5 %
- **C-Peptid (Protein)**
- Urinuntersuchung (Glukosurie und Mikroalbuminurie)
- T3, T4, TSH und Schilddrüsenultraschall

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor:

1. Stationärer Behandlung

2. Intensivierte konventionelle Insulintherapie (ICT) heute Standardtherapie!

Langwirksame Basalinsuline: 1 oder 2 am Tag: Insulin glargin +

Kurzwirksameinsuline oder Mahlzeiteninsulin (Bolus): Insulin lispro oder aspart

3. Richtige Ernährung und ausreichende Bewegung verbessern die Blutzuckerwerte

4. regelmäßige Blutzuckermessung

Herr Franz Maier ist 24 Jahre alt, wiegt 65 kg und ist 178 cm groß. Er stellte sich bei uns aufgrund von seit drei Monaten bestehender Müdigkeit vor. Die Beschwerden seien plötzlich aufgetreten und hätten sich im Verlauf verschlimmert.

Begleitsymptome: Polydipsie und Polyurie. Auf meine Fragen hin verneinte der Patient Sehstörungen, Polyphagie, Parästhesien, Kältegefühl, Bradykardie, Dysurie, Hautblässe und Tachykardie.

In der Vorgeschichte erwähnte der Patient eine Insomnie. Er hat keine relevanten Vorerkrankungen und nimmt zurzeit keine Medikamente ein. In der Vergangenheit erlitt er einen Ellenbogenbruch rechts, der konservativ mit einem Gipsverband behandelt wurde. Zudem leidet er an einer Pollenallergie und reagiert darauf mit Halsödeme. Der Patient raucht eine Zigarette pro Woche und trinkt ein Glas Wein pro Woche; Drogenkonsum wurde verneint.

Die Familienanamnese ergab: Der Vater verstarb an einem Myokardinfarkt, die Mutter leidet an Diabetes Typ 2. Er hat zwei Geschwister, die gesund sind.

Sozialanamnese: Er ist ledig, kinderlos und studiert. Er treibt keinen Sport. Der Impfstatus ist vollständig und es gab keine auffälligen Reiseanamnese.

Verdachtsdiagnose: Diabetes Typ 1

Differentialdiagnosen: Hypothyreose, Anämie und Zystitis.

Vorgeschlagene Maßnahmen:

- Körperliche Untersuchung

- Labordiagnostik: Blutbild, CRP, Elektrolyte, Nüchternblutzucker, HbA1c, Urinstatus, TSH, fT3, fT4, Anti-GAD- Antikörper, Anti-IA2, Anti Insulin und C-Peptid

Therapieansatz: Körperliche Aktivität fördern Ernährungsumstellung Langzeit-Insulintherapie

Arzt-Arzt-Gespräch:

Welche Differenzialdiagnose?

Diabetes insipidus?

Wie gehen Sie vor?

Erklären Sie die Erkrankung und die Untersuchung bis hin zur Behandlung für den Patienten.

Patientengespräch:

Patient: „Warum habe ich Diabetes Typ 1?“ Ich habe erklärt, dass die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr produziert und so weiter...

Patient: „Wie viel muss ich spritzen?“ Ich habe gesagt, dass ich es momentan nicht genau sagen kann; es hängt von den Zuckerwerten ab. Er wollte aber wissen, ob es Alternativen wie Insulinpumpen gibt, und ich habe ihm das erklärt.

Patient: „Gibt es andere Alternativen, falls ich kein Insulin mehr spritzen möchte?“ Ich habe gesagt, dass es soweit ich weiß, Operationen gibt, wie z. B. eine Verpflanzung von Insulinzellen, aber ich wusste den genauen Namen der OP nicht. Er sagte dann: „Ja, richtig: Pankreas-Transplantation.“

Herr Franz Meyer ist ein 24-jähriger Patient, der sich wegen Müdigkeit seit 3 Monaten vorgestellt habe. Er sei deswegen beim Hausarzt gewesen, der ihn zu uns überwiesen habe. Zusätzlich leide er an einem Polyurie-Polydipsie-Syndrom sowie an einem Gewichtsverlust von circa 5 kg innerhalb von 3 Monaten. Alle anderen Fragen seien verneint worden.

-VA: unauffällig bis auf Insomnie

-VE: Ellenbogenfraktur, die konservativ mittels Gipsverband immobilisiert worden sei.

-Medikamente: keine

-Allergie: Pollen sowie Haselnüsseallergie (es äußert sich mit tränenden Augen)

Keine Unverträglichkeiten

-Genussmittel:

Tabakkonsum: 1 bis 2 Zigaretten gelegentlich

Alkohol: Weißwein, ein Glas gelegentlich

-Familienanamnese:

Vater: an Myokardinfarkt gestorben

Mutter: DM2

Geschwister: ein Bruder, der gesund sei

Schwester: Ich habe eine Schwester, die behauptet, eine Hypothyreose zu haben, aber sie hat nur Symptome, wenn sie eine Prüfung hat oder etwas zu erledigen hat.

Reaktionen:

Was habe ich?

Mein Hausarzt hat mir gesagt, es könnte Krebs sein. Was meinen Sie, Frau Doktor?

Was werden Sie jetzt machen?

Frau Doktor, ich habe Angst vor Nadeln.

Arzt-Arzt-Gespräch: VD, DD

Warum haben Sie sich für Diabetes Typ 1 entschieden?

Was ist der Unterschied zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2?

Herr Josef Meyer, Alter: 24 Jahre alt, KGr: 167 KGw: 75

LS: Müdigkeit seit 9 Monaten BS: depressive Stimmung, Durchschlafstörungen, Vermehrtes Durstempfinden, Nykturi, Gewichtsabnahme 6-7 Kilo in den letzten 9 Monaten, Pruritus (ganze Körper), Dermatomykose

VE, OPs: einer OPs durch Osteosynthese wegen Ellenbogen Fraktur vor 3 Jahren

Allergie: gegen Hasel Nüsse und polinozis (allergische rhinitis und Tränen Augen)

Medikament: keine R.A. Unauffällig Impfpass sei komplette

Noxen: 10 Zigarillo pro Monat mit 18. Lebensjahr

Ein Flasche Weiß Wein pro Woche

Drogenanamnese: u.a.

Familienanamnese: Mutter—DM Typ 2 und PaVK

Vater: HI als Todesursache mit 65

Einen Bruder: keine relevanten Angaben

Eine Schwester: hyperthyreose

Sozialanamnese: alleinstehend, keine Kinder

BA: Student

VD: Diabetes mellitus Typ 1

DD: Anämie, Depression, Hyperthyreose, Körperliche Untersuchungen Lab: Blutbild} zwecks Anämie auszuschließen, Entzündungsparametern, Glucose } zwecks Bestätigung von DM

HbA1c } zwecks Bestätigung von DM, C - peptid Leber - Nieren werte, Urin Status } zwecks Nachweis von

Keton, Schilddrüse Hormonspiegelung } zwecks hyperthyreose auszuschließen, Apparat: Schilddrüse

Sonographie Therapie : stationäre Aufnahme Insulin Schulung Ernährungsberatung

Patient- Arzt: was habe ich?

Arzt - Arzt: Was ist die VD? Risikofaktoren? Labor Parametern? Warum sind C-Peptid und Urin Status wichtig? Diagnostische Kriterien von Diabetes mellitus? Akute und chronische Komplikationen? Warum ist die Schulung wichtig und nötig?

Aufklärung: Patient hat gefragt: muss ich Insulin spritze benutzen? Meine Mutter nimmt Tablette. Ist es möglich dass ich eine Tablette nehme?

Mögliche Anamnesefragen:

- Haben Sie vermehrten Durst?
- Wie oft und wie viel trinken Sie täglich?
- Müssen Sie häufiger und in großen Mengen Wasserlassen?
- Wie ist die Farbe und der Geruch Ihres Urin?
- Leiden Sie unter nächtliches Wasslassen? Wenn ja: Wie oft müssen Sie auf die Toilette?
- Leiden Sie unter häufige und widerkehrende Harnwegsinfektionen?
- Wie ist Ihre Appetit? Essen Sie mehr als sonst?
- Hat sich Ihr Gewicht in letzten Zeit verändert?
- Haben Sie trotz gutem Appetit ungewollt abgenommen?
- Verspüren Sie Kribbeln, Taubheits oder Schmerzen in de Füßen oder Händen?
- Fühlen sich Ihre Füße kalt oder brennen sie?
- Ist Ihnen Juckreiz oder eine trockene Haut aufgefallen?
- Haben Sie Probleme bei der Wundheilung bemerkt?
- Haben Sie in letzter Zeit eine Verschlechterung des Sehvermögens bemerkt?
- Haben Sie Schwierigkeiten beim Fokussieren?
- Leiden Sie unter Kalteschweis?
- Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Kraft nachgelassen hat?
- Leiden Sie unter Mundgeruch?
- Haben Sie Atemnot? Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie schnell und flach atmen?

Definition

Sie beruht auf einem Mangel an Insulin infolge einer Zerstörung der insulinproduzierenden Betazellen in den Langerhans'schen Inseln des Pankreas durch Autoimmunprozesse.

Symptome

Typische Symptome des Typ-1-Diabetes sind:

- Polyurie (vermehrtes Urinmenge)
- Polydipsie (gesteigertes Durstgefühl)
- Polyphagie (eine abnorm gesteigerte Nahrungsaufnahme)
- Leistungsabfall, Müdigkeit
- Kopfschmerzen
- Nausea, Bauchschmerzen
- Gewichtsverlust
- Pilzinfektionen der Haut
- Sehstörungen

Bei einer drohenden Ketoazidose (hohen Konzentration von Ketonkörpern im Blut) können zusätzlich Bewusstseinstörung, Kussmaul-Atmung (tief und betont Atmung) und Azetongeruch auftreten.

Diagnostik

- Nüchterblutzucker, HbA1c, C-peptid
- Einschätzung der Stoffwechselsituation: pH-Wert, Bicarbonat, Ketonkörper, Serumelektrolyte (Na, K, Cl), Kreatinin, Harnstoff, CRP, Leukozyten
- Glukose im Urin

Therapie

- Ernährungsumstellung
- Diabetschule
- Körperliche Bewegung
- Insulinersatztherapie

Anorexia nervosa

Julia Springer 19.09.2003 168cm/48kg

Die 17-jährige Patientin in untergewichtigem EZ (BMI <17) hat sich heute nur auf den Wunsch von ihrer Mütter wegen Inappetenz und starker Untergewicht vorgestellt. Der Patientin zufolge habe sie keine aktuellen Beschwerden. Die Patientin klagte über Appetitlosigkeit und Nahrungskarenz wegen Magersucht seit 1 Jahr. Zudem erwähnte die Patientin, dass sie Sportsüchtig sei (jeden Tag wache sie um 5 Uhr morgens zu joggen auf, sie wolle einen Marathon im Herbst machen) und sie Kaffeesüchtig sei (mehr als 4-5 Tassen pro Tag). Ferner seien der Patienten die folgenden Begleitsymptome aufgefallen: Völlegefühl nach dem Essen (laut der Patientin nur nach dem Erbrechen werde es besser). Vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf Obstipation seit Jahren (dazu nehme die Patientin Laxaberal und pflanzliches homöopathisches Abführmittel ohne große Wirkung) und Appetitlosigkeit. Keine relevanten Vorerkrankungen seien bekannt.

Als VO wurde bei Patientin Appendektomie mit 12. L.J. durchgeführt.

Keine Allergie sei bekannt.

Nikotin-, Alkohol- und Drogenkonsum wurden verneint. Familienanamnese sei unauffällig.

Sozialanamnese: die Patientin sei Schülerin im Gymnasium, wohne mit ihrer Eltern zusammen und habe einen Bruder (3 Jahren älter als sie).

Die anamnestische Angaben deuten am ehesten auf Anorexia nervosa hin. Als DD kommen folgende Erkrankungen in Betracht:

Depression

Anämie

Hyper/Hypothyreose

Gastritis

Psychische Erkrankungen (frühe Phase von Manifestation)

Um diese Diagnose festzustellen oder auszuschließen, empfehle ich folgende Maßnahmen:

1. KU

2. Labor: BB, CRP, ferritin, Vit B12, TSH, T3, T4

3. Abdomensonografie

4. Psychiatrische Konzil

Falls meine vermutliche Diagnose festgestellt würde, würde ich folgende Therapie vorschlagen:

Psychotherapie

Alternative Therapie (Lichttherapie, Schlafentzugstherapie)

Medikamentöse Therapie (SSRI, Trizyklische Antidepressiva)

Mögliche Anamnesefragen:

- Wie empfinden Sie Ihren Körper? Sind Sie zufrieden damit?
- Machen Sie Sorgen wegen Ihrer Figur? Falls ja: Gibt es Gründe dafür?
- Denken Sie, dass Sie „zu dick“ sind?
- Haben Sie Angst davor, an Gewicht zuzunehmen?
- Wie hat sich Ihr Gewicht in den letzten Zeiten entwickelt?
- Wie oft wiegen Sie sich?
- Wie ernähren Sie sich?
- Vermeiden Sie bestimmte Lebensmittel?
- Wie viele Mahlzeiten essen Sie am Tag?
- Lassen Sie manchmal Mahlzeiten bewusst aus?
- Leiden Sie unter Essattacken?
- Wie lässt sich Ihr Essverhalten beschreiben?
- Gab es einen bestimmten Auslöser, der Ihr Essverhalten beeinflusst?
- Leiden Sie unter Übelkeit oder Erbrechen?
- Erbrechen Sie absichtlich nach dem Essen?
- Wie sah das Erbrochene aus? Haben Sie Blut oder Beimischungen bemerkt?
- Was empfinden Sie nach dem Essen- Schuld, Angst, Zufriedenheit?
- Beeinflusst Ihr Gewicht Ihr Selbstwertgefühl?
- Haben Sie in letzter Zeit etwas Stressiges oder Traumatisches erlebt?
- Wurden Sie schon mal aufgrund Ihres Gewichtes oder Aussehen beleidigt?
- Hat jemand Ihnen empfohlen abzunehmen?
- Ist oder war bei Ihnen eine Essstörung oder andere Verhaltensauffälligkeiten bekannt?

- Fühlen Sie sich unter Druck?
- Fühlen Sie sich sozial isoliert oder ziehen Sie sich aus sozialen Aktivitäten zurück?
- Fühlen Sie sich tagsüber müde, erschöpft oder schwindelig?
- Leiden Sie unter Muskelkrämpfen, Muskelschwäche, Kribbeln oder Taubheitsgefühl?
- Fühlen Sie sich traurig oder niedergeschlagen?
- Haben oder hatten Sie schon mal einen Selbstmordgedanken?
- Können Sie sich gut konzentrieren?
- Haben Sie Schlafstörungen?
- Haben Sie Hautveränderungen bemerkt?
- Ist Ihnen oft kalt als sonst?
- Haben Sie Herzstolpern oder Herzsasen verspürt?
- Leiden Sie unter Schwellungen an den Beinen?
- Leiden Sie unter Haarausfall?
- Haben Sie Probleme mit Wasserlassen oder Stuhlgang?
- Nehmen Sie Abführmittel ein, um Gewicht zu verlieren?
- Treiben Sie regelmäßig Sport?

Definition

Unter einer **Anorexia nervosa** versteht man eine psychogene Essstörung, bei der es zum beabsichtigten Gewichtsverlust durch verminderte Nahrungsaufnahme, induziertes Erbrechen, Laxantien-Abusus und Hyperaktivität kommt.

Symptome

- ständige gedankliche Beschäftigung mit dem Thema Nahrung und Gewicht
- fehlende Krankheitseinsicht
- anhaltendes gewichtsreduzierendes Verhalten mit konsekutiv starkem Untergewicht
- selbstinduziertes Erbrechen
- Abusus von Pharmaka
- exzessive sportliche Aktivität wie Jogging und Fitness
 - Allgemeinsymptome
 - Kachexie
 - Ödembildung durch Eiweißmangel bzw. Hypalbuminämie
 - Hypothermie
 - Trommelschlägelfinger und Uhrglasnägel
 - Hormonsystem
 - tertiärer Hypogonadismus mit Pubertas tarda, primärer oder sekundärer Amenorrhoe, Potenz-/Libidostörungen, kindlichen Geschlechtsmerkmalen, fehlendem Wachstumsschub
 - Hypothyreose durch T4-Konversionsstörung (Low-T3-Syndrom)
 - Hypercortisolismus
 - STH-Erhöhung (somatotrophin)
 - Herz-Kreislauf-System
 - orthostatische Dysregulation
 - Bradykardie
 - Hypotonie
 - Haut
 - Haarausfall
 - Wiederauftreten der Lanugobehaarung (Hypertrichosis lanuginosa acquisita)
 - Cutis marmorata (fleckig, marmoriert aussehende Haut)
 - Akrozyanose
 - Bewegungsapparat
 - Osteoporose
 - Muskelschwäche
 - depressive Episoden

- Angststörungen, insb. soziale Phobie
- Persönlichkeitsstörungen (v.a. anankastische, vermeidende, dependente PS)
- Zwangsstörung
- Substanzmissbrauch (auch als Purgings)
- Suizidrisiko.

Diagnostik

-stark erniedrigtes Körpergewicht oder rapider Gewichtsverlust >20% in 6 Monaten

-BMI-Bewertung:

<18,5: anorektisches Gewicht

<16: stationäre Aufnahme empfehlenswert

<14: kritisch niedrig; zunehmend organische Komplikationen

<12: Lebensgefahr

<10: i.d.R. nicht mit dem Leben vereinbar

-Labordiagnostik:

- Endokrinologie
 - Verminderung von LH, FSH, Östrogen/Gestagenen bzw. Androgenen sowie von T3
 - Erhöhung von STH, Cortisol
- Amylaseerhöhung bei Sialadenose
- Anämie, Leukopenie, Thrombopenie
- Hypoproteinämie
- Elektrolytstörungen
- Hyperurikämie
- Hypercholesterinämie (Genese unklar)

-MRT

Therapie

- Gewichtszunahme (Zielvereinbarung: kontinuierliche Gewichtszunahme von ca. 500-700 g/Woche)
- kognitive Verhaltenstherapie, Familientherapie
- Vermittlung in Selbsthilfegruppen
- ggf. Östrogen- und Antidepressiva-Gaben

Polymyalgia Rheumatica

Name: Klaus Fischer

Alter: 32 Jahre **Gewicht:** 65 kg **Größe:** 1,75 m groß

Allergien/Unverträglichkeiten:

Er habe eine saisonale Pollenallergie

Genussmittel:

Nikotinkonsum er rauche nicht.

Alkoholkonsum er trinke 2 Gläser Rotwein am Tag.

Drogenkonsum wurde verneint.

Er fahre jeden Tag Fahrrad.

Sozialanamnese/gynäkologische Anamnese:

- Er sei getrennt und habe 2 gedunde Kinder.
- Er arbeite als Versicherungskaufmann.

Familienanamnese

- Der Vater sei en einem Herzinfarkt gestorben

- Die Mutter sei an eines natürlichen Todes gestorben

Aktuelle Beschwerden, vegetative Anamnese. Vorerkrankungen und Voroperation

Klaus Fischer ist ein 32-jährige Patient. **Er stellte sich bei uns weseit 5 Wochen bestehender beideseitige Schulterschmerzen vor.** Der Schmerz sei drückend besonders / vor allem Morgens. **Die Intensität** liege bei 4 auf der Schmerzskala, mit **Ausstrahlung in den Nacken**. Er **habe** Ibuprofen 400 mg eingenommen, **was** die Intensität der Schmerzen nicht verringert **habe**. **Als Begleitsymptome nannte er drückende und bitemporale Cephalgie.** In der **vegetativen Anamnese** erwähnte er Traurigkeit und Interessenverlust. **Außerdem habe** er Inappetenz und Insomnie wegen der Schmerzen.

An Vorerkrankungen leide die Patient an:

- arterieller Hypertonie

Es seien keine **Voroperationen** bekannt.

Der Patient nehme folgende Medikamente ein:

- Lisinopril (Dosierung unbekannt)

Er sei **vollständig geimpft** und sei in letzter Zeit nicht im Ausland gewesen.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf Polymyalgia rheumatica

Als Differentialdiagnosen kommen die folgenden in Betracht:

- zervikaler Diskusprolaps (Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule)
- rheumatoide Arthritis
- Depression mit somatischem Syndrom

um die Diagnose zu bestätigen, würde ich den Patienten körperlich untersuchen.

- Diagnosekriterien bei der (ACR) American College of Radiology (mind. 4 Punkte)

Zur weiteren Abklärung sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden:

Laboruntersuchung: Entzündungsparameter - BSG stark erhöht und CRP Erhöhung

- Rheumafaktor negativ, die CK ist normwertig.

-Auch die Schmerzlinderung mit Glukokortikoiden bestätigt die Diagnose

"Diagnose über das, was geholfen hat"

Apparative Untersuchung: Magneteresonanztomografie (MRT) Prolaps Grad und Spinalkanalstenose

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor:

- Prednison zwischen 12,5 und 25 mg täglich

- Methotrexate (**Immunsuppressiva**)

Mögliche Anamnesefragen

- Was führt Sie zu uns?
- Seit wann bestehen die Schmerzen?
- Wo genau haben Sie die Schmerzen?
- Sind die Schmerzen einseitig oder beiderseitig?
- Sind die Beschwerden plötzlich oder eher langsam angetreten?
- Haben sich die Schmerzen im Laufe der Zeit verschlechtert?
- Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10?
- Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
- Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben?
- Sind die Schmerzen anhaltend oder wiederkehrend?
- Sind die Schmerzen morgens oder abends stärker?
- Gibt es einen bestimmten Auslöser für die Beschwerden?
- Hatten Sie schon mal unter ähnlichen Beschwerden gelitten?
- Leiden Sie unter Muskelschwäche? Fühlen Sie sich müde oder erschöpft?
- Verspüren Sie Kribbeln oder Taubheitsgefühl?
- Haben Sie Kraftverlust an Ihren Händen oder Beinen bemerkt?
- Fallen Ihnen oft Gegenstände aus den Händen?
- Leiden Sie unter morgendlicher Steifigkeit?
- Haben Sie schon etwas dagegen eingenommen? Falls ja: was und in welcher Dosierung, wann, hat es Ihnen geholfen?
- Sind die betroffenen Gelenke angeschwollen, überwärmt oder gerötet?
- Ist Ihnen Hautveränderungen aufgefallen?
- Ist Ihnen Bewegungseinschränkungen an den betroffenen Gelenken aufgefallen?
- Haben Sie noch andere Beschwerden?
- Wo genau haben Sie Kopfschmerzen? Sind die Kopfschmerzen beidseitig? Intensität, Strahlung, Charakter...

Definition

ist eine Autoimmunerkrankung, die mit einer Vaskulitis einhergeht

Klinik

-symmetrische Schmerzen der proximalen Extremitätenmuskulatur (Hüftmuskulatur, Schultermuskulatur, Nackenmuskulatur). Die Schmerzen treten charakteristischerweise zur Nacht auf.

-Morgensteifigkeit und wechselnde bewegungsabhängige Beschwerden der betroffenen Muskulatur.

-Fieber,

-Abgeschlagenheit,

-Appetitverlust,

- Nachtschweiß
- depressive Verstimmung.
- symmetrischen Synovitis. (%20 der Patienten)

Diagnostik

Laborbefund: CRP und BSG sind erhöht.
Vielleicht Leukozytose und leichte Anämie.

Diagnosekriterien

herangezogen:

- Morgensteifigkeit > 45 min (2 Punkte)
- Rheumafaktor und/oder Anti-CCP-Antikörper negativ (2 Punkte)
- Beckengürtelschmerz oder verminderte Hüftbeweglichkeit (1 Punkt)
- Kein anderes Gelenk schmerzhaft (1 Punkt)
- Entzündliche Veränderungen (z.B. Bursitis subacromialis bzw. subdeltoidea) beider Schultern (1 Punkt)
- Entzündliche Veränderungen an mindestens einem Schulter- und Hüftgelenk (1 Punkt)

Eine Polymyalgia rheumatica gilt als gesichert, wenn mit dem o.a. Score mind. 4 Punkte erzielt werden.

-Therapie mit Glukokortikoiden spricht ebenfalls für eine Polymyalgia rheumatica ("Diagnosis ex juvantibus")

Differentialdiagnosen

- rheumatoide Arthritis
- Lupus erythematoses (SLE)
- Fibromyalgie
- Pyrophosphatarthropathie (CPPD)
- Riesenzellarteriitis (RZA)

Therapie

- Glukokortikoiden
- Immunsupresiva

Metabolisches Syndrom

Anton Kaiser, 53 Jahre alt, 170 cm groß, 115 kg schwer.

Allergien: Keine

Raucher: 30 Packungen pro Jahr seit 30 Jahren

Alkoholkonsum: Täglich 4 Flaschen Bier seit 2 Jahren

Drogen: Keine

Sozialanamnese:

Beziehung: Getrennt seit 2 Jahren, 2 gesunde Kinder, lebt allein

Arbeit: Arbeitslos seit 2 Jahren

Sport: Kein Sport

FA: Vater sei mit 80 Jahren verstorben

Mutter sei mit 55 Jahren verstorben an Mammakarzinom

Anamnese: Herr Kaiser ist ein 53-jähriger Patient, der sich wegen einer seit 2 Jahren fortschreitenden Gewichtszunahme mit Depression in unserer Station vorstellte. Der Pt berichtete, dass er seine Beschwerden mit Arbeitslosigkeit verknüpft habe.

Der Pt habe keine ähnlichen früheren Beschwerden angegeben. Gestern morgen habe er beim Hausarzt Blut abnehmen lassen, und die Laborergebnisse zeigten erhöhten Blutzucker und erhöhte Cholesterinwerte, weshalb er mit dem Verdacht auf Metabolisches Syndrom zu uns überwiesen wurde.

Dem Pt seien die folgende Begleitsymptome aufgefallen:

Sehstörungen (diabetische Retinopathie), Polyurie (ich habe versucht mit allen Krankheiten zu vergleichen, jedoch hat er nur die Beschwerde der Gewichtszunahme, sonst nix)

Vorerkrankungen: Gonarthrose seit 2 Jahren

Arterielle Hypertonie seit einigen Jahren

Appendektomie durchgeführt (Als Kind)

Impfstatus ist vollständig.

Medikation: Diclofenac 100 mg bei Bedarf

Ramipril 5 mg 1-0-0

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf das Metabolische Syndrom hin.

1. Persönliche Daten: Name: Max Mustermann Alter: 52 Jahre Gewicht: 98 kg Größe: 176 cm

2. Allergien: Keine bekannten Allergien

3. Genussmittel/Noxen:

☐ Nikotin: Raucher (ca. 10 Zigaretten/Tag, seit 20 Jahren)

☐ Alkohol: ca. 2x pro Woche (1–2 Bier oder Wein)

☐ Drogen: keine

☐ Sport: selten

4. Sozialanamnese:

☐ Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

☐ Arbeit: Büroangestellter

☐ Lebensweise: sedentär, wenig körperliche Aktivität

5. Familienanamnese:

☐ Vater: Diabetes mellitus Typ 2, Herzinfarkt mit 67 Jahren

☐ Mutter: Hypertonie, Adipositas

☐ Geschwister: keine relevanten Vorerkrankungen bekannt

6. Aktuelle Beschwerden:

Herr Max Mustermann ist ein 52-jähriger Patient, der sich heute wegen seit mehreren Monaten zunehmender Gewichtszunahme, insbesondere im Bauchbereich, sowie vermehrter Müdigkeit und Leistungsminderung in unserer Praxis vorstellte. Der Patient berichtet, dass er sich nach den Mahlzeiten häufig schläfrig fühle und eine deutliche Abnahme seiner körperlichen Belastbarkeit bemerkt habe. Zudem klagt er über wiederkehrende Kopfschmerzen und Schwindel, die vor allem morgens auftreten. Er gibt an, in den letzten Monaten vermehrt Durst zu verspüren und häufiger Wasser lassen zu müssen. Gelegentlich bemerke er ein Druckgefühl im Brustbereich, das jedoch nicht belastungsabhängig sei. Die Beschwerden seien schleichend über die letzten Monate entstanden und hätten sich allmählich verschlechtert.

7. Begleitsymptome:

Ferner sind dem Patienten folgende Begleitsymptome aufgefallen: Er berichtet über gelegentlich auftretendes Herzrasen (Tachykardie), insbesondere in Stresssituationen oder nach kohlenhydratreichen Mahlzeiten. Zudem sei ihm aufgefallen, dass seine Beine am Abend leicht anschwellen. Er klagt über vermehrtes nächtliches Schwitzen, das ihn häufig aus dem Schlaf wecke. Während eines kürzlichen Arztbesuchs habe er seinen Blutdruck selbst gemessen, der bei 145/90mmHg lag.

8. Vegetative Anamnese:

Die vegetative Anamnese ist weitgehend unauffällig, mit Ausnahme folgender Punkte:

☐ Der Patient berichtet über gelegentliche Einschlafprobleme und gibt an, dass er sich am Morgen nicht erholt fühle.

☐ Er leidet in den letzten Monaten vermehrt unter nächtlichem Schwitzen.

☐ Die Fragen nach Meläna, Fieber, Schüttelfrost, Schweißausbrüchen, Brustschmerzen und Luftnot wurden verneint.

9. Vorerkrankungen:

- ☐ Arterielle Hypertonie (seit 3 Jahren bekannt, aktuell nicht optimal eingestellt)
- ☐ Hyperlipidämie (erhöhte LDL- und Triglycerid-Werte)
- ☐ Glukosetoleranzstörung
- ☐ Adipositas (BMI 31 kg/m²)

10. Medikamentenanamnese:

- ☐ Ramipril 5 mg einmal täglich (unregelmäßige Einnahme)
- ☐ Atorvastatin 10 mg einmal täglich
- ☐ Keine weiteren Medikamente

11. Verdachtsdiagnose:

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ein metabolisches Syndrom hin.

12. Als Differentialdiagnosen kommen die Folgenden in Betracht:

- ☐ Diabetes mellitus Typ 2
- ☐ Primäre arterielle Hypertonie
- ☐ Nicht-alkoholische Fettlebererkrankung
- ☐ Schlafapnoe-Syndrom
- ☐ Hypothyreose (mögliche Ursache für Gewichtszunahme und Müdigkeit)

13. Diagnostik:

Zur weiteren Abklärung sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden.

1. Laboruntersuchungen:

- ☐ Nüchternblutzucker, HbA1c ☐ Lipidprofil (LDL, HDL, Triglyceride)
- ☐ Leberwerte (GOT, GPT, GGT)
- ☐ Harnsäure
- ☐ Nierenparameter (Kreatinin, eGFR)
- ☐ Schilddrüsenwerte (TSH, fT3, fT4) zum Ausschluss einer Hypothyreose

2. Weitere Untersuchungen:

- ☐ Blutdruck-Tagesprofil (24h-Blutdruckmessung)
- ☐ Abdomen-Sonographie zur Beurteilung der Leber (NAFLD?)
- ☐ EKG zur Beurteilung kardiovaskulärer Risikofaktoren
- ☐ Glukosetoleranztest (oGTT)
- ☐ Polygrafie (Schlafapnoe-Screening), falls nächtliche Atemaussetzer berichtet werden

14. Therapie:

1. Lebensstilmodifikation:

- ☐ Ernährungsumstellung: Kalorienreduzierte, mediterrane Kost
- ☐ Regelmäßige körperliche Aktivität: Mindestens 150 Minuten Bewegung pro Woche
- ☐ Gewichtsreduktion: Ziel BMI < 25 kg/m²
- ☐ Rauchstopp: Entwöhnungsprogramme oder Nikotinersatztherapie anbieten
- ☐ Reduktion des Alkoholkonsums

2. Medikamentöse Therapie:

- ☐ Optimierung der Blutdruckeinstellung (evtl. Anpassung der Medikation)
- ☐ Metformin 500 mg 1x täglich bei Nachweis einer Diabetesentwicklung
- ☐ Falls notwendig: SGLT2-Hemmer oder GLP-1-Agonisten zur Verbesserung der Glukoseregulation
- ☐ Bei Hypothyreose: L-Thyroxin-Therapie nach Bestätigung durch Laborwerte

3. Kontrolle und Nachsorge:

- ☐ Regelmäßige Kontrolle von Blutdruck, Blutzucker, Lipidwerten und Schilddrüsenwerten
- ☐ Schulung zur Ernährung und Bewegung
- ☐ Kontrolle in 3 Monaten zur Evaluierung des Therapieerfolgs

Metabolisches Syndrom Kriterien:

- Zentrale (stammbetonte) Adipositas mit Taillenumfang von $\geq 80\text{cm}$ (Frauen) bzw. $\geq 94\text{ cm}$ (Männer) sowie
- zusätzlich zwei der vier folgenden Faktoren:
 - erhöhte Triglyceride: $\geq 150\text{ mg/dL}$ ($1,7\text{ mmol/L}$)
 - erniedrigtes HDL-Cholesterin: Frauen: $< 50\text{ mg/dL}$ ($1,29\text{ mmol/L}$), Männer: $< 40\text{ mg/dL}$ ($1,03\text{ mmol/L}$)
 - erhöhten Blutdruck: Systolisch $\geq 130\text{ mmHg}$ oder Diastolisch $\geq 85\text{ mmHg}$
 - Nüchternblutzucker $\geq 100\text{ mg/dL}$ ($5,6\text{ mmol/L}$) oder Diabetes mellitus Typ 2

Risikofaktoren:

- Stress
- psychische Störungen, z.B. Schizophrenie
- körperliche Inaktivität
- erhöhte Menge an Viszeraalfett
- Obstruktives Schlafapnoesyndrom
- Chronische Nierenerkrankung
- Polyzystisches Ovarialsyndrom (für Frauen)
- Nicht-alkoholische Fettleber
- Alkohol
- Nikotin

Rheumatisches Fieber

Name: Olaf Stehmann

Alter: 48 Jahre Gewicht: -- kg Größe: -- m groß

Allergien/Unverträglichkeiten:

Er habe eine saisonale, Pollenallergie.

Genussmittel:

Nikotinkonsum: wurde verneint.

Alkoholkonsum: Er trinke Bier 2mal pro Woche.

Drogenkonsum wurde verneint.

Sozialanamnese

Familienanamnese

Medikamente

Er nehme keine Medikamente ein

Aktuelle Beschwerden, vegetative Anamnese. Vorerkrankungen und Voroperation:

Herr Olaf Stehmann ist ein 48-jähriger Patient. Er stellte sich bei uns wegen seit 2 **Tagen** bestehender, stechender, wandernder Schmerzen an den großen Gelenken vor. Die Intensität liege bei 7 auf der Schmerskala und wandere von einem Gelenk zum anderen. Er habe Ibuprofen 600 mg eingenommen, was die Intensität der Schmerzen nicht verringert habe. Als Begleitsymptome nannte er Rubor und Ödem. In der vegetativen Anamnese erwähnte er Fatigue, Inappetenz und 39°C Fieber. Des

Weiteren erwähnte der Patient vor 2 Wochen eine **Tonsillitis**. Bei genauer Befragung berichtet er, dass er nur 3 Tage lang Antibiotika eingenommen habe.

Es seien keine relevanten **Vorerkrankungen** oder **Voroperationen** bekannt.

Impfung und Reise: Er sei vollständig geimpft. Er sei in letzter Zeit nicht im Ausland gewesen.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf rheumatisches Fieber.

Als Differentialdiagnosen kommen die folgenden in Betracht:

- septische Arthritis
- rheumatische Arthritis

um die Diagnose zu bestätigen, würde ich den Patienten körperlich untersuchen

- Jones-Kriterien

- Messung der Vitalparameter
- kardiale Untersuchung (systolischen oder diastolisches Herzgeräusch, sowie Perikardreiben)
- neurologische Untersuchung

Zur weiteren Abklärung sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden:

Laboruntersuchung

- Erhöhte BSG: $\geq 60 \text{ mm/h}$, CRP-Anstieg: $\geq 3.0 \text{ mg/dL}$, Leukozytose
- **Rachenabstrich mit anschließender Kultur (Goldstandard)**

Apparativeuntersuchung

- EKG-Veränderungen (z.B. verlängerte PQ-Zeit)
- Echokardiographie (Perikarderguss)

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor:

1. **Penicillin G**: $4 \times 1 \text{ Mio. IE i. v.}$, 10–14 Tage

Bei Penicillinallergie werden **Makrolide** eingesetzt (Clarithromycin, Azithromycin)

2. Analgetikum: Ibuprofen oder Naproxen

3. Antipyretikum

4. Rezidivprophylaxe: (falls Herzbeteiligung) Penicillin G 1,2 Mio. IE i.m. alle 4 Wochen 5 für Jahre

5. Tonsillektomie

6. ggf. Klappenersatz bei Endokarditis (reemplazo valvular)

7. Prednisolon 80 mg/d pro Tag (Bei einer Herzbeteiligung)

Mögliche Anamnesefragen:

- Welche Gelenke sind genau betroffen?
- Sind die Schmerzen beid- oder einseitig?
- Seit wann haben Sie diese Beschwerden?
- Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10?
- Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben?
- Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
- Sind die Schmerzen plötzlich oder eher langsam aufgetreten?
- Gibt es vielleicht etwas, das die Schmerzen lindern oder verschlechtern?
- Haben Sie schon unter ähnlichen Beschwerden gelitten?
- Haben Sie eine bestimmte Auslöser bemerkt?
- Hatten Sie möglicherweise einen Unfall oder eine Verletzung?

- Hatten Sie in den letzten Zeiten Zeckenstiche?
- Springen die Schmerzen von Gelenk zu Gelenk?
- In welchem Zeitfenster wandern sie?
- Sind die betroffenen Gelenke gerötet, geschwollen oder überwärmt?
- Hatten Sie in den letzten Zeiten unter Mandel- oder Rachenentzündung gelitten? Hatten Sie in den letzten Zeiten unter einer Halsentzündung oder Halsschmerzen gelitten? Falls ja: Wurde Sie mit Antibiotika behandelt? Wie lange haben Sie die Antibiotika eingenommen?
- Haben Sie Fieber?
- Wie hoch war das Fieber?
- Ist das Fieber anhaltend oder wiederkehrend?
- Leiden Sie unter Schweißausbrüche, Schüttelfrost oder Nachtschweiß?
- Haben Sie Knotenvergrößerung unter der Haut verspürt?
- Sind Ihnen kleine Blutungen oder Verfärbungen auf der Haut aufgefallen?
- Hatten Sie in letzter Zeit Hautausschläge oder ringförmige Rötungen? (Erythema marginatum: scharf begrenzter, nicht-juckender, stammbetonter, rosaroter Hautausschlag)
- Haben Sie unwillkürliche Bewegungen oder Zittern bemerkt? (Chorea minor?)
- Leiden Sie unter Herzrasen oder -stolpern?
- Verspüren Sie Brustschmerzen oder Engegefühl?
- Ist Ihnen eine allgemeine Schwäche oder Müdigkeit aufgefallen?

Jones Kriterien (zwei Hauptkriterien oder 1 Haupt- und 2 Nebenkriterien)

- Hauptkriterien:
 - Subkutane Knötchen
 - Polyarthrit
 - Erythema marginatum
 - Chorea minor
 - Kardiitis (klinisch oder subklinisch per Echokardiographie)
- Nebenkriterien:
 - Fieber über 38,5 °C
 - Polyarthralgie
 - Verlängertes PR-Intervall im EKG
 - BSG über 60 mm in einer Stunde und/oder CRP über 3,0 mg/dl

Der Patient ist mit Gelenkschmerzen gekommen, er hat gesagt, dass die Schmerzen wandern, manchmal am Fußgelenk, manchmal an der Schulter, die Gelenke sind geschwollen, warm und schmerzhaft, er hatte auch Fieber und die Beschwerden sind vor 2 Tagen aufgetreten, ich habe nach Tonsillitis, gefragt und er hat mir gesagt, dass vor 2 Wochen er Halsschmerzen hatte und mit Antibiotika behandelt wurden.

Herr Olaf Stehmann, Müdigkeit seit 3 Tagen..... Gelenkschmerzen... Ödem, Überwärmung. Fieber 39. Inappetenz. Keine VE. Er hat vor 2 Wochen Angina Tonsillitis gehabt, die mit Penicillin behandelt wurde(nur 3 Tagen eingenommen habe)
Operation: Cholezystektomie
Eltern: gesund

Der Patient ist 45 JA, vor 3 Wochen hat er Tonsillitis (Streptokokken) gehabt, die wurde mit Penicillin behandelt (er hat das Antibiotikum nur 3 Tagen eingenommen). Seit 10 Tagen hat er Gelenkschmerzen, erstes in linke Ellenbogen dann in rechten Hüfte, Kniegelenk und Schulter. Er hat keine Vorerkrankungen oder Op, er nimmt keine Medikamente.

Meine Verdachtsdiagnose war rheumatisches Fieber.
Differentialdiagnose: septische Arthritis und rheumatische Arthritis .

Zöliakie

Name: Gustav Hirschmann Alter: 44 Jahre Größe: 1,70 m Gewicht: früher 69- 70 kg, jetzt ca. minus 6 kg (~64 kg), HA: Herr Müller

-Herr Hirschmann ist ein 44-jähriger Patient, der sich wegen seit 4 Monaten bestehender, langsam auftretender, rezidivierender, nahrungsabhängiger, diffuser Abdominalschmerzen ohne Ausstrahlung sowie Gewichtsabnahme von 6 kg bei uns vorgestellt hat.

Der Patient gab an, dass die Schmerzen nur 2-3 Stunden nach dem Essen von Brot aufgetreten seien. Die Schmerzintensität bewerte der Patient mit 4 von 10 auf der Schmerzskala. Des Weiteren klagte er über Lethargie, Fatigue, Flatulenz und beidseitige Cephalgie. Die vegetative Anamnese sei bis auf Insomnie (insbesondere beim Durchschlafen) und Steatorrhö unauffällig.

Familienanamnese:

Vater: Verstorben (unbekannt woran), keine VE

Mutter: Verstorben (unbekannt woran), keine VE

Geschwister: 2 gesunde Brüder

Sozialanamnese:

Familienstand: verheiratet, wohne zusammen mit seiner Frau.

Arbeit: Bauer

Kinder: 3 gesunde Kinder

Die Reiseanamnese sei leer und der Impfstatus sei vollständig.

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Zöliakie hin. Differentialdiagnostisch kommen Kolonkarzinom, Reizdarmsyndrom, Giardiasis und chronisch-entzündliche Darmerkrankungen in Betracht.

Zur weiteren Abklärung der Beschwerden würde ich folgende diagnostische Maßnahmen einleiten:

-Körperliche Untersuchung, DRU

-Labordiagnostik (dBB, CRP, BSG, Anti-Transglutaminase-IgA, gesamt-IgA, Stuhlprobe und -kultur, CEA, CA19-9, okkultes Blut im Stuhl)

-ÖGD mit Biopsieentnahme aus dem Duodenum, ggf. Koloskopie, ggf. Abdomensonografie (um DD auszuschließen)

Falls die Verdachtsdiagnose bestätigt wird, schlage ich folgende Therapie vor:

Verzicht auf glutenhaltiges Essen

Ernährungsberatung

Fragen des Patienten:

Muss ich hier bleiben?

Was habe ich?

Darf ich nicht mehr Brot essen?

Was soll ich denn essen?

Wieso habe ich diese Unverträglichkeit seit wenigen Monaten und nicht früher gekriegt, wie funktioniert das? (Pathophysiologie kurz erklären).

A-A-Gespräch: Verdachtsdiagnose?

Wieso Zöliakie? (Die Schmerzen treten nur nach dem Verzehr von Brot auf, Zeichen von Malabsorption)

Wo genau im Darmtrakt tritt Zöliakie auf? (Duodenum)

Wie sichern wir die Diagnose, außer der Labordiagnostik? (ÖGD mit Biopsieentnahme aus dem Duodenum)

Wieso Kolonkarzinom als DD? (Gewichtsabnahme)

Therapie (Verzicht auf glutenhaltiges Essen, Ernährungsberatung) Welches Essen ist noch erlaubt? (Mais, Reis, Kartoffeln, Möhren, usw.)

Der Patient hat nur fettiger Durchfall nach der Aufnahme von Brot und Nudeln seit 5 Monaten und Gewichtsverlust von ca. 6 kg innerhalb 5 Monaten. Ohne Schmerzen oder Fieber.

Arzt-Arzt Gespräch:

Differenzialdiagnose (DD)

Risikofaktoren

Warum denken sie nicht Morbus Crohn?

Der Durchfall des Patienten hält seit 5 Monaten in gleicher Schwere an, dauert zu lange, was könnte der Grund sein?

Diagnose und Therapie

Herr Hirschmann Gustav ist ein 44-jähriger Patient, der wegen seit mehr als 6 Monaten bestehender, fettiger Stuhlveränderungen und starker Gewichtsabnahme sich vorgestellt hat. Die andere Beschwerden waren Blähungen, Müdigkeit und Kopfschmerzen.

Er hat viel über seinen Stuhl gesprochen. Er habe zwei mal am Tag fettiger Stuhl und es sei schwer, seinen Stuhl zu säubern. Die Fragen nach Bauchschmerzen, Fieber, Trauma wurden verneint.

Ich habe erst gesagt, dass meine Verdachtsdiagnose kolorektales Karzinom ist. Meine erste DD war akute Pankreatitis.

AA Gespräch: Warum ist Stuhl fettig? Ist das normal? Ich habe gesagt, dass Fett wahrscheinlich nicht verdaut werden kann.

Warum? wegen Enzymemangel oder -probleme, Lipase-Amylase. Er hat gesagt, so es gibt Probleme bei Malabsorption. Wissen Sie einige Malabsorptionserkrankungen?

Ich habe Zöliakie gesagt, sie waren glücklich

Was machen Sie denn? Transglutaminase IgA, gesamte IgA, Biopsie aus Duedonum

Was erwarten Sie zu sehen? Zottenatrophie und Kryptenhyperplasie.

Was sind andere Laboruntersuchungen? Stuhlkultur, Hämoakkulttest

Mögliche Anamnesefragen:

- Seit wann haben Sie diese Beschwerden?
- Sind die Beschwerden plötzlich oder eher langsam aufgetreten?
- Haben Sie schon einmal unter ähnliche Beschwerden gelitten?
- Gibt es einen bestimmten Auslöser für die Beschwerden?
- Leiden Sie unter Durchfall oder Verstopfung?
- Wie sieht Ihr Stuhl aus?
- Haben Sie Blut oder Beimischungen im Stuhl bemerkt?
- Riecht Ihr Stuhl anders als sonst?
- Haben Sie Bauchschmerzen?
- Leiden Sie unter Blähungen oder einem Völlegefühl?
- Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen?
- Wie ist Ihr Appetit?
- Haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab- oder zugenommen?
- Fühlen Sie sich müde, erschöpft oder kraftlos?
- Haben Sie Konzentrationsstörungen?

- Leiden Sie an Hautausschlägen?
- Sieht Ihr Haut blass.
- Bekommen Sie öfters spontan blaue Flecken oder Einblutungen?
- Leiden Sie unter Haarverlust oder brüchige Nägel?
- Haben Sie Aphten in der Mundhöhle bemerkt?
- Leiden Sie unter Beinschwellungen?
- Können Sie gut in der Nacht sehen?
- Wie ernähren Sie sich? Verzichten Sie auf bestimmte Lebensmittel?
- Haben Sie bereits versucht, glutenhaltige Produkte zu verzichten?
- Haben sich Ihre Beschwerden nach Verzicht auf Gluten verbessert?

Definition

Die **Zöliakie** ist eine immunologische Erkrankung des Darmes ungeklärter Ursache, die durch in Getreide enthaltenen Proteine ausgelöst wird, die man unter dem Begriff Gluten zusammenfasst. Es kommt zu einer intestinalen Unverträglichkeit gegenüber den Getreideeiweißen. Wichtigste Auslöser sind Dinkel, Weizen, Roggen(çavdar) und Gerste(arpa).

Pathogenese

Die Zöliakie führt zu einer autoimmunologisch vermittelten Zottenatrophie mit deutlicher Vermehrung der T-Zellen in den Schleimhautepithelien. Die Gewebetransglutaminase (tTG) spielt bei der Pathogenese eine Schlüsselrolle. Sie ist u.a. in der extrazellulären Matrix basal der Enterozyten lokalisiert und katalysiert zwei Reaktionen:

Transglutaminierung und Deamidierung.

Antigenspezifische T-Zellen erkennen mit ihrem T-Zell-Rezeptor das auf dem MHC-II-Komplex präsentierte Peptid und initiieren eine Immunreaktion. Infolge der Komplexbildung von tTG und Gliadinpeptiden resultiert eine ausgedehnte Immunreaktion gegen die tTG selbst, was zur Bildung von Transglutaminase-Antikörpern (tTG-Ak) führt.

Die Aktivierung der T-Zellen löst eine vermehrte Produktion von Interferon-gamma und TNF-alpha aus und aktiviert B-Zellen und NK-Zellen. Die resultierende Entzündungsreaktion der Darmschleimhaut führt dann zu Zottenatrophie, Kryptenverbreiterung und Bürstensaumverlust.

Symptomatik

Durch die Zottenatrophie ist im oberen Dünndarm die Resorption von Nährstoffen und Mikronährstoffen (z.B. Eisen, B-Vitamine, Eiweiß, Kalzium, Zink, Kupfer) gestört. Dadurch resultiert ein vielfältiges, oft unspezifisches Symptombild, weshalb die Zöliakie auch als "Chamäleon der Gastroenterologie" beschrieben wird.

Es existieren viele verschiedene gastrointestinale, aber auch extraintestinale Symptome. Zu den möglichen gastrointestinalen Symptomen zählen:

- Diarrhoe
- Erbrechen mit und ohne Übelkeit
- habituelle Aphten
- Obstipation
- Flatulenz
- postprandiales Völlegefühl
- geblähtes Abdomen
- abdominelle Beschwerden/Schmerzen
- unklare Schmerzzustände

Zu den extraintestinalen Symptomen zählen zum Beispiel:[1]

- Kopfschmerzen/Migräne
- Erschöpfung
- Myalgie
- Nachtblindheit
- Gedeihstörung bzw. verminderte Wachstumsgeschwindigkeit und Kleinwuchs
- Pubertas tarda
- unklarer Gewichtsverlust
- Arthralgie
- Ataxie

Bei chronischen gastroenterologischen Symptomen, deren Ursachen nicht erklärbar sind, sollte man differenzialdiagnostisch eine Zöliakie ausschließen. Die Erkrankung kann leicht mit einem Reizdarmsyndrom, einer Laktoseintoleranz oder einer chronischen Pankreatitis verwechselt werden.

Diagnostik

Empfohlen wird aktuell (2024) zunächst eine Bestimmung des IgA gegen die Gewebstransglutaminase (Transglutaminase-2), das tTG-IgA, sowie das Gesamt-IgA zum Ausschluss eines IgA-Mangels.

Die histologische Sicherung der Diagnose erfolgt durch eine Dünndarmbiopsie, die im Rahmen einer Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) durchgeführt wird. Es müssen mindestens 40 T-Lymphozyten auf 100 Epithelzellen vorhanden sein. Ein Verlust oder subtotaler Verlust an Zotten bei erhöhten intraepithelialen Lymphozyten reicht histologisch für die Diagnose aus.

Differentialdiagnosen

- Nahrungsmittelallergien (Kuhmilchallergie, Sojaallergie, Weizenallergie)
- Morbus Crohn
- Tropische Sprue
- Nicht-Zöliakie-Nicht-Weizenallergie-Weizensensitivität
- Intestinales Lymphom
- Infektionen mit Parasiten (Lamblien, Cryptosporidien)
- Immunglobulin-Mangel
- Medikamente (z.B. Zytostatika)